



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**
SAÚDE

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM VOLUME 3

CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER

**ACOLHIMENTO ÀS DEMANDAS DA MULHER NOS
DIFERENTES CICLOS DE VIDA**

Florianópolis, Dezembro de 2016

**Versão 1.6
(Atualização em Outubro de 2025)**

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM VOLUME 3

ENFERMAGEM Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis **CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER**

**ACOLHIMENTO ÀS DEMANDAS DA MULHER NOS
DIFERENTES CICLOS DE VIDA**

Prefeito

Topázio Neto

Secretário de Saúde

Almir Adir Gentil

Secretário Adjunto

Humberto João dos Santos

Diretor de Atenção à Saúde

Daniela Salomé de Andrade

Gerente de Atenção Primária à Saúde

Ana Cristina Magalhães Fernandes Báfica

Responsável Técnica de Enfermagem e Coordenadora da Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem (CSAE)

Elizimara Ferreira Siqueira

Colaboradores

Alessandra De Quadra Esmeraldino
Alessandra Mafra
Ana Carolina Severino Da Silva
Anna C. Ribeiro Lopes Rodrigues
Ana C. Magalhães Fernandes Báfica
Ana Maria Bim Gomes
Andrey Teixeira
Carla Sousa Guedelha
Caren Cristina Della Múa Fonseca
Carmen Ruggi Bonfim Santoro
Caroline Schweitzer De Oliveira
Cilene Fernandes Soares
Cleusa Marcia Vieira
Cristiane Regina Pereira
Dalton H. Cordeiro Espindola
Daniela Cuadrado Fabozi
Daniela Salomé de Andrade
Deyse Ilza De Aquino

Edla Zwiener González
Fernanda De Conto
Fernanda Paese
Geórgia Januário Farias
Gisele Magnabosco
Guilherme Mortari Belaver
Izabel Cristina Matendal Conrat
Ingrid Valeria Veronez
Jadson Jovaert Mota Kreis
João Marcos Emerenciano
Julia Maria De Souza
Juliana Cipriano Braga Silva
Juliana Reinert Maria
Juliana Valentim
Karina Mendes Garcia
Laura D. R. Castillo Lacerda
Leila B. B. De A. Ferreira
Luana Silveira

Lucas Alexandre Pedebos
Lucilene Gama Paes
Lucilene Maria Schmitz
Luis Ramon Sousa do Nascimento
Marcel Canedo Gomes Da Silva
Milena Pereira
Missouri H. Bizarro Komatu Paixão
Noelia Fernandes De Oliveira
Priscilla Cibebe Tramontina
Renata Da Rosa Turatti Fetzner
Renata Campani Pereira
Sarah Soares Barbosa
Solange Alberti Andrzejewski
Stella Maris Pfitzenreuter
Talita Cristine Rosinski
Tatiana Vieira Fraga
Vinicius Paim Brasil
Vivian Costa Fermo



Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR). Acesse a cópia desta licença:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR

Como citar este documento: FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. PROTOCOLO DE ENFERMAGEM VOLUME 3 – Cuidado em saúde da mulher: acolhimento as demandas da mulher nos diferentes ciclos de vida. Florianópolis, 2025. Disponível em:

<<http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=protocolos+de+enfermagem&menu=11&submenuid=1478>>

APRESENTAÇÃO

A saúde da mulher é uma temática estruturante da atenção primária no Brasil desde seu início, ainda antes da construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Inicialmente focada apenas nas questões de saúde reprodutiva, foi expandida na tentativa de abarcar a integralidade pretendida para o SUS.

Por ser uma área temática bastante antiga no SUS, possui um grande conjunto de publicações, incluindo o primeiro protocolo deste município com ampliação das ações do enfermeiro, publicado em 2010. O presente documento não é uma atualização ou releitura do protocolo anterior, mas um novo documento focado no processo de trabalho do enfermeiro.

Da mesma maneira que nos protocolos anteriores, os temas abordados neste documento foram escolhidos pela magnitude e relevância na prática da enfermagem em atenção primária, e temos certeza que contribuirá em muito para o aumento da resolutividade da consulta de enfermagem. Além disso, reforça aspectos de grande relevância, mas que podem passar despercebidos na prática cotidiana do enfermeiro, sempre embasados nas evidências mais recentes. Nos casos de divergência entre este protocolo e o PACK-SMS/BMJ sobre as atribuições do enfermeiro, o que estiver escrito na versão mais atualizada do presente protocolo (sempre disponível no site da SMS) será o considerado oficialmente.

Para maiores detalhes ou aprofundamentos teóricos sobre os temas aqui abordados, continuamos recomendando livros texto, os Cadernos de Atenção Básica (publicação do Ministério da Saúde) ou artigos científicos específicos, muitos desses descritos nas referências deste protocolo.

Para efeitos legais, este documento está em acordo com a Lei Federal nº 7.498/1986 (regulamentação do exercício da enfermagem) e com a Resolução COFEN 195/1997 (solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro), sendo válido como protocolo institucional.

Almir Adir Gentil

Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis

SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS	7
LISTA DE FLUXOGRAMAS	10
1 - CONSULTA DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	11
1.1 – AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NA CONSULTA GINECOLÓGICA	11
1.1.1 – Entrevista	11
1.1.2 – Exame Físico e Clínico das Mamas na Consulta Ginecológica	12
1.1.3 – Exame Físico e Clínico do Períneo, Anus e Genitália	14
1.1.3.1 – Exame Especular	15
1.1.3.2 – Exame de Toque Bimanual	17
1.1.3.3 – Exame Retovaginal	20
2 - MANEJO PARA QUEIXAS GINECOLÓGICAS MAIS FREQUENTES NA APS	21
2.1 - CORRIMENTO VAGINAL, VULVOVAGINITES E CERVICITES	21
2.1.1 - Abordagem às Principais Causas de Corrimento Vaginal	23
2.1.1.1 - Candidíase	23
2.1.1.2 - Vaginose Bacteriana	25
2.1.1.3 - Vaginose Citolítica	26
2.1.2 - Hipersensibilidade ao Plasma Seminal	27
2.1.3 - Cisto ou Abscesso de Bartholin - Bartholinite	28
2.2 – INFECÇÃO URINÁRIA	30
2.2.1 – Manejo da Infecção Urinária	30
2.3 – MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA	34
2.4 – DISPAREUNIA E VAGINISMO	40
2.5 – INCONTINÊNCIA URINÁRIA	41
2.5.1 – Avaliação e Manejo da Incontinência Urinária	42
3 - PLANEJAMENTO REPRODUTIVO	44
3.1 – PRECONCEPÇÃO	44
3.2 – MÉTODOS CONTRACEPTIVOS	45
3.2.1 – Consulta de Enfermagem na Anticoncepção	46
3.2.2 – Taxa de Falha dos Métodos Contraceptivos	48
3.2.3 – Elegibilidade dos Métodos Contraceptivos	49
3.2.4 – Métodos Disponíveis na Rede Pública	53
3.2.5 – Métodos Não Disponíveis na Rede Pública	57
3.2.6 – Métodos Não Farmacológicos de Abordagem Comportamental	59
3.2.7 – Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre	65
3.2.7.1 – Contraindicações do Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre	66
3.2.7.2 – Manejo para as Principais Intercorrências Relacionadas Ao DIU De Cobre	68
3.2.8 – Contracepção de Emergência	71
4 - PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO	72
4.1 – TÉCNICA DE COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA	73

4.2 – RECOMENDAÇÃO PARA COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	74
4.3 – RECOMENDAÇÃO E CONDUTA CONFORME RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO	76
4.4 – ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO	78
4.5 – COLPOSCOPIA.....	81
5 - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA	83
5.1 – AÇÕES DE RASTREAMENTO	83
5.1.1 – Aprazamento das Mamografias de Rastreamento	83
5.1.2 – Resultados da Mamografia e Condutas da APS no Rastreio de Câncer de Mama	84
5.2 – AÇÕES MEDIANTE A PRESENÇA OU RELATO DE SINAIS OU SINTOMAS	85
5.3 – MASTALGIA E OUTROS SINTOMAS MAMÁRIOS	86
6 - ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL.....	88
6.1 – ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO PRÉ-NATAL	90
6.1.1 – Fluxo de Encaminhamento para Estratificação de Risco Gestacional em Florianópolis	90
6.1.2 – Situações Clínicas Encaminhadas ao Serviço de Urgência / Emergência Obstétrica	93
6.2 – PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL	94
6.2.1 – Exame Clínico Obstétrico (Cefalocaudal)	96
6.2.1.1 – Classificação do Edema	109
6.3 – EXAMES DE ROTINA PARA GESTANTE.....	110
6.3.1 – Rotina de Exames Laboratoriais no Pré-Natal para Risco Habitual	110
6.3.2 – Recomendações e Evidências sobre a Ultrassonografia nos Diferentes Períodos da Gestação	121
6.4 – MANEJO DE COMORBIDADES MAIS PREVALENTES NA GESTAÇÃO	122
6.4.1 – Prevenção e Manejo das Alterações Pressóricas e Hipertensão Arterial na Gestação.....	122
6.4.1.1 – Prescrição de Profilaxia pelo Enfermeiro	122
6.4.1.2 – Rastreamento de Rotina	124
6.4.1.3 – Implementação e Evolução de Enfermagem	125
6.4.2 – Manejo da Gestante com Diabetes Mellitus (DM)	125
6.4.2.1 – Diagnósticos e Classificação da Gestante com DM	126
6.4.2.2 – Processo de Enfermagem no Pré-Natal com DM	127
6.4.2.3 – Monitoramento Clínico-Laboratorial na DM.....	127
6.4.2.4 – Implementação de Enfermagem na DM	127
6.4.2.5 – Condutas no Pós-Parto na DM	128
6.4.3 – Manejo da Gestante com Asma.....	129
6.4.3.1 – Implementação de Enfermagem para Gestante com Asma	129
6.4.3.2 – Tratamento e Medicações para Gestante com Asma	130
6.4.4 – Manejo da Gestante com Sífilis	130
6.4.5 – Manejo da Gestante com Clamídia e/ou Gonorreia.....	131
6.4.6 – Manejo da Gestante com Varicela / Herpes-zoster.....	131
6.5 – MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO	132
6.6 - IMUNIZAÇÃO PARA GESTANTES SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL.....	139
6.7 - PLANO DE PARTO	142
6.8 - PRÉ-NATAL DO PARCEIRO OU PARES DO MESMO GÊNERO	143

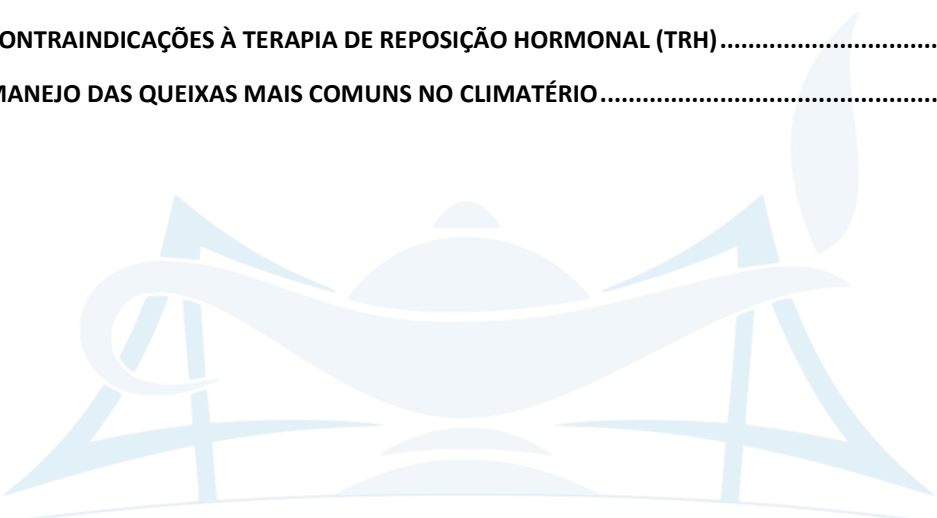
7 - ATENÇÃO À MULHER NO PUERPÉRIO – CONSULTA PÓS-NATAL	144
7.1 - ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NO PUERPÉRIO	145
7.2 - TRATAMENTO DA ANEMIA NO PUERPÉRIO.....	147
7.3 - ABORDAGEM AO ALEITAMENTO MATERNO	148
7.3.1 - Técnica de Amamentação	148
7.3.2 - Prevenção e Manejo dos Principais Problemas Relacionados à Amamentação	150
7.3.3 - Suspensão do Aleitamento Materno – Contraindicações Absolutas e Relativas	157
7.3.3.1 - Acompanhamento de Nutrizes Quanto à Infecção pelo HIV	159
7.3.4 - Retirada e Armazenamento do Leite Materno	160
7.3.5 - Modificações sobre a Lactação Normal	162
7.3.5.1 - Drogas Galactogogas	162
7.3.5.2 - Inibição da lactação	163
7.4 - ABORDAGEM OPORTUNÍSTICA SOBRE IMUNIZAÇÕES NO ATENDIMENTO À MULHER.....	164
8 - MENOPAUSA E CLIMATÉRIO.....	165
8.1 - TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH)	165
8.2 - MANEJO DAS QUEIXAS MAIS COMUNS NO CLIMATÉRIO	166
8.3 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO CLIMATÉRIO/MENOPAUSA.....	167
8.4 - CONTRACEPÇÃO NO CLIMATÉRIO	167
9 - ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO À ADOLESCENTE	168
9.1 - ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS NO ATENDIMENTO À ADOLESCENTE.....	169
9.2 - TESTAGEM SOROLÓGICA PARA MENORES DE 18 ANOS.....	170
10 – INFERTILIDADE.....	171
REFERÊNCIAS.....	172
ANEXO I – MODELO DE PLANO DE PARTO	177
ANEXO II – ALTERAÇÕES EMOCIONAIS MAIS COMUNS EM PUÉRPERAS.....	179
ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MAMADA	180
ANEXO IV – GRAU DE RECOMENDAÇÃO DE CONDUTAS	181
ANEXO V – CONTROLE DE ALTERAÇÕES	182

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - ENTREVISTA NA CONSULTA GINECOLÓGICA DE ENFERMAGEM	11
QUADRO 2 - EXAME FÍSICO E CLÍNICO DAS MAMAS.....	12
QUADRO 3 - EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA	14
QUADRO 4 - EXAME ESPECULAR	15
QUADRO 5 - EXAME DE TOQUE BIMANUAL	17
QUADRO 6 - EXAME DE RETOVAGINAL	20
QUADRO 7 – RACIOCÍNIO CLÍNICO E DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS NO CORRIMENTO VAGINAL, VULVOVAGINITES E CERVICITES.	21
QUADRO 8 – ABORDAGEM À CANDIDÍASE.	23
QUADRO 9 – ABORDAGEM À VAGINOSE BACTERIANA.....	25
QUADRO 10 – ABORDAGEM À VAGINOSE CITOLÍTICA.....	26
QUADRO 11 – ABORDAGEM À HIPERSENSIBILIDADE AO PLASMA SEMINAL.	27
QUADRO 12 – ABORDAGEM AO CISTO OU ABSCESSO DE BARTHOLIN - BARTHOLINITE.	28
QUADRO 13 – TRATAMENTO DA DIFICULDADE URINÁRIA EM MULHERES.....	31
QUADRO 14 – MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA	34
QUADRO 15 – DISPAREUNIA E VAGINISMO	40
QUADRO 16 – CLASSIFICAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA.....	41
QUADRO 17 – AVALIAÇÃO E MANEJO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA CONSULTA DE ENFERMAGEM	42
QUADRO 18 – IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PRÉ-CONCEPCIONAL	44
QUADRO 19 – EXAME FÍSICO E IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM NA ANTICONCEPÇÃO	46
QUADRO 20 – TAXA DE FALHA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS.....	48
QUADRO 21 – CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS	49
QUADRO 22 – CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE CONFORME O TIPO DE MÉTODO ESCOLHIDO E ORIENTAÇÃO AO ENFERMEIRO	50
QUADRO 23 – SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS, DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E IMPLANTE	53
QUADRO 24 – SÍNTESE DE OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO (NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA) ^{1,12,13,47}	57
QUADRO 25 – SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL	59
QUADRO 26 – CONTRAINDICAÇÕES PARA O DIU DE COBRE	66
QUADRO 27 – MANEJO DAS PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO DIU	68
QUADRO 28 – SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS DE EMERGÊNCIA	71
QUADRO 29 – RECOMENDAÇÕES PARA COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM MULHERES ENTRE 25 E 64 ANOS	74

QUADRO 30 – RECOMENDAÇÕES E CONDUTAS CONFORME OS RESULTADOS DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO.....	76
QUADRO 31 – ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO.....	78
QUADRO 32 – CONDUTAS DE INTERPRETAÇÃO E ENCAMINHAMENTO CONFORME LAUDO DA COLPOSCOPIA	82
QUADRO 33 – APRAZAMENTO DAS MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO	83
QUADRO 34 – RESULTADOS DA MAMOGRAFIA E CONDUTAS DA APS NO RASTREIO DE CÂNCER DE MAMA .	84
QUADRO 35 – CONDUTAS PARA MASTALGIA E/OU OUTRAS QUEIXAS MAMÁRIAS	86
QUADRO 36 – FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL EM FLORIANÓPOLIS	90
QUADRO 37 – SITUAÇÕES CLÍNICAS ENCAMINHADAS AO SERVIÇO DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA	93
QUADRO 38 – PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL	94
QUADRO 39 – EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)	96
QUADRO 40 – CLASSIFICAÇÃO DO EDEMA	109
QUADRO 41 – ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL	110
QUADRO 42 – RECOMENDAÇÕES E EVIDÊNCIAS SOBRE A ULTRASSONOGRAFIA NOS DIFERENTES PERÍODOS DA GESTAÇÃO	121
QUADRO 43 – PRESCRIÇÃO DE PROFILAXIA PELO ENFERMEIRO	122
QUADRO 44 – RASTREAMENTO DE ROTINA DAS ALTERAÇÕES PRESSÓRICAS E HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GESTAÇÃO.....	124
QUADRO 45 – PLANO DE AFERIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL PELA ENFERMAGEM	124
QUADRO 46 – DIAGNÓSTICOS E CLASSIFICAÇÃO DA GESTANTE COM DM.....	126
QUADRO 47 – MONITORAMENTO CLÍNICO-LABORATORIAL NA DM	127
QUADRO 48 – TRATAMENTO NOS CASOS DE SÍFILIS EM MULHERES, MULHERES GESTANTES E SEUS PARCEIROS.....	130
QUADRO 49 – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO CONFORME CULTURA IDENTIFICADA NOS CASOS DE RASTREAMENTO DE NG E/OU CT.	131
QUADRO 50 – MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO	132
QUADRO 51 – PRÉ-NATAL DO PARCEIRO OU PARES DO MESMO GÊNERO	143
QUADRO 52 – CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PUERPERAL	144
QUADRO 53 – ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NO PUERPÉRIO ^{53, 54, 55, 56, 57, 58, 59}	146
QUADRO 54 – TRATAMENTO DA ANEMIA NO PUERPÉRIO	147
QUADRO 55 – PRINCIPAIS ITENS A SEREM OBSERVADOS NA MAMADA	148
QUADRO 56 – PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO ..	150

QUADRO 57 – CONDIÇÕES CLÍNICAS AVALIADAS NA MANUTENÇÃO OU CONTRAINDICAÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO	158
QUADRO 58 – ACOMPANHAMENTO DE NUTRIZES QUANTO À INFECÇÃO PELO HIV	159
QUADRO 59 – PASSO A PASSO PARA RETIRADA, ARMAZENAMENTO E OFERTA DO LEITE MATERNO AO BEBÊ	160
QUADRO 60 – VACINAS DE ROTINA PRECONIZADAS PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL	164
QUADRO 61 – CONTRAINDICAÇÕES À TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH)	165
QUADRO 62 – MANEJO DAS QUEIXAS MAIS COMUNS NO CLIMATÉRIO	166



ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

LISTA DE FLUXOGRAMAS

FLUXOGRAMA 1 – CORRIMENTO VAGINAL OU CERVICITES	22
FLUXOGRAMA 2 – INFECÇÃO URINÁRIA.....	30
FLUXOGRAMA 3 – CÓLICA MENSTRUAL	39
FLUXOGRAMA 4 – VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE GESTAÇÃO PARA CONTRACEPÇÃO	47
FLUXOGRAMA 5 – CONDUTAS CONFORME RESULTADO DA COLPOSCOPIA	81
FLUXOGRAMA 6 – ALTERAÇÃO NAS MAMAS	85
FLUXOGRAMA 7 – ATENDIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA GESTAÇÃO	88



ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

1 - CONSULTA DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

1.1 – AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NA CONSULTA GINECOLÓGICA

1.1.1 – Entrevista

Quadro 1 - Entrevista na Consulta Ginecológica de Enfermagem

DADOS PESSOAIS	QUEIXA PRINCIPAL
• Nome (atenção aos pronomes ou nome social pelo qual a pessoa gostaria de ser chamada) • Idade • Estado Civil • Profissão/Ocupação • Escolaridade • Cor/ Etnia • Naturalidade/ Procedência • Residência • Religião	• É o que vai definir o Raciocínio Clínico; • Podem ser utilizados termos de descrição do paciente; • Oferecer espaço de escuta; • Gerir tempo da consulta; • Utilizar o letramento como habilidade para se comunicar nas intervenções iniciais a fim de estabelecer vínculo; • Uma consulta Ginecológica nem sempre vem a ter uma queixa como motivo, muitas vezes tem a ver com orientações, aconselhamentos ou prevenção Primária; • Definição do tempo, intensidade, evolução, características, fatores que pioram ou melhoram os sintomas relatados;
HISTÓRIA ATUAL	
• Comorbidades; • Alterações nas mamas; • Alterações de fluxo vaginal (mucorreia, leucorreia, vulvovaginites, vulvites, vaginites, cervicites) • Sangramento vaginal (ciclo uterino, sinusiorragia, metrorragia, amenorreia, alterações, escapes etc.) • Lesões anal e genital (períneo — derme — canal vaginal — mucosa); • Dor (pélvica, dismenorreia, dispareunia); • Risco de Infecção Sexual Transmissível (IST); • Outras alterações ou queixas de ordem geniturinárias;	
ANTECEDENTES PESSOAIS	
• Ginecológico: Ciclo de vida (menarca, sexarca, climatério e menopausa), ciclo uterino, data da última menstruação, sexualidade e gênero, atividade sexual, método de contracepção, últimos exames de rastreamento, alterações de colo uterino ou mamas; • Obstétricos: Paridade, aborto, intercorrências obstétricas, condições de nascimento, classificação de risco; • Patológicos: História de doenças crônicas e agudas, IST, medicamentos, cirurgias, vacinação, alergias, transfusões, hábitos; • Familiares: História de câncer - mama, ginecológicos, intestino, história de problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, leiomiomas, tuberculose, asma etc.; • Hábitos: Atividade física, cuidados nutricionais, tabagismo, recreação, rotina, uso de drogas, anabolizantes, suplementos nutricionais, etilismo, uso de drogas ilícitas, alterações emocionais; • Condições Culturais e Socioeconômicas: Ocupação, condições de higiene, renda familiar, histórico de violência, condições de moradia, saneamento básico.	

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

1.1.2 – Exame Físico e Clínico das Mamas na Consulta Ginecológica

Quadro 2 - Exame Físico e Clínico das Mamas

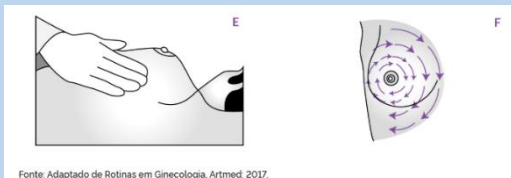
EXAME CLÍNICO DAS MAMAS	
Revisão Anatômica	
Fonte: Jarvis, 2016.	
Inspeção	
Avaliar a mulher sentada de frente para você, com as mamas descobertas;	
1. Inspeção Estática: Avaliar as mamas com relação a simetria, contorno e integridade da pele;	
Fonte: Rotinas em Ginecologia, Artmed, 2017.	
2. Inspeção Dinâmica: Pedir para paciente movimentar os braços em direção ao quadril e depois elevá-los. A seguir solicite que tracione uma mão na outra com cotovelos alinhados e para finalizar coloque os braços atrás da nuca. Verificar a presença de retrações e abaulamentos;	
Fonte: Rotinas em Ginecologia, 2017.	

Continua.

EXAME CLÍNICO DAS MAMAS

Palpação

Pode ser realizada com paciente com as mamas na nuca sentada ou deitada com os braços elevados. Realize a palpação das cadeias linfáticas, supraclaviculares e axilares. Examine cada área aplicando 03 níveis de pressão: leve, média e profunda. Realize movimentos circulares com as polpas digitais. Se for paciente mastectomizada apalpe a parede do tórax, a pele e a cicatriz cirúrgica.



Fonte: Adaptado de Rotinas em Ginecologia, Artmed, 2017.

Fonte: Rotinas em Ginecologia, 2017.

Padrão NORMAL

- **TAMANHO E SIMETRIA:** Discreta variação, mas na mesma proporção;
- **FORMA:** Redonda, oval e evertida;
- **COLORAÇÃO:** Depende da etnia da mulher; Normocorada;
- **PELE:** Íntegra, elástica, hidratada. A textura é geralmente lisa, com discreta rugosidade do mamilo e presença dos tubérculos de Montgomery. Pode ter presença de flacidez e estrias com a idade e gestação;
- **SECREÇÃO:** Nenhuma, láctea se em período gravídico puerperal;
- **TEMPERATURA:** Corporal;
- **SENSIBILIDADE:** Na palpação, a sensibilidade é discreta considerando o período do ciclo uterino que pode estar aumentada se próximo do período menstrual;
- **NÓDULOS LINFÁTICOS:** Não devem ser palpáveis (<1cm);

Padrão ANORMAL

- **TAMANHO E SIMETRIA:** Avaliar se a alteração das duas mamas é recente (pode indicar inflamação ou displasia);
- **FORMA:** Retrações ou depressões na superfície podem indicar fibrose e inclusive a suspeita de tumor;
- **PELE:** Vermelhidão, inflamação, manchas azuladas, ingurgitamento venoso aumentado, poros aumentados tipo "pele de casca de laranja", edema, nodosa, caroços, lesões, eritemas, úlceras, dermatites, dermatofitoses; A textura pode ser escamosa ou crostosa sugerindo "Doença de Paget".
- **SECREÇÃO:** Se secreção fétida, purulenta e/ou sanguinolenta, discutir com MFC a necessidade de exame de imagem para investigação;
- **TEMPERATURA:** Calor acima da temperatura corporal, associado ao Eritema pode ser um risco de inflamação.
- **SENSIBILIDADE:** Dolorosa
- **NÓDULOS LINFÁTICOS:** Supraclavicular, subclávia, intermediária, braquial escapular, mamária, mamária interna) - Nódulos linfáticos palpáveis na região citada > de 1 cm.
- **MASSAS/TUMORAÇÕES:** Avaliar o tamanho, forma, mobilidade, consistência e localização em relação aos quadrantes da mama. Geralmente tumores malignos são encontrados no quadrante superior, unilaterais e com bordas irregulares de forma infiltrativa, mal delimitados; duros, sem alteração de sensibilidade e fixos aos tecidos adjacentes. Fibroadenomas benignos medem geralmente de 1-5 cm e são redondos ou ovais, móveis, firmes, sólidos, elásticos, sem alteração de sensibilidade, únicos ou múltiplos em ambas as mamas. Doença fibrocística (Achado benigno) consiste em nódulos bilaterais, múltiplos, firmes, regulares, elásticos, móveis com bordas bem definidas. (Ver imagem a seguir).

Continua.

EXAME CLÍNICO DAS MAMAS

Palpação



Fonte: Weber, 2007.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

1.1.3 – Exame Físico e Clínico do Períneo, Anus e Genitália

Quadro 3 - Exame Físico e Clínico do Períneo, Anus e Genitália

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA		
Avaliar		
• Monte de Vênus/Pube; • Grandes e Pequenos Lábios; • Vestíbulo Vulvar;	• Meato Uretral • Glândulas de Bartholin; • Fúrcula Vaginal;	• Hímen/carúnculas; • Períneo/ Pelve; • Clítoris.
Inspeção e Palpação		
• PELE: A textura da pele é íntegra, lisa, macias sem a presença de lesões, intumescimentos, escoriações, processos inflamatórios, verrugas, vesículas úlceras ou outras feridas ou alterações; • PÊLOS PUBIANOS: Vai variar de acordo com a idade/ciclo de vida; Avaliar a presença de lêndeas, piolhos, chatos ou processos inflamatórios como foliculites; • COLORAÇÃO: Geralmente varia de acordo com a etnia, mantendo a parte interna rosada da mucosa vaginal; • SECREÇÃO: Varia conforme ciclo uterino, a textura da secreção vai de hialina a gelatinosa e leitosa em pouca quantidade e sem odor. Avaliar quando paciente traz queixa sobre odor, cor, prurido, ardência e outros sintomas associados que fogem do seu normal. • HÍMEN/ CARÚNCULAS: Quem já é ativo sexualmente com penetração, apresentará as carúnculas, que são excrescências arredondadas e de borda irregular secundária à rotura e cicatrização do hímen, após as primeiras relações sexuais. Para pessoas que não tiveram penetração, avaliar tipo de hímen, queixas e se ele oclui todo canal vaginal; • INTROITO VAGINAL: Avaliar o introito vaginal, pedir para paciente “tossir” e tracionar a pelve para frente, a fim de verificar a presença de prolapso ou outra alteração tumoral;		

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

1.1.3.1 – Exame Especular

Quadro 4 - Exame Especular

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

Exame Especular

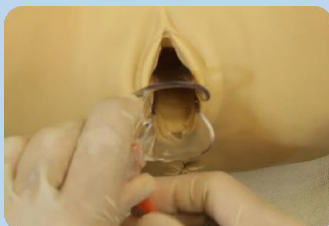
- **Procedimento:**

- Selecione o espéculo de tamanho adequado;
- Segure o espéculo na sua mão esquerda, com os dedos indicador e médio em torno das lâminas e polegar sobre o parafuso. Isso impede que as lâminas do espéculo abram de maneira dolorosa durante a inserção.
- Com seu dedo indicador direito e os dedos médios, empurre o introito vaginal para baixo para relaxar o músculo pubococcígeo;
- Insinue o espéculo de forma oblíqua, aplicando pressão para baixo, a fim de evitar na parede anterior da vagina a pressão da uretra.
- Solicite a paciente que a mulher faça força no períneo para baixo a fim de relaxar os músculos do períneo ao abrir o introito.
- Continue inserindo numa angulação de 45° graus para baixo, seguindo o declive natural vagina.
- Quando o espéculo estiver totalmente inserido, verifique se o colo está visualizado. Muitas vezes é necessário adaptar para as laterais, anteriormente ou posteriormente dependendo da anatomia de cada mulher, adaptando e buscando o colo e orientando a paciente. Observe o grau de desconforto avaliando se continua ou não.
- Após a visualização do colo uterino com o espéculo fixado, trave as lâminas do espéculo, apertando o parafuso.
- Inspeção em relação a coloração, superfície, consistência, secreção, integridade da pele, PH das secreções.

1.



2.



3.



4.



Fonte: Fiocruz.

- **Referências do Tamanho do Espéculo:**

- **Nº1 / P:** Mais utilizado e em pessoas jovens, nulíparas, vaginas hipotróficas ou pós menopausa;
- **Nº2/M:** Pessoas com história de partos vaginais ou flacidez de períneo discreta;
- **Nº 3/G:** Utilizado em mulheres obesas, onde a adiposidade da vulva prolonga o canal vaginal ou quando tem presente flacidez vaginal (cistocele e retocele), impedindo a visão completa do colo uterino.
- **Atenção:** Quanto maior o espéculo, maior o desconforto, então faça a decisão de maior conforto e cuidado com a paciente;

Continua.

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

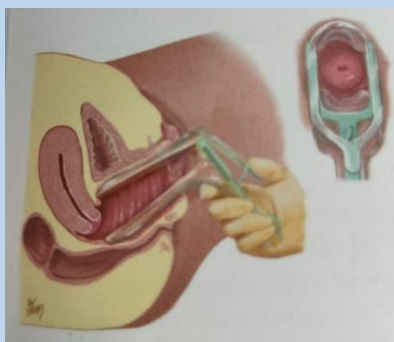
Exame Especular

• Boas Práticas:

- Não perca a oportunidade de ter um espelho a mão para que a paciente possa visualizar seu colo e sua vulva, de modo que o exame seja uma experiência de autoconhecimento para ela;
- Para algumas mulheres, a avaliação ginecológica é um momento doloroso e de constrangimento. Caso identifique resistências ou questões pós traumas psicológicos, ofereça a possibilidade dela mesma introduzir o espéculo. Pode ser uma experiência empoderadora e mais confortável, o que aumenta o vínculo e diminui a resistência ao exame.

Achados Normais:

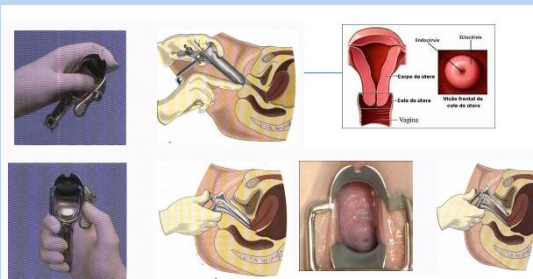
- Canal vaginal com mucosa rosada, úmidas, tecido liso, sem lesões, irritações ou alteração de secreção;
- Ph: 3,8 a 4,2;
- Colo do uterino rosado, liso por vezes com exposição da Junção escamo celular (JEC) com bordas bem regulares em região peri endocervical;
- Tom azulado em gestantes;
- Cor pálida em idosas;
- Secreção cervical é clara, sem odor de coloração clara ou levemente leitos e fluida;
- Óstio cervical puntiforme em nulíparas, e em fenda horizontal em múltiparas;



Fonte: Jarvis, 2016.

Achados Anormais:

- Canal vaginal com vermelhidão, lesões, secreções de odor fétido, microlesões, prurido, ardência, alteração de pH compatível com vulvovaginites;
- Rastreie sempre frente às alterações a possibilidade de ISTs;
- Colo assimétrico, área avermelhada, irregularidades manchas púrpuras, áreas esbranquiçadas, bordas irregulares, sangramento;
- Óstio cervical com presença de lesões e erosões.



Fonte: Jarvis, 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

1.1.3.2 – Exame de Toque Bimanual

Quadro 5 - Exame de Toque Bimanual

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

Exame de Toque Bimanual

(**NÃO** realizar como exame de rotina e, se for feito, realizar depois do exame especular.)

- **Material:**

- Luva, gel ou lubrificante;

- **Procedimento:**

- Aplique o lubrificante nos dedos médio e indicador da mão dominante enluvada;
- Em pé coloque mão não dominante sobre o abdome inferior da paciente.
- Em seguida, com cuidado, introduza o dedo médio e indicador na vagina;
- Espere um momento para que a pelve da mulher fique relaxada novamente, então exerça uma leve pressão posterior, a vagina deve se apresentar com mucosa lisa e sem sensibilidade excessiva;



Fonte: Jarvis, 2016.

- Palpe o **Colo Uterino** e identifique: contorno, consistência, mobilidade, sensibilidade;



Fonte: Jarvis, 2016.

- Para palpar o **Útero** posicione os dedos internamente na parede anterior ao colo. Aplique uma pressão mediana com a mão que repousa sobre o abdome. Aperte o útero entre as duas mãos e avalie: Tamanho, Posição, Forma e Consistência;

Continua.

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

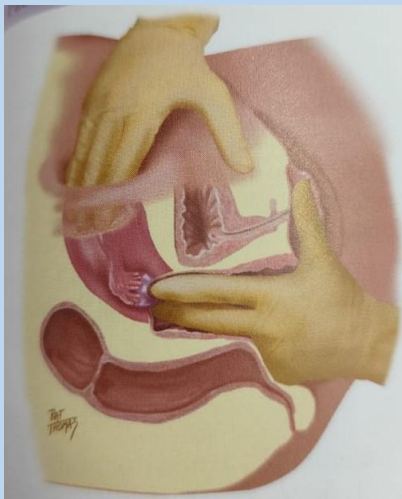
Exame de Toque Bimanual

(**NÃO** realizar como exame de rotina e, se for feito, realizar depois do exame especular.)



Fonte: Jarvis, 2016.

- A seguir palpe os **Ovários**, posicione internamente os dedos lateralmente em direção ao ovário (esquerdo e direito, um de cada vez) e coloque a mão que repousa sobre o abdome em direção aos dedos no interior da vagina e tente palpar o ovário avaliando: Forma, consistência, mobilidade e sensibilidade.



Fonte: Jarvis, 2016.

- Retire a mão dominante do interior da vagina e avalie a secreção presente na luva;

Continua.

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

Exame de Toque Bimanual

(**NÃO** realizar como exame de rotina e, se for feito, realizar depois do exame especular.)

Achados Normais:

- A parede da vagina apresenta-se lisa e sem sensibilidade excessiva;
- O colo uterino deve se apresentar firme e macio como se você sentisse a textura da ponta do nariz para NÃO grávidas e a textura da boca para possíveis gestantes;
- Os ovários medem aproximadamente 3x2x1cm (tamanho de uma noz) e tem forma amendoada. Os ovários são firmes, lisos, móveis e discretamente sensíveis à palpação. Uma quantidade mínima de secreção clara e inodora na luva é normal.

Achados Anormais:

- Sensibilidade aumentada ao toque pode indicar vulvovaginites ou outras infecções;
- Se o colo estiver com endurecimento e imobilidade pode indicar neoplasia;
- Se dor a mobilização do colo uterino (sinal do candelabro - Dor perineal a mobilização do colo uterino) pode indicar infecção (seguir conduta de [protocolo volume 02](#));
- Ao palpar o útero atenção para aumento uterino acima da pube e forma irregular com pressão dolorosa à palpação ou tumoração presente.
- Ao avaliar os ovários, atenção para tamanho aumentado, massas, imobilidade e sensibilidade extrema são anormais e devem ser investigados;
- Ao retirar os dedos, avalie a secreção presente na luva, atenção para grande quantidade de secreção com sangue, espumosa, ou fétida que pode ser sinal de vulvovaginites ou infecção;
- Atenção a ovários que são palpáveis em mulheres ou pessoas com útero que estão na menopausa a mais de 3 anos;

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

1.1.3.3 – Exame Retovaginal

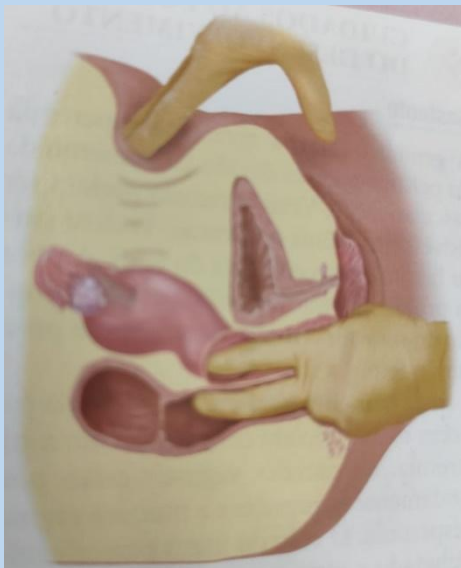
Quadro 6 - Exame de Retovaginal

EXAME FÍSICO E CLÍNICO DO PERÍNEO, ANUS E GENITÁLIA

Exame Retovaginal

- **Procedimento:**

- Esclareça à cliente que é necessário realizar o exame, sempre com consentimento dela;
- Avise antecipadamente que vai sentir um desconforto como um reflexo para evacuar, mas que isso não ocorrerá de verdade. Estimule ela a ficar o mais relaxada possível.
- Solicite que ela se curve para baixo e introduza o dedo indicador no orifício vaginal e o dedo médio no reto. Enquanto comprime para baixo a parede abdominal com a outra mão apalpe as estruturas reprodutivas internas, através da parede retal anterior. Retire o dedo que está no interior da vagina e termine o exame retal posteriormente.



Fonte: Jarvis, 2016.

Achados Normais:

- O septo retovaginal é normalmente liso, fino, móvel e firme. A parede uterina posterior é normalmente lisa, firme, redonda, móvel e não excessivamente sensível.

Achados Anormais:

- Presença de massas, tumorações, estruturas espessas, flacidez excessiva (retoccele), imobilidade, fístulas e sensibilidade dolorosa aumentada.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2 - MANEJO PARA QUEIXAS GINECOLÓGICAS MAIS FREQUENTES NA APS

2.1 - CORRIMENTO VAGINAL, VULVOVAGINITES E CERVICITES ^{1,8}

A Vagina é um ecossistema que na forma saudável vive em equilíbrio com relação a flora vaginal e sistema hormonal. O PH da vagina saudável é ácido e varia entre 3,8 e 4,5. As alterações do fluxo vaginal costumam ser o maior motivo das consultas de queixas ginecológicas na APS. O desequilíbrio da flora vaginal pode ser decorrente de Fatores intrínsecos que estão relacionados com o ciclo uterino e menstrual, alterações hormonais, comorbidade ou outras patologias. A Flora vaginal também pode se alterar por fatores extrínsecos como uso de antibióticos, métodos de contracepção hormonal, atividade sexual, traumatismos, hábitos e intolerâncias alimentares, bem como baixa imunidade e mau funcionamento do intestino.

As vulvovaginites constituem inflamações que afetam ao mesmo tempo a vagina e a vulva, alterando o fluxo vaginal e associados a outros sintomas como, ardência, coceira, microlesões, edema, odor fétido, sensibilidade e vermelhidão local. Elas são causadas por fungos e bactérias que habitam a flora vaginal, tendo maior frequência a vaginose bacteriana (bactérias anaeróbias como a *Gardnerella vaginalis*) ou candidíase (fungo *Candida Albicans* ou outras formas não *Albicans*).

Quando recorrente, verificar:

Quadro 7 – Raciocínio Clínico e Diagnósticos Diferenciais no Corrimento Vaginal, Vulvovaginites e Cervicites.

CORRIMENTO VAGINAL, VULVOVAGINITES E CERVICITES

- **Raciocínio Clínico:**

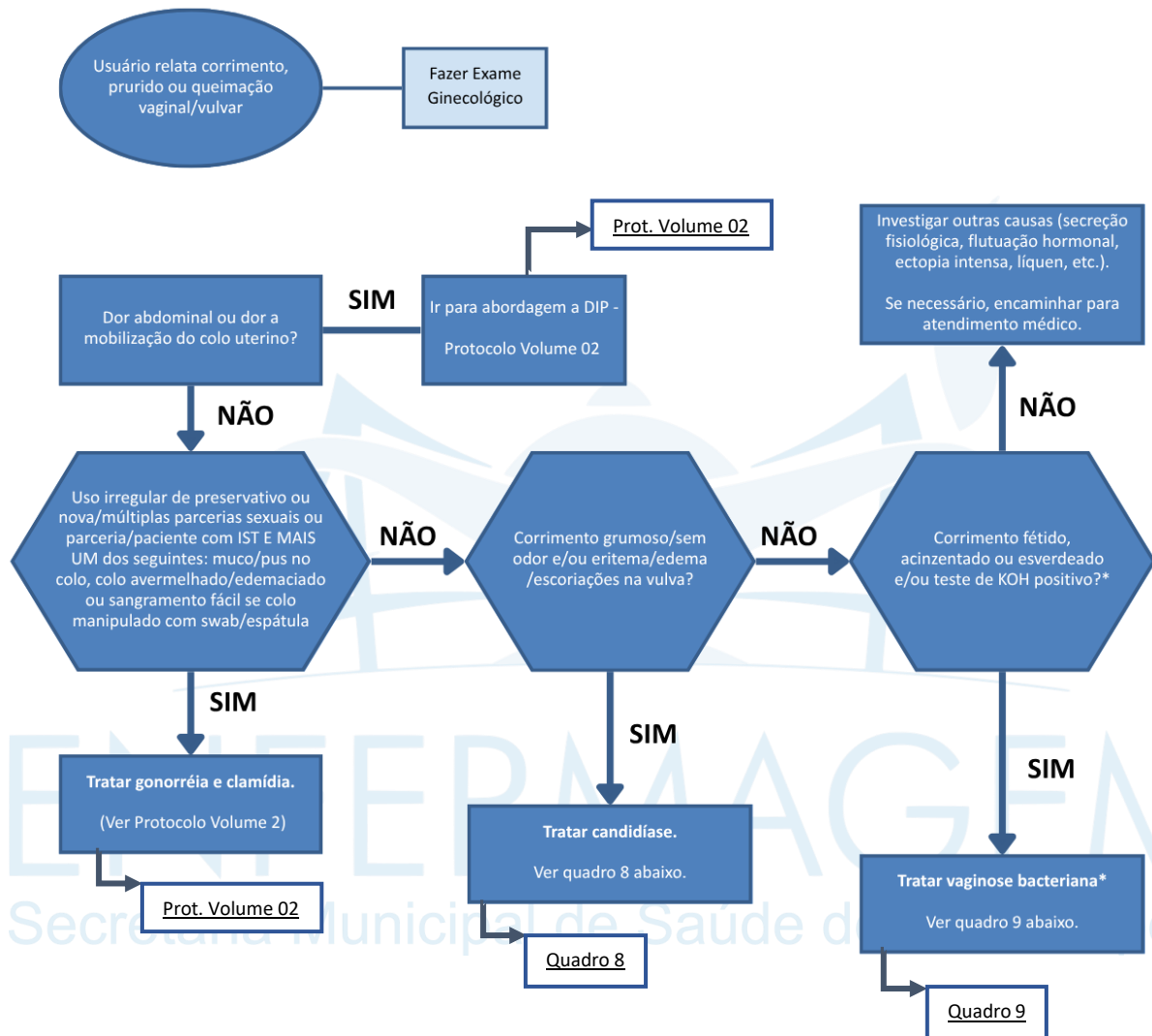
- Paciente foi devidamente avaliada e examinada?
- É fisiológica?
- É infecciosa?
- Está relacionada a uma Infecção Sexualmente Transmissível? Rastreie. (veja [Protocolo Volume 02](#))
- Está relacionada a uma Cervicite ou Doença Inflamatória Pélvica? (veja [Protocolo Volume 02](#))
- Está relacionada a uma lesão cervical? O exame de rastreamento de câncer de colo de útero está em dia? Tinha história de lesão sem seguimento ou está em seguimento?
- Está relacionada a uma patologia, tratamento ou procedimento que paciente realizou?
- Parceria sexual foi tratada ou avaliada?
- Verificar ciclo de vida da pessoa (Por ex.: Puerpério, aborto, menarca, sexarca, menopausa recentes?);

- **Possíveis Diagnósticos Diferenciais:**

- Variações cíclicas da secreção vaginal ou mucorreia, o uso de DIU e gestação também pode aumentar e alterar o fluxo vaginal fisiológico;
- Transudação Vaginal Fisiológica Exacerbada;
- Vaginite Alérgica;
- Vaginose citolítica;
- Cervicite (Clamídia / Gonorréia);
- Vaginite Inflamatória Descamativa;
- Tratamentos com medicamentos de função múltipla e não direcionados (cepas resistentes, doenças graves ocultas pela falta de avaliação devida).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Fluxograma 1 – Corrimento Vaginal ou Cervicites



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

* Se suspeita de tricomoníase (colo uterino com aspecto de morango ou framboesa; teste de KOH negativo), trate paciente e parcerias para tricomoníase (conforme capítulo 4 do [Protocolo de Enfermagem Volume 02](#)).

2.1.1 - Abordagem às Principais Causas de Corrimento Vaginal

2.1.1.1 - Candidíase

Quadro 8 – Abordagem à Candidíase.

ABORDAGEM ÀS PRINCIPAIS CAUSAS DE CORRIMENTO VAGINAL: CANDIDÍASE	
Causa Identificada	Sinais e Sintomas Principais
CANDIDÍASE	- Prurido vulvar - Hiperemia vulvar - Corrimento grumoso - Teste do KOH negativo
Implementação de Enfermagem	
Tratamento Medicamentoso¹: Miconazol creme vaginal 2% por 7 noites consecutivas (evitando relações sexuais durante o tratamento e por até 48 horas após seu término) ❖ <u>ESTE TRATAMENTO É O PRECONIZADO PARA GESTANTES;</u> OU Fluconazol² 150 mg dose única (NÃO PRESCREVER PARA GESTANTES) - Se severa, prescrever obrigatoriamente Fluconazol² 150 mg e repetindo a dose após 3 dias e após 6 dias da primeira dose; - Se recorrente (4 ou mais episódios em 12 meses), investigar DM e HIV e encaminhar a consulta médica. Parcerias de mulheres com infecção recorrente devem ser tratados(as) com Fluconazol² 150mg dose única (verificar alergia prévia). Observação: Em caso de pacientes em uso de métodos contraceptivos hormonais, recomenda-se o uso de preservativo ou outro método adicional até 07 (sete dias) após a última dose, devido à interação medicamentosa do antifúngico e aumento da taxa de falha do anticoncepcional. Esclareça à cliente que é necessário realizar o exame, sempre com consentimento dela.	
Continua.	

¹ Evitar a associação de mais de um antifúngico num mesmo tratamento.

² O Fluconazol é contraindicado em pessoas com histórico de problemas hepáticos pelo risco aumentado de toxicidade, diminui o efeito de contraceptivos hormonais orais e injetáveis combinados, verificar a interação com outros medicamentos. CONTRAINDICADO NA GESTAÇÃO. Contraindicado na gestação.

ABORDAGEM ÀS PRINCIPAIS CAUSAS DE CORRIMENTO VAGINAL: CANDIDÍASE

Implementação de Enfermagem

- **Medidas Não Farmacológicas**
 - Usar roupas íntimas de algodão e/ou dormir sem as elas a fim de promover melhor ventilação;
 - Evitar o uso de roupas apertadas ou diminuir o tempo de uso dessas;
 - Evitar uso de absorventes diários;
 - Investigar episódios de repetição.
- **Opções Alternativas**
 - **Melaleuca/TeaTree:** 1 ou 2 gotas de óleo essencial de melaleuca diluída em 100mL de água - fazer banhos de assento ou lavar delicadamente o interior da vagina com uma seringa de 20ml ou ducha vaginal com essa solução 1x ao dia por 5 dias.
 - **Camomila ou calêndula:** fazer infusão com 1 colher de sopa de extrato seco de camomila para 200ml de água. Lavar delicadamente a vagina, internamente, com seringa de 20ml ou ducha ginecológica com essa solução OU banho de assento com infusão das ervas. Faça um chá concentrado e dilua coado em bacia com água morna, permaneça sentada com a vulva totalmente imersa, por no mínimo 15 minutos. Promove alívio dos sintomas irritativos;
 - **Bicarbonato de sódio:** pode-se fazer banho de assento diluindo 1 colher de sopa de bicarbonato para cada 500ml de água.
 - **Babosa:** uso intravaginal. Descascar a Aloe Vera, garantindo que toda a casca verde e sua seiva amarelada sejam retiradas (pois são tóxicas). Cortar cubinhos de aproximadamente 2x2 cm, introduzir na vagina à noite como um supositório e retirar o excesso pela manhã, repetir por 7 dias;
 - **Óleo de coco:** alivia sintomas de coceira e ajuda a reepitelizar a região (refazer as células que foram descamadas). Passar uma colher de chá de óleo com os dedos após lavar com melaleuca ou bicarbonato;
 - É importante após cada tratamento repor os lactobacilos da vagina. Isso pode ser feito com iogurte natural por 3-5 noites. Usar uma colher de chá de qualquer iogurte natural sem sabor e sem adição de açúcar e passar por dentro da vagina com o dedo ou aplicador de pomada vaginal. Retirar o excesso no banho pela manhã. A reposição de lactobacillus do intestino pode ser feita com consumo de fermentados como kefir e kombucha.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.1.1.2 - Vaginose Bacteriana

Quadro 9 – Abordagem à Vaginose Bacteriana.

ABORDAGEM ÀS PRINCIPAIS CAUSAS DE CORRIMENTO VAGINAL: VAGINOSE BACTERIANA	
Causa Identificada	Sinais e Sintomas Principais
VAGINOSE BACTERIANA	- Corrimento com odor fétido; - Corrimento acinzentado; - Teste do KOH (teste de Whiff ou teste das aminas) positivo – adicionar duas gotas de KOH 10% à uma gota de secreção vaginal.
Implementação de Enfermagem	
Tratamento Medicamentoso: Metronidazol 500 mg VO de 12/12 horas por 7 dias ❖ <u>USO SEGURO PARA GESTANTES;</u> OU Metronidazol creme (100 mg/g) por 5 noites ❖ USO SEGURO PARA GESTANTES ❖ EM NUTRIZES, PREFERIR ESSA APRESENTAÇÃO¹ (NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA ATÉ 24 HORAS APÓS TÉRMINO DO TRATAMENTO). ¹ A excreção da droga pode conferir gosto amargo ao leite materno. A maioria dos estudos não relatou efeitos colaterais nos lactentes. No entanto, observar perda de apetite, vômitos e diarreia. Caso ocorram tais efeitos, o aleitamento deverá ser suspenso²⁴. Medidas Não Farmacológicas: - Uso de roupa íntimas de algodão e/ou dormir sem elas a fim de promover melhor ventilação; - Evitar o uso de roupas apertadas ou diminuir o tempo de uso dessas. - Observar diferenciação entre vaginose bacteriana e tricomoniase, já que a primeira não se qualifica como Infecção Sexualmente Transmissível (IST), não havendo a necessidade de convocação de parceiros; e a segunda sim, necessitando assim convocação desses. Opções Alternativas: Ácido Acético (Vinagre): Banho de assento com ácido acético (vinagre), (1-2 colheres de sopa em 1 litro de água) a fim de melhorar sintomas.	

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para as demais abordagens às queixas ginecológicas que tenham relações com outras ISTs (Tricomoniase, **Doença Inflamatória Pélvica (DIP)**, Donovanose, HPV, Herpes Genital, Sífilis, Gonorreia, entre outras), consultar [volume 02 do Protocolo de Enfermagem](#) (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

2.1.1.3 - Vaginose Citolítica

Quadro 10 – Abordagem à Vaginose Citolítica.

ABORDAGEM ÀS PRINCIPAIS CAUSAS DE CORRIMENTO VAGINAL: VAGINOSE CITOLÍTICA	
Causa Identificada	Sinais e Sintomas Principais
VAGINOSE CITOLÍTICA	- Prurido; - Queimação; - Dispareunia; - Disúria terminal; - Corrimento branco abundante que piora na fase lútea. - Facilmente confundida com a candidíase devido à similaridade dos sintomas, porém ocorre em função do aumento do número de Lactobacillus sp no trato genital inferior, cérvix e vagina, o que torna o pH local mais ácido (entre 3,5 e 4,5).
Implementação de Enfermagem	
Medidas Não Farmacológicas: - Realizar banho de assento com Bicarbonato de Sódio (por 5 a 10 minutos) com solução composta por 4 xícaras água morna para 1 a 2 colheres de sopa de Bicarbonato de Sódio, 2 vezes por semana, a cada 2 semanas ou até melhora dos sintomas. - Suspender produtos de uso vaginal com perfume, corante ou fórmulas químicas de potencial irritação; - Usar calcinhas de algodão, secar em lugares arejados e evitar roupas apertadas; - Evitar pelo período dos sintomas alimentos ricos em lactobacilos; - Solicitar avaliação médica com MFC senão melhora do quadro.	

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.1.2 - Hipersensibilidade ao Plasma Seminal

Quadro 11 – Abordagem à Hipersensibilidade ao Plasma Seminal.

ABORDAGEM ÀS PRINCIPAIS CAUSAS DE CORRIMENTO VAGINAL: HIPERSENSIBILIDADE AO PLASMA SEMINAL	
Causa Identificada	Sinais e Sintomas Principais
HIPERSENSIBILIDADE AO PLASMA SEMINAL	- Surgem no local que esteve em contato direto com o sêmen, costumeiramente aparecem entre 10 e 30 minutos após a relação e duram por horas ou dias, apresentando: - Hiperemia na pele ou mucosa - Sensação intensa de coceira e/ou prurido - Edema na região
Implementação de Enfermagem	
Medidas Não Farmacológicas: - Caso haja suspeita de alergia/hipersensibilidade ao plasma seminal do parceiro, orientar a utilização de preservativos ou evitar a ejaculação no interior da vagina. - Encaminhar para avaliação com MFC;	

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.1.3 - Cisto ou Abscesso de Bartholin - Bartholinite

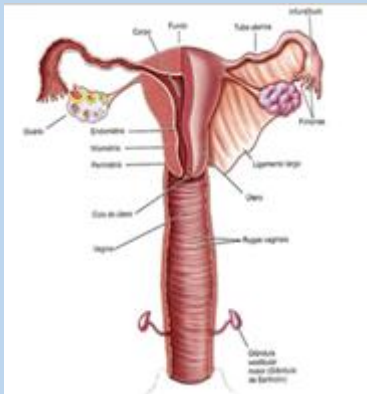
Quadro 12 – Abordagem ao Cisto ou Abscesso de Bartholin - Bartholinite.

ABORDAGEM AO CISTO OU ABSCESSO DE BARTHOLIN - BARTHOLINITE

Revisão Anatômica

GLÂNDULA DE BARTHOLIN

- A principal função das glândulas de Bartholin é a produção de um fluido mucoso que lubrifica a vulva e a entrada da vagina, especialmente durante a excitação sexual. Esse fluido ajuda com:
 - Lubrificação:** Facilita a relação sexual, reduzindo o atrito e o desconforto.
 - Umidade:** Mantém a área vulvar úmida, o que é importante para o conforto e a saúde da região.
 - Proteção:** O muco também ajuda a proteger a mucosa vaginal contra irritações e infecções.
- As glândulas de Bartholin são pequenas e localizadas na base dos grandes lábios, uma de cada lado da abertura vaginal. Normalmente, não são visíveis nem palpáveis.



Cisto do Ducto de Bartholin	Bartolinite
 Figura 1: Cisto do ducto da glândula de Bartholin do lado direito. Fotografia retirada do livro "Ginecologia de Williams - 2a Ed", página 123.	 Figura 2: Abscesso da glândula de Bartholin do lado direito. Fotografia retirada do livro "Ginecologia de Williams - 2a Ed", página 106.
→ Início insidioso → Geralmente unilateral → Pode ser assintomático ou gerar dor leve ou moderada ao andar, sentar ou <u>dispareunia</u> → Drenagem de secreção mucosa hialina	→ Instalação rápida → Geralmente unilateral → Massa dolorosa (dor intensa) → Presença de sinais <u>flogísticos</u> → Drenagem de secreção purulenta → Febre em apenas 1/5 dos casos

Fonte: Ginecologia de Williams, 2014.

Continua.

ABORDAGEM AO CISTO OU ABSCESSO DE BARTHOLIN - BARTHOLINITE

Definição

BARTHOLINITE

- É a inflamação da glândula de Bartholin, localizada na vulva, que causa dor, inchaço e vermelhidão na região. O tratamento varia de acordo com a gravidade da inflamação, podendo incluir cuidados locais e sistêmicos bem como drenagem de acordo com a evolução do abscesso e dos sintomas.

Implementação de Enfermagem

• Encaminhar avaliação com MFC para:

- Avaliação e conduta médica;
- Prescrição de antibioticoterapia;
- Verificar a necessidade de drenagem;
- Encaminhamento para avaliação ginecológica.

• Tratamento Medicamentoso:

- Dipirona Via Oral - 500mg a 1g - de 06/06 horas

❖ **NÃO PRESCREVER PARA GESTANTES E NUTRIZES**

- Paracetamol Via Oral - 500mg a 1g - de 06/06 horas

❖ USO SEGURO EM GESTANTES E NUTRIZES

• SE DOR POR 3 a 5 DIAS

- Ibuprofeno Via Oral - 300mg a 600 mg - de 08/08 horas
Ou

- Nimesulida 100 mg de 12/12 horas

❖ **NÃO prescrever se usuária com problemas gástricos, problemas de coagulação sanguínea, doença renal ou alergia a antiinflamatórios não esteróides – AINES).**

❖ NÃO PRESCREVER PARA GESTANTES E NUTRIZES

• Tratamento Não Farmacológico:

- **Higiene:** Lavar a área afetada com água morna e sabão neutro, evitando duchas vaginais ou produtos irritantes. Secar com toalha macia, evitar papel higiênico ou lenço umedecido. Evitar usar calcinha durante o período álgico do abscesso.
- **Compressas:** Aplicar compressas mornas na região por 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, para aliviar a dor e o inchaço.
- **Banho de assento:** Fazer banhos de assento com água morna por 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes ao dia, para aliviar o desconforto
 - O banho de acento pode ser realizado com infusão de ervas medicinais como: Barbatimão, lavanda, camomila, malva, tansagem, calêndula e hamamélis
 - Utilizar 2 colheres de sopa para 1 litro de água quente, a infusão deve ser reservada por 10 minutos antes de realizar o banho de assento.

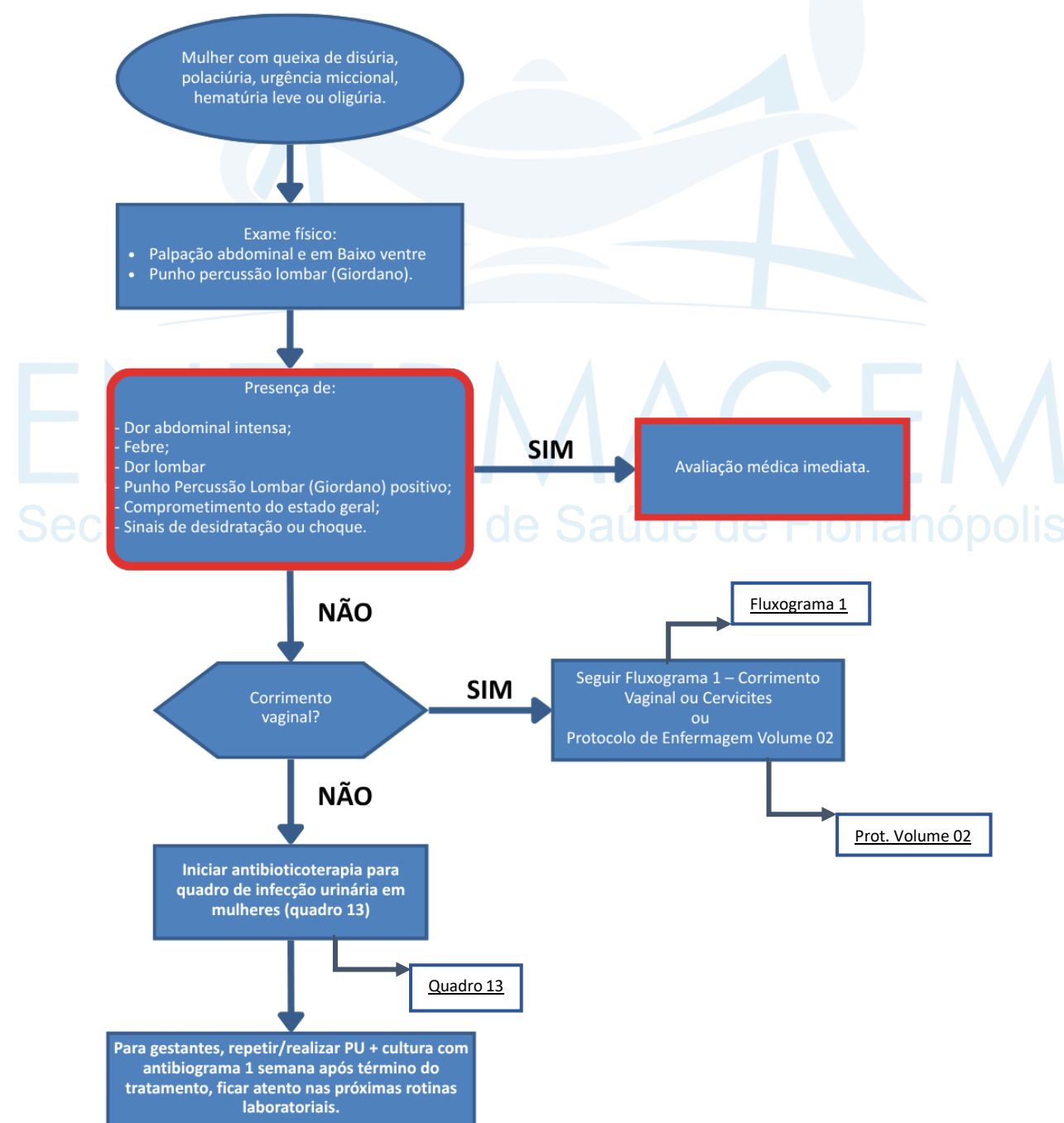
Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.2 – INFECÇÃO URINÁRIA ^{1, 11, 12}

As infecções urinárias em mulheres constituem uma das causas mais presentes em consultas, sejam médicas ou de enfermagem, junto às unidades de saúde, sendo a abordagem precoce e a intervenção adequada um fator preponderante para se evitar complicações ou mesmo internações desnecessárias. O quadro principal de manifestação clínica é a disúria, acompanhada de polaciúria, oligúria e urgência urinária.

2.2.1 – Manejo da Infecção Urinária

Fluxograma 2 – Infecção Urinária



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

QUADRO 13 – TRATAMENTO DA DIFICULDADE URINÁRIA EM MULHERES ^{1,12}

TRATAMENTO DA DIFICULDADE URINÁRIA EM MULHERES
Implementação de Enfermagem - Não Gestantes
• Para Não Gestantes: • Nitrofurantoína Via Oral ▪ 1 comprimido de 100mg de 6/6 horas por 5 a 7 dias; Ou ▪ 20ml da solução de 5mg/ml de 6/6 horas por 5 a 7 dias; ❖ NÃO PRESCREVER PARA MULHERES AMAMENTANDO FILHOS MENORES DE 30 DIAS, COM HIPERBILIRRUBINEMIA(ICTERÍCIA) E/OU DEFICIÊNCIA DE G6PD (IDENTIFICADA NO TESTE DO PEZINHO) • Sulfametoxazol + Trimetropina Via Oral ▪ 2 comprimidos de 400mg+80mg de 12/12 horas por 3 dias; Ou ▪ 20ml da solução de 40mg+8mg/ml de 12/12 horas por 3 dias; ❖ NÃO PRESCREVER PARA MULHERES AMAMENTANDO • Cefalexina Via Oral: (SOMENTE USAR ESSA OPÇÃO PARA NÃO GESTANTES E EM CASO DE FALTA DAS OPÇÕES ACIMA) ▪ 1 comprimido de 500mg de 6/6 horas por 7 dias; ▪ Ou ▪ 10ml da solução de 50mg/ml de 6/6 horas por 7 dias; ❖ <u>USO SEGURO PARA MULHERES AMAMENTANDO;</u> • Analgesia: • Dipirona Via Oral ▪ 500mg a 1g de 06/06 horas ❖ NÃO PRESCREVER PARA GESTANTES E NUTRIZES. • Paracetamol Via Oral ▪ 500mg a 1g de 06/06 horas; ❖ <u>USO SEGURO EM GESTANTES E NUTRIZES;</u>
Continua.

TRATAMENTO DA DIFICULDADE URINÁRIA EM MULHERES

Implementação de Enfermagem – Não Gestantes

- **Tratamento Não Farmacológico:**

- Aumentar ingesta hídrica;
- Orientar sinais de agravamento do quadro clínico (febre, dor lombar, dor abdominal) e retornar à unidade ou procurar serviço de urgência
- Não há necessidade de solicitação de exames laboratoriais (PU e Urocultura). Caso sintomas permaneçam após o tratamento inicial, discutir/encaminhar para consulta médica para solicitação destes exames

Tratamento Medicamentoso Para Gestante Antibioticoterapia

- O enfermeiro **PODERÁ PRESCREVER** o tratamento medicamentoso **APENAS**:

- Na 1ª evidência laboratorial de ITU (urocultura positiva acompanhada de antibiograma);
- No 1º quadro sintomático de ITU baixa (cistite);

- **Opções de Tratamento:**

- **1ª opção - 1 comprimido de cefalexina 500mg** de 6/6 horas por 7 dias;
Ou
- **2ª opção - 1 comprimido de Amoxicilina/ácido clavulânico 500mg+125mg** de 12/12 horas por 7 dias;
Ou
- **3ª opção - 1 comprimido de Nitrofurantoína 100 mg** de 6/6 horas por 10 dias.

❖ NÃO PRESCREVER APÓS 36ª SEMANA DE GESTAÇÃO;

❖ SE PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS APÓS TRATAMENTO COMPLETO EM QUALQUER DAS OPÇÕES ADOTADAS, É NECESSÁRIO AVALIAÇÃO MÉDICA.

- **Opções de Analgésicos:**

- **Paracetamol Via Oral**

- **500mg a 1g** de 06/06 horas;

❖ USO SEGURO EM GESTANTES E NUTRIZES;

Continua.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

TRATAMENTO DA DIFICULDADE URINÁRIA EM MULHERES

Implementação de Enfermagem na Gestante

- Repetir/realizar PU + cultura com antibiograma de 2-7 dias após tratamento - discutir caso com MFC para interpretação do caso e seguimento com urocultura;
- Orientar sinais de agravamento do quadro clínico (febre, dor lombar, dor abdominal, contrações) e retornar à unidade ou procurar serviço de urgência;
- Vincular a gestante às consultas e exames pré-natais;
- Recomendar aumento de ingesta hídrica;
- Orientar higiene íntima adequada;
- Recomendar que a gestante realize esvaziamento vesical regular e urinar antes e após as relações sexuais;
- **ITU DE REPETIÇÃO** (Dois ou mais episódios de ITU na gestação)
 - Considerar história de 2-3 ITUs, antes de engravidar no último ano;
 - Atenção a fatores predisponentes como por exemplo: imunossupressão, diabetes, alterações renais;
 - **Discutir com MFC** a possibilidade de profilaxia e controle com urocultura até o final da gestação;

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

2.3 – MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA

A **dor pélvica** é uma queixa comum na saúde da mulher, podendo ser **aguda** (duração < 3 meses) ou **crônica** (≥ 6 meses). A enfermagem desempenha um papel fundamental na **identificação, avaliação e manejo** dessas condições, aplicando o Processo de Enfermagem para um cuidado centrado na paciente.

Quadro 14 – Manejo de Enfermagem na Dor Pélvica Aguda, Crônica e Cíclica

MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA	
Avaliação	Diagnósticos de Enfermagem
• Entrevista Detalhada: • Características da dor: ○ Início, duração, localização, intensidade (usar escalas como EVA), tipo (cólica, pontada, queimação), irradiação, fatores de melhora/piora. • Sintomas associados: ○ Febre, sangramentos, corrimentos, alterações urinárias/intestinais, dispareunia, náuseas, vômitos. • Histórico: ○ Menstrual, obstétrico, sexual, cirurgias prévias, infecções. • Fatores psicossociais: ○ Estresse, histórico de violência, conflitos. • Exame Físico: • Palpação abdominal • Toque vaginal bimanual (se pertinente e consentido) para avaliar dor à mobilização do colo uterino e anexos • Presença de massas. • Considerar sinais de alerta: • Febre alta, irritação peritoneal, comprometimento do estado geral, dor intensa e súbita.	• Dor Aguda/Crônica. • Risco de Infecção. • Conhecimento Deficiente. • Padrão Sexual Ineficaz. • Ansiedade.
DOR PÉLVICA CÍCLICA	
• Está relacionada ao Ciclo uterino / Menstrual • Geralmente paciente refere dor lateralizada em baixo ventre no período de ovulação; • IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM • Orientar sobre o ciclo uterino; • Recomendar o uso de mapa menstrual ou de percepção de fertilidade; • Tranquilizar e Acolher orientando que é uma condição fisiológica específica; • Avaliar paciente, diferenciando a dor de patologias, DIP, vulvovaginites, ISTs. Para tal, realize um exame clínico ginecológico e exames de teste rápido se forem necessários, bem como os de rastreamento; • Afastar a possibilidade de gestação (realizar teste rápido de gravidez) ou outra intercorrência ou sintoma.	
Continua.	

MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA

DOR PÉLVICA CÍCLICA

• TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

- Dipirona: **1 comprimido de 500 mg** 6/6hs por até 3 dias;
- Paracetamol: **1 comprimido de 500mg** 6/6hs por até 3 dias;
- Hioscina: **1 comprimido de 10 mg** 8/8hs por até 3 dias;
- Em caso de não melhora do quadro ou surgimento de outras sintomas, encaminhar e discutir conduta com MFC ou Ginecologia SMS para verificar a necessidade de exame de Imagem e demais condutas;

DOR NO PERÍODO MENSTRUAL (CÓLICA MENSTRUAL)

• DEFINIÇÃO

- Dor pélvica cíclica associada à menstruação que atinge entre 50% e 90% das mulheres em idade fértil, com impacto importante na qualidade de vida e produtividade. Pode ser primária (sem causa orgânica identificável) ou secundária (relacionada a patologias como endometriose, mioma etc.).

• CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Dor tipo cólica, iniciada antes ou no início do fluxo menstrual, podendo irradiar para lombar e coxas. Pode acompanhar náusea, cefaleia, diarreia, fadiga e irritabilidade.

• AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM

- Acolhimento qualificado, escuta ativa, avaliação do ciclo uterino, padrão da dor, sinais de alarme e impacto funcional. Fundamenta o cuidado individualizado e o encaminhamento oportuno

• IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM

- Enfatizar que dor menstrual não deve ser naturalizada.
- A enfermagem tem papel fundamental na promoção do autocuidado, escuta ativa e orientação segura.
- Enfrentar o tabu da dor menstrual como parte da prática ética e política da enfermagem.
- Valorizar o relato da mulher e assegurar seus direitos sexuais e reprodutivos.
- **Medidas Não Farmacológicas**
 - Termoterapia (bolsa de água quente), atividade física, técnicas de relaxamento, fitoterapia, aromaterapia, massagem, auriculoterapia, yoga e acupuntura.
 - Educação em saúde para autonomia corporal;
 - Fitoterapia
 - 01 folha de mil ramas, 05 folhas de melissa e 05 folhas de alfavaca anisada - abafar em água quente por 10 min - Tomar até 5 vezes ao dia
 - ❖ Avaliar se fica muito sonolenta com Melissa e evitar atividades que exijam atenção como dirigir.
 - ❖ **NÃO PRESCREVER PARA GESTANTES E NUTRIZES.**

Continua.

MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA

DOR NO PERÍODO MENSTRUAL (CÓLICA MENSTRUAL)

- **Tratamento Medicamentoso:**
 - **Dipirona Via Oral - 500mg a 1g** - de 06/06 horas
 - **Paracetamol Via Oral - 500mg a 1g** - de 06/06 horas
 - **Hioscina Via Oral - 10mg** - de 08/08 horas por até 5 dias
 - **Ibuprofeno 300-600mg Via Oral de 8/8 hs** iniciados 1-2 dias antes da menstruação até 5 dias.
Ou
 - **Nimesulida 100 mg Via Oral 12/12 hs** se dor por 3 a 5 dias.
 - ❖ **ATENÇÃO: NÃO PRESCREVER** Se usuária com problemas gástricos, problemas de coagulação sanguínea, doença renal ou alergia a anti-inflamatórios não esteroides – AINES.
- **Casos refratários:**
- Avalie o caso e sugira contraceptivos hormonais combinados ou isolados adequando a clínica centrada na pessoa.
 - (verifique os critérios de elegibilidade).

DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**
- Dor hipogástrica, dor à palpação anexial e mobilização cervical.
- **AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM**
- Avaliar febre ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), secreção vaginal anormal, leucocitose.
- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**
- Realizar avaliação subjetiva e objetiva (exame clínico ginecológico - exame especular e toque bimanual);
- Orientar quanto a adesão ao tratamento e abstinência sexual por pelo menos 7 dias e até final do tratamento e desaparecimento dos sintomas;
- Realizar educação sexual para prevenção, notificação e tratamento de parceiros.
- Encaminhar ao médico(a) MFC para avaliação e conduta ambulatorial com antibioticoterapia se quadro sugestivo de DIP*;
- Aconselhar sexo seguro/prevenção combinada: fornecer preservativo/gel lubrificante
- Orientar teste regular de ISTs e o que é e onde buscar PEP/PrEP.
- Fornecer autotestes de HIV para paciente e parcerias se disponível.
- Realizar testes rápidos de HIV, sífilis (se tem história prévia de sífilis, solicite teste não treponêmico, ao invés de realizar teste rápido), hepatite C e B (se tem anti-HBs ≥ 10 , considere imune, não precisa testar/vacinar).

Continua.

MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA

CISTO OVARIANO (TORÇÃO/RUPTURA)

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Dor abdominal aguda, intensa, com irritação peritoneal. Atentar para sinais de alerta.

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

- Encaminhar para avaliação com médica(o) - MFC;
- Identificar sinais de urgência e encaminhar imediatamente para serviço de emergência.
- Auxiliar na estabilização se possível.

ENDOMETRITE PÓS-PARTO/ABORTO

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Sangramento/corrimento fétido, comprometimento do estado geral (febre).

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

- Acolhimento e escuta qualificada;
- Avaliar paciente e riscos;
- Encaminhar para avaliação médica (MFC);
- Encaminhar para hospital de referência (provável internação para antibioticoterapia).

INFECÇÃO/LITÍASE URINÁRIA

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Disúria, polaciúria, hematúria, dor lombar.

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

- Avaliar paciente e se for ITU não complicada realizar tratamento conforme capítulo deste protocolo;
- Realizar avaliação objetiva /exame físico, giordano, investigar vulvovaginites associadas;
- Solicitar compartilhamento de consulta com médica(o) na suspeita de Litíase urinária ou ITU complicada.

ENDOMETRIOSE

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Dor cíclica intensa (piora no período perimenstrual), infertilidade, dispareunia, alterações intestinais/urinárias cíclicas.

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

- Acolhimento e escuta qualificada.
- Avaliar paciente em exame clínico ginecológico;
- Verificar história e uso de medicamentos;
- Encaminhar para atendimento médico ou dependendo do quadro para UPA / hospital para investigação e tratamento especializado e exames de imagem.

Continua.

MANEJO DE ENFERMAGEM NA DOR PÉLVICA AGUDA, CRÔNICA E CÍCLICA

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Ritmo intestinal irregular, fezes ressecadas.

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

- Orientar dieta rica em fibras e aumento da ingestão de líquidos.
- Estimular bons hábitos;
- Prescrever o uso de óleo mineral - tomar de 1-3 colheres de sopa ao dia se necessário;
- Recomendar uso de probióticos;
- Estimular o uso de práticas integrativas (aromaterapia, acupuntura, massagem, auriculoterapia, yoga)
- Avaliar risco de hemorroidas ou dor ao evacuar;
- Afastar possibilidade de intolerância alimentar;
- Encaminhar para psicologia ou nutrição se necessário;
- Evitar uso de laxantes;
- Solicitar compartilhamento com consulta médica se verificar algum tipo de obstrução intestinal de acordo com a avaliação subjetiva e objetiva;
- Incentivar atividade física regular.

VIOLÊNCIA / FATORES PSICOSSOCIAIS

- **CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS**

- Histórico de abuso, relações conflituosas, sofrimento psíquico, dor sem causa orgânica aparente.

- **IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM**

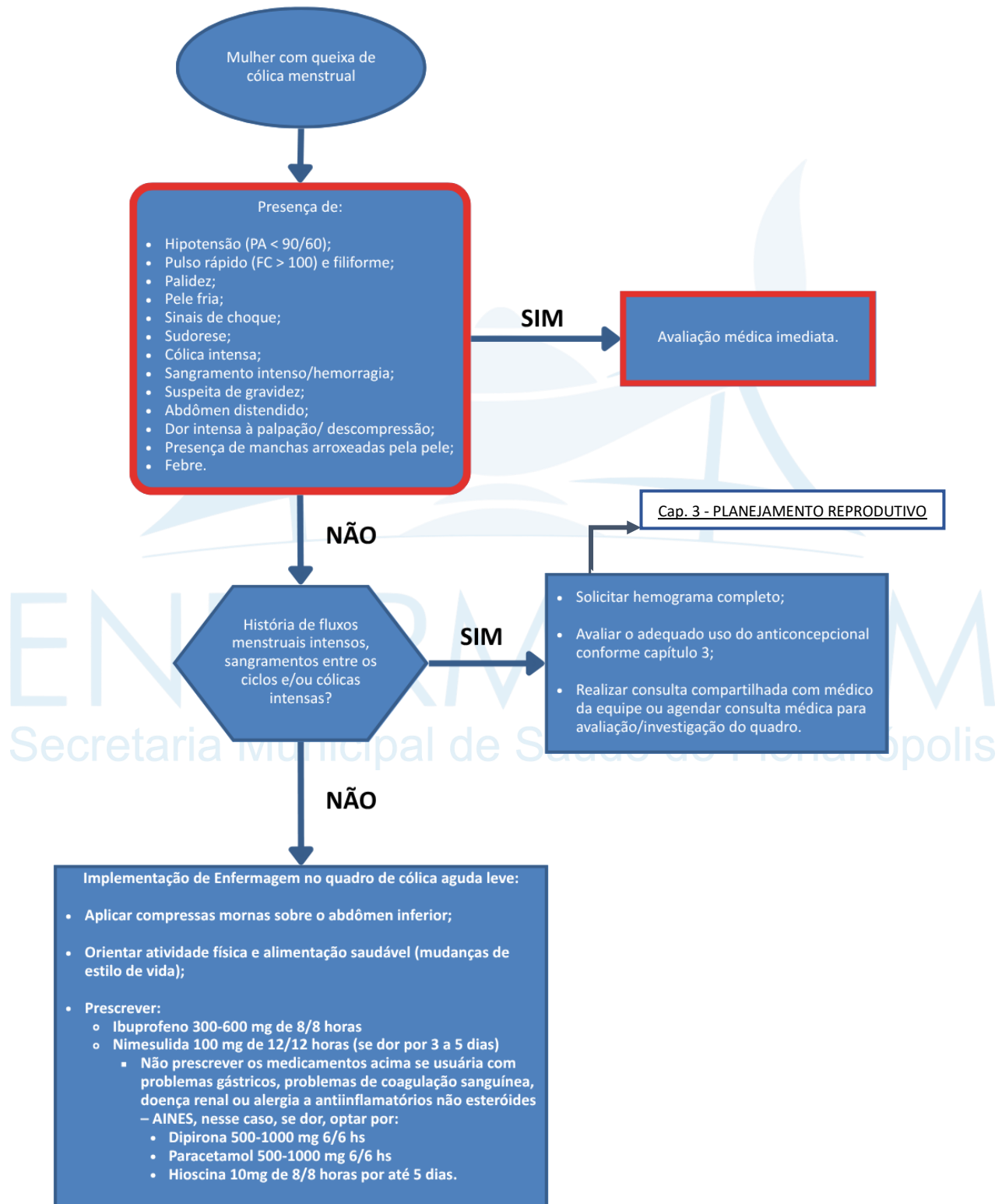
- Acolhimento, escuta qualificada e ambiente seguro.
- De acordo com gravidade da situação paciente pode ser encaminhada para Espaço Acolher ou HU (para violência sexual até 72 horas);
- Notificação compulsória.
- Articulação com a rede de apoio psicossocial (psicologia, serviço social).
- Estimular atividade física/lazer.
- Orientar sobre psicoterapia e práticas integrativas/complementares.

OUTROS

Qualquer outra suspeita clínica que indique alteração e dor abdominal discutir e encaminhar com médica (o) o atendimento.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Fluxograma 3 – Cólica Menstrual



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.4 – DISPAREUNIA E VAGINISMO

Quadro 15 – Dispareunia e Vaginismo

DISPAREUNIA E VAGINISMO
• DEFINIÇÃO • A dispareunia é um sintoma bastante comum e desafiador do ponto de vista clínico, já que o profissional de saúde se depara com inúmeras possibilidades de etiologias, sendo o histórico de enfermagem (anamnese e o exame físico) a principal ferramenta de elucidação diagnóstica. • CAUSAS POTENCIAIS • Questões fisiológicas como menopausa, diminuição de estrogênio, posição no ato sexual e outras patologias, dentre as quais situações infecciosas potencialmente graves, como a Doença Inflamatória Pélvica, são algumas das tantas possibilidades diagnósticas possíveis. • IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM • Orientar o uso de lubrificantes íntimos à base de água diante de queixas de lubrificação insuficiente; • Considerar a estrogenização local caso os lubrificantes se mostrem pouco eficazes no caso de mulheres climatéricas ou menopausadas, conforme a seguinte conduta: ○ Estriol 1 mg/g em creme vaginal, aplicar 0,5 g/dia por via vaginal durante 21 dias consecutivos, seguido de uma pausa de 7 dias. Repetir o ciclo, se necessário, por até 3 meses (tempo máximo de tratamento). ○ A aplicação deve ser realizada com o aplicador próprio da medicação. ○ Na persistência dos sintomas, encaminhar para avaliação médica. ○ NÃO PRESCREVER SE: ▪ Mulher com história de cânceres dependentes de estrogênio (mama, ovários, endométrio), distúrbio da circulação/coagulação, porfiria, distúrbios hepáticos ou sangramento uterino anormal. • A queixa de dispareunia deve ser sempre valorizada, pois além de causas clínicas presentes e objetivamente identificáveis, pode ser indicativa de outras situações a qual a mulher pode estar exposta, mas de difícil identificação imediata, como as de cunho psicossocial: história de violência sexual e doméstica, traumas, insatisfação sexual, dentre outras.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

2.5 – INCONTINÊNCIA URINÁRIA ^{25, 26, 27, 28, 29}

A incontinência urinária (IU) é uma disfunção do assoalho pélvico, definida pela queixa ou observação da perda involuntária de urina. Trata-se de uma disfunção miccional prevalente em mulheres relacionada a anatomia da pelve, gestações, partos e diminuição de estrogênio após menopausa. Outras causas estão relacionadas a fatores de risco como ansiedade, depressão e constipação intestinal funcional.

Na consulta de enfermagem com comunicação clínica centrada na pessoa é comum identificarmos a IU secundária a outras demandas como: prolapso de órgão pélvico (POP), atendimento a pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, na coleta de preventivo, fases do ciclo de vida (pós menopausa, puerpério), dermatite por incontinência, disfunção sexual, constipação intestinal, isolamento social, entre outras.

O papel do enfermeiro é identificar a classificação da IU, possíveis causas e fatores de risco, fornecer informação sobre as possibilidades de manejo e tratamentos (conservador, farmacológico e cirúrgico), conscientizar que algumas causas de IU são reversíveis e que apesar de prevalente não é uma condição normal de saúde. Nesse protocolo abordaremos o tratamento conservador dos tipos de IU mais prevalentes: de urgência, de esforço e mista.

Quadro 16 – Classificação da Incontinência Urinária

CLASSIFICAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Incontinência Urinária De Esforço
Ocorre quando a pessoa tosse, espirra, levanta peso, levanta de lugares como cadeiras e cama. Isso acontece devido ao aumento da pressão do abdome que exige mais do músculo do assoalho pélvico. Está relacionada à musculatura do assoalho pélvico, que pode estar fraco, tenso ou lento.
Incontinência Urinária De Urgência
Ocorre a perda de urina logo após uma vontade forte e repentina de urinar. Normalmente a pessoa não consegue chegar até o banheiro, e por vezes acaba urinando na roupa. A pessoa com este tipo de incontinência tende a ir várias vezes ou até mesmo acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Está relacionada a bexiga, que pode estar sensível ou muito ativa.
Incontinência Urinária Mista
Ocorre perda de urina quando a pessoa realiza algum esforço, como também pode ser um desejo súbito de urinar.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Na avaliação de enfermagem, é importante identificar fatores de risco como história obstétrica de cirurgias pélvicas, menopausa, doenças em tratamento ou medicamentos de uso contínuo, história de infecção urinária, dor pélvica crônica, constipação ou incontinência fecal, disfunção sexual (falta de desejo sexual, diminuição da lubrificação vaginal, dor na penetração).

2.5.1 – Avaliação e Manejo da Incontinência Urinária

Quadro 17 – Avaliação e Manejo da Incontinência Urinária na Consulta de Enfermagem

AVALIAÇÃO DA VULVA, PERÍNEO E ASSOALHO PÉLVICO INCONTINÊNCIA URINÁRIA	
Consultar <u>Quadro 3</u>	
O que Avaliar	Como Avaliar
Inspeção estática - presença de lesão perineal e/ou episiotomia, elasticidade e umidade da mucosa vaginal	Afastar pequenos lábios, observar presença de cicatrizes, de dermatite associada à incontinência, secreção vaginal e de prolapso em repouso.
Inspeção dinâmica - observar a estabilidade ou instabilidade do introito vaginal e projeção de órgão pelo canal vaginal (prolapsos) Se identificado prolapsos de órgão pélvico, realizar avaliação conjunta com médico.	Orientar a simulação de força de evacuação, e em seguida a contração de assoalho pélvico (relaxar o corpo, focar a região anal e puxar para dentro como se precisasse segurar gases). Prolapso de órgão pélvico - Identificar o grau (I, II, III e IV) e localização (anterior, cúpula e posterior).
Palpação - Perceber se há rigidez muscular ao toque, força muscular, tensão e ou hiperatividade puborretal.	Realizar toque vaginal bimanual. Reorientar a contração de assoalho pélvico sem contração de músculos do abdômen, glúteos e coxas e sem pausar o movimento respiratório. Observar a capacidade de sustentação em 10 segundos, capacidade de relaxamento. Avaliar propriocepção (percepção da musculatura correta a ser trabalhada).
IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM - INCONTINÊNCIA URINÁRIA	
Atividade Psicomotora Prejudicada: - Relaxar o corpo, respirar profundamente, focar na região anal e puxar o ânus para dentro (contrair e puxar para dentro) como se precisasse segurar o escape de gases. - Não contrair os músculos abdominais, os glúteos e as coxas durante o movimento, nem prender a respiração durante a contração. Força da Musculatura Pélvica Alterada: - Realizar Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico (TMAP)*. Contrair os músculos do assoalho pélvico como que simulando a interrupção do fluxo urinário por 8 a 10 segundos, seguido de relaxamento completo do assoalho pélvico. Realizar séries de 10, três a cinco vezes ao dia. - É importante ressaltar que o fluxo urinário real nunca deve ser interrompido como forma de exercício, pois essa ação pode levar à cessação da contração detrusora com consequente resíduo pós-miccional elevado.	
Continua.	

IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM - INCONTINÊNCIA URINÁRIA

• Espasticidade Perineal:

- Realizar a massagem intravaginal durante o banho, na posição agachada ou em pé com um dos pés apoiados em um banco ou apoio, ou deitada na cama; tocar com o polegar direito à parede lateral esquerda do canal vaginal, sentir os pontos de rigidez e massagear em movimentos circulares ou lineares até sentir relaxamento do ponto de tensão; repetir o movimento com o polegar esquerdo e parede vaginal direita;
- Realizar banho de assento com água morna, por 15 a 20 minutos, uma a três vezes ao dia; se houver dor associada, pode-se optar por fazer o banho com chá de camomila;
- Aplicar calor seco com bolsa de água quente, bolsa de gel ou sementes. Sentar-se sobre a bolsa de escolha por 20 a 30 minutos, de uma a três vezes ao dia;
- Executar exercícios de contração dos músculos do assoalho pélvico, de forma rápida e forte e com posterior relaxamento completo, com foco no relaxamento. Repetir séries de 10, três vezes ao dia.

• Modificações de Estilo de Vida para IU de Esforço:

- Aumentar a ingestão hídrica e de outros líquidos durante o dia.
- Incluir alimentos ricos em fibras na dieta.
- Reduzir peso corporal (para os casos de sobrepeso e obesidade);
- Sentar-se adequadamente no vaso sanitário, evitando deixar a musculatura tensa;
- Aguardar o esvaziamento completo da bexiga quando for urinar;
- Relaxar o corpo e mente com atividades físicas de baixo impacto, lazer ou meditação.

• Modificações de Estilo de Vida para IU de Urgência:

- Aumentar a ingestão hídrica e de outros líquidos durante o dia.
- Incluir alimentos ricos em fibras na dieta.
- Evitar alimentos e bebidas que são irritantes para a bexiga, como: refrigerantes, café, chá mate, chá preto e alimentos apimentados.
- Reduzir o consumo/quantidade de bebidas alcoólicas.
- Relaxar corpo e mente com atividades físicas de baixo impacto ou meditação.
- Aguardar o esvaziamento completo da bexiga quando for urinar.
- Interromper a ingestão de líquidos 2 horas antes de dormir.
- Criar um planejamento de frequência urinária (normalmente a frequência é de 4-7 vezes ao dia, mas esse número pode subir se a ingestão de líquidos for maior).
- Anotar a quantidade e horário de idas ao banheiro para urinar e verificar o tempo de intervalos.
 - Se intervalos de 15 minutos, tentar progredir para 30 minutos, quando 30 minutos estiver fácil, aumentar para 45 ou 60 minutos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

O Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico (TMAP) auxilia no alívio dos sintomas de incontinência urinária, principalmente a de esforço. Além disso, as modificações no estilo de vida também podem contribuir no tratamento.

Em cada consulta é importante avaliar a recuperação e em caso de persistência dos sintomas encaminhar para consulta médica.

3 - PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 12, 49, 51, 52

Em 12 de janeiro de 1996 foi sancionada a Lei nº 9.263, que regulamenta o planejamento familiar no Brasil, visando assegurar os direitos de homens e mulheres, adultos (as) e adolescentes, em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva. O conceito de planejamento familiar vem sendo substituído por planejamento reprodutivo, buscando uma abordagem mais ampla que reconheça que tanto homens quanto mulheres podem planejar sua reprodução individualmente, mesmo sem a intenção de formar uma família. Nesse contexto, o planejamento reprodutivo inclui um conjunto de ações que garanta direitos iguais de pré-concepção e contracepção, levando em consideração o contexto de vida de cada pessoa e o direito de todos de decidir sobre sua reprodução, sem distinção.

3.1 – PRÉ-CONCEPÇÃO 1,13,14,50

Com o desenvolvimento da sociedade e cada vez mais a mulher tornando-se protagonista da decisão da melhor hora de engravidar, o enfermeiro na consulta de enfermagem deve procurar abordar o tema, não só da prevenção de uma gestação, mas também o planejamento da concepção, seja através de uma escuta qualificada, apoio emocional, esclarecimento de dúvidas ou mesmo o início do ácido fólico e solicitação de exames, quando necessário.

Quadro 18 – Implementação De Enfermagem no Período Pré-Concepcional

PERÍODO PRÉ-CONCEPCIONAL - IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM

• Abordagem

- Acolher dúvidas e angústias relacionadas a uma futura gestação, abordando a história clínica e obstétrica atual/pregressa da mulher e, se possível, de seu(sua) parceiro(a);
- Perguntar sobre a DUM e orientar sobre formas de identificar o período fértil (cálculo do período com base no 1º dia de sangramento da última menstruação, levando em consideração a duração do ciclo de cada mulher, as modificações que ocorrem no muco cervical/secreção vaginal tornando-o mais abundante, a discreta elevação da temperatura corporal, o aumento da libido, entre outros);
- Perguntar sobre os hábitos alimentares e orientar seguir uma dieta saudável e equilibrada pelo menos 3 meses antes e durante toda a gravidez:
 - Uma dieta saudável inclui uma alimentação variada e equilibrada com proteínas, vitaminas e minerais, contemplando vegetais verdes e laranja, carne, peixe, feijão, nozes, grãos integrais e frutas.
 - Contemplar na alimentação o ácido fólico e o ferro dada a sua importância:
 - ❖ O ácido fólico é encontrado em alimentos como legumes (feijão, lentilha e ervilha), frutas cítricas, grãos integrais e vegetais de folhas verdes.
 - ❖ O ferro é encontrado em alimentos como carnes e aves, peixes, vegetais de folhas verdes e legumes;
- Avaliar o histórico vacinal (hepatite B, dupla adulto, tríplice viral e febre amarela) e, em caso de atraso ou ausência, vacinar conforme calendário vacinal vigente. Em caso de necessidade de vacinação, a mulher deverá evitar a concepção até pelo menos 30 dias após completar o esquema vacinal indicado (tríplice viral e febre amarela);

Continua.

PERÍODO PRÉ-CONCEPCIONAL - IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM

- Abordar os riscos do fumo e álcool: como aborto, baixo peso ao nascer, síndrome da morte súbita infantil, síndrome alcoólica fetal, anemia materna e diabetes gestacional, e apoiar a cessação antes da gravidez, se necessário;
 - Questionar sobre uso de medicações contínuas e comorbidades pré-existentes, sobretudo as de caráter crônico, encaminhar para o MFC a fim de assegurar que a patologia esteja sob manejo adequado e compatível com a possibilidade de uma gestação vindoura;
 - Verificar situação da necessidade de realização/solicitação de exames, conforme quadro abaixo;
 - Convidar parceria para realizar consulta de enfermagem, incluindo no processo de escolha e programação familiar (Para maiores informações consultar o Guia do Pré-natal do parceiro para profissionais de saúde; disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_saude_1ed.pdf).
- **Prescrição (No mínimo 30 dias antes da concepção e até completar 12 semanas de gestação)**
 - **Ácido fólico 0,4 mg** – 1 comprimido 1x ao dia
 - **Ou**
 - **Ácido fólico solução: 0,2 mg/ml** - 40 gotas 1x ao dia
 - Na indisponibilidade do ácido fólico 0,4mg, poderá ser prescrito ácido fólico 5mg/dia.
 - **Solicitação de Exames**
 - Teste Rápido de Gravidez (TIG) ou laboratorial (BHCG), em caso de atraso menstrual;
 - Exames de Rastreamento de colo do útero ou outros, verificar situação e caso necessário, realizar os mesmos;
 - Ofertar sorologias conforme protocolo vigente.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

3.2 – MÉTODOS CONTRACEPTIVOS ^{1,12,13,49,50,51}

O enfermeiro deve aconselhar os usuários na escolha do método contraceptivo levando em consideração seus desejos e necessidades individuais. Para isso, é crucial ouvir atentamente o usuário, encorajando-o a expressar suas expectativas em relação ao método e explorando suas necessidades e preocupações.

Não existe um método contraceptivo universalmente superior. Portanto, o enfermeiro desempenha um papel fundamental ao aconselhar o usuário na escolha do método que melhor se adapte às suas necessidades, considerando sua singularidade.

No processo de enfermagem, a avaliação deve abranger diversos aspectos, como idade, estilo de vida, amamentação, tabagismo, comorbidades, uso de medicamentos, perfil sociocultural, histórico gineco-obstétrico, idade da menarca e sexarca, padrão do ciclo menstrual, presença de dismenorrea, experiência anterior com métodos contraceptivos, história ou sintomas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's), história de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), Trombose Venosa Profunda (TVP), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), enxaqueca, complicações

vasculares, doença hepática, câncer, além de investigar possibilidade de gestação atual, conforme *check list* para verificação de gravidez.

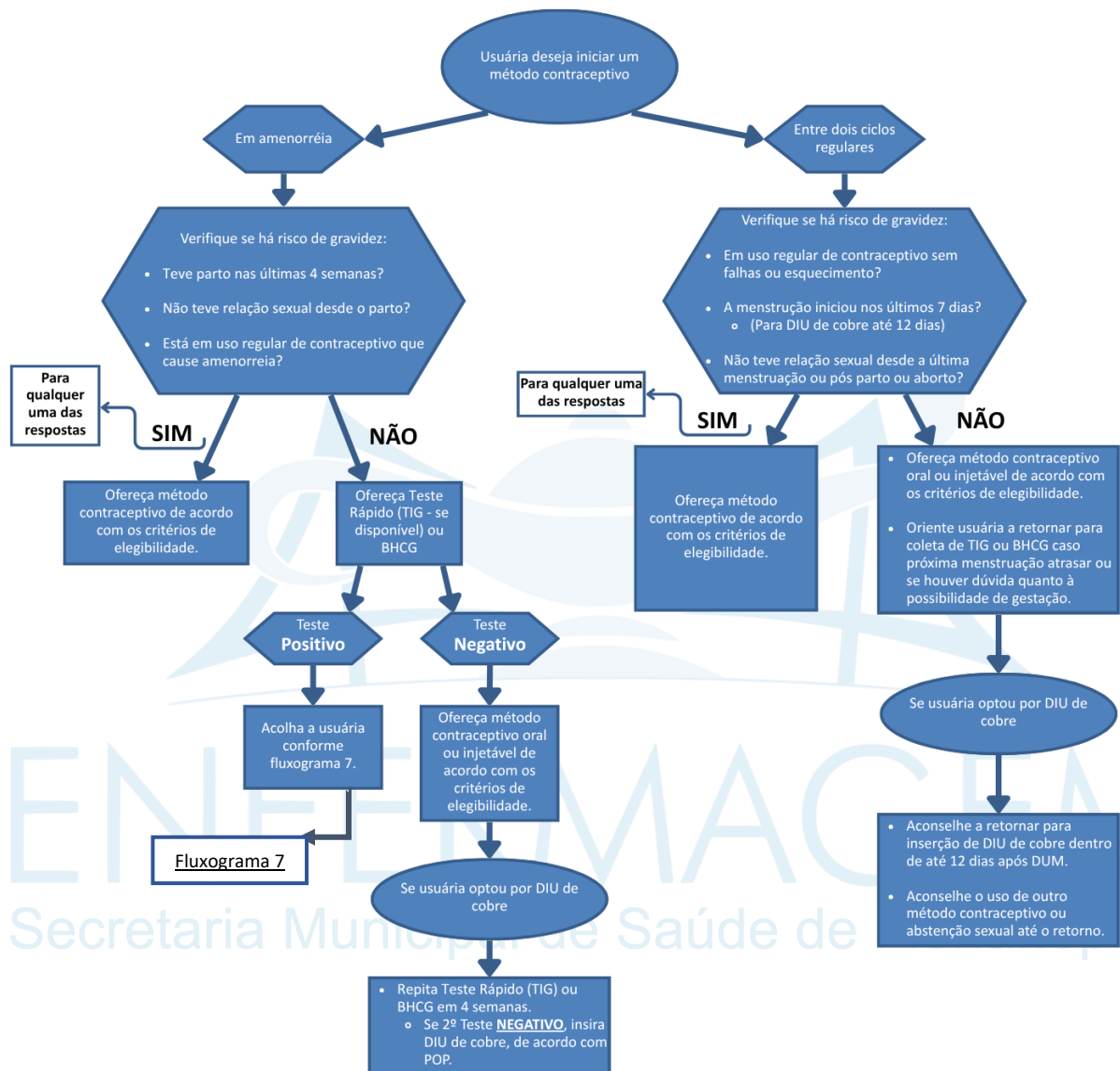
3.2.1 – Consulta de Enfermagem na Anticoncepção ⁵⁰

Quadro 19 – Exame Físico e Implementação de Enfermagem na Anticoncepção

CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ANTICONCEPÇÃO
EXAME FÍSICO
• Pressão arterial; • Peso e altura - calcule o IMC; • Circunferência abdominal - se indicado, para cálculo de RCV (conforme protocolo volume 1); • Exame pélvico ou genital - essencial para inserção de DIU, diafragma, laqueadura e vasectomia ou se necessário.
IMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM
• Avaliar elegibilidade clínica do método de escolha do usuário, conforme o Quadro <u>20</u> ; • Apresentar a eficácia de cada método, conforme <u>Quadro 20</u> ; • Orientar a forma de uso e o que fazer em caso de esquecimento para os métodos contraceptivos hormonais; • Informar os possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas que possam vir a interferir na eficácia do método, bem como frisar a importância do uso de métodos adicionais quando necessário. ▪ Caso deseje saber mais sobre as interações medicamentosas com os métodos contraceptivos, acessar o seguinte conteúdo: https://www.drugs.com/drug_interactions.html . • Encorajar o uso de preservativo; • Verificar a compreensão do usuário e se restaram dúvidas; • Agendar retorno anual ou antes se necessário.
SOLICITAÇÃO DE EXAMES
• Teste Rápido (TIG) ou BHCG, se necessário, de acordo com fluxograma a seguir; • Citopatológico de colo do útero, verificar situação e necessidade, de acordo com o Capítulo <u>4 - PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO 1, 5, 11, ^{12, 13}</u>; • Ofertas sorologias conforme protocolo vigente.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Fluxograma 4 – Verificação da Possibilidade de Gravidez para Contracepção



Fonte: Adaptado de WHO, 2022.

O quadro 20 apresenta a eficácia de cada método, dependendo do uso "perfeito", considerado a forma ideal, com manuseio correto e em todas as relações; e do uso "típico", considerada a forma habitual do método, que está sujeito a esquecimento, vômitos etc.

3.2.2 – Taxa de Falha dos Métodos Contraceptivos

Quadro 20 – Taxa de Falha dos Métodos Contraceptivos

TAXA DE FALHA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS		
	Taxa de Gravidez	
Método	Uso Perfeito	Uso Típico
Implante	0.1	0.1 - 0.6
Vasectomia	0.1	0.15
Laqueadura	0.5	0.5
DIU hormonal	0.5	0.7
DIU com cobre	0.6	0.8 - 1.4
LAM (por 6 meses)	0.9	2
Injetável mensal	0.05	3
Injetável trimestral	0.2	1.7 - 4
Contraceptivos orais combinados	0.3	5.5 - 7
Contraceptivos orais só de progestógeno	0.3	7
Adesivo combinado	0.3	7
Anel vaginal combinado	0.3	7
Preservativo masculino	2	5.4 - 13
Preservativo feminino	5	21
Método de ovulação	3	23
Outros métodos de conscientização sobre fertilidade		15
Diafragma com espermicida	16	17
Coito interrompido	4	13.4 - 20
Espermicida	16	21

Legendas

Muito efetivo
0 – 0,9

Efetivo
1 - 9

Moderadamente Efetivo
10 - 19

Menos Efetivo
> 20

Fonte: Adaptado de WHO, 2022.

*Uso típico – é a forma costumeira, corriqueira, habitual do uso do método e que está sujeita a esquecimento, vômitos, diarreia etc.

Observação: método contraceptivo é considerado método de apoio quando é associado àquele que já em uso para se potencializar a efetividade da anticoncepção. Exemplos: métodos comportamentais como a abstenção sexual, preservativo masculino e feminino.

As categorias de elegibilidade dos contraceptivos, sejam eles hormonais ou não, são assim definidas pela OMS, o quadro 21 foi adaptado da fonte para melhor definir as possibilidades de prescrição pelos (as) enfermeiros(as):

3.2.3 – Elegibilidade dos Métodos Contraceptivos

Quadro 21 – Categorias de Elegibilidade dos Métodos Contraceptivos

CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS		
Categoria	Definição	Prescrição
01	A condição não restringe o uso do método contraceptivo.	Prescrição realizada pelo enfermeiro ou médico.
02	As vantagens do uso do método nesta condição superam o risco teórico ou comprovado.	Prescrição realizada pelo enfermeiro ou médico, nos casos em que não haja método com menor risco disponível/aceitável. Sempre ponderar o uso e ficar atento a possíveis sinais/sintomas decorrentes do método ou de problemas de saúde gerados por estes.
03	Os riscos teóricos ou comprovados do uso do método superam as vantagens nesta condição.	Prescrição médica somente.
04	O risco do uso do método é inaceitável nesta condição.	Não prescreva.

Fonte: Adaptado de WHO, 2022.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

QUADRO 22 – CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE CONFORME O TIPO DE MÉTODO ESCOLHIDO E ORIENTAÇÃO AO ENFERMEIRO 19, 50 (ADAPTADO)

CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE CONFORME O TIPO DE MÉTODO ESCOLHIDO E ORIENTAÇÃO AO ENFERMEIRO							
CONDIÇÃO ATUAL	PÍLULA COMBINADA	PÍLULA SOMENTE COM PROGESTÁGENO (exceto minipílula de noretisterona)	INJETÁVEL COMBINADO (mensal)	INJETÁVEL COM PROGESTÁGENO (trimestral)	DIU DE COBRE	MINIPÍLULA DE NORETISTERONA	IMPLANTE
IDADE INFERIOR A 40 ANOS	1	1	1	1 2 se <18 anos	1 2 se <20 anos	NÃO UTILIZAR	1
IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 40 ANOS	2	1	2	1 (18 aos 45 anos) 2 se >45 anos	1	NÃO UTILIZAR	1
NULÍPARA	1	1	1	1	2	NÃO UTILIZAR	1
AMAMENTAÇÃO - MENOS DE 6 SEMANAS APÓS O PARTO	4	3	4	3	1 = A partir de 4 semanas após o parto	NÃO UTILIZAR	2
AMAMENTAÇÃO - ENTRE 6 SEMANAS E 6 MESES APÓS O PARTO	3	1	3	1	1	1	1
AMAMENTAÇÃO - MAIS DE 6 MESES APÓS O PARTO	2*	1	2	1	1	NÃO UTILIZAR	1
PÓS-PARTO NÃO AMAMENTANDO	3 = < 21 dias 4 = < 21 dias e fatores de risco TEV 2 = 21–42 dias 3 = 21–42 dias e fatores de risco TEV 1 = > 42 dias	1	3 = < 21 dias 4 = < 21 dias e fatores de risco TEV 2 = 21–42 dias 3 = 21–42 dias e fatores de risco TEV 1 = > 42 dias	1	1 = a partir de 4 semanas após o parto	NÃO UTILIZAR	1
GRAVIDEZ ECTÓPICA ANTERIOR	1	2	1	1	1	NÃO UTILIZAR	1
OBESIDADE (IMC maior que 30 kg/m ²)	2	1 2 se <18 anos	2	1 2 se <18 anos - uso de acetato de medroxiprogesterona	1	NÃO UTILIZAR	1
IST ATUAL (EXCETO HEPATITE E HIV)	1	1	1	1	4/2**	NÃO UTILIZAR	1
MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES (idade, fumo, diabetes e HAS)	3/4	2	3/4	3	1	NÃO UTILIZAR	2
TABAGISMO EM MULHERES COM MENOS DE 35 ANOS	2	1	2	1	1	NÃO UTILIZAR	1
TABAGISMO EM MULHERES COM MAIS DE 35 ANOS	3/4	1	3/4	1	1	NÃO UTILIZAR	1
HAS CONTROLADA	3	1	3	2	1	NÃO UTILIZAR	1
HAS com PAS>160 e PAD>=100 mmHg	4	2	4	3	1	NÃO UTILIZAR	2
HAS + DOENÇA CARDIOVASCULAR	4	2	4	3	1	NÃO UTILIZAR	-

Observações e continuação da tabela na próxima página.

CATEGORIAS DE ELEGIBILIDADE CONFORME O TIPO DE MÉTODO ESCOLHIDO E ORIENTAÇÃO AO ENFERMEIRO

CONDIÇÃO ATUAL	PÍLULA COMBINADA	PÍLULA SOMENTE COM PROGESTÁGENO (exceto minipílula de noretisterona)	INJETÁVEL COMBINADO (mensal)	INJETÁVEL COM PROGESTÁGENO (trimestral)	DIU DE COBRE	MINIPÍLULA DE NORETISTERONA	IMPLANTE
HISTÓRICO DE PRESSÃO ALTA NA GESTAÇÃO (PA ATUAL NORMAL)	2	1	2	1	1	Utilizar apenas se estiver amamentando e estiver entre 6 meses e 6 semanas após o parto = 1	1
TEP/TVP ATUAL OU RECENTE	4	3	4	3	1	NÃO UTILIZAR	3
HISTÓRICO FAMILIAR DE TEP/TVP (1º GRAU)	2	1	2	1	1	NÃO UTILIZAR	1
HISTÓRICO DE TEP/TVP NO PASSADO, COM OU SEM USO DE ANTICOAGULANTE ORAL	4	2	4	2	1	NÃO UTILIZAR	2
INFARTO OU AVC	4	2/3	4	3	1	NÃO UTILIZAR	2/3
DISLIPIDEMIA sem outros fatores de risco	2/3	2	2/3	2	1	NÃO UTILIZAR	2
DM sem COMPLICAÇÕES VASCULARES	2	2	2	2	1	NÃO UTILIZAR	2
DM com COMPLICAÇÕES VASCULARES	3/4	3 2	3/4	2 /3	1	NÃO UTILIZAR	2
ENXAQUECA SEM AURA MENOS DE 35 ANOS	2***/3	1/2	2***/3	2	1	NÃO UTILIZAR	2
ENXAQUECA SEM AURA MAIS DE 35 ANOS	3/4	1/2	3/4	2	1	NÃO UTILIZAR	2
ENXAQUECA COM AURA - QUALQUER IDADE	4	2*/3	4	2*/3	1	NÃO UTILIZAR	2/3
CA DE MAMA ATUAL OU PASSADO	4	4	4	4	1	NÃO UTILIZAR	3/4
USO DE ANTICONVULSIVANTES	3	3	2	1	1	NÃO UTILIZAR	2 = barbitúricos, carbamazepina oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato 1 = Lamotrigina
USO DE TARV/HIV ^c	1/2****	1/2****	1/2****	1/2****	1/2	NÃO UTILIZAR	1/2
USO DE RIFAMPICINA	3	3	2	2	1	NÃO UTILIZAR	2
DOENÇA DA VESÍCULA BILIAR ATUAL OU HISTÓRIA DA DOENÇA RELACIONADA AO ACO	3	2	2	2	1	NÃO UTILIZAR	2
HEPATITE VIRAL AGUDA OU EXACERBADA	4#/2	1	3#/2	1	1	NÃO UTILIZAR	1
TUMORES HEPÁTICOS: ADENOMA HEPATOCELULAR OU HEPATOMA	4	3	3	3	1	NÃO UTILIZAR	3/2

Ver observações na próxima página.

Fonte: Adaptado de WHO, 2022.

* Método de categoria 2 na introdução e categoria 3 na continuidade, neste caso deve-se optar por um método mais seguro ou encaminhar para avaliação médica.

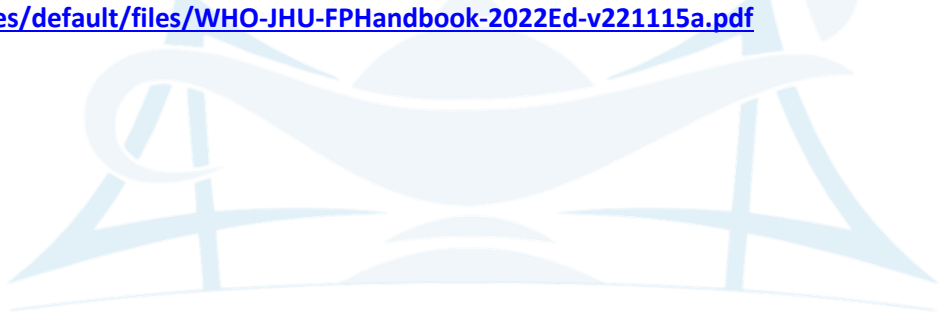
** Pode ser inserido após 12 semanas do tratamento completo e sem sintomas de DIP, cervicite purulenta, tricomoníase, clamídia ou gonorreia.

Continuidade do método: categoria 2

*** Se Maior de 35 anos: Categoria OMS 2 na introdução do método e categoria OMS 3 na manutenção, devendo optar por outro método mais seguro ou encaminhar para avaliação médica.

**** O esquema básico de TARV atual (Tenofovir/Lamivudina + Dolutegravir) pode ser utilizado com qualquer método contraceptivo hormonal (Categoria 1), os demais esquemas podem reduzir a eficácia do método (Categoria 2). Orientar este grupo a utilizar o preservativo em todas as relações sexuais.

Fonte: World Health Organization; Johns Hopkins; United States Agency for International Development, 2022. <https://fphandbook.org/sites/default/files/WHO-JHU-FPHandbook-2022Ed-v221115a.pdf>



ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

Os métodos contraceptivos disponíveis na rede estão divididos em hormonais, de barreira e os irreversíveis/cirúrgicos, os quais são explicados no quadro abaixo.

3.2.4 – Métodos Disponíveis na Rede Pública

Quadro 23 – Síntese de Métodos Anticoncepcionais Hormonais, Cirúrgicos e Dispositivo Intrauterino (DIU) ^{1,12,13}

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS, CIRÚRGICOS E DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)			
Método/ responsável	Tipo disponível na rede municipal e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos Colaterais Mais Comuns
Pílula combinada estrogênio/ Progestágeno (mensal, do tipo monofásico) (Médico e/ou Enfermeiro)	Etinilestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg OU Etinilestradiol de baixa dosagem (menor ou igual a 0,35 µg/progestágeno) <i>Classificação: método hormonal</i>	• Iniciar nos primeiros 5 dias do ciclo; • Manter o uso de preservativo no mínimo por 7 dias após início do método; • Ingerir o comprimido uma vez ao dia por 21 dias, sempre no mesmo horário, dar 7 dias de intervalo e reiniciar a cartela. Em caso de esquecimento: • Até 12 horas: orientar a ingestão do comprimido esquecido assim que se lembrar; • Acima de 12 horas: orientar a ingestão do comprimido esquecido assim que se lembrar e utilizar preservativo por 07 dias; • Mais de 1 episódio de esquecimento na mesma cartela: utilizar preservativo até o término da cartela. Em caso de vômitos: Se ocorrer no período de 4 horas após a ingestão do comprimido, orientar o uso de preservativo até o final da cartela.	• Alterações de peso, que podem estar relacionadas a questões metabólicas; • Sensibilidade em mamas, náuseas, tontura: tranquilizar usuária, geralmente a melhora é espontânea; • Alteração de humor: geralmente é melhora espontânea; • Sangramento anormal: comum nos 3 primeiros meses*; • Se dor de cabeça severa ou alteração da visão: encaminhe para avaliação médica; • As pílulas de doses estrogênicas maiores, bifásicas ou trifásicas podem ser utilizadas como medida de exceção em mulheres com perdas sanguíneas intermenstruais persistentes ou situações de interação medicamentosa, neste sentido a usuária deve ser encaminhada para uma avaliação e conduta médica. (prescrição exclusiva do médico)
Injeção de estrogênio/ Progestágeno (Médico e/ou Enfermeiro)	Enantato de noretisterona/ Valerato de Estradiol 50/5mg OU Acetato de medroxiprogesterona/Cipionat o de estradiol 25/5mg <i>Classificação: método hormonal</i>	• Injeção IM a cada 4 semanas (ou 30 dias); • Iniciar entre o 1º e 5º dia do ciclo (preferencialmente no primeiro dia do ciclo menstrual); • Usar preservativo nos primeiros 7 dias após a primeira aplicação do método; Em caso de atraso: • Até 7 dias: aplique nova injeção; • Mais que 7 dias: descarte a possibilidade de gestação** e, após, inicie novo ciclo, utilizando preservativo nos 7 primeiros dias.	• Alterações de peso, que podem estar relacionadas a questões metabólicas; • Sensibilidade em mamas, náuseas, tontura: tranquilizar usuária, geralmente a melhora é espontânea; • Alteração de humor: geralmente melhora espontânea; • Sangramento anormal: comum nos 3 primeiros meses*; • Se dor de cabeça severa ou alteração da visão: encaminhe para avaliação médica.

Continua.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS, DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E IMPLANTE

Método/ responsável	Tipo disponível na rede municipal e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos Colaterais Mais Comuns
Injeção de progestágeno (trimestral) (Médico e/ou Enfermeiro)	Acetato de medroxiprogesterona 150 mg <i>Classificação: método hormonal</i>	• Injeção IM a cada 12 semanas (ou 90 dias); • Pode iniciar a qualquer momento se certeza de não estar grávida ou nos primeiros 5 dias do ciclo menstrual (preferencialmente no primeiro dia); • Usar preservativo no mínimo nos primeiros 7 a 14 dias após aplicação. Em caso de atraso: • <u>Até 2 semanas:</u> aplique nova injeção; • <u>Mais de 2 semanas:</u> descarte primeiro a possibilidade de gravidez** e, após, aplique o método.	• Amenorreia (comum); • Alterações de peso, que podem estar relacionadas a questões metabólicas; • Sangramento anormal: comum nos 3 primeiros meses*; • Se dor de cabeça severa ou alteração da visão: encaminhe para avaliação médica*.
Dispositivo intrauterino (DIU) (Inserção/retirada: Médico e/ou Enfermeiro; Prescrição do método: Médico e/ou Enfermeiro)	DIU de Cobre (DIU-Cu) <i>Classificação: método de barreira</i>	• Inserção e retirada do DIU podem ser realizadas por profissional ENFERMEIRO (A) HABILITADO (A) EM CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA. • REALIZAR TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ PARA A INSERÇÃO • Para demais informações veja 3.2.7 – Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre e 3.2.8 – Contracepção de Emergência ^{1,2,11,12,13,46,49}	• Ciclos menstruais mais intensos e com fluxo aumentado podem ocorrer; • Logo após a inserção, os efeitos mais comuns, os quais geralmente desaparecem ao longo das semanas, é o sangramento uterino de pequena a média quantidade; caso apresente fluxo intenso avaliar, em conjunto com médico da equipe; • Para manejo das principais intercorrências relacionadas ao DIU, verifique o Quadro 27.
Minipílula de progestágeno isolado (Médico e/ou Enfermeiro)	Noretisterona 0,35 mg <i>Classificação: método hormonal</i>	• Escolher este método se a mulher estiver amamentando e após 6 semanas do parto; • Tomar na mesma hora, todos os dias e manter aleitamento materno exclusivo; • Obs: não deixar ultrapassar mais de 3 horas em relação ao horário habitual, caso ultrapasse utilizar preservativo por 2 dias.	• Sangramento anormal: comum nos primeiros 3 meses*; • Dor de cabeça leve, náuseas, sensibilidade mamária: tranquilizar paciente. Se necessário, encaminhar para consulta médica.

Continua.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS, DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E IMPLANTE

Método/ responsável	Tipo disponível na rede municipal e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos Colaterais Mais Comuns
Métodos cirúrgicos (irreversíveis)	Encaminhamento para: Laqueadura tubária Vasectomia	É permitida a esterilização voluntária de homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos de idade ou pelo menos 2 filhos vivos (Os requisitos foram atualizados pela Lei nº 14.443, de 2022). Realizar consulta individual ou em grupo abordando aspectos éticos, legais e de seus direitos reprodutivos, explicando de forma simplificada o procedimento cirúrgico a ser realizado, tirando assim todas as dúvidas e angústias manifestadas pelos usuários; A pessoa interessada deverá registrar manifestação expressa de vontade, assinando-o em duas vias, uma via ficará com a pessoa e a outra anexada ao prontuário. Não há mais a necessidade de consentimento do cônjuge para a realização de laqueadura tubária ou vasectomia. É definido o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Entregar termo de consentimento livre e esclarecimento, lendo em conjunto com o mesmo a fim de não haver dúvidas em relação ao processo de encaminhamento, lembrando sempre ao usuário sobre o risco de uma cirurgia e, que ambos os métodos são considerados na prática IRREVERSÍVEIS; Solicitar espermograma após 2 e 3 meses da realização da vasectomia para verificar o sucesso do procedimento cirúrgico.	- Pós-operatório com dor leve é o sintoma mais comum, devendo ser manejado com orientações gerais e repouso. Para os homens orienta-se evitar carregar peso por um período não inferior a 5 dias. Para mulheres segue-se a orientação de rotina pós-cirúrgica; - Presença de sinais infecciosos devem ser avaliados prontamente pelo médico da equipe/unidade ou referenciar para serviço de urgência.
Dispositivos contraceptivos implantáveis	Implanon: 68 mg de etonogestrel Durabilidade de <u>03 anos</u>, podendo ser inserido 4 semanas após o parto <i>Classificação: método hormonal</i>	- Inserção e retirada do implante podem ser realizadas por profissional ENFERMEIRO (A) HABILITADO (A) EM CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA DEFINIDA PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA - O dispositivo deve ser inserido entre o dia 1 (primeiro dia de sangramento menstrual) e o dia 5 do ciclo menstrual, mesmo se a paciente ainda estiver com sangramento menstrual. Se inserido como recomendado, outro método anticoncepcional não é necessário. Se divergir do período de inserção recomendado, a paciente deve ser orientada a usar um método de barreira durante 7 dias após a inserção.	- Sensibilidade em mamas: tranquilizar usuária, geralmente sintomas são de leve a moderada intensidade e diminui com o uso contínuo; - Cefaleia leve. Se necessário, encaminhar para consulta médica. - Alterações no padrão de sangramento (prolongado no primeiro ano, irregular, pouco frequente ou ausência de menstruação).

Observações na próxima página.

* Se sangramento intenso e regular e interferindo com a qualidade de vida, questionar se há sangramento em outras partes do corpo (gengiva, arranhões leves, lesões de pele):

- Sangramento presente em outras partes do corpo: se sinais de gravidade presentes (hipotensão, palidez, fraqueza, nível de consciência alterado), encaminhar para avaliação médica. Sem sinais de gravidade, solicitar hemograma, TAP e TTPA e encaminhar para consulta médica após resultado dos exames;
- Sangramento ausente em outras partes do corpo: solicitar hemograma. Se $Hb \leq 12$, prescrever sulfato ferroso 160mg ao dia (4 comprimidos) por 3 meses. Repetir hemograma em 2 meses. Troque o método. Maneje cólica/sangramento menstrual conforme Fluxograma 3 – Cólica Menstrual

**** Em casos de atraso superior a 7 dias na aplicação do contraceptivo mensal ou 14 dias no contraceptivo trimestral**, recomenda-se a realização de um teste rápido de gravidez para descartar uma possível gestação. A mulher deve ser orientada sobre a necessidade de utilizar um método contraceptivo adicional (como preservativos) até que a proteção contraceptiva seja restabelecida. É importante explicar a possibilidade de falha do teste rápido de gravidez, especialmente em gestações muito iniciais (poucos dias ou semanas), e reforçar a importância da **decisão compartilhada para aplicação do anticoncepcional**, considerando as informações clínicas e os desejos da paciente.

RECOMENDAÇÃO: FAZER SEMPRE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ E SE MESMO ASSIM PERMANECER A DÚVIDA, SUGERE-SE AVALIAÇÃO MÉDICA COMPLEMENTAR.

O manual da OMS (2022), traz as seguintes explicações complementares sobre esta situação:

Uma paciente que tenha atrasado mais de 7 dias poderá receber a injeção seguinte do CONTRACEPTIVO MENSAL se:

- Ela não tiver feito sexo nos 7 dias após o período em que ela deveria ter recebido sua última injeção, ou
- Ela utilizou um método de apoio ou tomou pílulas anticoncepcionais de emergência (PAEs) depois de ter feito sexo desprotegido nos 7 dias após o período em que ela deveria ter tomado sua última injeção, ou ela precisará de um método de apoio nos primeiros 7 dias após a injeção.
- Ela estiver mais do que 7 dias atrasada e não atende aos critérios acima, medidas adicionais poderão ser tomadas para que se tenha certeza razoável de que ela não está grávida (Ex. Teste rápido de gravidez e Avaliação médica complementar).
 - Discuta o motivo que levou a usuária a se atrasar e as soluções para isso. Se retornar na data certa for frequentemente um problema, sugira a utilização de um método de apoio no período em que atrasar a injeção seguinte, a ingestão de PAEs ou a escolha de outro método.

Uma paciente que tenha atrasado mais de 2 semanas (14 dias) poderá receber a injeção do CONTRACEPTIVO TRIMESTRAL seguinte se:

- Ela não tiver feito relação sexual nas 2 semanas após o período em que ela deveria ter recebido sua última injeção; ou
- Ela utilizou um método de apoio ou tomou PAEs depois de ter feito sexo desprotegido nas 2 semanas após o período em que ela deveria ter tomado sua última injeção; ou
- Ela estiver em amamentação de forma exclusiva ou quase e deu à luz há menos de 6 meses. Ela precisará de um método de apoio nos primeiros 7 dias após a injeção. Se a paciente estiver mais do que 2 semanas atrasada e não atende aos critérios acima, medidas adicionais poderão ser tomadas para que se tenha

certeza razoável de que ela não está grávida (Ex. Teste rápido de gravidez e avaliação médica complementar). Estas medidas são úteis porque muitas mulheres que utilizaram injetáveis só de progestógeno não ficarão menstruadas por pelo menos alguns meses, mesmo após a interrupção do uso. Assim, pedir a ela que retorne durante sua próxima menstruação significa que a injeção seguinte poderia ser desnecessariamente retardada, deixando-a possivelmente sem proteção contraceptiva

- Converse com a usuária o motivo do atraso e soluções para evitá-lo. Se o retorno no prazo certo for um problema frequente, sugerir a utilização de um método de apoio quando ocorrer atraso na sua próxima injeção, que ela tome PAEs, ou a escolha de outro método.

3.2.5 – Métodos Não Disponíveis na Rede Pública

Para o usuário que optar por utilizar um método não disponível na rede pública, o enfermeiro realizará a consulta de enfermagem, orientando e avaliando sobre os métodos disponíveis no mercado, os quais são explicados no quadro abaixo.

Quadro 24 – Síntese de Outros Métodos Anticoncepcionais Hormonais disponíveis no mercado (não disponibilizados na rede pública)^{1,12,13,47}

SÍNTESE DE OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO (NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA)			
Método/responsável	Tipo disponível na rede privada e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos colaterais mais comuns
DIU liberador de levonorgestrel	Levonorgestrel 52mg (liberação de 20 mcg / dia) Durabilidade de <u>05 anos</u> , podendo ser inserido 4 semanas após o parto <i>Classificação: método hormonal</i>	• A inserção e retirada não é realizada por enfermeiro.	• Oligomenorreia ou amenorreia • Pode ocorrer ainda expulsão, dor ou sangramento.
Adesivo hormonal combinado	Norelgestromina 6mg/Etinilestradiol 0,60 mg (contra indicado para mulheres com mais de 90kg) <i>Classificação: método hormonal</i>	• Sobre a pele limpa e livre de cosméticos, aplicar o primeiro adesivo no 1º dia de sangramento do ciclo menstrual. Locais de aplicação (realizar rodízio semanal): nádegas, abdome, parte superior externa do braço ou parte superior do dorso, em local onde não haja fricção por roupas justas. Nunca aplicar o adesivo nas mamas; • Trocar o adesivo de 07/07 dias, por 03 semanas e deixar 01 semana sem adesivos, para reiniciar nova embalagem.	• Sensibilidade em mamas: tranquilizar usuária, geralmente sintomas são de leve a moderada intensidade e diminui com o uso contínuo; • Pode ocorrer ainda cefaleia, reações no local da aplicação e náusea.
Continua.			

SÍNTESE DE OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO (NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA)

Método/responsável	Tipo disponível na rede privada e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos colaterais mais comuns
Comprimido vaginal revestido combinado estrogênio/Progestágeno	Levonorgestrel 0,25 mg/ etinilestradiol 0,05 mg <i>Classificação: método hormonal</i>	• Iniciar a primeira aplicação no 1º dia do ciclo; • Introduzir o comprimido, via intravaginal, uma vez ao dia, preferencialmente no mesmo horário, por 21 dias consecutivos e realizar 7 dias de intervalo antes de reiniciar a nova cartela; Manter o uso de preservativo no mínimo por 7 dias após início do método. Em caso de esquecimento: • Até 12 horas: orientar a ingestão do comprimido esquecido assim que se lembrar; • Acima de 12 horas: orientar a ingestão do comprimido esquecido assim que se lembrar e utilizar preservativo por 07 dias; • Mais de 1 episódio de esquecimento na mesma cartela: utilizar preservativo até o término da cartela.	• Sangramento intermenstrual; • Sensibilidade em mamas: tranquilizar usuária, geralmente sintomas são de leve a moderada intensidade e diminui com o uso contínuo; • Pode ocorrer ainda cefaleia, náuseas, dismenorrea.
Anel vaginal	Etonogestrel 11,7 mg/ etinilestradiol** 2,7 mg** <i>Classificação: método hormonal</i>	• Inserir o anel via intravaginal (até o fundo do canal) no 1º dia de sangramento do ciclo menstrual e deixá-lo lá por 3 semanas, quando o mesmo deverá ser retirado. Deverá ser feita 01 semana de pausa antes da colocação de um novo anel. Se o anel ficar fora da vagina por mais de 2 horas, acidentalmente, é necessário utilizar um método de barreira.	• Aumento do fluído vaginal; • Cefaleia; • Irritação vaginal.
Minipílula de progestágeno isolado	Linestrenol 0,5 mg** Levonorgestrel 0,030 mg** <i>Classificação: método hormonal</i>	• Escolher este método se a mulher estiver amamentando e após 6 semanas do parto; • Tomar na mesma hora, todo o dia e manter aleitamento materno inclusive; • Obs.: não deixar ultrapassar mais de 3 horas em relação ao horário habitual, caso ultrapasse utilizar preservativo por 2 dias.	• Sangramento anormal: comum nos primeiros 3 meses (ver * Se sangramento intenso e regular); • Dor de cabeça leve, náuseas, sensibilidade mamária: tranquilizar paciente. Se necessário, encaminhar para consulta médica.

Continua.

SÍNTESE DE OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO (NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA)

Método/responsável	Tipo disponível na rede privada e classificação	Como usar/ Condutas do enfermeiro	Efeitos colaterais mais comuns
Pílula de progestágeno isolado (Médico e/ou Enfermeiro)	Desogestrel 75 µg <i>Classificação: método hormonal</i>	• Iniciar nos primeiros 5 dias do ciclo; • Manter o uso de preservativo no mínimo por 7 dias após início do método; • Ingerir o comprimido uma vez ao dia, preferencialmente no mesmo horário, sem pausas entre as cartelas	• Irregularidade no sangramento menstrual, desde amenorreia até sangramento frequente, irregular, ocasional ou prolongado.

3.2.6 – Métodos Não Farmacológicos de Abordagem Comportamental

Além dos métodos anticoncepcionais hormonais, os não farmacológicos de abordagem comportamental também podem ser orientados à mulher conforme quadro abaixo, visto que a escolha final de qual deles usar é da própria pessoa. Importante orientar sobre as taxas de falha de cada um deles, que pode ser visto no Quadro 20 deste documento.

Quadro 25 – Síntese de Métodos Anticoncepcionais Não Farmacológicos de Abordagem Comportamental³²

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL			
Método	Descrição	Como explicar	Observações
Calendário (tabelinha, Ogino-Knauss)	Os dias férteis são calculados na base da história menstrual dos últimos seis meses. Em mulheres com ciclos mais ou menos regulares, com duração entre 26 e 32 dias, o período fértil vai do dia 8 ao dia 19 do ciclo.	Orientar a mulher que o 1º dia de sangramento menstrual deverá ser assinalado no calendário com um “M” e os 06 dias seguintes com um círculo. Depois deverá assinalar os 12 dias seguintes com um X A chance de uma gestação ocorrer é pequena entre o dia marcado com M e os 06 dias seguintes marcados com círculo. A ocorrência de relações nos 12 dias marcados com X aumenta a probabilidade de concepção. Terminados os dias com X, as chances de uma nova gestação voltam a cair.	• Pode ser utilizado como método anticoncepcional, se associado com abstinência nos dias férteis ou com método de barreira; • Pode ser utilizado como método pró-conceptivo, caso a mulher esteja desejando uma gestação, privilegiando as relações no período fértil; • É importante atentar para a regularidade dos ciclos.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

Método	Descrição	Como explicar	Observações
Muco cervical (Billings)	Os dias férteis são os chamados dias úmidos, quando há muco cervical em quantidade mais abundante no canal vaginal, com extravasamento de secreção que forma fio.	Orientar a mulher a observar, diariamente, a presença ou ausência de fluxo mucoso mediante sensação de secura ou umidade da vulva e analisar as características do muco, de acordo com a seguinte descrição: pegajoso, turvo, elástico, claro, transparente ou sensação escorregadia. Havendo fluxo mucoso, e/ou sensação de lubrificação, é muito provável a ocorrência do período fértil.	• Pode ser utilizado como método anticoncepcional, se associado com abstinência nos dias férteis ou com método de barreira; • Pode ser utilizado como método pró-conceptivo, caso a mulher esteja desejando uma gestação, privilegiando as relações no período fértil.
Temperatura corporal basal	Os dias férteis se calculam pela variação da temperatura corporal, que se eleva depois da ovulação.	Orientar a mulher a aferir sua temperatura corporal da mesma maneira (oral, vaginal, retal), no mesmo horário, todas as manhãs, antes de se levantar, registrando os valores. Nos dias em que for observada elevação entre 0,2° a 0,5°C, é provável que esteja no período fértil (aproximadamente no meio do ciclo menstrual, para muitas mulheres). Atingido o pico máximo de temperatura, ela deverá permanecer nesse novo nível até a próxima menstruação. Este aumento de temperatura é resultado da elevação dos níveis de progesterona, que tem um efeito termogênico.	• Pode ser utilizado como método anticoncepcional, se associado com abstinência nos dias férteis ou com método de barreira; • Pode ser utilizado como método pró-conceptivo, caso a mulher esteja desejando uma gestação, privilegiando as relações no período fértil; • É importante atentar para outros fatores que possam interferir com variações da temperatura corporal, como a ocorrência de infecções, por exemplo; • O termômetro deve ser sempre o mesmo.
Sintotérmicos	Os dias férteis se calculam por um conjunto de sinais físicos, incluindo o muco cervical e a temperatura.		
Coito interrompido	Consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação e o sêmen ser depositado longe dos genitais femininos.	Orientar a mulher a conversar sobre o método com o(s) parceiro(s), instruindo-o(s) a realizar a ejaculação fora de sua vagina.	• É necessário autocontrole do(s) homem(s) e confiança entre os envolvidos; • Importante orientar que o líquido pré-seminal pode conter espermatozoides e, mesmo não ocorrendo a ejaculação no interior da vagina, pode ocorrer a gravidez.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

Método	Descrição	Como explicar	Observações
Camisinha feminina	Consiste num tubo de poliuretano ou látex com uma extremidade fechada e a outra aberta, acoplado a um anel ou esponja (depende do modelo) flexível. O primeiro anel ou esponja, que fica solto dentro do tubo, serve para ajudar na inserção e na fixação de preservativo no interior da vagina. O segundo anel constitui o reforço externo do preservativo que, quando corretamente colocado, cobre parte da vulva. O produto já vem lubrificado e deve ser usado uma única vez. O poliuretano, por ser mais resistente do que o látex, pode ser usado com vários tipos de lubrificantes. Forma uma barreira física entre o pênis e a vagina, servindo de receptáculo ao esperma, impedindo seu contato com a vagina, assim como impede que os microorganismos da vagina entrem em contato com o pênis ou vice-versa.	Orientar a mulher acerca do correto procedimento de colocação: • O preservativo feminino pode ser colocado em qualquer momento, desde que seja antes da penetração, e retirado com tranquilidade após o término da relação; • Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável (em pé com um dos pés em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada). O anel móvel/esponjinha deve ser apertado e introduzido na vagina; • Com o dedo indicador, ele deve ser empurrado o mais profundamente possível para alcançar o colo do útero; • O anel (externo) deve ficar aproximadamente 3 cm para fora da vagina. Durante a penetração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel externo. O preservativo não deve ficar retorcido; • Deve ser utilizado um novo preservativo a cada nova relação. Para retirá-lo, segure as bordas do anel externo fazendo um movimento de torção para manter o esperma dentro do preservativo. Puxe-o delicadamente para fora da vagina, jogando-o no lixo.	• É válido recomendar o armazenamento dos preservativos em lugar fresco, seco e de fácil acesso ao casal, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo de validade; • O preservativo feminino já vem lubrificado, no entanto, se for preciso, podem ser usados lubrificantes de base aquosa ou oleosos (estes somente nos preservativos que NÃO são à base de látex); • O anel externo do preservativo feminino pode deslizar dentro da vagina. Se isso acontecer basta o homem retirar o pênis, colocar o mesmo preservativo de maneira correta e reintroduzir o pênis. Não é necessário usar novo preservativo. Durante a penetração, o preservativo também pode provocar um pequeno ruído durante a relação sexual. A adição de lubrificante dentro do preservativo ou diretamente no pênis pode evitar esses acontecimentos; • Não deve ser usado junto com o preservativo masculino porque o atrito aumenta o risco de rompimento.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

Método	Descrição	Como explicar	Observações
Camisinha masculina	Consiste em um envoltório de látex ou silicone (não disponível no SUS) que recobre o pênis durante o ato sexual e retém o esperma por ocasião da ejaculação, impedindo o contato com a vagina, assim como impede que os microorganismos da vagina entrem em contato com o pênis ou vice-versa. É um método que, além de evitar a gravidez, reduz o risco de transmissão do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis.	Orientar a mulher acerca do correto procedimento de colocação, para que ela mesma coloque no(s) parceiro(s) ou instrua-o(s) a fazê-lo: • O preservativo deverá ser colocado antes de qualquer penetração, com o pênis em ereção. O receptáculo existente na extremidade do preservativo deve ser apertado durante a colocação, retirando todo o ar do seu interior; • Ainda segurando a ponta do preservativo, desenrolá-lo até a base do pênis; • Após a ejaculação, retirar o preservativo com o pênis ainda ereto; • Retirar o preservativo segurando-o pela base para que não haja vazamento de esperma; • O preservativo não deve ser reutilizado, devendo ser descartado no lixo após o uso.	• É válido recomendar o armazenamento dos preservativos em lugar fresco, seco e de fácil acesso ao casal, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo de validade; • Devem ser usados apenas lubrificantes a base de água, pois o uso de lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares) danifica o látex, aumentando o risco de ruptura; a maioria dos preservativos são fabricados com lubrificantes; • No caso de ruptura durante o ato sexual, o preservativo deve ser substituído imediatamente.
Método da amenorreia lactacional (LAM)	Consiste em utilizar a amamentação exclusiva como opção de planejamento familiar. Age impedindo a ovulação por meio ação dos hormônios envolvidos na amamentação que atuam sobre o eixo hipotálamo – hipófise - ovário. A sucção frequente por parte do lactente envia impulsos nervosos ao hipotálamo materno, alterando a produção hormonal, o que leva à anovulação; como consequência da não ovulação ocorre a “amenorreia”, um dos critérios básicos para a eficácia deste método. Geralmente as condições ideais para a adoção da LAM se encerram por volta dos 6 meses de vida do lactente.	Orientar a mulher a amamentar de forma exclusiva até o sexto mês de vida da criança, 10 a 12 vezes por dia durante as primeiras semanas após o parto e 8 a 10 vezes por dia, mais uma vez durante a noite, nos primeiros meses. Observar, adicionalmente, qualquer sinal de ovulação e/ou menstruação e rever suas escolhas contraceptivas.	

Continua.

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

Método	Descrição	Como explicar	Observações
Diafragma	Consiste num anel flexível, coberto no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone em forma de cúpula que se coloca na vagina cobrindo completamente o colo uterino e a parte superior da vagina, impedindo a penetração dos espermatozoides no útero e trompas.	• Orientar a mulher a identificar o colo do útero por meio do auto-toque vaginal. Quando colocar o diafragma, a usuária deve ser capaz de sentir o colo do útero através da borracha, portanto deve estar bem familiarizada com tal identificação; • Urinar e lavar as mãos antes de colocar o diafragma; • Antes de cada uso, examinar cuidadosamente o diafragma contra a luz, para assegurar-se da inexistência de defeitos ou furos; • Em caso de uso com geleia espermicida, aplicá-la dentro da parte côncava do diafragma (mais ou menos uma colher das de chá); • Segurar o diafragma com uma das mãos, com a parte côncava virada para cima (com a geleia dentro), pressionar e unir as bordas com os dedos médio e polegar; • Afastar os lábios da vulva com a outra mão e colocar, dentro da vagina, o diafragma dobrado, empurrando-o na direção do fundo posterior da vagina até onde seja possível; • Com o dedo indicador, empurrar a borda anterior do diafragma até que esta se apoie na face posterior do púbis; • Verificar a correta colocação do diafragma por meio do auto-toque, certificando-se de que o colo uterino esteja coberto pela membrana de borracha; • Colocar o diafragma na vagina na posição que achar mais confortável (deitada, de cócoras ou em pé, com uma das pernas levantada ou sentada na beirada de uma cadeira); • O diafragma não deve ser retirado antes de um período de 06 nem maior que 24 horas após a última relação sexual, e deve-se evitar duchas vaginais durante esse período; • Remover o diafragma colocando o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o para baixo e para fora; • Após o uso, lavar o diafragma com água e sabão neutro, enxaguar bem, secar e guardar no estojo próprio.	• Requer utilização de técnica de medida por parte do profissional de saúde para indicar o melhor tamanho <u>*(VER TÉCNICA PARA MEDIÇÃO A SEGUIR)</u>; • A vida média útil do diafragma é em torno de 3 anos, se observadas as recomendações do produto; • O diafragma pode ser colocado antes da relação sexual (minutos ou horas) ou utilizado de forma contínua. Nesta última modalidade, é aconselhável retirar o diafragma uma vez ao dia, lavá-lo (preferencialmente durante o banho, desde que este ocorra pelo menos 6 horas após o coito) e imediatamente recolocá-lo. Durante a menstruação, o diafragma deve ser retirado, evitando, assim, a possibilidade de acúmulo de sangue na vagina/útero reduzindo o risco de infecção genital; • O uso frequente de espermicida associado ao diafragma causa irritação, fissuras e microfissuras na mucosa vaginal e cervical (efeito dose-tempo dependente), aumentando o risco de infecção pelo HIV e outras DST; • A detecção de IST é motivo para suspender o uso do método. O retorno ao uso, ficará condicionado à cura da infecção e reavaliação de risco de nova IST e infecção pelo HIV.

***TÉCNICA PARA MEDIÇÃO DO DIAFRAGMA:**

O tamanho adequado do diafragma para cada mulher corresponde ao comprimento diagonal do canal vaginal, desde a face posterior da sínfise púbica até o fundo do saco vaginal posterior. A medição deve ser feita por profissional de saúde treinado, por meio da seguinte técnica:

- 1 - Introduzir os dedos indicador e média na vagina, até que a extremidade do dedo médio atinja o fundo do saco vaginal posterior;
- 2 - Em seguida, com a ponta do polegar da mesma mão ou com o dedo de outra mão, marcar o local em que o dedo indicador toca a sínfise púbica;
- 3 - Retirar os dedos da vagina e medir o diâmetro aproximado;
- 4 - A distância da ponta do polegar e o local onde o dedo médio toca o fundo da vagina corresponde ao diâmetro aproximado;
- 5 - Partindo de um número inferior ao diâmetro aproximado, determinado pelo toque vaginal, experimentar as variações de 5 em 5mm, por meio dos anéis de prova ou, na ausência destes, de um jogo de diafragmas de amostra. Os diafragmas devem ser experimentados um a um, até se encontrar o que melhor se adapte à vagina;
- 6 - O anel (ou a borda do diafragma) deve tocar as paredes laterais da vagina e se assentar confortavelmente entre a sínfise púbica e o fundo de saco posterior;
- 7 - O diâmetro correto do diafragma é determinado ao se encontrar o maior tamanho que, adaptando-se perfeitamente à vagina, não fique deformado e não seja percebido com desconforto pela mulher.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

3.2.7 – Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre

A resolução COFEN nº 690/2022 normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo, define que o enfermeiro poderá realizar a inserção, supervisão e retirada de DIU se:

- Realizar curso de capacitação presencial, com carga horária mínima de 70 horas, sendo 20 horas teóricas e teórico-práticas e 50 horas práticas;
- Realizar no mínimo 20 (vinte) inserções supervisionadas por enfermeiro habilitado;
- Realizar atualizações regularmente, de acordo com as revisões de protocolos assistenciais, normas e rotinas;
- Recomenda-se ainda que, para realizar o curso de capacitação, o enfermeiro deverá obedecer aos critérios exigidos pelo treinamento ofertado pela rede para inserção de DIU por enfermeiros.

*Ressalta-se que a capacitação citada acima não está contemplada no treinamento de adesão aos protocolos de enfermagem.

*Todo o enfermeiro capacitado segue o Procedimento Operacional Padrão já estabelecido, a fim de garantir a segurança do usuário e profissional.

***O enfermeiro deverá sempre verificar a possibilidade de gravidez, de acordo com o Fluxograma 4 – Verificação da Possibilidade de Gestação para Contracepção**

*Priorizar inserção durante o ciclo menstrual (facilidade de inserção do método e descarte de gestação ao mesmo tempo).

*Realizar a coleta do citopatológico antes da inserção, caso esteja com rastreamento em atraso, de acordo com cap. 4 - PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO ^{1, 5, 11, 12, 13}.

*No caso de aumento do sangramento menstrual e/ou cólicas durante os 03 primeiros meses de uso, o enfermeiro deverá encaminhar paciente para o médico ou solicitar avaliação conjunta;

*Realizar o seguimento após a inserção:

- Em uma semana com enfermeira(o) de sua área de referência;
- Após o primeiro ciclo menstrual.
- Anualmente, caso não haja intercorrências.

Informações úteis sobre o DIU:

- Não há evidências para a recomendação de antibioticoterapia e/ou remoção do DIU em mulheres assintomáticas com citologia cervical positiva para Actinomyces (bacilo anaeróbio gram positivo integrante da flora vaginal e gastrintestinal normais). Nesse caso, é importante questionar e examinar a paciente sobre sinais e sintomas de DIP, procedendo conforme [Protocolo de Enfermagem Volume 2](#);

- Em caso de DIP, cervicite purulenta, tricomoniase, clamídia ou gonorreia, o enfermeiro deverá realizar o tratamento de acordo com o [Protocolo de Enfermagem Volume 2](#). O DIU poderá ser ofertado após 3 meses do tratamento completo e confirmando em uma nova avaliação que não há sinais de infecção;
- Nuligestas e nulíparas podem utilizar o método, no entanto as taxas de expulsão do dispositivo são discretamente mais elevadas;
- O DIU costuma ser eficaz se introduzido em menos de 48 horas do parto (procedimento realizado em ambiente hospitalar. neste caso), com ou sem aleitamento, desde que não haja infecção puerperal; ou após 4 semanas do parto;¹
- Nas demais situações, pode ser introduzido em qualquer período do ciclo menstrual, desde que afastada a possibilidade de gravidez. Sugere-se que seja dada preferência para a colocação durante o ciclo menstrual uma vez que os processos fisiológicos que ocorrem no colo uterino nesse período facilitam a colocação do dispositivo e reduzem o desconforto feminino;
- Em casos de inserção difícil ou histórico de expulsão anterior, o enfermeiro **poderá solicitar ultrassonografia transvaginal para avaliar o posicionamento do DIU.**

3.2.7.1 – Contraindicações do Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre

Quadro 26 – Contraindicações para o DIU de Cobre ⁴⁹

CONTRAINDICAÇÕES PARA O DIU DE COBRE			
Condição	Categoria de Elegibilidade		Observações
	Iniciando Método	Método já em Uso	
LUPUS - com severa trombocitopenia	3	2	
Pós-parto			
De 48 horas a <4 semanas	3		≥ 4 semanas é categoria 1
Sepse puerperal	4		
HIV			
Doença clínica de HIV grave ou avançada (estágio 3 ou 4 da OMS)	3	2	A condição é categoria 2 para inserção de DIU para pacientes assintomáticos ou doença clínica leve por HIV (estágio 1 ou 2 da OMS)
			Continua.

CONTRAINDICAÇÕES PARA O DIU DE COBRE

Condição	Categoria de Elegibilidade		Observações
	Iniciando Método	Método já em Uso	
Infecções e/ou distúrbios do trato reprodutivo			
Sangramento vaginal inexplicável (suspeito de condição grave), antes da avaliação	4	2	
Doença trofoblástica gestacional - Níveis de β-hCG diminuídos ou indetectáveis	3		
Doença trofoblástica gestacional - Níveis de β-hCG persistentemente elevados ou doença maligna	4		
Câncer cervical (aguardando tratamento)	4	2	
Câncer do endométrio	4	2	
Câncer do ovário	3	2	
Miomas uterinos – Com distorção da cavidade uterina	4		Miomas uterinos sem distorção da cavidade uterina é categoria 1
Anomalias anatômicas - Cavidade uterina distorcida	4		Outras anormalidades não distorcendo a cavidade uterina ou sem interferir na inserção (incluindo estenose ou lacerações) é categoria 2
Tuberculose Pélvica conhecida	4	3	
Doença inflamatória pélvica (DIP), cervicite purulenta atual, trichomonas, clamídia ou gonorreia	4	2	Não há necessidade de remover o DIU se desejar continuar a usá-lo. Se infecção passada (assumindo que não há fatores de risco atuais para ISTs) Pode ser inserido após 3 meses do tratamento completo, confirmando em avaliação que não há sinais de infecção.
Aumento do risco de ISTs	2/3*	2	*A condição é de categoria 3 se uma mulher tiver uma probabilidade individual muito alta de contrair ISTs

Fonte: Adaptado de WHO, 2022.

3.2.7.2 – Manejo para as Principais Intercorrências Relacionadas Ao DIU De Cobre

Quadro 27 – Manejo das Principais Intercorrências Relacionadas ao DIU⁵¹

MANEJO DAS PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO DIU			
Situação	Descrição	Conduta	Observações
Sangramento genital/aumento do fluxo menstrual	Efeito adverso mais comum.	Prescrever ibuprofeno 600mg 8/8h por até 5 dias ou nimesulida 100mg 12/12h por até 5 dias.	Atentar para a possibilidade de deslocamento do DIU, gravidez, infecção (endometrite ou salpingite), pólipos, leiomioma ou câncer endometrial.
Dor	Dismenorreia é comum, principalmente nos três primeiros meses.	Avaliar quanto a presença de DIP, gravidez ectópica, aborto, perfuração uterina ou expulsão do DIU. Se descartado outras complicações, prescrever ibuprofeno 600mg 8/8h por até 5 dias ou nimesulida 100mg 12/12h por até 5 dias.	Pode-se ofertar práticas integrativas como uso de auriculoterapia e acupuntura para auxílio das mulheres na redução da dor, durante e após a inserção do DIU, conforme protocolos vigentes e habilitação profissional. Uso de AINE antes da inserção não diminui a dor.
Reação vagal	Manobras bruscas de mobilização do colo ou mulheres mais susceptíveis podem desenvolver reação vaso-vagal, com hipotensão, palidez, bradicardia e sudorese.	Manter a mulher deitada em decúbito dorsal. Observação clínica para posterior liberação.	Se a reação vagal ocorrer antes da introdução do DIU, é recomendado a suspensão do procedimento.
Transfixação uterina	Evento raro, ocorrendo 1/1000 inserções. Não há sintomas específicos, mas podem estar presentes dor abdominal leve/moderada e sangramento uterino.	Realizar exame físico observando presença de sinais de alerta – encaminhar para avaliação médica se presentes. Caso o paciente não tenha exame de imagem (USG transvaginal) solicitar para verificar se realmente o DIU transfixou.	Se confirmado a transfixação, médico(a) deverá encaminhar para retirada Não há contraindicação para uso de outro DIU posteriormente.
Fio não identificado	O fio do DIU pode não estar visível devido à expulsão, perfuração, mau posicionamento e gravidez.	Introduzir escovinha da coleta do preventivo no canal endocervical e puxar rotacionando. Solicitar USG TV.	DIU normo-inserido com fio não aparente pode ser mantido até o momento previsto para a sua troca (10 anos após a inserção), quando a mulher deve ser encaminhada para retirada por meio de histeroscopia.
DIU não identificado na cavidade uterina	Pode ocorrer por expulsão ou perfuração com penetração do DIU na cavidade peritoneal.	Se exame de imagem (USG TV) confirma ausência de DIU na cavidade uterina, sem sinais de expulsão ou conhecimento da paciente, encaminhe ao médico para avaliação.	
Continua.			

MANEJO DAS PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO DIU

Situação	Descrição	Conduta	Observações
Infecção pélvica	Quando relacionado ao DIU, ocorre no primeiro mês de uso. A DIP está relacionada às ISTs, e não o DIU isoladamente.	Tratamento para vaginose é o mesmo para mulheres que não usam o DIU.	Não é necessário a retirada do DIU para o tratamento de DIP/vaginose. Na evidência de DIP, iniciar tratamento conforme descrito no Protocolo Volume 2 (prescrição médica).
Expulsão	Mais comum no primeiro ano de uso. Fatores de risco: inserção no pós-parto imediato, expulsão prévia de DIU, aumento do fluxo menstrual e dismenorrea severa. Suspeita de expulsão parcial: corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, sinusorragia ou dispareunia.	Se DIU identificado na cavidade vaginal, retirar e descartá-lo. Verificar possibilidade de gravidez (realizar TIG ou solicitar BHCG). Solicitar USG transvaginal.	Se exames de imagem (USG e RX de abdômen) não mostram DIU na cavidade uterina e peritoneal, considerar que DIU foi expulso.
Falha contraceptiva com uso do DIU	Risco de gravidez é maior no primeiro ano de uso. Risco maior de parto prematuro.	Se gravidez em uso de DIU, encaminhar para MFC para investigar gravidez tubária. Encaminhar para alto risco para retirada do DIU.	Uso do DIU não aumenta risco de gravidez ectópica Risco de aborto pode chegar a 50% (se removido precocemente, as taxas equivalem às de não usuárias de DIU).
DIU deslocado	O posicionamento ideal do DIU é no fundo uterino. Considera-se mal posicionado se algum segmento esteja inserido no miométrio, no canal cervical (abaixo do orifício interno) ou distante do fundo uterino (no istmo), o que pode ocorrer em 10% dos casos.	DIU localizado no istmo e que não descende ao canal cervical (localizado acima do orifício interno), em mulheres assintomáticas, não carecem de reposicionamento, uma vez que a probabilidade de expulsão é pequena. Posicionado abaixo do orifício interno, pode ser retirado e inserido novo DIU ou posicioná-lo por vídeo-histeroscopia (conduta médica).	

Continua.

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

MANEJO DAS PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO DIU

Situação	Descrição	Conduta	Observações
Actinomicose em colpocitologia	Actinomyces é um organismo comensal da vagina, mas pode associar-se à infecção quando há proliferação exagerada. Em mulheres que usam DIU de cobre, há maior prevalência deste organismo.	Não é necessário a retirada do DIU ou tratamento em mulheres assintomáticas. Quando há doença infecciosa pélvica por Actinomyces, remover o DIU (pois este organismo se desenvolve em corpos estranhos) e encaminhar para MFC para iniciar antibioticoterapia (penicilina ou derivados).	
Ressonância magnética	Mulheres que utilizam DIU de cobre podem realizar ressonância magnética da pelve com segurança.		Orientar à mulher que relate no local do exame que utiliza DIU pela possibilidade de afetar as sequências utilizadas e os artefatos do exame
Colpocitologia oncótica alterada	O uso do DIU não aumenta o risco de neoplasia intraepitelial cervical ou câncer de colo uterino.	Não há necessidade de retirada do DIU inicialmente, mas de acordo com o tratamento poderá retirado através da avaliação do especialista (encaminhar)	

Fonte: Adaptado de Giordano et al, 2015.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

3.2.8 – Contracepção de Emergência ^{1,2,11,12,13,46,49}

A contracepção de emergência consiste no método anticonceptivo para prevenção de gestação inoportuna ou indesejada após uma relação sexual desprotegida, ou falha conhecida ou presumida do método de rotina, conforme abaixo:

- 3 ou mais perdas consecutivas de comprimidos contraceptivos orais combinados;
- Pílula apenas com progestágeno (minipílula) tomada com mais de 3 horas de atraso;
- Contraceptivo injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona de depósito) aplicada com mais de 2 semanas de atraso;
- Contraceptivo injetável mensal (estrogênio e progestágeno) aplicada com mais de 7 dias de atraso;
- Dispositivo intra-uterino
- Erro de cálculo do método de abstinência periódica, ou a incapacidade de abster-se ou usar um método de barreira nos dias férteis do ciclo;
- Expulsão do DIU;
- Rompimento ou deslocamento do preservativo durante o ato sexual.

Quadro 28 – Síntese de Métodos Anticoncepcionais de Emergência

SÍNTESE DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS DE EMERGÊNCIA		
Método	Indicação	Observações
DIU de cobre	Inserção até 5 dias após a relação sexual desprotegida	• Realizar PEP (conforme Protocolo Volume 02) e Teste Rápido de Gravidez; • Eficácia de até 99% quando inserido em até 5 dias após a relação sexual desprotegida.; • Se o método contraceptivo de emergência for usado devido à violência sexual, o DIU não é recomendado devido ao risco de infecção sexualmente transmissível. • Seguir o Procedimento Operacional Padrão já estabelecido, assim como descartar possível gestação** no momento da inserção e realizar o seguimento após procedimento.
Levonorgestrel 0,75mg	2cp dose única, até 72 horas após a relação sexual desprotegida	• Realizar PEP (conforme Protocolo Volume 02) e Teste Rápido de Gravidez; • Eficácia de 89% quando usado em até 72 horas após a relação sexual desprotegida. • Não se recomenda mais a utilização de esquema fracionado, utilizado anteriormente, por não aumentar a eficácia e ter o risco de esquecimento do segundo comprimido; • Se houver vômitos até uma hora após a ingestão dos comprimidos, repetir a dose.

Apesar da facilidade de acesso ao método, que pode ser prescrito e inserido por enfermeiro capacitado institucionalmente, **a contracepção de emergência não deverá substituir as medidas de planejamento reprodutivo e familiar**, devendo ser desencorajado seu uso rotineiro pelo paciente. É necessário lembrar que o uso repetitivo ou frequente da Anticoncepção de Emergência (AE) compromete sua eficácia ao longo do tempo devido ao acúmulo das sucessivas taxas de falha por cada exposição.

Na indisponibilidade dos comprimidos de levonorgestrel ou quando não houver indicação para inserção de DIU, o enfermeiro deverá encaminhar a mulher para consulta médica.

4 - PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO ^{1, 5, 11, 12, 13}

No Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres e a quarta causa de morte de mulheres por câncer. Com exceção do câncer de pele, esse tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente.

É fundamental garantir o acesso a rastreamento em consultas agendadas e/ou em demanda espontânea/opportunística.

A citologia oncótica (Papanicolaou, colpocitopatológico, Paptest, entre outros) é o exame de rastreamento universal para o câncer de colo do útero e sua realização é recomendada para todas as **mulheres entre 25 e 64 anos**, independentemente da orientação sexual, incluindo mulheres que fazem sexo com outras mulheres que já tenham tido penetração (grupo que menos se submete ao exame) e homens trans. O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais.

Se alterações suspeitas no colo forem detectadas no exame especular, independentemente da idade/aprazamento, é permitido realizar a coleta. Isso vale em casos de relato de sangramento vaginal depois das relações sexuais, no intervalo entre as menstruações ou após a menopausa. Não sendo, no entanto, recomendado como rastreamento para população geral, fora da faixa etária preconizada, uma vez que a incidência do câncer invasor do colo do útero em mulheres até 24 anos é muito baixa e o rastreamento é menos eficiente para detectá-lo além de aumentar risco de iatrogenias.

Para mulheres com mais de 64 anos que nunca se submeteram ao exame, recomenda-se realizar duas vezes, com intervalo de um a três anos. No caso de resultado negativo, elas não precisam fazer novos exames, visto que não há evidências de efetividade do rastreamento após os 65 anos.

Como medidas preventivas, o enfermeiro deve informar à paciente que alguns fatores aumentam a predisposição para a doença: infecção por HPV, sexo desprotegido, tabagismo, paridade, imunossupressão e uso de contraceptivos orais.

Para mulheres fora da população alvo para rastreamento de câncer de colo do útero, deve **ser estimulada a vacinação contra o HPV entre 09 anos e 14 anos 11 meses e 29 dias, em dose única e realização da estratégia de resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias, para resgatar os não vacinados (aqueles com dose zero de vacina HPV)**. A vacina contra o HPV também está disponível para as mulheres e homens de 09 a 45 anos de idade vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos, ou de medula óssea e pacientes oncológicos, imunossuprimidos por doenças e/ou tratamento com drogas imunossupressoras sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses) e vítimas de violência sexual se imunocompetentes verificar esquema vacinal de acordo com a faixa etária. Recentemente, pessoas de 15 a 45 anos que tomam Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) foram incluídas no público da vacina contra o HPV (NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 101/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS).

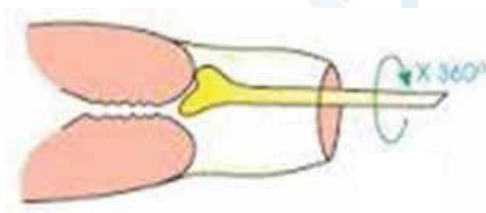
Para que o rastreamento seja eficaz, é importante levar em conta a utilização correta da técnica de coleta, o transporte e conservação adequados da amostra. Para garantir boa representação celular do epitélio do colo do útero, o exame citopatológico deve conter amostra do canal cervical (endocérvice) coletada com escova apropriada e da ectocérvice, coletada com espátula tipo ponta longa (espátula de Ayre).

4.1 – TÉCNICA DE COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA

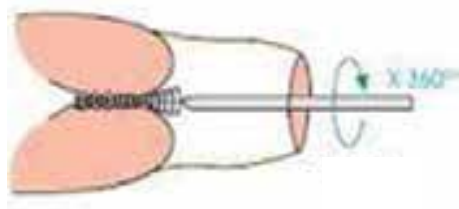
A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais, assim como exames de ultrassonografia transvaginais com uso de gel condutor, deve ser evitada por 48 horas antes da coleta, pois essas substâncias recobrem os elementos celulares dificultando a avaliação microscópica, prejudicando a qualidade da amostra para o exame citopatológico.

O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. O melhor período do ciclo para a coleta é o ovulatório, sendo recomendado aguardar pelo menos cerca de 5 dias após a menstruação para a realização da coleta. No entanto, no caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e a coleta, se indicada, pode ser realizada.

Para coleta na ectocérvice utiliza-se espátula de Ayre, do lado que apresenta reentrância. Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo o orifício cervical, para que toda superfície do colo seja raspada e representada na lâmina, procurando exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, para não prejudicar a qualidade da amostra.



Para coleta na endocérvice, utilizar a escova endocervical. Recolher o material introduzindo a escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360°, percorrendo todo o contorno do orifício cervical.



Estender o material sobre a lâmina de maneira delicada para a obtenção de um esfregaço uniformemente distribuído, fino e sem destruição celular. O esfregaço obtido deve ser imediatamente fixado para evitar o dessecamento do material.



Fonte: Acervo dos autores.

Muitas vezes o profissional se depara com situações especiais que suscitam dúvidas sobre a coleta da citologia oncológica. O quadro a seguir procura explicitar as situações referentes à coleta de citopatológico, dando direcionamento ao profissional enfermeiro na prática ginecológica durante a consulta de enfermagem.

4.2 – RECOMENDAÇÃO PARA COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS

Quadro 29 – Recomendações para Coleta de Citopatológico em Mulheres entre 25 e 64 Anos^{5,12}

RECOMENDAÇÕES PARA COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM MULHERES ENTRE 25 E 64 ANOS	
Situação	Recomendação
Mulheres que não iniciaram a vida sexual	Não há indicação para rastreamento do câncer de colo do útero e seus precursores nesse grupo de mulheres.
Mulheres até 24 anos	- Apesar de essa faixa etária não ser alvo do rastreamento do câncer do colo do útero, as recomendações que seguem visam a orientar os profissionais como proceder na situação em que recebam essas mulheres com esse diagnóstico citológico. - Se a mulher até 24 anos tiver sido submetida ao exame citopatológico e apresentar ASC-US ou Lesão Intraepitelial de Baixo Grau, a citologia deverá ser repetida em três anos até os 25 anos. No caso de novo exame normal, reiniciar o rastreamento aos 25 anos. A qualquer momento, caso apresentem citologia com alterações mais graves, deverão ser encaminhadas à colposcopia.
Gestantes	- Seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres (25 a 64 anos); - O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde para realização de pré-natal.
Climatério e pós-menopausa	- Devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres; - Na eventualidade de o laudo do exame citopatológico mencionar dificuldade diagnóstica decorrente de atrofia epitelial; ou a mulher apresentar vaginite/colpíte atrófica que dificulte a coleta (sem queixas), realizar estroginização pela administração de Estriol 0,1% creme vaginal de preferência à noite, durante 21 dias, com pausa de 5 a 7 dias para realização da coleta; - Caso a vaginite/colpíte atrófica gere queixas, seguir orientações do <u>Capítulo 7 - ATENÇÃO À MULHER NO PUERPÉRIO – CONSULTA PÓS-NATAL</u>. Atenção: Embora a absorção sistêmica do estrogênio tópico seja mínima, não prescreva para mulheres com história de carcinoma de mama ou demais tumores estrogênio-dependentes.
Continua.	

RECOMENDAÇÕES PARA COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM MULHERES ENTRE 25 E 64 ANOS	
Situação	Recomendação
Histerectomizadas	- Em caso de histerectomia subtotal (com permanência do colo do útero), deve seguir rotina de rastreamento; - Em caso de histerectomia total: não se faz mais rastreamento, pois a possibilidade de encontrar lesão é desprezível; Exceção: se a histerectomia foi realizada como tratamento de câncer de colo do útero ou lesão precursora (ou foram diagnosticados na peça cirúrgica), seguir o protocolo de controle de acordo com o caso, realizando a coleta na porção final da vagina: - Lesão precursora – controles cito/colposcópicos semestrais até dois exames consecutivos normais; - Câncer invasor – controle por cinco anos (trimestral nos primeiros dois anos e semestral nos três anos seguintes); se controle normal, citologia de rastreio anual.
Mulheres infectadas pelo vírus HIV, imunossuprimidas por transplante de órgãos sólidos, em tratamentos de câncer e em uso crônico de corticosteroides	- O exame citopatológico deve ser realizado após o início da atividade sexual (não há idade mínima), com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão, inclusive depois dos 64 anos (não há idade máxima); - Em mulheres HIV positivas com CD4 abaixo de 200 células/mm³, deve ser priorizada a correção dos níveis de CD4 e, enquanto isso, deve ser realizado rastreamento citológico a cada seis meses; - Considerando a maior frequência de lesões multicêntricas, é recomendado cuidadoso exame da vulva (incluindo região perianal) e da vagina. - Mulheres imunossuprimidas apresentando ASC-US ou LSIL em resultado citológico devem ser encaminhadas para colposcopia já no primeiro exame alterado.
Mulheres que buscam o CS para realização da citologia oncológica em função de corrimentos	- Embora a avaliação de corrimentos vaginais não demande a coleta de colpocitológico, a queixa deve ser avaliada no momento do exame e tratada quando necessário, não descartando a oportunidade de realizar a coleta do material se o motivo de contato da mulher se deu pelo corrimento; - Em alguns casos, como na suspeita de tricomoniase, recomenda-se tratar a mulher e reagendar a coleta do material cervical em 03 meses, pelo risco de prejuízo da amostra.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

No caso de os resultados não se apresentarem normais ou com amostra insatisfatória, é sugerida uma rotina de aprazamento e encaminhamentos conforme recomendações do INCA e Ministério da Saúde, descrita abaixo no quadro 30, considerando outros achados clínicos descritos no quadro 31.

4.3 – RECOMENDAÇÃO E CONDUTA CONFORME RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO ¹

Quadro 30 – Recomendações e Condutas Conforme os Resultados do Exame Citopatológico de Colo Uterino

RECOMENDAÇÕES E CONDUTAS CONFORME OS RESULTADOS DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO		
Resultado	Especificação	Recomendações
Atipias de significado indeterminado	Em células escamosas; Provavelmente não neoplásica.	Repetição da citologia em 06 meses ou 12 meses. Se dois exames citopatológicos subsequentes com intervalo de 06 meses (no caso de mulheres com 30 anos ou mais) ou 12 meses (no caso de mulheres com menos de 30 anos) forem negativos, a mulher deverá retornar à rotina de rastreamento citológico trienal; se achado de lesão igual ou mais grave, encaminhar para colposcopia.
	Não se pode afastar lesão de alto grau.	Encaminhar para a colposcopia e proceder encaminhamentos conforme Quadro 32
	Em células glandulares; Provavelmente não neoplásica; não se pode afastar lesão de alto grau.	Encaminhar para a colposcopia e proceder encaminhamentos conforme Quadro 32
	De origem indefinida; Provavelmente não neoplásica; não se pode afastar lesão de alto grau.	Encaminhar para a colposcopia e proceder encaminhamentos conforme Quadro 32
Lesão intraepitelial de baixo grau	--	Repetição da citologia em 06 meses: Se dois exames negativos, seguir rotina de rastreamento; se lesão igual ou mais grave, encaminhar para colposcopia.
Lesão intraepitelial de alto grau	--	Encaminhar para a colposcopia com urgência via regulação, e proceder encaminhamentos conforme Quadro 32
Continua.		

RECOMENDAÇÕES E CONDUTAS CONFORME OS RESULTADOS DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO		
Resultado	Especificação	Recomendações
Lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasor.	--	Encaminhar para a colposcopia com urgência via regulação, e proceder encaminhamentos conforme <u>Quadro 32</u>
Adenocarcinoma in situ ou invasor	--	Solicitar ao MFC encaminhamentos necessários para o CEPON.
Amostra insatisfatória	--	Repetir o exame em 3 meses com correção, quando possível, do problema que motivou o resultado insatisfatório.
Amostra satisfatória, porém com presença de células escamosas, apenas	--	Repetir o exame com intervalo de 01 ano, e com dois exames normais anuais consecutivos, o intervalo poderá ser de 3 anos.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

4.4 – ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO¹

Quadro 31 – Achados Clínicos Comuns no Colo Uterino

ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO		
Achado Clínico	Explicação	Conduta do Enfermeiro
Ectopia	Trata-se de um achado clínico relativamente comum, sendo normalmente resultado da eversão da JEC (junção escamo-colunar) por causas fisiológicas relacionadas ao ciclo menstrual, gravidez ou uso de contraceptivos hormonais.	Não há indicação de intervenção na maioria dos casos. É fundamental reforçar a importância do uso de preservativo tendo em vista que a exposição de uma área mais vascularizada torna a mulher mais suscetível a contrair ISTs, em especial clamídia, gonorreia e HPV. Havendo dúvidas, aguardar o resultado do preventivo e repetir o exame especular para descartar alterações transitórias. Na persistência, correlacionar com o resultado do preventivo, queixas do usuário (sangramento após as relações sexuais, mucorreia excessiva) e, se necessário, encaminhar à colposcopia, orientando que a usuária leve o resultado do preventivo.
Cisto de Naboth	São achados benignos oriundos da obstrução dos ductos excretores das glândulas endocervicais	Não há necessidade de encaminhamento para outro profissional já que não há intervenção necessária.
Pólipos cervicais	Apresentam-se como projeções da mucosa pelo orifício cervical.	As condutas do enfermeiro são as mesmas adotadas no caso das ectopias.
Continua.		

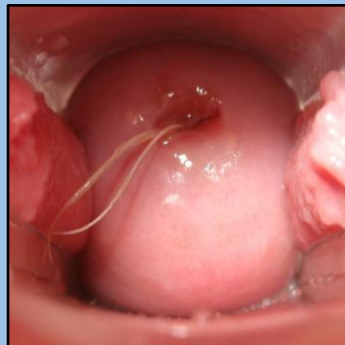
ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO

Exame Especular^{26,27}

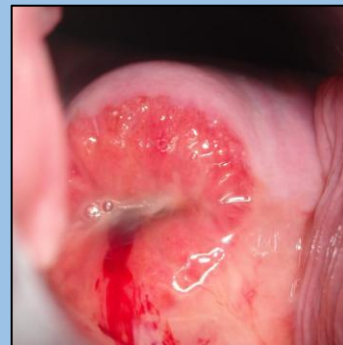
Normal



Nulípara: Colo róseo, sem ectopia, óstio puntiforme, leucorréia fisiológica



Colo róseo, ectopia discreta periorificial, óstio puntiforme, presença de fios do DIU no óstio externo, cistos de Naboth em lábio anterior, leucorréia fisiológica



Colo róseo, ectopia extensa, presença de sangramento ativo em óstio externo, óstio em fenda, leucorréia fisiológica.

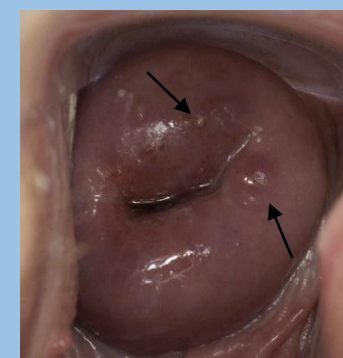


Multípara: Colo corado, ectopia presente, óstio em fenda sugestivo de laceração cervical prévia, leucorréia fisiológica.



Climatério/menopausa: Colo hipocorado, sem ectopia, óstio puntiforme com atrofia, muitas vezes apresenta petéquias e/ou é friável.

Considerar estrogenização local conforme Quadro 29

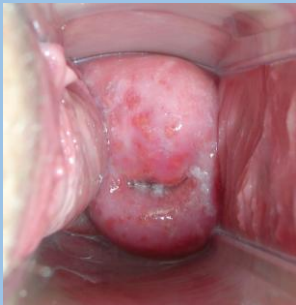


Cistos de Naboth: achados normais no exame especular

Continua.

ACHADOS CLÍNICOS COMUNS NO COLO UTERINO

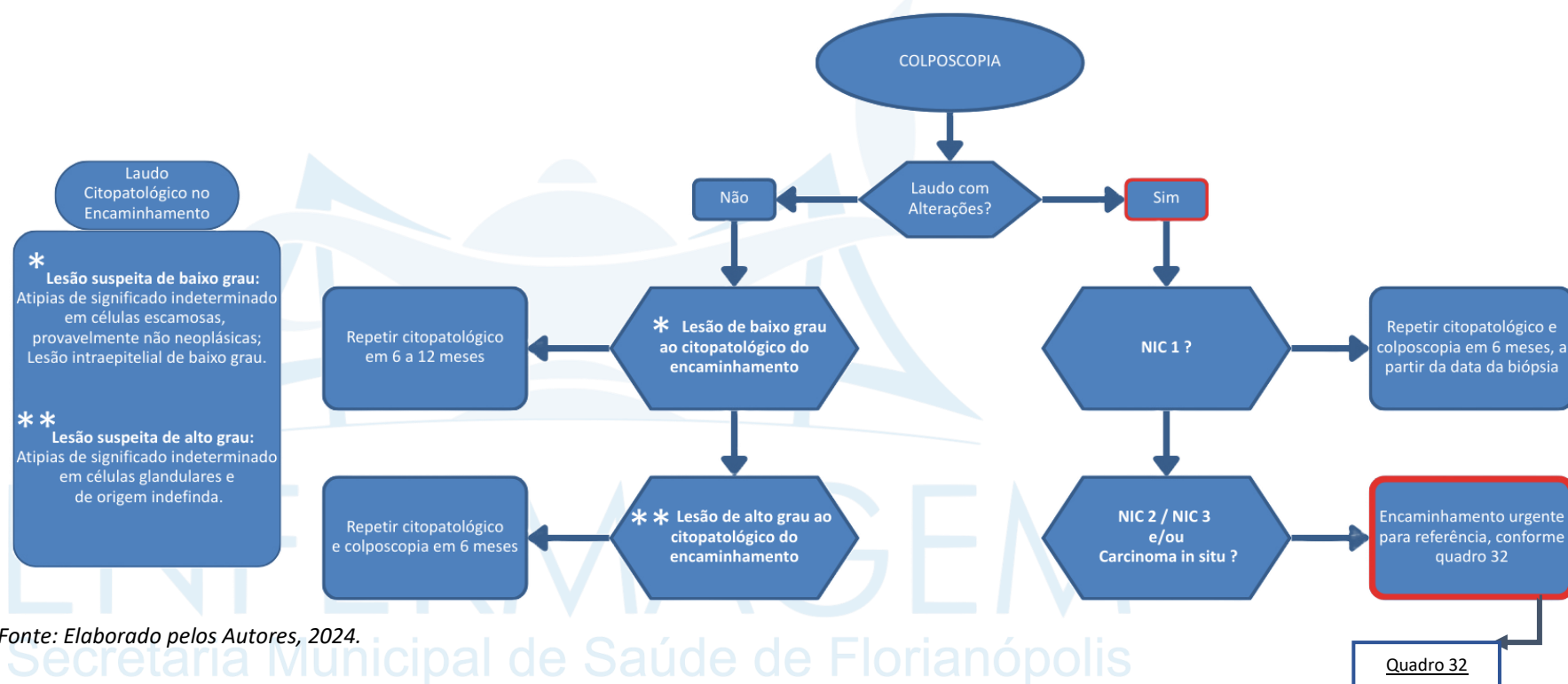
Exame Especular^{26,27}

ANORMAL					
					
	Colo com sinais de inflamação, hiperemiado, com presença de leucorréia em grumos brancos (aspecto de leite qualhado) sugestivo de colpíte por <i>Candida Albicans</i>. Tratar conforme capítulo <u>2.1.1 - Abordagem às Principais Causas de Corrimento Vaginal</u> e coletar CP (se uso de creme vaginal, realizar coleta 48h após término do tratamento).	Colo com lesão macroscópica em lábio posterior, provável lesão condilomatosa saliente. Realizar coleta de CP e encaminhar para colposcopia.	Colo com sinais de inflamação, hiperemiado, com aspecto framboesa sugestivo de colpíte por <i>Trichomonas vaginalis</i>. Tratar conforme capítulo <u>2.1.1 - Abordagem às Principais Causas de Corrimento Vaginal</u> e reagendar a coleta do material cervical em 3 meses, pelo risco de prejuízo da amostra.	Colo com presença de pólipos exteriorizados através do óstio externo. Encaminhar para ginecologia, se queixa de sangramento vaginal e/ou dispareunia.	Colo com presença de mucopus em óstio externo sugestivo de cervicite por <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ou <i>Chlamydia trachomatis</i>. Tratar mulher e parceiro conforme <u>protocolo vol 2</u>.

4.5 – COLPOSCOPIA

A colposcopia é um exame diagnóstico utilizado para examinar de maneira detalhada o colo do útero, a vagina e a vulva, com o objetivo de identificar alterações celulares ou lesões precursoras de câncer, como displasias cervicais. Durante o exame, o profissional utiliza um colposcópio, um equipamento com lentes de aumento e luz, que permite uma visualização ampliada das áreas anatômicas envolvidas. Para os enfermeiros, é fundamental compreender a importância da colposcopia como uma ferramenta de triagem para a detecção precoce de lesões cervicais, principalmente em mulheres com resultados alterados no exame de Papanicolau.

Fluxograma 5 – Condutas Conforme Resultado Da Colposcopia



Quadro 32 – Condutas de Interpretação e Encaminhamento Conforme Laudo da Colposcopia

CONDUTAS DE INTERPRETAÇÃO E ENCAMINHAMENTO CONFORME LAUDO DA COLPOSCOPIA		
Presença de Alteração no Exame	Resultado	Conduta do Enfermeiro
Colposcopia SEM Alterações	Exame normal sem alterações	- Caso encaminhamento tenha sido por Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL): <u>Repetir citopatológico em 6 e 12 meses;</u> - Caso encaminhamento tenha sido por Lesão intraepitelial de alto grau (ex: HSIL): <u>Repetir citopatológico e colposcopia em 6 meses.</u>
Colposcopia COM Alterações	- Lesão Intraepitelial Escamosa de baixo grau (LSIL) - Neoplasia Intraepitelial - Cervical Grau 1 (NIC I) - Neoplasia - Intraepitelial Vaginal de Grau 1 (NIVa 1)	- Repetir <u>citopatológico e colposcopia</u> em 6 meses a partir da data de realização da biópsia. <u>Avaliação ginecologia</u> - seguimento compartilhado.
	- Neoplasia Intraepitelial Cervical de Alto Grau 2 e 3 (NIC II, III) - Carcinoma in situ.	- Encaminhamento prioritário via <u>Regulação (Sisreg)</u> para Patologia Cervical Unidade de referência Terciária. - Seguimento compartilhado com Ginecologia após avaliação da referência Terciária.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

- Consulte POP - Gestão do Cuidado em Colposcopia em:
<https://docs.google.com/document/d/1fcgBuorGqvTAdGvN3umJzF9cycz8mVwug4ZVFewuL5I/edit?usp=sharing>

5 - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA ^{1,5,11,12}

5.1 – AÇÕES DE RASTREAMENTO

O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo tipo mais incidente na população feminina.

Trata-se de uma condição muitas vezes relacionadas a fatores de risco que aumentam as possibilidades do surgimento da doença, tais como: menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, primeira gestação após 30 anos, antecedentes familiares de câncer de mama (especificamente na mãe e nas irmãs), excesso de peso, sedentarismo, exposição à radiação ionizante e terapia de reposição hormonal.

O rastreamento do câncer de mama no Brasil, conforme as novas diretrizes do Ministério da Saúde, organiza-se da seguinte forma para a prática de enfermagem:

Para a população geral, o rastreamento com mamografia é realizado a cada dois anos para mulheres na faixa etária de **50 a 74 anos**. Para mulheres entre **40 e 49 anos**, o acesso à mamografia é garantido no SUS sob demanda, sendo imprescindível que a enfermagem atue na **decisão compartilhada**, orientando de forma clara sobre os benefícios e os possíveis danos do exame nessa idade.

Já para o grupo de **Alto Risco** (cerca de 1% da população), é indicado o início do rastreamento anual mais precoce, a partir dos **35 anos**, com exame clínico das mamas e mamografia para seguintes critérios:

- Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama ou ovário, abaixo dos 50 anos de idade;
- Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino
- Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ;

***Nota Técnica de Florianópolis de 25 de setembro de 2025:** Atualização das Diretrizes do Ministério da Saúde (MS) para o Rastreamento Mamográfico em Mulheres de Risco Habitual. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1MqFTJO6ozBEAPWMs5Cz8fEsrQdtBqEBnk7nRieFij_8/edit?usp=sharing.

O aprazamento das **mamografias de rastreamento** deverá seguir a rotina sugerida pelo MS²⁵, conforme quadro abaixo.

5.1.1 – Aprazamento das Mamografias de Rastreamento

Quadro 33 – Aprazamento Das Mamografias De Rastreamento ²⁵

APRAZAMENTO DAS MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO	
População alvo	Periodicidade do rastreamento com mamografia
Mulheres de 50 – 74 anos	Exame clínico das mamas sob demanda e previamente à solicitação de mamografia de 2 em 2 anos.
Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado	Exame clínico das mamas sob demanda e previamente à solicitação de mamografia anual.
Mulheres de 40 – 49 anos*	Exame clínico das mamas sob demanda (mesmo sem sinais e sintomas) e decisão compartilhada e informada sobre riscos e desvantagens para acesso à solicitação de Mamografia de 2 em 2 anos.

***Considerando a ampliação do acesso, o MS utiliza “decisão compartilhada” como mecanismo de cautela, reconhecendo os danos potenciais do rastreamento nessa faixa etária segundo as melhores evidências.**

5.1.2 – Resultados da Mamografia e Condutas da APS no Rastreo de Câncer de Mama

1,11,13

Quadro 34 – Resultados da Mamografia e Condutas da APS no Rastreo de Câncer de Mama

RESULTADOS DA MAMOGRAFIA E CONDUTAS DA APS NO RASTREAMENTO DE CÂNCER DE MAMA	
Resultado da Mamografia (BIRADS)	Conduta do Enfermeiro
0 – Inconclusivo	Avaliação adicional - interconsulta com MFC para pactuação da conduta sobre solicitação de exame de imagem adicional (USG de mamas ou mamografia adicional – compressão focal ou magnificação), sendo de solicitação médica.
1 – Sem achados	Rotina de rastreamento.
2 – Achado benigno	Rotina de rastreamento.
3 – Achado provavelmente benigno	Controle radiológico em 6 meses. Se persistência do achado, encaminhar ao MFC ou interconsulta com esse para segmento/encaminhamento.
4 – Achado suspeito	Encaminhamento para MFC/médico equipe ou interconsulta com esse para avaliar seguimento/encaminhamento imediatos.
5 – Achado altamente suspeito	Encaminhamento para MFC/médico equipe ou interconsulta com esse para avaliar seguimento/encaminhamento imediatos.
6 – Achado com diagnóstico de câncer, mas não tratado	Encaminhamento para MFC/médico equipe ou interconsulta com esse para avaliar seguimento/encaminhamento imediatos.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

O exame clínico das mamas (ECM), é imprescindível na avaliação de lesões suspeitas de neoplasia mamária, bem como na diferenciação entre nódulos palpáveis e não palpáveis. O **rastreamento por meio do exame clínico é alvo de grande controvérsia na literatura científica**, pois não há dados suficientes que o recomendem por melhorias na eficácia do diagnóstico, bem como o isentem de sobrediagnóstico. O INCA lançou em 2015 as “Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil”, em que não há sugerida nem a recomendação nem a contra-recomendação deste procedimento, uma vez que **o balanço entre possíveis danos e benefícios é incerto**. Dessa forma, fica facultada ao enfermeiro a realização do exame conforme sua habilidade para a execução do procedimento enquanto método de rastreamento.

Sobre a solicitação de ultrassonografias de mamas como **método de rastreamento**, o Ministério da Saúde contra recomenda o procedimento, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.

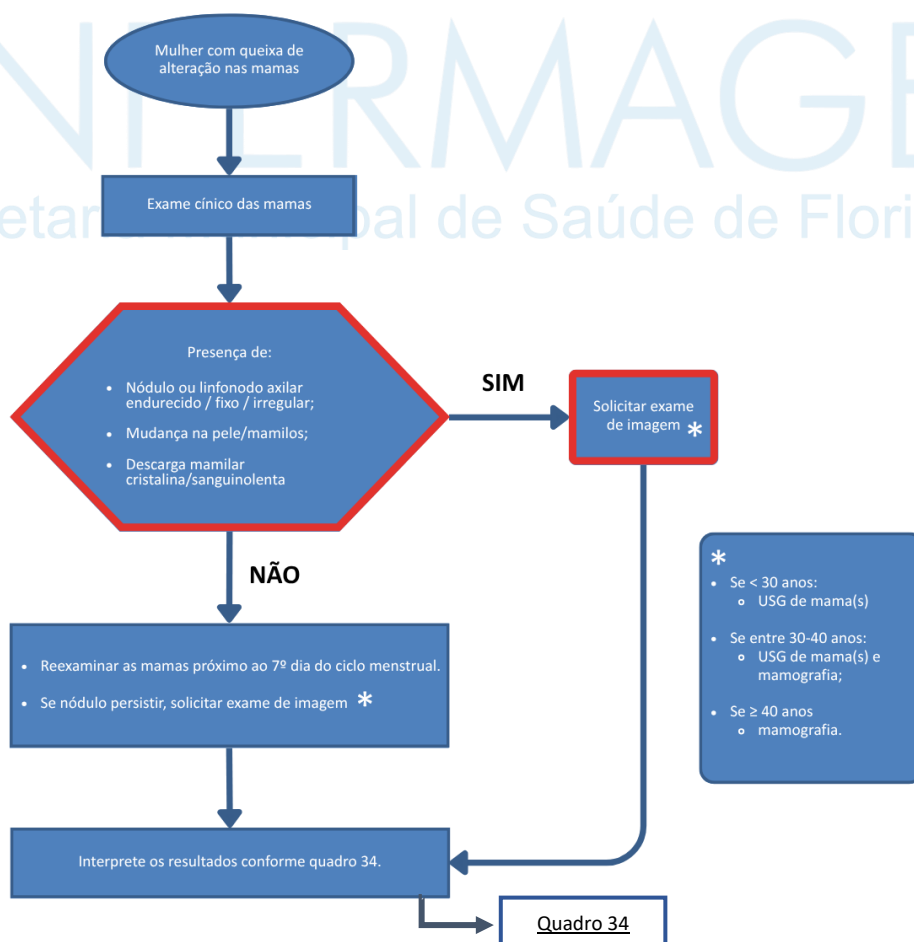
5.2 – AÇÕES MEDIANTE A PRESENÇA OU RELATO DE SINAIS OU SINTOMAS

Diante dos seguintes sinais e sintomas, o enfermeiro deverá realizar interconsulta com MFC para pactuação da conduta ou encaminhar a paciente imediatamente para a consulta médica:

- Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos;
- Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual;
- Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade;
- Descarga papilar sanguinolenta unilateral;
- Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos
- Presença de linfadenopatia axilar;
- Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja;
- Retração na pele da mama;
- Mudança no formato do mamilo.

Tais sinais podem servir de evidência para alguma alteração possivelmente grave nas mamas, e por isso exames complementares se fazem necessários para uma adequada investigação, conforme abaixo:

Fluxograma 6 – Alteração nas Mamas



Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

5.3 – MASTALGIA E OUTROS SINTOMAS MAMÁRIOS ^{1,11}

A mastalgia é uma queixa muito comum nos atendimentos de rotina. Pode estar relacionada, na maioria das vezes, com processos fisiológicos do organismo feminino modulados pelo sistema endócrino ou até mesmo como sintoma de gestação.

Como regra, sinais e sintomas que desaparecem totalmente após a menstruação raras vezes são causados por processos malignos. Em algumas situações a mastalgia pode estar relacionada ao uso de contraceptivos hormonais (principalmente com altas dosagens de estrogênio) ou terapias de reposição hormonal, pois o uso de hormônios pode agravar o desconforto nas mulheres mais sensíveis, sendo contraindicados nos casos de mastalgia mais acentuada.

As alterações funcionais benignas da mama, antes equivocadamente denominadas “displasias mamárias”, são variações da fisiologia normal da glândula mamária nas suas transformações evolutivas e involutivas ao longo do ciclo de vida da mulher. Como entidade clínica, essas alterações podem ser definidas como uma síndrome caracterizada por dor mamária e nodularidade, que pode ser difusa ou localizada, em uma ou em ambas as mamas.

Diante da queixa de mastalgia, muitas vezes a elucidação da sua relação com processos fisiológicos para a paciente é uma conduta suficiente para maior tolerância à dor e desmistificação deste sintoma como indicativo de casos de câncer. Entretanto é importante apurar a presença de alterações mamárias por meio do ECM e seguir as orientações conforme preconizado pelo MS.

Quadro 35 – Condutas para Mastalgia e/ou Outras Queixas Mamárias ¹¹

CONDUTAS PARA MASTALGIA E/OU OUTRAS QUEIXAS MAMÁRIAS	
Situação	Conduta do Enfermeiro
Mastalgia COM Febre (Tax>38°C)	- Desconfiar de mastite e encaminhar ao MFC para avaliação imediata. Na ausência deste, encaminhe ao serviço de referência; - Em caso de nutrízes, além da conduta acima, avaliar ingurgitamento mamário e orientar medidas conforme cap. <u>7.3 - ABORDAGEM AO ALEITAMENTO MATERNO</u> ^{1,11,12}.
Mastalgia SEM Febre	- Investigar gestação; - Tranquilizar a paciente sobre o fato de o câncer raramente causar dor; - Verificar o uso do sutiã e orientar uso de roupa íntima adequada se necessário; - Se gestante, tranquilize e ofereça cuidado pré-natal, evitando medicação; Prescrever paracetamol 500 mg a cada 6 horas por até 3-5 dias ou ibuprofeno* 300-600mg por até 3-5 dias. - Se persistência do quadro, encaminhar para o MFC e solicitar retorno para reavaliação; - Se Método Anticoncepcional (MAC) hormonal, discutir possibilidade de troca para método não hormonal no caso de já haver passado os 3 primeiros meses de uso e mantido este efeito colateral.

Continua.

CONDUTAS PARA MASTALGIA E/OU OUTRAS QUEIXAS MAMÁRIAS	
Situação	Conduta do Enfermeiro
Descarga Papilar Espontânea em Não Nutrizes	- Investigar gestação; - Verificar o uso de medicações que podem cursar com este sintoma: - Contraceptivos hormonais, medicamentos com efeito de galactagogos (sulpirida, domperidona, metoclopramida), metildopa e digoxina; - Apurar características da descarga: - Bilateral ou unilateral? - Unilateral costuma ser maior sinal de gravidade. - Bilateral costuma ter relação hormonal, mas não se deve descartar hipóteses menos favoráveis; - Láctea ou Serosa: tranquilizar a paciente; - Sanguinolenta ou Purulenta: solicitar exame de análise de descarga papilar.
Retração Mamilar	Se for uma alteração recente, encaminhar para avaliação com MFC.
Descamação e Erosão do Mamilo / Aréola ou Pele com Aspecto de Laranja	- Encaminhar para o MFC, agendando consulta prioritária. - Considerar doença de Paget.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

* Tomar com / após alimentação.

- Evite se: Úlcera péptica, reação alérgica severa prévia ou exacerbação de asma, doença renal, gestação ≥ 30 semanas.
- Cuidado se: Paciente ≥ 65 anos, hipertensão, insuficiência cardíaca, dispepsia, uso de AAS, corticosteroides, varfarina, abuso de álcool.

Você Sabia?



O autoexame das mamas, que foi muito estimulado no passado, não provou ser benéfico para a detecção precoce de tumores e por trazer falsa segurança, dúvida e excesso de exames invasivos. Portanto, não deve ser orientado para o reconhecimento de lesões, embora possa ser recomendado para que a mulher tenha conhecimento de seu próprio corpo, devendo o profissional de saúde valorizar as queixas e percepções da paciente.

O efeito do rastreamento mamográfico em mulheres entre 40 e 49 anos tem demonstrado ser desfavorável enquanto medida de saúde coletiva. Apresenta taxa significativa de falsos-positivos, gerando estresse, procedimentos desnecessários e não alterando o desfecho da mortalidade por câncer de mama.

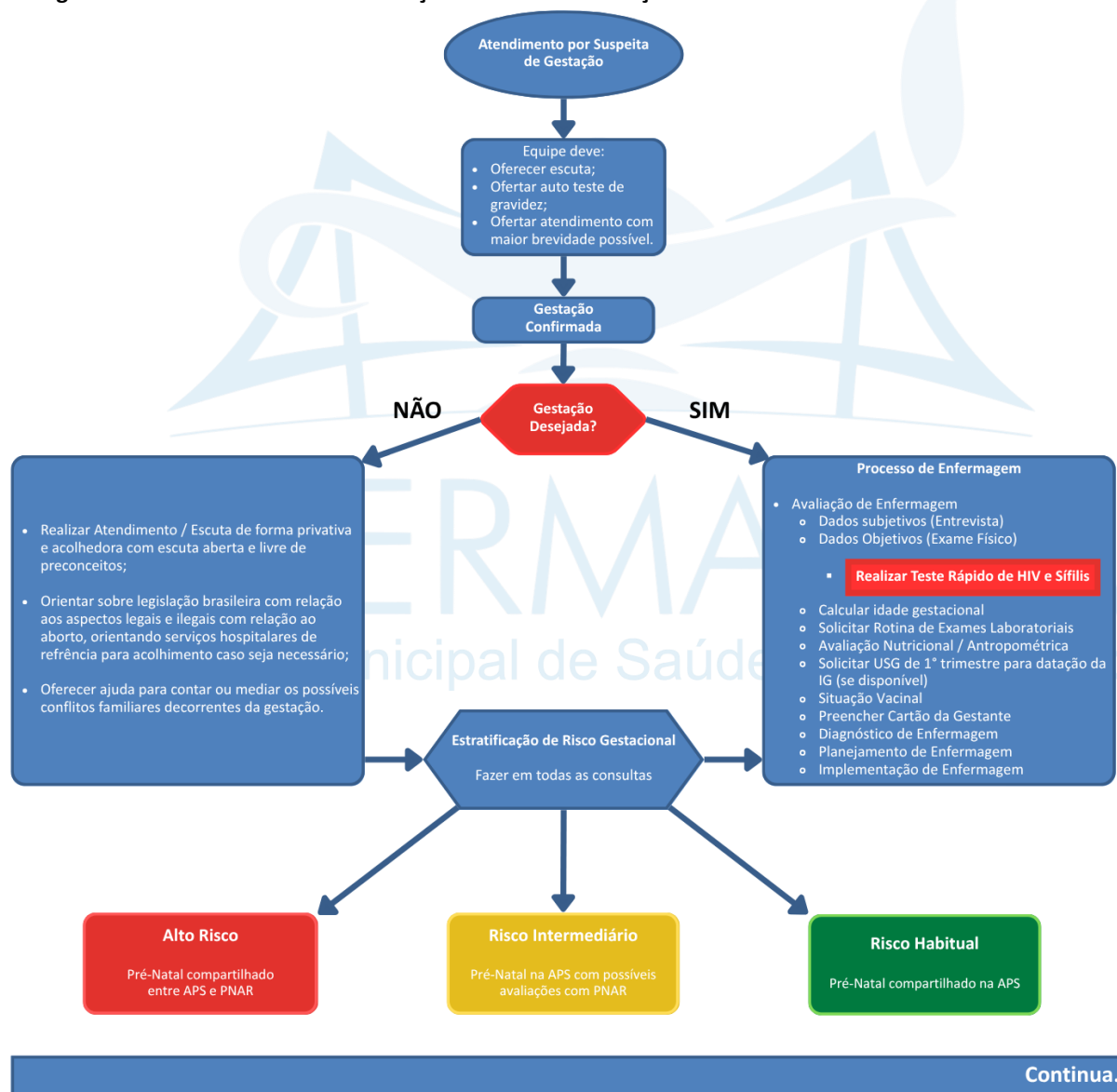
Há estudos que sugerem que a eficácia do rastreamento do câncer de mama é questionável quanto ao desfecho da prevenção de mortes por essa doença. Um deles chega a afirmar que o malefício causado pelo sobrediagnóstico sobrepõe-se ao benefício da detecção precoce.

Também há estudos que demonstram a indução de cânceres de mama em função da exposição inadvertida à radiação ionizante (como nas mulheres com menos de 50 anos que se submetem periodicamente ao exame de mamografia).

6 - ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL

O enfermeiro, ao atender mulher em idade fértil com atraso menstrual de uma semana ou superior, deve considerar a possibilidade de gravidez. A informação de uso de método anticoncepcional (MAC) não exclui essa hipótese, sendo necessária a realização de teste rápido (TIG) ou laboratorial (BHCG) para confirmação. Em caso de resultado positivo devem ser implementadas as primeiras condutas do pré-natal, começando pela classificação de risco.

Fluxograma 7 – Atendimento e Classificação de Risco na Gestação



Alto Risco

Pré-Natal compartilhado entre APS e PNAR

- Encaminhar para Pré-Natal Odontológico;
- Elaborar plano de cuidados, auto cuidado e plano de parto centrados na pessoa e nos riscos ocorridos;
- Realizar a implementação de enfermagem buscando monitorar, seguir e acompanhar a estabilização clínica e vigilância para detecção precoce de agravos decorrentes dos fatores de risco e morbidades identificadas.

Risco Intermediário

Pré-Natal na APS com possíveis avaliações com PNAR

- Encaminhar para Pré-Natal Odontológico;
- Elaborar plano de cuidados, auto cuidado e plano de parto centrados na pessoa;
- Realizar a implementação de enfermagem acompanhando, monitorando e seguindo as ações de prevenção de agravos decorrentes dos fatores de risco.

Risco Habitual

Pré-Natal compartilhado na APS

- Encaminhar para Pré-Natal Odontológico;
- Elaborar plano de cuidados, auto cuidado e plano de parto centrados na pessoa;
- Encaminhar visita para maternidades;
- Desenvolver práticas educativas, integrativas e culturais conforme oferta, disponibilidade e habilidade da equipe.

- O seguimento, de acordo com as recomendações do MS e OMS, deve ser:
 - Até 28 semanas: mensalmente;
 - De 28 a 36 semanas: quinzenalmente;
 - De 36 até 41 semanas/parto: semanalmente, ajustando a frequência conforme a necessidade da gestante, caso precise de um intervalo menor.
- Recomenda-se planejar junto à paciente e à equipe as consultas de rotina do pré-natal, intercalando entre enfermagem e medicina. É importante agendar ou encaminhar a consulta de pré-natal odontológico e demais especialidades, como psicologia, nutrição, serviço social etc., se o caso exigir cuidado multidisciplinar (discutir ou incluir o profissional seguindo seus fluxos de trabalho).
- Entre 40 e 41 semanas, encaminhar para a maternidade de referência para avaliação da vitalidade fetal.
- No caso de pacientes que desejam realizar laqueadura, orientar a paciente a levar o encaminhamento e o termo de consentimento devidamente assinados por ela e pela equipe. Não há necessidade de registro em cartório.
- Não existe alta da Assistência Pré-Natal. Esse tipo de assistência transiciona para o período intra e pós-parto, onde a equipe é responsável não somente pelo atendimento pós-parto da puerpera, mas também do recém-nascido.
- Em situações emergenciais como sangramento, trabalho de parto prematuro, alteração no BCF etc., é importante a avaliação de urgência na maternidade de referência (verificar as situações no fluxo de classificação de risco).
- Atenção ao risco de transmissão vertical!
 - Ofereça o teste rápido quantas vezes for necessário, de acordo com cada caso, centrado na história da pessoa. O diagnóstico precoce salva crianças e gestantes.
- Mantenha todos os registros atualizados com informações legíveis no cartão de pré-natal e no prontuário da pessoa.
- Realize busca ativa em caso de ausência em consultas programadas ou no pós-parto, caso não compareça aos seguimentos puerperais e de acompanhamento do RN.
- Monitorar é fundamental para o sucesso da assistência pré-natal e um parto seguro. Avalie a presença em consultas, a realização de exames e seus resultados, sinais de alerta e agravos ou comorbidades.
- Mesmo que a paciente seja referenciada para o PNAR, ela continua com seu vínculo e acompanhamento com a equipe de Saúde da Família, que é a ordenadora da assistência pré-natal.
- Evite termos pejorativos (Mãezinha, príncipezinho, princesinha, paizinho). Cada pessoa é diferente e pode interpretar a forma como você se refere a ela como desrespeitosa. Chame pelo nome, pergunte se a pessoa prefere ser chamada por algum pronome diferente. Seja respeitoso, empático e gentil em todas as situações, e acolhedor nas situações diversas ou atípicas às quais você está culturalmente acostumado como profissional de saúde. Estude sempre habilidades de comunicação, letramento em saúde e gênero; com certeza, isso repercutirá em sua prática para melhor.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

6.1 – ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO PRÉ-NATAL

Ao enfermeiro compete o acompanhamento do pré-natal de risco habitual/baixo risco, com o devido encaminhamento para o alto risco diante das situações apresentadas no quadro abaixo. A gestante que realiza o pré-natal de alto risco deverá, igualmente, ser acompanhada no Centro de Saúde (CS) pelo seu enfermeiro de referência e demais profissionais que compõem a equipe de Saúde da família. A estratégia de risco deve ser realizada em todo atendimento realizado com a gestante. A classificação de risco é uma das grandes ferramentas de prevenção da Mortalidade Materna, Fetal, Infantil e de Transmissão vertical.

6.1.1 – Fluxo de Encaminhamento para Estratificação de Risco Gestacional em Florianópolis

Quadro 36 – Fluxo de Encaminhamento para Estratificação de Risco Gestacional em Florianópolis

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL EM FLORIANÓPOLIS		
	PNAR SMS: Encaminhado por Enfermagem e Medicina	PNAR - SES: Encaminhado somente por Medicina
Condições Clínicas Prévia	- HAS crônica compensada; - Hipotireoidismo compensado; - Doença cardíaca/cardiopatia compensada (ex.: ICC); - Obesidade grau I (IMC 30-34,9) e II (IMC 35-39,9); - História de cirurgia cervical e/ou uterina anterior; - Pneumopatias moderadas (ex.: asma, DPOC); - Epilepsia; - Cirurgia bariátrica há mais de 6 meses; - Alterações genéticas parentais; - Histórico de transplante de órgão; - Anormalidade no trato geniturinário (ex.: rim único, rim em ferradura, útero bicornio, malformação uterina, miomatose > 4 cm ou múltiplos ou miomas submucosos, tumores anexiais e outras anormalidades que causem restrição de cavidade uterina, especialmente se associada a abortamento/prematuridade); - Presença de DIU; - HIV com diagnóstico prévio à gestação; - Encaminhar também para a SMS - CONSULTA EM INFECTOLOGIA ADULTO	- HAS descompensada; - Cardiopatias com repercussão hemodinâmica; - Diabetes mellitus 1 ou 2; - Tireoidopatias (ex.: hipertireoidismo ou hipotireoidismo clínico); - Hepatopatias crônicas (ex.: hepatites virais, cirrose); - Doença psiquiátrica grave (ex.: psicoses, depressão grave); - Estratificar risco e, se necessário, encaminhar também para equipe multiprofissional e CAPS; - Obesidade grau III (IMC > 40); - Pneumopatias graves (ex.: asma, DPOC); - Doença renal grave; - Doenças hematológicas (ex.: doença falciforme, púrpura trombocitopênica autoimune (PTI) e trombótica (PTT), talassemias, coagulopatias), antecedentes de tromboembolismo; - Hemopatias e anemia grave (hemoglobina < 8 g/dl); - Doenças autoimunes (ex.: collagenose); - Cirurgia bariátrica há menos de 6 meses; - Uso de medicamentos teratogênicos; - Anticonvulsivantes: barbitúricos, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, primidona e fenobarbital; - Estabilizadores de humor: carbonato de lítio, ácido valpróico;

Continua.

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL EM FLORIANÓPOLIS

	PNAR SMS: Encaminhado por Enfermagem e Medicina	PNAR - SES: Encaminhado somente por Medicina
História Reprodutiva Anterior	- História de ≥ 2 abortos espontâneos consecutivos; - História de morte fetal ou neonatal; - História de placenta prévia, acretismo placentário; e/ou descolamento prematuro de placenta - História de parto pré-termo; - História de anomalia congênita/malformação fetal; - História de RN com peso < 2500 g ou > 4500 g; - História de crescimento intrauterino restrito; - História de pré-eclâmpsia prévia;	- Incompetência istmo cervical em gestação anterior; - Pré-eclâmpsia com resultado obstétrico ruim: eclâmpsia, síndrome HELLP, óbito fetal intrauterino, internação materna em UTI; - Psicose puerperal na gestação anterior;
Intercorrências Clínicas/Obstétricas Na Gestação Atual	- HAS gestacional compensada; - Diabetes gestacional não compensada com dieta durante 2 semanas; - Infecção urinária de repetição (3x ou mais) ou infecção urinária alta na gestação; - Hiperêmese gravídica refratária (após internação por vômitos persistentes com desidratação e perda de peso $> 5\%$); - Zika, dengue e chikungunya na gestação atual - Citopatológico alterado (lesão intraepitelial de baixo grau); - AIDS/HIV prévio à gestação; - Encaminhar também para a SMS - CONSULTA EM INFECTOLOGIA ADULTO	- Doença hipertensiva da gestação/pré-eclâmpsia; - Cálculo renal com obstrução; - Restrição de crescimento intrauterino; - Feto acima do percentil 90% ou suspeita de macrosomia; - Polidrâmnio/oligodrâmnio; - Colo curto em USG transvaginal entre 20 e 24 semanas; - Suspeita de acretismo placentário; - Placenta prévia com diagnóstico após 28 semanas de gestação com ou sem sangramento; - Hepatopatias (por exemplo: colestase gestacional ou elevação de transaminases); - Anemia grave ou anemia refratária ao tratamento - Isoimunização RH; - Câncer materno com diagnóstico ou tratamento durante a gestação; - Neoplasias ginecológicas na gestação atual; - Alta suspeita clínica de câncer de mama; - Gemelaridade; - Sífilis (terciária ou com achados ecográficos sugestivos de sífilis congênita ou resistente ao tratamento com penicilina benzatina); • <u>Ver também próxima página.</u>

Continua.

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL EM FLORIANÓPOLIS

	PNAR SMS: Encaminhado por Enfermagem e Medicina	PNAR - SES: Encaminhado somente por Medicina
Intercorrências Clínicas/Obstétricas Na Gestação Atual	<u>Página Anterior.</u>	• Condiloma acuminado (no canal vaginal/colo ou lesões extensas localizadas em região genital/perianal); • Hepatites agudas com diagnóstico em gestação atual; • Hanseníase com diagnóstico na gestação atual; • AIDS/HIV com diagnóstico na gestação; ○ Encaminhar também para SMS - CONSULTA EM INFECTOLOGIA - ADULTO • Mais de um parto prematuro (<36 semanas); • Tuberculose; • Toxoplasmose ou Rubéola ou Citomegalovírus diagnosticado na gestação atual com risco de transmissão fetal; • Lesão de alto grau em colo uterino (NIC II - III); • Suspeita de malformação fetal ou arritmia fetal; • Dependência e/ou uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; ○ Encaminhar também para equipe multiprofissional e CAPS-AD; • Endocrinopatias descompensadas;

Fonte: Extraído do Protocolo de Acesso Pré Natal de Alto Risco.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

6.1.2 – Situações Clínicas Encaminhadas ao Serviço de Urgência / Emergência Obstétrica

Quadro 37 – Situações Clínicas Encaminhadas ao Serviço de Urgência / Emergência Obstétrica

SITUAÇÕES CLÍNICAS ENCAMINHADAS AO SERVIÇO DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

- Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta prévia);
- Amniorrexe prematura: perda de líquido vaginal (consistência líquida, em pequena ou grande quantidade, mas de forma persistente), podendo ser observada mediante exame especular com manobra de Valsalva e elevação da apresentação fetal;
- Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial $\geq 140/90$ em duas oportunidades na consulta após as 20 semanas de idade gestacional;
- Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito;
- Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia);
- Crise hipertensiva (PA $\geq 160/110$);
- Anemia grave (Hb ≤ 8) com repercussão hemodinâmica;
- Trabalho de parto prematuro (contrações e modificação de colo uterino em gestantes com menos de 36 semanas);
- IG a partir de 41 semanas confirmadas;
- Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes;
- Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular ou outra infecção que necessite de internação hospitalar;
- Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes (dor no membro inferior, edema localizado e/ou varicosidade aparente);
- Investigação de icterícia;
- Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento sistêmico;
- Restrição súbita de crescimento intrauterino – oligodrâmnio – no terceiro trimestre;
- Diminuição da movimentação fetal, BCF persistentemente < 120 ou > 160 bpm, outras situações clínicas que necessitem de avaliação do bem-estar fetal;
- Suspeita de óbito fetal.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

6.2 – PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL

Quadro 38 – Processo de Enfermagem para Consulta Pré-Natal

PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL - 1ª CONSULTA

• 1. AVALIAÇÃO - COLETA DE DADOS SUBJETIVOS (ENTREVISTA COMPLETA)

- **Históricos Clínico** (comorbidades, patologias, intervenções cirúrgicas etc.); **Ginecológico** (intervenções cirúrgicas, patologias, intercorrências, agravos, método utilizado anteriormente); **Obstétrico** (nº de gestações, abortamentos, tipo de parto, filhos vivos, intercorrências etc.) e **familiar** (comorbidades, rede de apoio etc.)
- **Hábitos de vida** (tabagismo, álcool, má alimentação, drogas, sedentarismo etc.); **Condições socioeconômicas e culturais** e **Avaliação psicossocial inicial** (humor, ansiedade, expectativa, rede de apoio)
- Avaliar estado vacinal e calcular idade gestacional;

• 1. AVALIAÇÃO - COLETA DE DADOS OBJETIVOS (EXAME FÍSICO)

- Coletar Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites;
- Aferir Sinais Vitais (PA, FC, Tº, FR);
- Aferir Peso e Altura (cálculo IMC);
- Exame Clínico Ginecológico e Obstétrico;
- Revisão de exames solicitados;
- Avaliação do bem-estar fetal;

• 2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM

- Conhecimento deficiente relacionado ao processo da gestação inicial, evidenciado por verbalização de dúvidas sobre os primeiros sinais e cuidados.
- Ansiedade relacionada à confirmação da gravidez e expectativas futuras, evidenciada por verbalização de preocupações e incertezas.
- Conforto prejudicado relacionado às alterações fisiológicas da gravidez.
- Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais (ou menos do que as necessidades corporais).
- Padrão de sono perturbado relacionado a alterações hormonais e desconforto físico.
- Manifestações: Preocupação excessiva, inquietação, tensão.
- Risco de infecção relacionado às alterações imunológicas e fisiológicas da gestação.
- Disposição para conhecimento melhorado sobre cuidados na gravidez.
- Risco de volume de líquidos deficiente/excessivo relacionado a alterações hemodinâmicas e retenção hídrica.
- Mobilidade física prejudicada relacionada a alterações posturais e peso fetal.
- Risco de adesão ineficaz ao regime terapêutico relacionado à falta de conhecimento ou recursos.

• 3. PLANEJAMENTO

- Realizar um planejamento de cuidados voltado para a história da gestante a ser atendida correspondendo ao diagnóstico de enfermagem levantado;
- Estabelecer metas e resultados esperados;
- Descrever as intervenções necessárias para alcance das metas e resultados esperados
- Planejar ações de acordo com grau de entendimento e letramento da gestante sobre sua saúde na Gravidez.
- Oferecer escuta ativa, validar os sentimentos e queixas e responder as suas dúvidas;
- Orientar cuidados de promoção da saúde e tecnologias não farmacológicas de cuidado centrado na história da gestante;
- Orientar sobre a importância e realização dos exames laboratoriais
- Realizar a classificação de Risco e encaminhar para PNAR se necessário conforme fluxo municipal;
- Realizar, entregar, aconselhar e orientar os laudos para os testes rápidos;
- Prescrever e orientar sobre a suplementação de ácido fólico;
- Avaliar a necessidade de outras profilaxias e adequar conforme recomendação;

• 4. IMPLEMENTAÇÃO (As intervenções planejadas deverão ser descritas para o sujeito da implementação)

- Exemplo: Retornar em 7 dias.
- Tomar ácido fólico etc.
- Realizar exames de rotina de 1º trimestre (conforme 6.3 – EXAMES DE ROTINA PARA GESTANTE, solicite um a um)
- Tomar ácido fólico 0,2mg (40 gotas) ou 1 cp de 5mg conforme disponibilidade, até 12 semanas de gestação
- Agendar a próxima consulta. (Retornar em X dias/mês)

• 5. EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

- Avaliar os resultados alcançados que foram planejados
- Descrever os resultados já implementados/alcançados
- Apontar necessidades de retorno para completar o planejamento de enfermagem
- Registrar todas as informações do episódio de cuidado.

Obs.: Os diagnósticos de enfermagem e as intervenções definidas no planejamento e descritas na implementação constituem modelo mínimo para a consulta, podendo existir outros conforme necessidade da paciente e raciocínio clínico do enfermeiro.

Continua.

PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL

1º TRIMESTRE	• Dar seguimento mensal para situações de baixo risco nas consultas de enfermagem seguindo o Processo de Enfermagem e registros preconizados no prontuário e Cartão da Gestante; • Recomenda -se que as consultas sejam intercaladas entre Enfermagem e Medicina com encaminhamento para PNAR e Equipe multi quando necessário. • Solicitar e avaliar exames de Rotina de 1º trimestre; • Realizar testes rápidos de 1º trimestre; • Atenção a Classificação de Risco; • Atenção às profilaxias recomendadas conforme clínica da gestante; • Atenção ao Cálculo de IG, avaliação nutricional, Exame físico completo BCF e Sinais vitais; • Aconselhamento e orientação de cuidados de Promoção a saúde; • Avaliar Estado Vacinal;
2º TRIMESTRE	• Dar seguimento mensal para situações de baixo risco nas consultas de enfermagem seguindo o Processo de Enfermagem e registros preconizados no prontuário e Cartão da Gestante; • Recomenda -se que as consultas sejam intercaladas entre Enfermagem e Medicina com encaminhamento para PNAR e Equipe multi quando necessário. • Solicitar exames de Rotina de 2º trimestre; • Realizar testes rápidos de 2º trimestre; • Atenção a Classificação de Risco; • Atenção às profilaxias recomendadas conforme clínica da gestante; • Atenção ao Cálculo de IG, avaliação de ganho de peso, Exame físico completo BCF e Sinais vitais; • Aconselhamento e orientação de cuidados de Promoção a saúde; • Manejo dos desconfortos;
3º TRIMESTRE	• Recomendado seguimento quinzenal de 28 a 36 semanas, semanal de 36 a 41 semanas para situações de baixo risco nas consultas de enfermagem seguindo o Processo de Enfermagem e registros preconizados no prontuário e Cartão da Gestante; • Solicitar avaliação na maternidade com 40 semanas, para avaliação de vitalidade fetal; • Recomenda -se que as consultas sejam intercaladas entre Enfermagem e Medicina com encaminhamento para PNAR e Equipe multi quando necessário. • Solicitar exames de Rotina de 3º trimestre; • Realizar testes rápidos de 3º trimestre; • Atenção a Classificação de Risco; • Construção do Plano de Parto; • Atenção às profilaxias recomendadas conforme clínica da gestante; • Atenção ao Cálculo de IG, avaliação de ganho de peso, Exame físico completo BCF e Sinais vitais; • Aconselhamento e orientação de cuidados de Promoção a saúde sobre período pré-parto, intra-parto e pós-parto; • Assegurar acesso a consulta puerperal e do Recém-nascido, bem como apoio a amamentação; • Manejo dos desconfortos;

6.2.1 – Exame Clínico Obstétrico (Cefalocaudal)

Quadro 39 – Exame Clínico Obstétrico (Cefalocaudal)

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

Preparo da Gestante e do Ambiente

- Acolher a gestante, explicar o procedimento e obter consentimento verbal, pedindo licença posteriormente para tocar no corpo da gestante;
- Antes de iniciar o exame lavar as mãos e aquecê-las se caso for necessário;
- Pedir para gestante esvaziar a bexiga antes do exame, se for oportuno já realize a coleta de exame, conforme necessidade e disponibilidade;
- Garantir ambiente privativo, tranquilo e confortável;

Aferição de Sinais Vitais

- **AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL:**
 - A medição da Pressão Arterial (PA) é um componente fundamental da avaliação obstétrica e deve ser realizada em todas as consultas de pré-natal (baixo e alto risco), de demanda espontânea, no trabalho de parto, no pós-parto e no período puerperal. Devido às alterações Fisiológicas da gestação (como modificações hemodinâmicas e hormonais).
 - A técnica de aferição deve ser rigorosa e correta, pois é um procedimento essencial tanto para o diagnóstico precoce de síndromes hipertensivas quanto para o monitoramento da saúde materna e fetal, em que erros na medição podem levar a resultados falsamente alterados, impactando o diagnóstico e manejo clínico.
 - Após a aferição os valores devem ser devidamente registrados no cartão da gestante (que deve estar sempre com ela) e no prontuário.
- **Técnica Correta:**
 - **Posicionamento:**
 - A gestante deve estar sentada, com as costas apoiadas, pernas descruzadas, pés apoiados no chão e braço na altura do coração. Em situações de difícil posicionamento, pode-se aferir em decúbito lateral esquerdo.
 - **Manguito:**
 - Deve ser adequado ao braço da paciente, cobrindo de 80% a 100% da circunferência do braço. O uso de manguitos inadequados (muito pequenos ou grandes) compromete a precisão da medida. No caso de gestantes obesas utilizar o manguito braquial largo, adequado para pessoas obesas.
 - **Local de Aferição:**
 - Preferencialmente no braço direito, desde que não haja contraindicações (como lesões ou fístulas). Braço despido sem roupas ou acessórios compressivos.
 - **Momento:**
 - A paciente deve estar em repouso por 5- 10 minutos antes da aferição, em ambiente calmo. Evitar aferir a Pressão Arterial em gestantes com bexiga cheia; evitar conversa durante a medição.
 - **Interpretação:**
 - Normal: PA <140/90 mmHg;
 - Alerta: PA ≥140/90 mmHg (avaliar sintomas e repetir em 4-6 horas)
 - Urgência: ≥ 160/110 mmHg (Encaminhamento para maternidade imediato).

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

Aferição de Sinais Vitais

- **AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL**

- **Atenção:**
 - ⚠ O diagnóstico de síndromes hipertensivas na gestação, como **pré-eclâmpsia**, exige além da elevação da PA, a investigação de outros critérios laboratoriais e clínicos, sempre discuta o caso e avaliação com Medicina.
 - ❖ Em caso de ausência de médico no momento, encaminhe para avaliação na maternidade. Aferições isoladas em situações de estresse, dor ou conversa durante o procedimento podem gerar falsos positivos.
 - ⚠ **Atenção à Hipotensão de Supina:** Na posição supina o útero grávido comprime a veia cava inferior dificultando o retorno venoso da metade inferior do corpo ao coração, reduzindo então o enchimento cardíaco, diminuindo assim o débito cardíaco, provocando então uma hipotensão arterial
 - ❖ Orientar nesse caso gestante manter decúbito lateral esquerdo;
 - ⚠ Avaliar em conjunto com MFC, a necessidade de monitoramento pressórico com registro e alteração na frequência das consultas reduzindo o intervalo das consultas de pré-natal e encaminhamento para Alto Risco.

- **AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR**

- **Indicações:**
 - Quando é necessário monitorar os fatores de risco para diabetes gestacional (IMC elevado, idade ≥ 25 anos, histórico familiar de diabetes, histórico de macrosomia, entre outros) ou ainda quando existe uma suspeita diagnóstica pelo relato/queixa da gestante;
 - Quando monitoramento de diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG);
 - Quando queixas clínicas como hipoglicemia, mal-estar, sudorese, tontura ou cefaleia.
 - **Atenção:**
 - ⚠ Este exame não substitui os exames preconizados no **Rastreamento Pré Natal**, ele auxilia na assistência não medicamentosa da gestante, diminuindo iatrogenias e facilitando a intervenção em casos de alteração, quando necessária;
- **Preparo:**
 - **Jejum:** 8-12hs para glicemia em jejum;
 - **Sem jejum:** Para medidas pós prandiais (1 ou 2 horas após as refeições);
 - **Eventualmente:** Em casos de mal-estar, sinais de hipoglicemia ou hiperglicemia;
 - **Atenção:** Se gestante tiver praticado algum tipo de atividade física antes, pode interferir no resultado;
- **Técnica Correta:**
 - **Material:**
 - Glicosímetro, lanceta, fita reagente e álcool 70%.
 - **Procedimento:**
 - 1. Higienizar as mãos da gestante.
 - 2. Realizar antisepsia do dedo (preferencialmente lateral do terceiro ou quarto dedo).
 - 3. Realizar a punção após secar o álcool.
 - 4. Desprezar a primeira gota e coletar a segunda, quando indicado.
 - 5. Registrar o valor, horário e situação (jejum, pós-prandial ou ocasional).

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

Aferição de Sinais Vitais

- **AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR**
 - **Interpretação:**
 - Em jejum: Até 92 mg/dl;
 - 1 h pós prandial: Até 140 mg/dl;
 - 2h pós prandial: Até 120 mg/dl;
-  **Valores Críticos:**

 -  **< 60mg/dl (hipoglicemia)**
 - ❖ Oferecer carboidrato de ação rápida (suco/bala)
 - ❖ Solicitar avaliação médica;
 -  **> 200mg/dl (hiperglicemia grave)**
 - ❖ Encaminhar para avaliação médica imediata;
- **Cuidados:**
 - Usar glicosímetro calibrado com fitas válidas;
 - Alternar os dedos, para evitar lesões (quando for necessário realizar monitoramento);
 - Registrar o valor, data, horário e condições no prontuário e no cartão da Gestante ou folha/caderno de monitoramento glicêmico;
 - **AFERIÇÃO DE SPO2 / TEMPERATURA**
 - Aferir temperatura e SPO2 sempre que gestante apresentar queixas ou avaliação física indicar que é necessário.

DADOS ANTROPOMÉTRICOS

- **AFERIÇÃO DE PESO**
 - Monitorar o ganho ponderal adequado, identificando e classificando riscos como desnutrição ou excesso de peso que possam impactar na saúde materno infantil.
 - Aferir em todas as consultas de pré-natal, em balança preferencialmente digital (maior precisão), calibrada e em superfície plana;
 - Pesar com roupas leves ou peso estimado das roupas descontado, sem calçados e com bexiga vazia;
 - Registrar em prontuário e Cartão da gestante;
 - Ganho de peso recomendado (IOM, 2009):
 - Baixo peso (IMC <18,5)
 - Peso Normal (IMC entre 18,5 e 24,9)
 - Sobrepeso (IMC entre 25 e 29,9)
 - Obesidade (IMC >= 30) - Realizar Classificação de Risco;
- Atenção:**

 -  **Ganho Insuficiente**
 - Risco de Restrição de Crescimento fetal;
 -  **Ganho Excessivo**
 - Maior Chance de Macrossomia, DMG e Hipertensão;

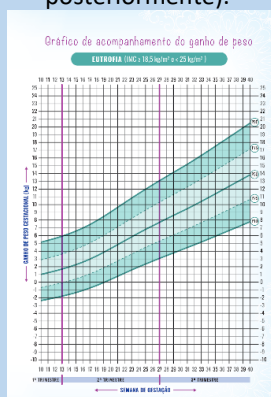
Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

DADOS ANTROPOMÉTRICOS

• AFERIÇÃO ALTURA

- Tem como objetivo calcular o IMC pré gestacional para avaliar o ganho de peso adequado durante a gestação e acompanhamento nutricional.
- Procedimento:
 - Gestante em posição ereta em pé, descalça, com costas retas e calcanhares unidos.
 - Com o estadiômetro vertical ou fita métrica fixa na parede, alinhar a régua horizontal no topo da cabeça e ler os centímetros acusados;
 - Realizar o registro na 1ª consulta no prontuário e cartão da gestante (não é necessário repetir aferição posteriormente).



INSPEÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

• CABEÇA

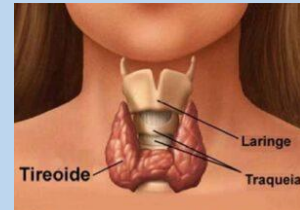
- Sinal de Halba:
 - Observe a formação de lanugem (pelos finos) nos limites do couro cabeludo. Isso é um sinal fisiológico da gestação, indicando maior nutrição dos folículos pilosos devido às alterações metabólicas e hormonais.
- Mucosas Oculares:
 - Verifique a coloração das mucosas. Elas podem estar coradas (normais) ou hipocoradas (pálidas), o que pode sugerir **anemia**, condição comum na gravidez.
- Nariz:
 - Inspeccione a presença de **edema** (inchaço). O inchaço nasal é frequente na gestação devido ao aumento do volume sanguíneo e à vascularização.
- Cloasmas (Melasma Gravidico):
 - Avalie a pele da face para identificar manchas escuras, principalmente no rosto. Essas manchas são causadas pelo aumento da melanina, estimulada pela progesterona. Oriente a gestante sobre a importância do **uso de protetor solar** para prevenção e manejo.
- Gengivas:
 - Examine as gengivas para sinais de **sangramento ou lesões**. A gestação pode intensificar a inflamação gengival, tornando-as mais sensíveis e propensas a sangrar.
- Dentição:
 - Faça uma inspeção geral dos dentes. É fundamental que a gestante seja encaminhada para **avaliação pré-natal odontológica** como parte da rotina de pré-natal.
- Mucosa Orofaríngea e Canal Auditivo:
 - Avalie essas áreas apenas se houver queixas específicas ou indicação clínica.

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

INSPEÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

- **PESCOÇO**
- **Circunferência do Pescoço:**
 - Observe o aumento da circunferência do pescoço. Essa alteração é frequentemente causada pela **hipertrofia fisiológica da tireoide**, que se torna mais evidente por volta do quinto mês de gestação. Qualquer nódulo ou assimetria deve ser investigado.



Fonte: Acervo dos Autores, 2024.

AUSCULTA CARDÍACA

- O sistema circulatório da gestante sofre alterações hemodinâmicas (placenta, hormônios, retenção hídrica, e compressão uterina) que vão causar impacto no débito cardíaco, pressão arterial e sintomatologia da gestante.
- O débito cardíaco eleva-se de 30% - 50%, há um aumento da frequência cardíaca de 10% - 20%.
- Como sintomas gerais algumas gestantes podem referir taquicardia, queda da pressão arterial, sensação de dispneia, diminuição de resistência aos exercícios físicos, alteração na ausculta cardíaca e sopro fisiológico.

AUSCULTA PULMONAR

- **Hiperventilação**
 - Há um aumento discreto da frequência respiratória e um aumento corrente de 40%-50% do volume corrente. Diminuição de pCO_2 e excreção de $NaHCO_3$ - alcalose respiratória compensada.



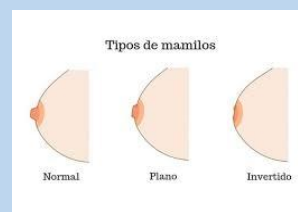
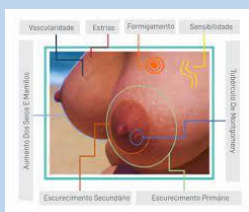
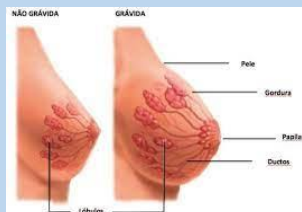
Fonte: Jarvis, 2016.

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AVALIAÇÃO DAS MAMAS

- Tipo de mamilo (hipertrófico, protuso, semi-protuso, plano e invertido);
- Sinal de Hunter (aumento da pigmentação e tamanho da aréola);
- Rede de Haller (veias visíveis através da pele em forma de rede);
- Presença de Tubérculos de Montgomery (glândulas sebáceas no mamilo);
- Excreção de colostro;
- Avaliar pele (integridade, turgor, lesões, fissuras, estrias etc).



Fonte: Jarvis, 2016.

AVALIAÇÃO DO ABDOME

- A avaliação do abdome de uma gestante é um pilar do acompanhamento pré-natal, essencial para monitorar a saúde materna e o desenvolvimento fetal.
- **Inspeção:**
 - Observa-se o formato, tamanho, presença de cicatrizes, formato do abdome, presença de estrias, possíveis alterações de pele como dermatites, lesões, hérnias, diástase, linha nigra, movimentos fetais visíveis e possíveis encurtamentos ligamentares uterinos que refletem em dor em baixo ventre ou na cintura.
- **Palpação:**
 - Avalia-se o tônus uterino, a apresentação fetal (pelas Manobras de Leopold-Zweifel), após a mensuração da altura uterina (indicador de crescimento fetal e idade gestacional) e a presença de contrações.
- **Ausculta:**
 - Procedimento essencial para confirmar a vitalidade fetal e avaliar a frequência e o ritmo dos batimentos cardíacos (BCF), audíveis geralmente 9- 12 semanas.
- Por fim, a avaliação do abdome também pode incluir a identificação de pontos de dor, sinais de irritação peritoneal ou outras anormalidades que demandem investigação adicional.
- A interpretação desses achados, aliada à história clínica completa da gestante e a exames complementares, permite um acompanhamento adequado, intervenções oportunas e a prevenção de complicações durante a gestação.

Continua.

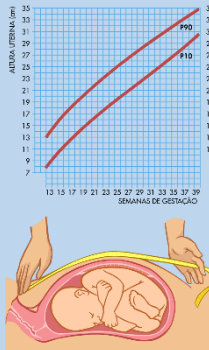
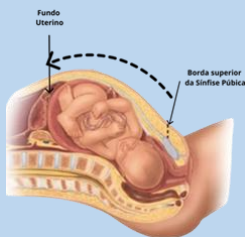
EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

MENSURAÇÃO DA ALTURA UTERINA (AU)

- A mensuração da altura uterina (AU) é um procedimento clínico essencial no acompanhamento do pré-natal, que permite avaliar indiretamente o crescimento fetal, contribuindo para a identificação precoce de alterações como restrição de crescimento intrauterino (RCIU) ou macrosomia fetal.
- Deve estar dentro da faixa delimitada pelos percentis 10 e 90 do gráfico de crescimento uterino, de acordo com a idade gestacional.
- **Técnica Correta:**
 - Solicitar que a gestante **esvazie a bexiga**, pois a bexiga cheia **pode alterar a AU em até 3 cm**.
 - Com a gestante em **decúbito dorsal**, identificar:
 - A borda superior da sínfise púbica.
 - O fundo uterino, palpado na linha média abdominal.
 - Posicionar uma **fita métrica inelástica**:
 - Fixar uma extremidade na borda superior da sínfise púbica.
 - Deslizar a fita com a **borda cubital da mão**, pela **linha média do abdome**, até o fundo uterino.
- **Interpretação:**
 - A partir de **20 semanas**, a AU (em cm) costuma coincidir aproximadamente com a idade gestacional (± 2 cm).
 - A medida deve ser registrada no **gráfico de crescimento uterino**, observando se está dentro dos percentis 10 e 90.

⚠️ ATENÇÃO: Condutas frente a desvios

- **TRAÇADOS INICIAIS ACIMA OU ABAIXO DA FAIXA:**
 - **Discutir caso com MFC;**
 - Realizar nova medição em interconsulta, para confirmar ou descartar erro na estimativa da idade gestacional ou possível risco fetal;
 - De acordo com o resultado e seguimento pode ser necessário avaliar com maior frequência.
 - Orientar bem a paciente sobre a avaliação;
- **TRAÇADOS PERSISTENTEMENTE FORA DA FAIXA:**
 - Se a **inclinação do gráfico for semelhante**, suspeitar de **erro na idade gestacional**
 - ❖ Realizar interconsulta/avaliação médica e avaliar a necessidade de **ultrassonografia** ou encaminhamento ao pré-natal de alto risco (PNAR);
 - Se a **inclinação for diferente**, pode indicar alteração no crescimento fetal.
 - ❖ Encaminhar para avaliação médica.



Fonte: MS, 2006; Acervo dos Autores, 2024.

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

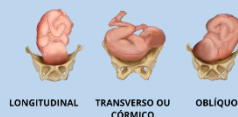
PALPAÇÃO - MANOBRAS DE LEOPOLD - ZWEIFEL

- As manobras de Leopold-Zweifel consistem em uma sequência de quatro tempo de palpções obstétricas sistematizadas, realizadas no abdome materno, com o objetivo de:
 - Avaliar as características fetais,
 - Identificar a posição, apresentação, situação e atitude fetal,
 - Estimar a idade gestacional
 - Avaliar a quantidade de líquido amniótico.
 - Fundamentais para subsidiar a tomada de decisões clínicas;
 - Orientar a ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF);
 - Planejar o cuidado obstétrico.

1º TEMPO



- Delimitar o fundo do útero com a parte cubital das mãos a fim de identificando a parte fetal que ocupa e definindo então a **SITUAÇÃO**.



2º TEMPO



- Deslize as mãos Apalpando desde o fundo do útero até a parte inferior do útero a fim de sentir o dorso fetal definindo então a **POSICÃO**.



3º TEMPO



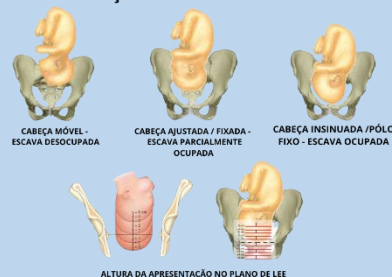
- Identifique mobilizando com a mão o pólo que se apresenta na parte do estreito superior da escava da pelve na parte inferior do útero, definindo então a **APRESENTAÇÃO**.



4º TEMPO



- Posicionar as mãos gentilmente na fossa ilíaca e ir direcionando em direção a pelve a fim de verificar espaço e mobilidade determinando assim a **INSINUAÇÃO**.



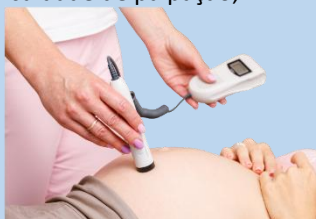
Fonte: Adaptado de Canva, 2024.

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AUSCULTA FETAL

- **Preparação da Gestante**
- Posicionar a gestante em decúbito dorsal, lateral ou semi-fowler, priorizando seu conforto e prevenindo compressão da veia cava;
- Realizar as manobras de Leopold-Zweifel para localizar o dorso fetal, que é o melhor ponto para ausculta de BCF;
- Quando não for possível a determinar a apresentação e a situação fetal pelas manobras de leopold-Zweifel (comum nos primeiros meses de gestação), a linha de Ribemont serve como guia anatômico para ausculta fetal. Nessa situação, recomenda-se realizar a ausculta dos BCFs nos quatro quadrantes do abdome materno, cruzando uma linha vertical (linha média) e uma horizontal (altura das espinhas ilíacas antero-superiores).
 - **Finalidade:** Buscar o local onde os batimentos são mais audíveis e nítidos, ajustando conforme a resposta sonora;
 - **Conduta:** Posicione o sonar doppler nos 4 quadrantes, mantenha onde os BCFs forem mais claros e fortes.
 - Esse método suprime a necessidade imediata de determinar a posição fetal, especialmente em casos de dificuldade de palpação;



Fonte: Adaptado de Canva, 2024.

- **Escolha e Preparo do Instrumento**
- **Sonar Doppler:** A partir de 10-12 semanas;
 - Aplicar gel sobre o transdutor;
- **Estetoscópio de Pinnard:** Geralmente a partir de 20 semanas;
- **Realização da Ausculta**
- Posicionar o aparelho no local mais adequado (dorso fetal);
- Contar os BCFs durante 1 minuto completo;
- Avaliar:
 - **Frequência:** Normal entre 110 e 160 bpm;
 - **Ritmo:** Se é regular ou irregular;
 - **Regularidade:** Presença ou Ausência de variações;
- **Reconhecer os ruídos fetais, que podem incluir:**
- Batimentos Cardíacos Fetais - BCF;
- Sopro Funicular: Som provocado pela compressão do cordão umbilical, geralmente sincrônico com os batimentos.

⚠️ ATENÇÃO AOS ACHADOS

- ⚠️ **Alterações persistentes** da frequência dos BCFs (Abaixo de 110 bpm ou acima de 160 bpm) devem ser avaliadas pelo médico;

- É comum ocorrer **aumento transitório da frequência** em situações como:

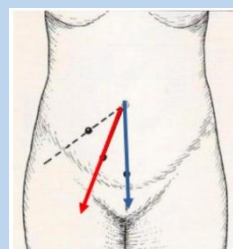
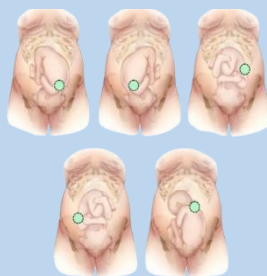
- ❖ Contrações uterinas;
- ❖ Movimento fetal;
- ❖ Estímulo mecânico durante a ausculta;

- ⚠️ **Desacelerações** dos BCFs durante ou após contrações podem ser sinal de sofrimento fetal e indicam necessidade de avaliação médica ou encaminhamento à maternidade.

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AUSCULTA FETAL



Fonte: Jarvis, 2016.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AValiação DA DINÂMICA UTERINA

- **Objetivo:**
 - Padronizar a avaliação clínica da atividade uterina em gestantes com queixas de contrações, diferenciando contrações fisiológicas irregulares (Braxton Hicks) para as de Trabalho de Parto (Cheyne-Stokes) que dependendo da idade gestacional pode envolver o risco de Trabalho de parto prematuro, com base em critérios clínicos validados.
- **Avaliar quando a gestante apresentar:**
 - Queixas de contrações uterinas;
 - Dor lombar/pélvica rítmica;
 - Aumento da pressão pélvica;
 - Mudanças na movimentação fetal;
 - Endurecimento abdominal frequente;
- **Preparação**
 - Ambiente privativo e calmo;
 - Posicionar a gestante em decúbito lateral esquerdo (10 min.)
 - Esvaziar a bexiga antes do exame;
- **Avaliação Clínica**
 - Posicionar a mão dominante no fundo uterino;
 - Avaliar simultaneamente:
 - **Frequência** (contrações/10 min);
 - **Duração** (Segundos);
 - **Intensidade** (leve/moderada/forte);
 - **Ritmicidade** (regular/irregular);
- **Crítérios Diagnósticos**

Parâmetro	Braxton Hicks	Cheyne Stokes - TP
Frequência	<3/10 min	≥3/10 min
Duração	<30 seg	≥30 seg
Intensidade	Leve, localizada	Progressiva, irradiada
Ritmo	Irregular	Regular
Resposta repouso	Cessa	Persiste

Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AValiação da Dinâmica Uterina

• Conduta



ATENÇÃO AOS SINAIS DE ALERTA

- Mais de 4 contrações /10 min;
- Duração > 30 segs. cada;
- Avaliar a possibilidade de Trabalho de Parto (considerar Idade gestacional para definir se TP a termo, se TP prematuro ou outro tipo de intercorrência);
- Verificar se está associado com:
 - Perda de líquido;
 - Sangramento;
 - Alteração de Movimento Fetal;



Discutir caso com MFC



Encaminhamento para avaliação na Maternidade;

- **No caso de Contrações de Braxton Hicks, recomendar:**
 - Hidratação oral;
 - Repouso em decúbito lateral esquerdo;
 - Orientar gestante ou rede de apoio a avaliar a dinâmica uterina em casa;
 - Banho morno;
 - Retorno para reavaliação em 1 hora e depois com maior brevidade se necessário;
- **Discutir caso com MFC e decidir se é necessário avaliação da vitalidade fetal na maternidade por cardiotocografia ou ainda a necessidade de solicitação de uma USG;**
- **Decidir se é necessário realizar toque vaginal;**
 - Evitar toques vaginais < 34 semanas;
 - Não realizar toques vaginais de rotina;
 - Não realizar manobra de Leopold se suspeita de placenta Prévia;

GIORDANO

- O sinal de Giordano é um achado clínico para avaliar a presença de alteração urinária a nível renal. Pela ação da progesterona e estrogênio a maior parte das gestantes têm ITU assintomática, nessa bacteriúria sem sintomas pode levar a 30% de chance de cistite e mais de 50% de chance de pielonefrite, necessitando assim de intervenção imediata, pois aumenta o risco de sepse, parto prematuro e restrição do crescimento fetal.
- **Realizar quando a gestante apresentar**
 - Sintomas de dor lombar unilateral;
 - Febre sem foco aparente;
 - Histórico de Infecção urinária recorrente;
- **Procedimento**
 - **Posicionamento:** Gestante deve estar sentada inclinada para frente;
 - Realizar, na região lombar, mais precisamente na área da loja renal, sem presença de roupa, uma percussão com a borda ulnar da mão.
- **Interpretação:**
 - **Negativo:** Quando ausência de dor reflexa;
 - Investigue outras causas para a queixa e discuta com MFC, se for necessário.



Positivo: Quando a dor é involuntária e reflexa de forma imediata, indicando alteração renal.

▪ **ENCAMINHE PARA AVALIAÇÃO MÈDICA IMEDIATA.**

Continua.

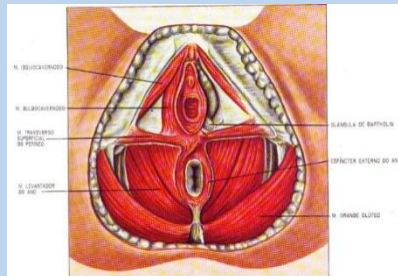
EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

AVALIAÇÃO PÉLVICA (Ver técnica de exame físico no Quadro 39)

- **Indicação**
 - Realizar conforme queixas da gestante (ex.: corrimento, sangramento, suspeita de bolsa rota).
 - O exame pode ser somente avaliação externa ou incluir o uso do espéculo para avaliação interna, conforme necessidade.
 - **NÃO REALIZAR COMO ROTINA, SOMENTE SE NECESSÁRIO.**
- **Preparação**
 - **Posição:** Decúbito dorsal em posição ginecológica.
 - Cuidar para o risco de hipotensão de supina.
 - **Técnica opcional:** Se necessário, permitir que a própria paciente introduza o espéculo ou utilize espelho de mão para melhor visualização.
 - A iluminação deve ser adequada para avaliação detalhada
- **Avaliação do Aparelho Genital Externo / interno**
 - **Sinal de Jacquemier:** Mucosa vaginal violácea (alteração hormonal da gestação).
 - **Inspecção:**
 - Observar o Fluxo vaginal (cor, odor, consistência), lesões, vulvovaginites, tumores, bartolinite, prolapso genital ou ruptura de períneo.
 - Sinais de bolsa rota: Perda de líquido amniótico.
 - Sangramento ou tampão mucoso.
 - Incontinência urinária.
 - Avaliação de região anal
 - ❖ Presença de hemorroidas (comuns na gestação).
 - ❖ Presença de varizes vulvares ou perianais.



Sinal de Jacquemier.



Fonte: Acervo dos Autores, 2024.

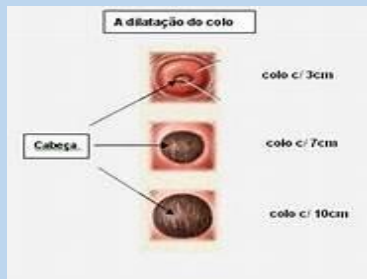
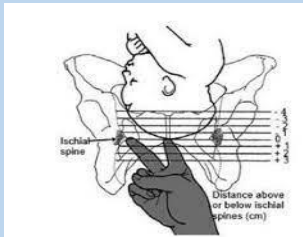
Continua.

EXAME CLÍNICO OBSTÉTRICO (CEFALOCAUDAL)

TOQUE VAGINAL (QUANDO NECESSÁRIO)

- Indicação

- **NÃO DEVE SER USADO ROTINEIRAMENTE NA AVALIAÇÃO DE UMA GESTANTE**
- No entanto ele se encontra descrito aqui pela necessidade de se utilizar em situações de queixa da gestante e com o objetivo de identificar dois momentos que se seguem:
 - Em suspeita de trabalho de parto apreciam-se as condições da vagina, se é permeável e se há presença de septos, as características do colo (dilatação, espessura, esvaecimento e centralização, altura - plano De Lee).
 - Pelo toque confirmam-se a apresentação, a posição e sua variedade. Por último, verificam-se as condições da bacia



Fonte: Acervo dos Autores, 2024; Adaptado de Canva, 2024; Jarvis, 2016.

MEMBROS SUPERIORES / INFERIORES E PÉS

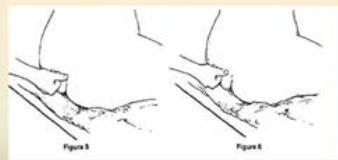
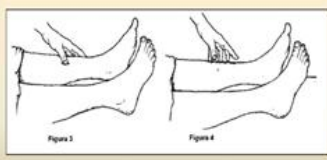
- Avaliar

- Atenção para presença de varizes, ferimentos, tendinites, síndrome do túnel do carpo;
- Atenção para edemas, conforme quadro abaixo.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

6.2.1.1 – Classificação do Edema

Quadro 40 – Classificação do Edema

CLASSIFICAÇÃO DO EDEMA		
REALIZAÇÃO DO EXAME FÍSICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE EDEMA		
- A presença de edema ocorre em 80% das gestantes e é pouco sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Posicione a paciente em decúbito dorsal, lateral, ou sentada e pressione a pele com o polegar. O edema foi avaliado mediante abaulamento demorado do local que foi pressionado. - Na face e nos membros superiores, identifique a presença de edema pela inspeção.		
TÉCNICA AVALIAÇÃO DE EDEMA SACRO  Figura 3 Figura 4 TÉCNICA AVALIAÇÃO DE EDEMA MMII  Figura 5 Figura 6   		
Fonte: MS, 2006.		
Características	Classificação	Conduta
Edema presente somente no tornozelo, sem alteração de pressão Arterial ou aumento de peso súbito	+ / +++	- Verificar se o edema está relacionado com a atividade laboral ou a posição que a gestante permanece maior parte do seu tempo; - Verificar o calçado; - Verificar temperatura e estação do ano.
Edema presente em membros inferiores, com alteração de Pressão Arterial e aumento de peso.	++ / +++	- Realizar repouso em decúbito lateral esquerdo; - Verificar a presença de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia grave e interrogar a gestante sobre os movimentos fetais; - Marcar retorno semanal na ausência de sintomas; - Realizar interconsulta e agendar consulta com médico da unidade. - Caso haja hipertensão, encaminhar gestante para um serviço de alto risco.
Edema generalizado (face, tronco e membros) ou que já se mostra presente quando a gestante acorda acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso.	+++ / +++	- Gestante de risco em virtude de suspeita de pré-eclâmpsia ou outras intercorrências. - Encaminhar a gestante para avaliação médica na unidade e encaminhar para serviço de alto risco.

6.3 – EXAMES DE ROTINA PARA GESTANTE

6.3.1 – Rotina de Exames Laboratoriais no Pré-Natal para Risco Habitual ¹

Quadro 41 – Rotina de Exames Laboratoriais no Pré-Natal para Risco Habitual

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL			
Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS (ou outro teste treponêmico) e VDRL (ou outro teste não treponêmico) Realizar nos 1º, 2º e 3º trimestres e quando for necessário;	• Teste rápido: NÃO REAGENTE	• Se primeiro exame for não reagente e ausência de suspeita clínica de sífilis ou se os dois testes foram não reagentes: ausência de infecção ou período de incubação (janela imunológica) de sífilis recente; • Manter o monitoramento de rotina do pré-natal, com programação dos exames subsequentes até o momento do parto; • Em caso de suspeita clínica e/ou epidemiológica, solicitar nova coleta de amostra em 30 dias.	• É recomendado realizar em todos os trimestres, e se o resultado for positivo, recomenda-se tratamento imediato, já que o tratamento durante a gestação é benéfico para a mãe e para o feto (grau de recomendação); • Realizar VDRL mensalmente até o fim da gestação. Após o término, fazer monitoramento conforme rotina para não gestante (3/3 meses até fechar 12 meses); • Se TR positivo, tratar com primeira dose de penicilina e agendar retorno em 7 dias para teste não treponêmico. Não Precisa aguardar VDRL para iniciar tratamento; • Repetir o exame no 2º e 3º trimestre, no momento do parto e em caso de abortamento; • Lembrar que a sífilis é de notificação compulsória; • O diagnóstico definitivo de sífilis é estabelecido por meio da avaliação da história clínica e dados epidemiológicos; • Atenção para história de sífilis pregressa e tratamentos anteriores
	• VDRL: NÃO REAGENTE	• Se primeiro exame for reagente, coletar amostra para o segundo exame e iniciar o tratamento; • Se segundo exame reagente: diagnóstico de sífilis; • Notificação, conclusão do tratamento, controle de cura (VDRL mensal) e programação para investigação de sífilis congênita no neonato; • Se segundo exame não reagente ver combinações seguintes; • Avaliação da parceria sexual; • Consultar protocolo volume 02 para controle de cura e vigilância de reinfecção;	
	• Teste rápido: REAGENTE	• Se primeiro exame (primeiro exame) for reagente, coletar amostra para o segundo exame e iniciar o tratamento; • Segundo exame não reagente: realizar terceiro exame (teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro); • Se terceiro exame não reagente: resultado falso reagente para o primeiro teste, sendo excluído o diagnóstico de sífilis; • Se terceiro exame reagente: suspeita de sífilis recente ou de sífilis tratada, caso haja documentação de tratamento adequado; • Notificação, conclusão do tratamento, controle de cura (VDRL mensal) e programação para investigação de sífilis congênita no neonato; • Avaliação da parceria sexual; • Consultar as diretrizes para protocolo de controle de cura e vigilância de reinfecção.	
	• VDRL: REAGENTE	• Se terceiro exame reagente: suspeita de sífilis recente ou de sífilis tratada, caso haja documentação de tratamento adequado; • Notificação, conclusão do tratamento, controle de cura (VDRL mensal) e programação para investigação de sífilis congênita no neonato; • Avaliação da parceria sexual; • Consultar as diretrizes para protocolo de controle de cura e vigilância de reinfecção.	
	• Teste rápido: NÃO REAGENTE	• Provável falso-reagente no teste não treponêmico, principalmente nos casos em que a titulação for menor ou igual a 1:4; • Se titulação > 1:4, realizar teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste treponêmico realizado; • Avaliar resultado, história de tratamento anterior, titulação dos resultados anteriores, avaliação clínica; • Concluir se cicatriz sorológica ou infecção aguda;	
	• VDRL: REAGENTE		

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO HIV ou ANTI HIV Realizar nos 1º, 2º e 3º trimestres e quando for necessário;	NÃO REAGENTE	- Manter o monitoramento de rotina do pré-natal, com programação dos exames subsequentes até o momento do parto; - Realizar aconselhamento pré e pós testagem.	- Nos casos de gestantes já com diagnóstico de HIV positiva ou em uso de TARV encaminhar para acompanhamento em serviço de Pré-Natal de Alto Risco e atentar para a prevenção de transmissão vertical; - As gestantes HIV positivas deverão ser orientadas a não amamentar; - Em caso de gestante que o resultado foi reagente e não sabia, deve ser encaminhada para serviço de Pré-Natal de Alto Risco; - Em ambas as situações mantém o seguimento na Atenção básica concomitante; - Toda gestante infectada pelo HIV deve receber TARV durante a gestação, com dois objetivos: profilaxia da transmissão vertical ou tratamento da infecção pelo HIV; - Atentar para que essa mulher receba desde a maternidade a cabergolina para inibição da lactação e que tenha acesso à fórmula infantil para seu RN, conforme portaria;
	- REAGENTE - Confirmar com teste confirmatório;	- Discutir e encaminhar com médico o cuidado, com encaminhamento para Pré-Natal de alto risco (PNAR) e/ou Serviços de Referência para DST/AID, infectologia ou demais especialidades; - Realizar aconselhamento pós testagem;	
HTLV 1/2 1º Trimestre ou quando exposição ao risco;	Não Reagente	Descartar HTLV 1/2;	Atenção: - Muito importante registrar no cartão da gestante e orientar bem a paciente principalmente para o conhecimento da equipe que vai assistir parto; - É importante recomendar o uso de preservativo na relação sexual; - No caso de exame positivo testar RN, parceria e investigar história familiar para localizar mais infectados; - Contraindicações à amamentação em mães vivendo com HTLV-1/2, sendo recomendado o uso de inibidores de lactação(cabergolina) e de fórmulas lácteas. - O tratamento é direcionado de acordo com a doença relacionada ao HTLV. A pessoa deverá ser acompanhada nos Centros de saúde e, quando necessário, receber seguimento em serviços especializados para diagnóstico e tratamento precoce de doenças associadas ao HTLV. - Embora não haja um tratamento curativo para as manifestações neurológicas do HTLV-1 (HAM), recomenda-se que todo indivíduo acometido deve ser assistido por equipe multidisciplinar que inclua profissionais médicos (neurologista, infectologista, urologista, dermatologista, oftalmologista), fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos. Por outro lado, casos que apresentam ATLL, o tratamento tem por racional obter resposta completa ou parcial, porém, ainda não existe consenso entre as opções de primeira linha de tratamento.
	Reagente / indeterminado	Realizar teste confirmatório: - Se Negativo - Descartar HTLV1/2; - Se Positivo - Confirma infecção por HTLV1/2; - Se Indeterminado/Inconclusivo - Coletar nova amostra de exame em 3 meses (nesse caso é recomendável o exame confirmatório molecular para esclarecer o caso);	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
TOXOPLASMOSE IgG e IgM 1º trimestre, caso for <u>Não Reagente</u> realizar nos 1º, 2º e 3º trimestres;	• IgG: REAGENTE	• Avidéz de IgG fraca ou gestação > 16 semanas: - o Possibilidade de infecção na gestação – iniciar tratamento imediatamente;	• A toxoplasmose é uma doença que pode cursar de maneira assintomática para a gestante, mas ser transmitida verticalmente, com repercussões importantes para o bebê: restrição de crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade e/ou manifestações clínicas e sequelas como microftalmia, lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, hepatoesplenomegalia, erupção cutânea e retardo mental. • Sempre discutir em matriciamento, com MFC e consultar as diretrizes para informações mais detalhadas sobre investigação e tratamento; • Toxoplasmose gestacional e congênita são agravos de notificação compulsória; • Caso a gestação tenha menos de 16 semanas e IgM reagente, deve ser feito imediatamente o teste de avidéz de IgG, na mesma amostra de soro; • Nos exames realizados após 16 semanas de gestação, não há necessidade do teste de avidéz, pois mesmo uma avidéz alta não descartaria infecção adquirida durante a gestação, embora possa ser útil para ajudar a determinar a época em que ocorreu. É importante lembrar que em algumas pessoas a avidéz dos anticorpos IgG permanece baixa por mais tempo, não sendo a avidéz baixa uma certeza de infecção recente; • Fornecer orientações sobre prevenção primária para as gestantes suscetíveis: - o Lavar as mãos ao manipular alimentos; - o Lavar bem frutas, legumes e verduras antes de se alimentar; - o Não ingerir carnes cruas, mal cozidas ou mal passadas, incluindo embutidos (salame, copa etc.); - o Evitar o contato com o solo e a terra de jardim; se isso for indispensável, usar luvas e lavar bem as mãos após a atividade; - o Evitar contato com fezes de gato no lixo ou no solo; - o Após manusear carne crua, lavar bem as mãos, assim como também toda a superfície que entrou em contato com o alimento e todos os utensílios utilizados; - o Não consumir leite e seus derivados crus, não pasteurizados, sejam de vaca ou de cabra; - o Propor que outra pessoa limpe a caixa de areia dos gatos e, caso isso não seja possível, tentar limpá-la e trocá-la diariamente utilizando luvas e pazinha; - o Alimentar os gatos com carne cozida ou ração, não deixando que eles façam a ingestão de caça; - o Lavar bem as mãos após o contato com os animais;
	• IgM: REAGENTE	• Avidéz (MFC) forte e gestação < 16 semanas: - o Doença prévia – não repetir exame;	
	• IgG: NÃO REAGENTE • IgM: REAGENTE	• Doença recente: - o Encaminhar para o médico para iniciar tratamento imediatamente; - o Repetir o exame após três semanas;	
	• IgG: REAGENTE • IgM: NÃO REAGENTE	• Doença prévia: - o Não repetir o exame;	
	• IgG: NÃO REAGENTE • IgM: NÃO REAGENTE	• Suscetível (orientar medidas de prevenção) • Repetir o exame no 2º e 3º trimestres).	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B OU HBsAg Solicitar 1º e 3º trimestres	NÃO REAGENTE	- Descartar Hepatite B; - Investigar estado vacinal se não vacinada, encaminhar para realizar imunização; - Fazer aconselhamento pré e pós-teste;	- A hepatite B tem alto potencial de morbidade da doença para a mãe e o feto. Neonatos infectados têm grande probabilidade de se tornarem portadores crônicos e desenvolverem doença hepática ao longo da vida. - O rastreamento sorológico deve ser oferecido para mulheres grávidas porque a intervenção pós-natal pode diminuir o risco de transmissão mãe e filho; - Toda gestante HBsAg não reagente deve receber a vacina para hepatite B ou ter seu calendário completado, independentemente da idade
	REAGENTE	- Solicitar HBeAg e transaminases (ALT/TGP e AST/TGO); - Fazer aconselhamento pré e pós-teste; Em caso de resultado reagente, a gestante deve ser encaminhada para consulta médica no Centro de Saúde e ao Pré Natal de Alto Risco.	
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE OU ANTI - HCV Solicitar 1º e 3º trimestres	NÃO REAGENTE	- Fazer aconselhamento pré e pós-teste; - Descartar Hepatite C;	- Oportunize, preferencialmente, teste rápido. - Essa testagem é oferecida oportunisticamente à gestante devido ao recorte epidemiológico de pessoas com Hepatite C no município de Florianópolis. Ao realizar os testes rápidos sempre procure oferecer a testagem para Hepatite C; - Priorize que este exame seja realizado principalmente em situações de vulnerabilidade ou risco.
	REAGENTE	- Realizar notificação; - Checar fluxo Epidemiológico; - Discutir e encaminhar com médico o atendimento;	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
HEMOGRAMA Solicitar no 1º, 2º e 3º trimestres.	• Hemoglobina (Hb) $\geq 11\text{g/dl}$ - o Ausência de Anemia • Hemoglobina (Hb) 8-11 g/dl - o Anemia leve a moderada • Hemoglobina (Hb) $< 8\text{ g/dl}$ - o Anemia Grave	• Profilaxia: Na ausência de anemia prescrever 1 comprimido ao dia de Sulfato Ferroso a todas as gestantes a partir de 16 semanas de gestação para uso até o 3º mês de pós-parto;	• O ajuste da dose/posologia pode ser modificado de acordo com o medicamento ofertado pela farmácia (40mg ou 60mg), respeitando a dose de Ferro elementar necessária. • Em caso de sensibilidade ou reação adversa ao Sulfato Ferroso, ofertar outras possibilidades como o Quelato de Ferro (Precisa de prescrição médica - não padronizado pelo SUS); • Em caso de anemia matriciar caso com nutrição e ver possibilidade de acompanhamento ou interconsulta; • Oriente e promova o consumo de alimentos saudáveis, ricos em Ferro (Folhas verdes, carne vermelha, vísceras, grãos, beterraba, açaí) e Vitamina C (frutas cítricas, abóboras, pimentões, frutas vermelhas); • A Vitamina C auxilia na absorção do Ferro, porém não existe evidência para suplementação, oriente consumir alimentos ricos nela diariamente (ela não faz depósito eliminamos pela urina); • Evitar consumir o Sulfato Ferroso com leite - os alimentos ricos em cálcio diminuem absorção do Ferro, realize adequação da profilaxia de cálcio com o uso de Sulfato ferroso para que tenha um intervalo mínimo que não prejudique a absorção do ferro no organismo; • Pacientes que apresentem sensibilidade, inicie com dose mínima aumentando até chegar a dose desejada gradativamente para melhor adaptação;
		• Se Anemia: - o Prescrever 120 mg (dose diária) de Sulfato Ferroso e solicite hemograma em 1 mês; • Caso a hemoglobina estiver subindo - o Mantenha o tratamento e monitore com hemograma mensal; • Se hemoglobina estagnada ou caindo - o Prescreva 240 mg (dose diária) e monitore com hemograma mensal. • Caso a Hemoglobina continue caindo - o Encaminhe atendimento médico ou interconsulta • Caso ela aumente para $> 11\text{g/dl}$ - o Reduza para 1 comprimido de Sulfato ferroso (dose profilática) até para o 3º mês de pós-parto;	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA Solicitar no 1º trimestre.	• HbAA: - o Sem doença falciforme; • Hb A com qualquer variante: - o Gestante sem doença falciforme. • HbAC: - o Heterozigose para hemoglobina C - o Sem doença falciforme.	• Não há necessidade de encaminhamento ou orientações especiais;	• A gravidez é uma situação potencialmente grave para usuárias com doença falciforme, assim como para o feto e o recém-nascido. Os efeitos na gravidez podem ser aumento das crises dolorosas, piora do quadro de anemia, abortamento, crescimento intrauterino restrito, trabalho de parto prematuro e pré eclâmpsia, além de complicações respiratórias e digestivas. • Gestantes com traço falciforme devem receber orientações e aconselhamento genético pela equipe da Atenção Básica. • Gestantes com diagnóstico de doença falciforme devem ser encaminhadas para o serviço de referência disponível na rede de saúde (pré-natal de alto risco, hematologia ou outro serviço especializado). • Nota: Em caso de resultado positivo, encaminhar para atendimento médico ou realizar interconsulta.
	• HbAS: - o Heterozigose para hemoglobina S ou traço falciforme - o Sem doença falciforme.	• Não há necessidade de encaminhamento ao pré-natal de alto risco; • Investigar a possibilidade do pai da criança ter o traço falciforme e orientar sobre os cuidados com o recém-nascido - o Discutir caso com MFC;	
	• Hb SS, HbSC, Hb Sβ+ tal, Hb Sβ0 tal ou Hb SD Punjab: - o Doença falciforme	• Discutir e encaminhar o cuidado com o pré-natal de alto risco;	
TIPAGEM SANGUÍNEA COM FATOR RH Solicitar no 1º trimestre.	• Tipagem: - o A, B, AB e O • Fator Rh: - o Negativo ou Positivo	• Se o fator Rh for negativo, realizar exame de Coombs indireto; • Antecedente de hidropsia fetal ou neonatal, independentemente do Rh, realizar exame de Coombs indireto.	• Orientação sobre os possíveis parâmetros de mãe com Rh negativo e seguimento;

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
COOMBS INDIRETO Solicitar no 1º trimestre e se fator Rh negativo, mensalmente a partir da 24ª semana de gestação até o parto;	• Positivo: - o Gestante sensível.	• Para casos com resultado positivo: - o Discutir e encaminhar com MFC o caso; - o Classificar risco e encaminhar para o PNAR - Pré Natal de alto Risco;	• Solicitar quando: • Confirmação de gestante com fator Rh negativo; • A partir da 24ª semana de gestação mensalmente até o final da Gestação; • Programar junto à maternidade imunoglobulina anti-D em até 72 horas pós-parto; • São condições que aumentam o risco de sensibilização materna ao antígeno Rh: - o Sangramento vaginal materno. - o Abortamento, gestação molar ou gestação ectópica. - o Procedimento invasivo intrauterino. - o Cirurgia fetal intraútero. - o Óbito fetal. - o Versão cefálica externa. - o Trauma abdominal • Conduta Profilática • Para mães não sensibilizadas - Coombs negativo: - o Administrar 300 µg de imunoglobulina anti-D nos seguintes momentos: ▪ Na 28 a 34 semanas de gestação; ▪ ❖ (Atenção! fluxo a estabelecer) ▪ Até 72 horas após o parto de recém-nascido Rh+ ou de fator Rh desconhecido. ▪ Até 72 horas após procedimento/evento (que leve à risco de sensibilização materna).
	• Negativo: - o Gestante não sensível.	• Para casos com resultado negativo: - o Repetir o exame a partir da 24ª semana de gestação mensalmente até o final da gestação considerando reclassificar o risco conforme resultado.	

Continua.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
GLICEMIA DE JEJUM Solicitar no 1º trimestre	< 92 mg/dL	Rastreio negativo: Exame normal;	Para todas as gestantes na primeira consulta - A hiperglicemia materna, em qualquer das formas de diabetes na gravidez, está associada a um aumento de complicações fetais e neonatais (macrossomia fetal, prematuridade, morte intrauterina, hipoglicemia e disfunção respiratória neonatal) e na gestante (hipertensão, pré-eclâmpsia, elevação de índices de cesariana); - Classificar Risco se história de DM prévia à Gestação - Discutir e encaminhar atendimento com MFC (Médico); - Atenção para Classificação risco quando as gestantes têm fatores de risco para Diabetes gestacional; - Com relação ao Automonitoramento de glicemia Capilar (AMGC): - Disponibilizar glicosímetro, fitas reagentes e instrumento de registro; - Orientar paciente como manusear e usar o glicosímetro; - Estabelecer controle de horários de verificação; - Monitorar resultados do AMGC junto a gestante, registrando no prontuário; - Toda gestante diabética deve realizar AMGC; - Caso a gestante utilize insulina ensinar manuseio e autoaplicação, rodízio de lugares, conservação da insulina e controle glicêmico; - Encaminhar para nutricionista; - Estimular bons hábitos, atividade física monitorada e qualidade de vida.
	≥ 92mg/dl	- Risco para DMG alto: exame alterado - Investigar alteração; - Discutir e encaminhar com médico para atendimento médico imediato; - Solicitar Automonitoramento de Glicemia capilar (AMGC); - Se o resultado for maior que 110 mg/dl, o diagnóstico será de DMG. - Orientar medidas de prevenção primária e referir ao alto risco, mantendo o acompanhamento na UBS.	
	≥ 126mg/dL - Rastreio positivo.	- Rastreio Positivo para DMG - Exame alterado - Discutir e encaminhar com médico a paciente para atendimento e classificação de risco para PNAR.	
TESTE DE TOLERÂNCIA DE GLICOSE – TTOG Solicitar a partir das 24 semanas	Diagnóstico prévio de diabetes mellitus.	Não realizar TOTG	- Gestantes com diagnóstico prévio de DM serão classificadas como Alto Risco, sendo acompanhadas pelo PNAR (mantém também com ESF) e seguindo conduta laboratorial específica para monitoramento da DM, solicitada pelo médico; - Acompanhar o AMGC, monitorar adesão e uso correto da terapia medicamentosa; - Promover bons hábitos alimentares e atividade física monitorada; - Discutir caso com equipe multi;
	- Jejum < 92 mg/dL e 1 hora < 180 mg/dL e 2 horas < 153 mg/d	Se exames anteriores normais: Ausência de Diabetes;	- Mantener o AMGC e seguir rotina Pré natal; - Atenção a novas classificações de risco e encaminhamentos se necessário; - Atenção a história anterior da gestante e possíveis riscos;
	- Jejum 92 - 125 mg/dL ou 1 hora ≥ 180 mg/dL ou 2 horas ≥ 153 - 199 mg/dL	Diabetes Mellitus Gestacional;	- Discutir e encaminhar com médico consulta para acompanhamento do caso; - Encaminhar para nutricionista; - Promover e orientar bons hábitos como atividade física, cuidados nutricionais; - Classificar Risco e Encaminhar para PNAR;
	- Jejum ≥ 126 mg/dL ou 2 horas ≥ 200 mg/dL	Diabetes mellitus com diagnóstico na gravidez	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
EXAME DE URINA, UROCULTURA e TSA (ANTIBIOGRAMA) Solicitar no 1º, 2º e 3º Trimestres.	Leucocitúria: - Presença acima de 10.000 células por ml ou cinco células por campo; Hematúria: - Presença acima de 10.000 células por ml ou de três a cinco hemácias por campo; Proteinúria: - Alterado > 10 mg/dl; Presença de outros elementos: - Não necessitam de condutas especiais. ENFERMEIRO NÃO FAZ TRATAMENTO DE ITU DE REPETIÇÃO - CONDUTA MÉDICA	Leucocitúria: - Avaliar urocultura para confirmar presença de ITU. Cilindrúria, hematúria sem ITU ou sangramento genital, proteinúria maciça ou traços em dois exames consecutivos: - Discutir ou encaminhar para avaliação médica. Traços de proteinúria isolada: - Discutir e encaminhar com médico o cuidado; - Repetir exame em 15 dias; - Se persistente, mantenha acompanhamento conjunto. Traços de proteinúria associados à hipertensão e/ou edema: - Discutir ou encaminhar para avaliação médica. Proteinúria maciça: - Discutir ou encaminhar para avaliação médica. Pielonefrite: - Encaminhar para atendimento médico ou para maternidade imediatamente;	Gestante com Sintomas Urinários: - Realizar manejo conforme protocolo de tratamento de infecção do trato urinário (ITU) na gestação. Infecções Urinárias de Repetição ou persistência da bacteriúria após tratamento: - Discutir ou encaminhar para avaliação médica. ITU de Repetição: - Realizar controle laboratorial com urina tipo I, urocultura e TSA em até 7 dias após o término do tratamento. Avaliar necessidade de novos exames conforme entrevista e quadro clínico. - Na ausência de médico no centro de Saúde ou em casos de ITU refratária, repetição ou pielonefrite, encaminhar imediatamente à maternidade.
TSH 1ª Consulta.	Resultado Normal - Rastreio negativo 1º trimestre (0.1 a 2.5 mU/L); 2º trimestre (0.2 a 3 mU/L); 3º trimestre (0.3 a 3 mU/L) Se suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo e T4 livre ou total baixo); Paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,5 mcg/kg de levotiroxina; Diagnóstico de hipertireoidismo.	- Seguir rotina Pré Natal de Baixo Risco; - Suspeita-se ser um caso de hipotireoidismo subclínico com TSH acima de 10mU/L; - Atenção sempre a uma nova classificação de risco; - Mantém Rotina Pré Natal no Centro de Saúde; - Classificar Risco gestacional; - Discutir com MFC da Equipe; - Encaminhar para PNAR;	Solicitar TSH para gestantes com seguinte quadro clínico ou história: > de 30 anos; - DM tipo 1 ou outras condições autoimunes IMC > 30; - História familiar / pessoal de problemas de tireoide; - Histórias de partos prematuros e abortamento recorrente; - História pessoal ou familiar de alterações na tireoide; - História de irradiação de cabeça / pescoço; - Gestantes em uso de amiodarona, lítio ou contraste radiológico iodado; - Gestante proveniente de áreas com deficiência de iodo; - Sintomas de hipotireoidismo (ganho de peso ou desânimo sem causa definida, pele seca, piora/nova constipação não explicada, intolerância ao frio) - Solicitar o TSH e discutir sempre o resultado e conduta com MFC; - Atenção ao uso de polivitamínicos com presença de biotina; O rastreamento universal de hipotireoidismo em gestantes não é recomendado.

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
RASTREIO DE CLAMÍDIA E GONORREIA	Para quem solicitar: - Gestante menor de 30 anos 1ª consulta (rastreamento universal) - Gestante menor de 30 anos e <u>práticas sexuais de risco</u> 1ª consulta e 3º trimestre <u>Prática de risco</u>: IST ou PEP no último ano; Nova/múltiplas parcerias sexuais; Uso irregular de preservativos	- O enfermeiro deverá prescrever o tratamento em caso de resultado detectável para <i>Chlamydia trachomatis</i> (CT) e/ou <i>Neisseria gonorrhoeae</i>. Chlamydia Trachomatis (CT) e Neisseria gonorrhoeae (NG) - Ceftriaxona 500mg, 1 ampola IM em dose única + Azitromicina 500mg, 2 cp VO em dose única. Somente para Neisseria gonorrhoeae (NG) - Ceftriaxona 500mg, 1 ampola IM em dose única + Azitromicina 500mg, 2 comprimidos VO em dose única. Somente Chlamydia trachomatis (CT) - Azitromicina 500mg, 2 comprimidos VO em dose única.	- Os sítios de coleta devem ser definidos conforme práticas sexuais, podendo ser realizado em mais de 1 sítio, conforme: - Vaginal receptivo = swab vaginal. - Anal receptivo = swab anal. - Oral ativo = swab orofaringe. - Não há necessidade de repetir exame (exame para verificar cura) após tratamento de rastreamento positivo. Evite solicitar exames desnecessários; Importante: - Prescreva o mesmo tratamento de forma concomitante para todas as parcerias sexuais (mesmo que tenha usado preservativos) dos últimos 60 dias, independente de testes ou sintomas. - Orientar a abster-se de sexo (paciente e parcerias) por pelo menos 7 dias após o tratamento. VER CONDOTA EM PROTOCOLO VOLUME 02
	Negativo	Ausência do Streptococcus do grupo B.	- A infecção por Streptococcus do grupo B (GBS) costuma estar associada à sepse neonatal, meningite, pneumonia, óbito neonatal, aborto séptico, coriomnionite, endometrite e outras infecções perinatais - Alguns estudos sugerem que a estratégia de <i>screening</i> universal para as gestantes, associada ao uso de antibiótico profilático, é segura e efetiva. Orientações para Coleta de Swab Vaginal e Anal (Gestantes 35ª a 37ª semanas) Swab vaginal: - Coletar 1 amostra no introito vaginal sem uso de espéculo. - Introduzir o swab cerca de 2 cm na vagina inferior. - Realizar movimentos circulares por toda a parede vaginal. Swab anal: - Introduzir o swab cerca de 0,5 cm no esfíncter anal, de forma suave. Cuidados no dia da coleta: Pela manhã: não tomar banho nem evacuar antes da coleta. - Se tomou banho ou evacuou, aguardar até o fim da tarde para realizar a coleta. Evitar o uso de cremes vaginais e ducha interna nas 48 horas anteriores. ATENÇÃO: Registre em destaque no cartão da gestante se resultado positivo para conhecimento da maternidade (pode usar marca texto).
STREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICO DO GRUPO B	Positivo	Presença do Streptococcus do grupo B.	

Continua.

ROTINA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PRÉ-NATAL PARA RISCO HABITUAL

Exame	Parâmetros	Interpretação e Conduta	Implementação de Enfermagem
CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO	Seguir quadro de resultados de citopatologia e de recomendação de seguimento no capítulo 4 - PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO^{1, 5, 11, 12, 13}	- Seguir rastreamento recomendado pelo INCA - pacientes com 2 exames consecutivos anuais sem alteração seguem posteriormente um exame a cada 3 anos; - Qualquer conduta por alteração em cérvix em gestante deve ser discutida com MFC e encaminhada para avaliação com especialista; - Não há contraindicação de coleta em qualquer período ou trimestre gestacional;	- É uma oportunidade para avaliação pélvica e investigação de vulvovaginites, ISTS ou outras alterações de colo e canal vagina A coleta deve ser realizada em gestantes que: - Tenham de 25-64 anos; - Que não tenham realizado o rastreamento nos últimos 3 anos; - Que nunca tenham realizado o exame; - Que se encontram em seguimento; - Que estão na repetição anual do rastreamento (por 2 anos consecutivos).

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

6.3.2 – Recomendações e Evidências sobre a Ultrassonografia nos Diferentes Períodos da Gestação

Quadro 42 – Recomendações e Evidências sobre a Ultrassonografia nos Diferentes Períodos da Gestação

RECOMENDAÇÕES E EVIDÊNCIAS SOBRE A ULTRASSONOGRRAFIA NOS DIFERENTES PERÍODOS DA GESTAÇÃO		
Trimestre da Gestação	Implementação e Conduta	Recomendações e Evidências
1º Trimestre	Enfermeira(o) pode solicitar para datação de Idade gestacional e/ou quando data da última menstruação (DUM) desconhecida / incerta	Benefícios e Indicações - A ultrassonografia de rotina em gestações de baixo risco não demonstra benefícios para a mãe ou o recém-nascido (Grau de Recomendação A). - Quando indicada, a ultrassonografia precoce (preferencialmente transvaginal) pode auxiliar no diagnóstico de: - Gestações múltiplas, - Datação mais precisa da idade gestacional (reduzindo induções por "gestação prolongada"), - Confirmação da viabilidade fetal. - Gestação ectópica; Datação da Idade Gestacional (IG) - A IG deve ser calculada com base na primeira ultrassonografia, sem recalculer em exames posteriores. - Quanto mais avançada a gestação, maior a margem de erro em relação à Data da Última Menstruação (DUM): 1º trimestre: variação de 3 a 7 dias em relação à DUM. - Erro esperado: ~8% em relação à DUM. Critério de definição da IG: - Se a DUM estiver dentro da variação esperada, priorizar a DUM. - Se a diferença for maior, considerar a ultrassonografia.
2º Trimestre	Enfermeira(o) pode solicitar USG Obstétrica entre 17- 22 semanas de gestação na rotina Pré-Natal	Efetividade e Evidências - A ultrassonografia (USG) aumenta a detecção de malformações congênitas, mas não há evidências de que sua realização rotineira em gestações de baixo risco melhore o prognóstico perinatal (Grau de Recomendação A). Período Ideal para Rastreamento - Entre 18 e 22 semanas, os órgãos fetais já estão formados e podem ser avaliados com maior precisão. - Essa é a janela ideal para rastreamento de malformações, quando indicado.
3º Trimestre	Caso seja necessário a investigação por imagem de USG a enfermeira(o) deve encaminhar para avaliação médica	Evidências Científicas - Segundo revisão da Cochrane, a ultrassonografia de rotina após a 24ª semana não apresenta benefícios comprovados em gestações de baixo risco (Grau de Recomendação A). Indicações Específicas - A ultrassonografia pode ser útil em casos de: - Suspeita de alteração do crescimento fetal (ex.: altura uterina discrepante). - Avaliação complementar quando clinicamente necessário. Nota: A solicitação do exame deve ser individualizada, baseada em achados clínicos e não como rotina indiscriminada.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

6.4 – MANEJO DE COMORBIDADES MAIS PREVALENTES NA GESTAÇÃO

6.4.1 – Prevenção e Manejo das Alterações Pressóricas e Hipertensão Arterial na Gestação

As síndromes hipertensivas gestacionais (SHG) são uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil e no mundo. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são consideradas evitáveis, mas ainda representam um desafio de saúde pública.

- Acometem entre 5% e 10% das gestações.
- A pré-eclâmpsia afeta cerca de 1,5% das gestantes brasileiras com maior impacto em mulheres negras (pretas e pardas).
- A eclâmpsia ocorre em aproximadamente 0,5% dos casos.
- Dentre as principais causas de morte por causas perinatais nas regiões sul e sudeste do Brasil, estão as causas hemorrágicas e cardiovasculares;
- São a principal causa de morbimortalidade materna e perinatal e prematuridade no Brasil (BRASIL, 2022; WHO, 2019);
- Em Florianópolis, 15,38% dos óbitos maternos entre 2012 e 2024 foram por essas causas (painel de monitoramento da VE - SMS).

6.4.1.1 – Prescrição de Profilaxia pelo Enfermeiro

Quadro 43 – Prescrição de Profilaxia pelo Enfermeiro

PRESCRIÇÃO DE PROFILAXIA PELO ENFERMEIRO			
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS)			
Indicação	Critérios para Início de Uso	Dose	Período
• Prevenção de pré-eclâmpsia e Eclâmpsia em gestantes com alto risco	• Iniciar se presença pelo menos 1 dos fatores de alto risco: - o História de Pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia prévia; - o HAS, Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2; - o Doença renal crônica, Lúpus eritematoso sistêmico ou outra doença autoimune; • Ou dois fatores de risco moderado: - o Primeira gestação atual ou última gestação após >10 anos; - o Gestação múltipla; - o histórico familiar de pré-eclâmpsia - o IMC ≥ 35 kg/m²; - o > 40 anos; - o Uso de técnicas de reprodução assistida na gestação atual;	• 100 mg/dia (1 comprimido) ao dia por via oral de preferência a noite;	• Iniciar a partir das 12 semanas de gestação e manter até 36-37 semanas de gestação (10 dias antes da Data Provável do Parto); • Realize um planejamento do uso; • Implemente e registre no prontuário e cartão da gestante; • Monitore o uso de forma adequada;

Continua.

PRESCRIÇÃO DE PROFILAXIA PELO ENFERMEIRO
SUPLEMENTAÇÃO UNIVERSAL DE CÁLCIO EM GESTANTES

Indicação	Crítérios para Início de Uso	Dose	Período
- A suplementação universal de cálcio para as gestantes se justifica pelos dados de baixa ingestão de cálcio pelas mulheres brasileiras em associação às evidências de redução do risco de pré-eclâmpsia e da morbimortalidade dela decorrente com a suplementação desse micronutriente. - A suplementação de cálcio é uma estratégia importante para reduzir a morbimortalidade materna, especialmente de mulheres negras e indígenas	- Encaminhar para atendimento compartilhado com o médico ou para consulta médica todos os casos em que a gestante apresentar intolerância ao Cálcio para reajuste de dose; - O cálcio não deve ser administrado juntamente com o suplemento de ferro e deve ser mantido um intervalo mínimo de 2 horas entre os dois suplementos, pois a absorção do cálcio pode ser reduzida na presença de ferro ou outros nutrientes. - O cálcio não deve ser ingerido em jejum; - Evitar sua associação com alimentos ricos em fitatos, oxalatos ou ferro (como feijão, espinafre, couve etc.), bem como evitar a associação com alta ingestão de cafeína e de alimentos ultraprocessados, que podem prejudicar a absorção; - É fundamental ainda que a suplementação seja acompanhada de orientações para promoção de alimentação adequada e saudável, com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, priorizando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e evitando alimentos ultraprocessados, que podem prejudicar a saúde materna e fetal.	- Prescrever dois comprimidos de carbonato de cálcio 1.250 mg (500 mg de cálcio) ao dia, equivalente a 1.000 mg de cálcio elementar, para todas as gestantes; - Na falta de Cálcio isolado poderá ser prescrito o Cálcio que vem associado com Vitamina D na dosagem preconizada; - Caso a gestante apresente intolerância ao uso do cálcio, inicie com 1 comprimido até chegar na dose recomendada. Caso gestante não tolere mesmo assim, solicite que MFC (Medicina) avalie gestante seguindo então a conduta médica; - Para qualquer outra situação de ajuste de dose de Cálcio que não está preconizada na Nota técnica (Link abaixo) ou no protocolo de Enfermagem 03, a prescrição deverá ser realizada pelo médico; Nota Técnica de Florianópolis de 06 de março de 2025: Recomendações sobre a suplementação de cálcio para gestantes do município de Florianópolis com objetivo de prevenir distúrbios hipertensivos na gestação. - Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13r8m_zCNZZvIBnh_2vsnpwR8wKIGSx8bidJ9p9Ucx0/edit?usp=sharing. - Ingerir o suplemento à noite com leite ou suco de frutas;	Com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

6.4.1.2 – Rastreamento de Rotina

- Aferição da **pressão arterial (PA)** deve ser feita:
 - **Em todas as consultas de pré-natal.**
 - Na **consulta pré-concepcional**, quando houver.
- A melhor estratégia de detecção da hipertensão na gestação é a **identificação precoce de alterações pressóricas** (OPAS, 2018).

Quadro 44 – Rastreamento de Rotina das Alterações Pressóricas e Hipertensão Arterial na Gestação

RASTREAMENTO DE ROTINA DAS ALTERAÇÕES PRESSÓRICAS E HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GESTAÇÃO	
Classificação	Critérios (mínimo 2 aferições com 15 min. de intervalo)
Hipertensão Gestacional	PAS $\geq$ 140 mmHg e/ou PAD $\geq$ 90 mmHg
Hipertensão Grave	PAS $\geq$ 160 mmHg e/ou PAD $\geq$ 110 mmHg
• Atenção: Pressão diastólica deve ser registrada na fase V de Korotkoff (desaparecimento do som).	

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

Quadro 45 – Plano de Aferição e Monitoramento de Pressão Arterial pela Enfermagem

PLANO DE AFERIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL PELA ENFERMAGEM	
Situação Clínica	Conduta e Frequência de Aferição de PA e Monitoramento
• PA < 140x90 mmHg, sem sintomas	• Aferir em todas as consultas de Pré-Natal e de Demanda Espontânea;
• PA $\geq$ 140x90 mmHg ◦ Sem traço de proteinúria no teste rápido de urina	• Aferir 2x/semana ◦ Discutir e encaminhar com médico o atendimento; ◦ Realizar teste rápido de urina para avaliar traço de proteinúria 1x/semana;
• PA $\geq$ 140x90 mmHg ◦ Com traço de proteinúria no teste rápido de urina;	• Aferir 3x/semana ◦ Discutir e encaminhar com médico o atendimento; ◦ Encaminhar ao pré-natal de alto risco (PNAR);
• PA $\geq$ 160x110 mmHg	• Encaminhamento imediato para atendimento médico; • Encaminhar para UPA/Maternidade;
• ATENÇÃO	• Toda aferição de PA deve ser registrada em prontuário, no cartão da gestante ou impresso de monitoramento de Pressão Arterial; • Qualquer PA com sintomas de Alarme encaminhar imediatamente e realize registro completo; • Gestantes com monitoramento de PA devem ser avaliadas em consulta com maior frequência; • Compartilhe com técnicos de enfermagem as gestantes da área em monitoramento e treine os mesmos para identificarem alterações segurem o fluxo recomendado para atendimento imediato da gestante; • Reforce a toda equipe a importância do registro no prontuário, no cartão da gestante e impresso de monitoramento de PA; • Utilize os testes rápidos de urina para detecção de proteinúria, se disponível em no Centro de Saúde. Caso não tenha, mantenha o monitoramento com maior atenção aos valores Pressóricos e quadro clínico da gestante;
	• LEMBRE SEMPRE: SE NÃO REGISTROU E MONITOROU - VOCÊ NÃO FEZ!

6.4.1.3 – Implementação e Evolução de Enfermagem

1. **Identificar** os sinais e sintomas **precocemente** (cefaleia, escotomas, epigastria, edema, aumento de PA, ganho ponderal e sinais de sobrecarga hídrica).
2. Verificar se as receitas dos medicamentos anti-hipertensivos estão em dia e se gestante está fazendo uso de forma adequada com adesão.
3. Verificar uso adequado e adesão de AAs e da suplementação de Cálcio;
4. **Registrar imediatamente** no prontuário valores aferidos, técnicas utilizadas e posição da gestante.
5. Lembrar-se sempre de discutir e encaminhar com o médico de sua equipe (MFC) os riscos;
6. Realizar matriciamento ou encaminhamento para outros profissionais como nutricionista, psicologia, serviço social, farmacêutico, educador físico, fisioterapeuta, caso identifique que há contribuição destes profissionais para o atendimento da gestante que poderá impactar no cuidado;
7. Capacitar sua equipe de técnicos de enfermagem para estarem atentos às gestantes que realizam monitoramento de pressão arterial
 - Cerifique-se:
 - Eles executam a técnica de aferição corretamente;
 - Estão registrando de forma devida;
 - Realize orientação de como deve ser;
8. Capacitar seus ACSs para que identifiquem situações atípicas nas gestantes da área;
9. **Encaminhar** imediatamente para atendimento médico, pré-natal de alto risco e UPA/Maternidade nos casos de:
 - **PA $\geq$ 140x90 mmHg com sintomas**
 - **PA $\geq$ 160x110 mmHg mesmo sem sintomas**
10. **Realizar educação em saúde** com orientação sobre sinais de alerta e importância da adesão ao pré-natal.

6.4.2 – Manejo da Gestante com Diabetes Mellitus (DM)

O **diabetes mellitus gestacional (DMG)** é definido pelo como qualquer grau de intolerância à glicose, de gravidade variável, com início ou primeiro reconhecimento durante a gestação, excluindo-se casos de diabetes mellitus prévia. Quando a hiperglicemia detectada na gestação atinge valores compatíveis com os critérios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 ou 2, considera-se **DM previamente existente diagnosticado na gestação (overt diabetes)**. O diagnóstico diferencial é fundamental, pois ambas as condições estão associadas a riscos maternos e perinatais, exigindo acompanhamento e manejo específicos (BRASIL, 2021).

A condição é comum na gravidez e afeta cerca de **18% das gestantes atendidas no SUS**. Fatores de risco incluem: **obesidade, idade >25 anos, história familiar de DM, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, macrosomia fetal anterior e óbito fetal sem causa aparente**.

Durante a gestação, há aumento fisiológico da resistência à insulina, especialmente após a **24ª semana**, devido à ação de hormônios placentários. Quando o pâncreas materno não compensa essa demanda, ocorre a hiperglicemia.

Essa alteração está associada a **maior risco de complicações maternas e perinatais**, com impactos que podem se estender ao longo da vida da mãe e da criança.

O diabetes mellitus na gestação, seja pré-existente ou diagnosticado durante o pré-natal (diabetes gestacional), exige acompanhamento contínuo e multiprofissional para prevenir complicações maternas e perinatais. A equipe de enfermagem tem papel essencial no rastreamento, educação em saúde, vigilância clínica e adesão ao plano terapêutico.

REPERCUSSÕES EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO	
Na mãe	Nos filhos
GRAVIDEZ INICIAL	FETAIS
Aborto espontâneo	Crescimento fetal excessivo
AO LONGO DA GESTAÇÃO	Distocia de ombros
Pré-eclâmpsia	Lesão pelo braquial
Hipertensão gestacional	Hipoxia intrauterina
Hidrânio	Insuficiência placentária
Infecção do trato urinário	Óbito fetal
PARTO	NEONATAIS
Trabalho de parto prematuro	Hipoglicemia
Tocotraumatismo	Hiperbilirrubinemia
Parto instrumental	Icterícia/kemicterus
Cesárea	Policitemia
Infecção pós-parto	Trombose
PUERPÉRIO	Prematuridade
Infecção pós-parto	Distúrbio respiratório
Hemorragia pós-parto	Óbito neonatal
Tromboembolismo	MÉDIO E LONGO PRAZO
MÉDIO E LONGO PRAZO	Sobrepeso e obesidade
Dificuldade para perder peso	Alterações no metabolismo de:
DMG em futuras gestações	– Glicose (tolerância diminuída)
DM tipo 2	– Lipídios (dislipidemia)
Doença cardiovascular	– Ácidos graxos
	DMG (filhas) e DM tipo 2
	Doença cardiovascular

Fonte: MS 2019 / MS, 2023.

6.4.2.1 – Diagnósticos e Classificação da Gestante com DM

Quadro 46 – Diagnósticos e Classificação da Gestante com DM

DIAGNÓSTICOS E CLASSIFICAÇÃO DA GESTANTE COM DM
Critérios diagnósticos (ADA/SBD/OMS)
• Jejum ≥ 92 mg/dL • 1h após TOTG ≥ 180 mg/dL • 2h após TOTG ≥ 153 mg/dL • HbA1c $\geq 6,5\%$ (para DM prévio)

A enfermagem deve garantir o rastreamento laboratorial entre 24–28 semanas para gestantes de risco habitual e documentar adequadamente os resultados.

6.4.2.2 – Processo de Enfermagem no Pré-Natal com DM

- **Avaliação Contínua:**
 - Sintomas de hiperglicemia ou hipoglicemia;
 - Ganho de peso e IMC;
 - Sinais de infecção urinária ou vulvovaginite;
 - Presença de edema, alterações visuais, dor epigástrica (risco de pré-eclâmpsia).

6.4.2.3 – Monitoramento Clínico-Laboratorial na DM

Quadro 47 – Monitoramento Clínico-Laboratorial na DM

MONITORAMENTO CLÍNICO-LABORATORIAL NA DM	
Parâmetro	Frequência Sugerida
Glicemia Capilar	Jejum e 1-2hs pós prandial, pelo menos 3 x na semana • Ajustar conforme caso clínico da gestante
Pressão Arterial	Toda consulta, tanto programática como espontânea;
Peso Corporal	Toda consulta, tanto programática como espontânea;
Proteinúria em fita de teste rápido de urina	Mensal ou conforme classificação de risco • Desde que fitas disponíveis no CS
HbA1c (Hemoglobina glicada)	A cada 6–8 semanas (se gestante tiver Diabetes Mellitus prévio) • Este exame é de solicitação médica; Enfermeira(o) realiza monitoramento dos resultados • Classificando risco se for necessário;
Movimentação fetal	A partir da 28ª semana • Relato da gestante;

6.4.2.4 – Implementação de Enfermagem na DM

1. Realizar educação alimentar conforme plano nutricional individualizado (encaminhar e acompanhar adesão à nutricionista);
2. Promover prática de atividade física leve (se liberada, matriciar com educador físico);
3. Acompanhar a adesão ao uso de medicamentos (insulina, metformina - matriciar com farmacêutico a fim de promover melhores práticas no uso do medicamento);
4. Capacitar gestante para uso e aplicação da insulina, conservação, rodízio e realizar o automonitoramento de glicemia capilar (AMGC) se uso de insulina e se caso nunca usou;
5. Revisar, monitorar e auxiliar a gestante na sua prática e habilidade a fim de promover melhora na terapêutica e resultado no uso da medicação, identificando se existe um uso inadequado ou fragilidades no seu autocuidado no caso de gestantes com DM prévia em uso de insulina;
6. Verificar critérios e prescrição para que a gestante adquira o glicosímetro e fitas reagentes, orientar uso, verificar aparelho e monitorar o AMGC, registrando resultado e ensinando gestante a anotar em instrumento impresso de controle;
7. Capacitar técnicos de enfermagem para auxiliarem a gestante no processo de automonitoramento da glicemia capilar, bem como na fase inicial de uso da medicação, sempre avaliando e chamando a enfermeira(o) se alguma alteração ou anormalidade;

8. Orientar sobre sintomas de alerta e monitoramento fetal;
9. Avaliar e discutir com médica(o) MFC da equipe a necessidade de uma avaliação oftalmológica e da função renal para as gestantes com DM prévia;
10. Encaminhar à consulta médica para avaliação em caso de sinais de descompensação metabólica;
 - Discutir com médico encaminhamento à maternidade;
 - Discutir com médico avaliação e consulta antecipada com PNAR.

⚠ SINAIS DE RISCO A SEREM MONITORADOS

Glicemias persistentemente > 140 mg/dL pós-prandial;
Perda de peso não planejada;
Sinais de cetoacidose: náusea, vômito, sonolência, respiração rápida;
Diminuição de movimentos fetais;
Sinais de pré-eclâmpsia: PA elevada + dor epigástrica ou proteinúria.

*Encaminhar para Atendimento com médica(o) MFC,
garantir retorno prévio ao pré-natal de alto risco e
reclassificar riscos se assim for.*

11. Prescrever recomendações adicionais preventivas:
 - **Ácido Acetilsalicílico (AAS) 100–150 mg/dia**
 - Indicado para gestantes com DM tipo 1 ou 2;
 - Iniciar a partir de 12 semanas, manter até 10 dias antes da DPP;
 - **Suplementação Universal de cálcio 1.000 mg/dia**
 - Reduz risco de pré-eclâmpsia;
 - Iniciar a partir de 12 semanas até o parto;

6.4.2.5 – Condutas no Pós-Parto na DM

- Garantir consulta, monitoramento dos riscos no Período Puerperal;
- Acesso a Planejamento Reprodutivo;
- Reavaliação glicêmica (6-12 semanas) para descartar DM persistente.
- Orientação sobre risco aumentado em gestações futuras e DM tipo 2.
- O manejo multidisciplinar é essencial para reduzir riscos e garantir uma gestação segura;

6.4.3 – Manejo da Gestante com Asma

A asma é a doença respiratória crônica mais comum na gestação, com impacto direto na morbimortalidade materna e fetal. Pode se agravar, melhorar ou permanecer estável durante a gravidez. Exacerbações são mais frequentes no 2º trimestre, e o risco de insuficiência respiratória aumenta devido às alterações fisiológicas pulmonares da gestação (GINA, 2024).

Os sintomas incluem sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse, desencadeados por alérgenos, infecções ou mudanças ambientais. O diagnóstico é clínico e pode ser confirmado pela espirometria com $VEF1/CVF < 0,8$ e reversibilidade com broncodilatador ($>12\%$ ou 200 ml). O controle da asma é classificado como controlado, parcialmente controlado ou não controlado (GINA, 2024).

6.4.3.1 – Implementação de Enfermagem para Gestante com Asma

A enfermagem desempenha papel central no acompanhamento da gestante asmática, com autonomia clínica na avaliação dos sintomas respiratórios, estratificação de risco, adesão ao tratamento e educação em saúde.

1. Realizar escuta qualificada e classificação dos sintomas e riscos.
2. Identificar sinais de gravidade (ex. fala entrecortada, tiragem, uso de musculatura acessória).
3. Fornecer o espaçador para gestante, se caso tiver falta de espaçador na rede ensinar como adaptar uma garrafinha pet de 500ml até que tenha a reposição de um espaçador adequado;
4. Orientar sobre o uso correto do espaçador, essencial para eficácia dos inalatórios, especialmente em situações de crise. O espaçador aumenta a deposição pulmonar do medicamento e reduz efeitos colaterais.
5. Evitar o uso direto da bombinha sem espaçador, especialmente com corticosteroides inalatórios, pois pode provocar candidíase oral e reduzir a eficácia terapêutica.
6. Estimular a adesão ao plano terapêutico, reforçando a importância do uso contínuo dos medicamentos de manutenção, mesmo na ausência de sintomas.
7. Conferir e educar gestante para uso correto da bombinha e para que não falte medicamento e nem prescrição médica.
8. Acompanhar o plano de autocuidado, com monitoramento de PFE (Pico de Fluxo Expiratório) e saturação de O_2 (alvo $\geq 94\%$).
9. Encaminhar para Atendimento médico (MFC) e para PNAR, em caso de crise de asma moderada/grave ou descontrole persistente.
10. Realizar educação em saúde e prevenção de crises com cuidados como:
 - Evitar gatilhos ambientais (fumaça, poeira, mofo);
 - Controlar comorbidades como rinite e refluxo;
 - Incentivar a vacinação (influenza, COVID-19);
 - Manter acompanhamento regular e plano de ação para crises;
 - Facilitar acesso prioritário para atendimento médico se for necessário;
 - Registrar em cartão de gestante e prontuário eletrônico com alertas necessários para as situações de risco.

6.4.3.2 – Tratamento e Medicações para Gestante com Asma

O tratamento que é **CONDUTA E PRESCRIÇÃO MÉDICA**, baseia-se em:

- Corticosteroide inalatório (CI): primeira escolha para controle (ex. budesonida, beclometasona).
- Beta2-agonista de curta duração (salbutamol): indicado para alívio das crises.
- Associações CI + Beta2 de longa duração: usadas quando CI isolado não controla os sintomas.
- Corticosteroides sistêmicos: indicados em crises moderadas a graves.
- Sulfato de magnésio EV: usado em emergências com refratariedade ao tratamento inicial.
- A maior parte dos medicamentos é segura na gravidez (categorias B/C - FDA).
- A budesonida é a mais estudada e considerada segura para uso contínuo (GINA, 2024; Ministério da Saúde, 2022).

6.4.4 – Manejo da Gestante com Sífilis

Quadro 48 – Tratamento nos casos de sífilis em mulheres, mulheres gestantes e seus parceiros.

TRATAMENTO NOS CASOS DE SÍFILIS EM MULHERES, MULHERES GESTANTES E SEUS PARCEIROS		
Sífilis primária, secundária ou recente, ou seja, menos de 1 ano de evolução	Sífilis tardia, ou seja, mais de 1 ano de evolução	Observação
• Penicilina 2.400.000 UI - o Dose única - o 1.200.000 UI em cada nádega.	• Penicilina 7.200.000 UI - o (2.400.000 por semana, durante 3 semanas.) ▪ 1.200.000 UI em cada nádega.	• Seguimento mensal durante o pré-natal e após o parto durante o primeiro ano de vida (Ver protocolo volume 2) • Gestantes alérgicas devem ser encaminhadas para dessensibilização junto a referência hospitalar • As parcerias dos últimos 90 dias devem sempre ser convocadas para avaliação e tratamento, conforme estadiamento. - o As parcerias dos últimos 90 dias devem sempre ser tratadas independente de testes. Se o teste para sífilis destas for positivo, realizar tratamento conforme quadro 3.3 do protocolo volume 2. Se for não reagente (teste negativo), realizar a aplicação de uma dose (2,4 milhões de UI) de penicilina. Registrar essas informações no prontuário e na caderneta da gestante, se este for o caso.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2022.

6.4.5 – Manejo da Gestante com Clamídia e/ou Gonorreia

Quadro 49 – Tratamento medicamentoso conforme cultura identificada nos casos de rastreamento de NG e/ou CT.

TRATAMENTO NOS CASOS DE SÍFILIS EM MULHERES, MULHERES GESTANTES E SEUS PARCEIROS		
Agente Etiológico	Primeira Escolha	Segunda Escolha
<i>Chlamydia Trachomatis</i> (CT) e <i>Neisseria Gonorrhoeae</i> (NG)	- Ceftriaxona 500mg, 1 ampola IM em dose única + Azitromicina 500mg, 2 cp VO em dose única	- Na indisponibilidade de Ceftriaxona, utilizar: Gentamicina 240 mg IM em dose única • (CONTRAINDICADO EM GESTANTES) + Azitromicina 500 mg 4 comprimidos VO dose única
Somente para <i>Neisseria Gonorrhoeae</i> (NG)	- Ceftriaxona 500mg, 1 ampola IM em dose única + Azitromicina 500mg, 2 comprimidos VO em dose única	
Somente <i>Chlamydia Trachomatis</i> (CT)	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos VO em dose única	- Doxiciclina 100 mg, VO, 2x ao dia (12/12 horas), por 7 dias • (CONTRAINDICADO EM GESTANTES)
Importante: - Prescreva o mesmo tratamento de forma concomitante para todas as parcerias sexuais dos últimos 60 dias, independente de testes ou sintomas. - Oriente abster-se de sexo (paciente e parcerias) por pelo menos 7 dias após o tratamento		

Fonte: Adaptado de Brasil, 2022.

6.4.6 – Manejo da Gestante com Varicela / Herpes-zoster

A varicela é uma doença viral causada pelo vírus Varicela Zoster, habitualmente benigna na infância, embora esteja associada a complicações em gestantes. A infecção em gestantes no primeiro ou no segundo trimestre de gestação pode resultar em embriopatia.

„ Gestantes que nunca tiveram varicela e que tiveram contato com pessoa infectada (varicela ou herpes zóster) durante pelo menos 1 hora em ambiente fechado, deverão receber a Imunoglobulina (IGHVAZ) até 96 horas a partir do contato.

Realizar solicitação via e-mail à rede de frio (querovacina@gmail.com) e ligar para o setor para certificar que foi recebido pelo telefone 3271-1710.

A dose é de 125UI/10Kg de peso corporal, independentemente da idade. A dose mínima é de 125 UI e a dose máxima é de 625 UI por via intramuscular.

6.5 – MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Quadro 50 – Modificações e Desconfortos Mais Frequentes na Gestaç o

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO		
Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Cefaleia	- Bastante comum no primeiro trimestre devido a alterações hormonais; - Pode também estar relacionada à tensão emocional, ansiedade, medo, insegurança a períodos longos em jejum e ingesta hídrica inadequada; - Sempre afastar o risco de alterações na Pressão Arterial e sinais de pré-eclâmpsia; - Investigar história prévia de enxaqueca ou outras causas ou uso de medicamentos.	- Repousar em local com pouca luminosidade e boa ventilação; - Conversar com a gestante tentando identificar fatores emocionais, exercícios de relaxamento e respiração, prática de meditação, yoga ou natação podem ser práticas interessantes; - Facilitar a expressão de sentimentos e expectativas; - Estimular a participação em grupos de gestantes ou de psicoterapia; - Estimular a prática física; - Estimular aumento da ingesta hídrica e alimentação adequada; - Se dor recorrente, solicitar avaliação médica; - Afastando a hipótese de qualquer risco prescrever: - Paracetamol (500-750 mg), de 6/6 horas.
Desmaios/ Tonturas/ Fraquezas	- Alteração na mecânica corporal e instabilidade motora e de hemodinâmica (vasodilatação e hipotonia vascular (progesterona) e estase sanguínea em membros inferiores); - Diminuição do débito cardíaco; - Quadros de Hipotensão postural e de supina (por compressão da veia cava e aorta abdominal) - Anemia; - Hipoglicemia.	- Repousar de preferência em decúbito lateral esquerdo; - Movimentar-se com mais cuidado e mais devagar; - Estimular prática de exercícios físicos e respiratórios; - Evitar ambientes fechados e com muitas pessoas; - Orientar alimentação fracionada rica em ferro e vitamina C; - Incentivar ingesta hídrica adequada; - Sentar-se com a cabeça abaixada ou deitar-se de decúbito lateral esquerdo e respirar profunda e pausadamente para aliviar os sintomas; - Nos casos recorrentes, o uso de meias elásticas pode melhorar o retorno venoso; - Retorno venoso pode estar indicado; - Avaliar a pressão arterial.
Sonolência	Relacionada a aspectos que circundam o universo psíquico da gestante como a regressão inconsciente ao seu nascimento, ambivalência, introspecção e muitas vezes fuga para auxiliar no enfrentamento dos medos e inseguranças que circundam a hora do parto.	- Estimular a gestante falar sobre suas expectativas e sentimentos; - Estimular o repouso; - Estimular a prática física, exercícios de respiração, yoga; - Estimular a meditação; - Avaliar Pressão arterial; - Aumentar ingesta hídrica.

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Insônia	- Stress, sobrecarga de trabalho; - Dificuldade de achar uma postura confortável para dormir; - Aspectos emocionais que circundam o momento do parto como ansiedade, medo; - Aspectos emocionais que circundam o cuidado e a chegada do bebê; - Movimentação fetal excessiva.	- Estimular a gestante falar sobre suas expectativas e sentimentos; - Estimular o repouso; - Estimular a prática física, exercícios de respiração, yoga; - Estimular a meditação; - Avaliar Pressão arterial; - Aumentar ingesta hídrica; - Estimular atividades de lazer e companhia de pessoas da rede de apoio da gestante - Participar de grupos de gestantes; - Ler livros e filmes que relaxem; - Evitar tumultos, situações de medo, pessoas indesejáveis, notícias ruins; - Banhos mornos, massagens; - Chá de erva doce, suco de maracujá com talo de alface.
Náuseas/ vômitos	- Devido as alterações hormonais da gravidez são comuns no primeiro trimestre da gravidez, retornando as vezes no 3º trimestre também; - Costumam ser mais intensas pela manhã, ao acordar ou após um período de jejum prolongado. Pioram com estímulos sensoriais, em especial do olfato, como o cheiro de cigarro; ou do paladar, como pasta de dentes; - Atenção a aspectos emocionais que circundam a gestante, expectativas com a gravidez, ansiedade, história previa de tabagismo; - Gestação não planejada, problemas conjugais, gestante adolescente ou muito jovem; - Avaliar sempre o risco de evolução para Hiperêmese gravídica caracterizada por vômitos contínuos e intensos ocasionando muitas vezes a desidratação, perda de peso, alterações urinárias e alterações metabólicas.	- Fazer alimentação fracionada de 3/3 h de preferência; - Alimentar-se logo ao acordar e antes de deitar comer algo leve; - Evitar jejum prolongado; - Comer devagar e mastigar bem os alimentos; - Dar preferência a alimentos pastosos e secos (pão, torradas, bolachas); - Evitar alimentos muito gordurosos, temperados, doces ou com odor forte; - Realizar ingesta hídrica adequada; - Avaliar risco de desnutrição; - Orientar apoio psicoterápico, se necessário; - Evitar chá de camomila; - Ofertar auriculoterapia ou acupuntura; - Consumir gengibre in natura - 500mg a 1g/dia; - Na suspeita de Hiperêmese Gravídica, solicitar avaliação médica. - Prescrever tratamento medicamentoso, se necessário: - Dimenidrinato (50mg ou 100 mg) - 1 cp de 8/8 hs (não exceder 400 mg/dia) - Dimenidrinato (50mg ou 100mg) + Piridoxina 10mg - 1 cp de 8/8 hs (não exceder 400 mg/dia) - Metoclopramida 10mg de 8/8hs até 5 dias – não ultrapassar 30mg/dia AVALIAR SE PACIENTE TEM ALERGIA OU SENSIBILIDADE À MEDICAÇÃO, DEVIDO AO RISCO DE SINTOMAS EXTRA PIRAMIDAIIS (TREMORES, ANSIEDADE E DESEQUILIBRIO POSTURAL) NÃO PRESCREVER METOCLOPRAMIDA PARA MULHERES MENORES DE 18 ANOS

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Queixas urinárias	- A provável compressão da bexiga pelo útero gravídico, diminui a capacidade volumétrica, ocasionando a urgência e frequência de urinar e a nictúria (aumento do ritmo miccional no período de sono), que se acentua à medida que a gravidez progride, dispensando tratamento e cuidados especiais. - Avaliar sempre: - Presença de sinais de alerta; - Presença de sintomas sistêmicos.	- Aumentar ingestão hídrica; - Repouso em decúbito lateral esquerdo; - Orientar que o sintoma é transitório até o final da gravidez; - Caso existam sintomas sugestivos de infecção urinária, avaliar conforme <u>Quadro 13</u>
Dor Abdominal/ Cólica	- Entre as causas mais frequentes estão: o corpo lúteo gravídico, flatulência, sensação de queda causada pelo peso da barriga, cólicas intestinais o estiramento do ligamento redondo e as contrações uterinas de Braxton Hicks, geralmente são discretas, indolores, sem ritmo e desaparecem espontaneamente (por volta da 30ª semana); - Também pode ter dor abdominal baixa pelo peso uterino e o relaxamento das articulações da pelve. - Avaliar sempre: - Presença de sinais de alerta (febre, sinal de Blumberg positivo, sangramento vaginal, cólicas que se tornam mais frequentes e fortes com o passar do tempo); - Presença de ITU; - Verificar se a gestante não está apresentando contrações uterinas.	- Orientar paciente manter repouso em decúbito lateral esquerdo (aumenta débito cardíaco, facilita o fluxo da placenta, aumentando a oxigenação para o bebê e a mãe); - Encorajar a falar de seus sentimentos e expectativas; - Usar cintas ou travesseiros e almofadas para apoiar barriga; - Orientar cuidados nutricionais, aumento ingestão hídrica e bons hábitos para prevenir a constipação e flatulência; - Avaliar dinâmica uterina e sinais de parto prematuro; - Em caso de TPP, orientar manter repouso, evitar esforço, abstinência sexual até cessarem contrações e não estimular o mamilo; - Prescrever hioscina 10 mg de 8/8 horas por até 5 dias se necessário.
Pirose/ Azia	- Devido a alterações hormonais, ocasionando distúrbios na motilidade gástrica resultando em refluxo e regurgitação, aumento da pressão intra-abdominal aumento da pressão intraperitoneal, pelo crescimento uterino; - Presente na maioria das vezes durante toda gestação, é mais observado no 3º trimestre; - Se presença concomitante com elevação pressórica, investigar possibilidade de pré-eclâmpsia. - Avaliar sempre: - História Clínica; - Uso de medicamentos.	- Fazer alimentação fracionada de 3/3 h de preferência; - Evitar líquido durante as refeições e deitar-se logo após as refeições; - Ingerir líquido gelado durante a crise ou gelo ou ainda uma bolacha seca; - Elevar a cabeceira da cama ao dormir; - Evitar frituras, café, chá mate e preto, doces, alimentos gordurosos e/ou picantes; - Caso essas medidas não resolvam prescrever Hidróxido de alumínio, 10-15 ml (duas colheres de chá a uma colher de sopa) após as refeições e ao deitar-se; - Encaminhar para avaliação médica caso não tenha melhora do quadro.

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Edema	- No geral, surge no 3º trimestre da gestação, resultando da ação dos hormônios esteroides dos ovários, da placenta e da suprarrenal e das modificações circulatórias relacionadas com mecânica postural, atividades laborais ou hábitos da gestante, aumentando a congestão venosa devido também ao ortostatismo (ficar em pé) prolongado e com a deambulação; - Desaparece pela manhã e acentua-se ao longo do dia. - Avaliar sempre: - A possibilidade do edema patológico, em geral associado à hipertensão e proteinúria, sendo sinal de pré-eclâmpsia (veja <u>Quadro 40</u>); - A maioria das grávidas edemaciadas exibe gestação normal; - Com maior frequência no final da gestação, mas pode aparecer em todo período gestacional.	- Elevar pernas acima da linha do coração pelo menos 10/15 min. várias vezes ao dia; - Realizar exercícios rotatórios com tornozelos; - Dormir em decúbito lateral esquerdo com as pernas elevadas, se caso for necessário adaptar o pé da cama com tijolos. Esta posição favorece o retorno venoso diminuindo o edema; - Usar roupas leves, evitando meias elásticas ou roupas apertadas que dificultem o retorno venoso; - Orientar dieta normossódica e aumentar ingestão hídrica; - Realizar controle de peso e pressão arterial.
Dor lombar e dor na região pélvica	- As ações dos hormônios agem ativamente em nossas articulações causando um evento denominado embebição gravídica, a adaptação da postura materna, peso fetal, deslocamento do centro de gravidade, tensões posturais e dorsal, problemas em nervo ciático podem ser as possíveis causas da gestante referir dor lombar e dor na região pélvica. - Avaliar sempre: - Características da dor (mecânica ou inflamatória, tempo de evolução, fatores de melhora ou piora, relação com o movimento); - Sinais e sintomas associados (alerta para febre, mal-estar geral); - Sintomas urinários, enrijecimento abdominal e/ou contrações uterinas, déficit neurológico); - História de trauma.	- Recomendar o uso de sapatos confortáveis e evitar saltos altos; - Recomendar a aplicação de calor local e massagens; - Recomendar acupuntura; - Corrigir postura e movimentar-se devagar; - Indicar atividades de alongamento, relaxamento e orientação postural; - Se não melhorarem as dores, considerar prescrever Paracetamol (500-750 mg), de 6/6 horas; - Utilizar travesseiros entre as pernas para alinhar coluna; - Evitar exercícios em excesso seguindo o ritmo que a gestante conseguir suportar com conforto; - Realizar atividades de lazer para diminuir o estresse e ansiedade; - Estimular a gestante a confiar em sua consciência corporal restringindo o que lhe causa dor e desconforto; - Encaminhar para fisioterapia caso necessário.

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Cãibras	- Geralmente iniciam no primeiro trimestre e podem se intensificar até o final da gravidez; - A causa pode estar associada a alguns fatores dentre eles: - Estiramento da musculatura e da fáscia; - Deficiente circulação nos músculos devido a pressão uterina; - Redução do nível de Cálcio; - Compressão de raízes nervosas; - Problemas posturais;	- Aumentar ingestão de alimentos ricos em potássio (banana/melão) e reduzir alimentos ricos em fósforo (iogurte, grãos, carne vermelha etc.); - Recomendar pisar em superfície fria; - Massagear músculo contraído e dolorido; - Evitar o alongamento muscular excessivo ao acordar, em especial dos músculos do pé (ato de se espreguiçar); - No último trimestre evitar ficar na mesma posição por período prolongado; - Nas crises, a grávida com câimbras nos membros inferiores se beneficia muito do calor local, da aplicação de massagens na perna e da realização de movimentos passivos de extensão e flexão do pé; - Evitar excesso de exercício físico e massagear o músculo contraído e dolorido; - Realizar alongamentos específicos, com orientação profissional;
Constipação Intestinal e Flatulências	- Pela ação hormonal dos esteroides e progesterona, há um relaxamento da musculatura lisa, diminuindo peristaltismo, diminuição do tônus, aumentando o tempo do esvaziamento gástrico, favorecendo a flatulência e hábito de eliminação intestinal inadequado; - Às vezes é agravado pela consistência das fezes, fissuras e hemorroidas.	- Ingerir alimentos ricos em fibras como legumes, verduras, frutas, vegetais crus e grãos integrais, mamão, linhaça, gergelim, mamão, ameixa seca; - Fracionar alimentação 3/3 horas; - Estabelecer como rotina horário de evacuação; - Aumentar ingestão hídrica; - Evitar alimentos flatulosos (feijão, grão-de-bico, lentilha, repolho, brócolis, pimentão, pepino e couve); - Realizar higiene anal após evacuação com água e sabão; - Evitar óleos minerais que dificultam a absorção das vitaminas; - Caso cuidados não sejam efetivos encaminhar para avaliação médica.
Sialorreia	A sialorreia, ptialismo ou salivagem excessiva é uma das queixas que mais incomodam na gravidez. Está associada a náusea e pode causar a perda de líquidos, eletrólitos e enzimas.	- Orientar paciente sobre o desconforto; - Manter dieta semelhante à indicada para náuseas e vômitos; - Orientar a gestante a deglutir a saliva; - Aumentar ingestão hídrica.

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Hiperpigmentação da Pele	- O aparecimento de manchas castanhas e irregulares na face ocorre em torno de 50% a 70% das gestantes, dando origem ao cloasma gravídico; - Devido ao aumento dos Hormônios melanina, estrógeno e progesterona.	- Geralmente desaparecem lentamente, ou ao menos regridem após o parto. Entretanto, um número considerável de casos exige tratamento dermatológico; - Orientar que é comum na gravidez e costuma diminuir ou desaparecer após o parto; - Evitar exposição direta ao sol (usar boné, chapéu ou sombrinha); - Utilizar filtro solar, aplicando no mínimo três vezes ao dia.
Dispneia	- Embora o fator mecânico (compressão do diafragma pelo útero gravídico) contribua para o agravamento da queixa no final da gestação, é a hiperventilação a maior responsável por esse distúrbio respiratório; - Atentar sempre as comorbidades e história clínica da paciente.	- É recomendado realizar ausculta cardíaca e pulmonar e, se houver alterações, encaminhar para avaliação médica; - Solicitar repouso em decúbito lateral esquerdo; - Elevar a cabeceira da cama.
Hemorroidas	- O mais provável é que, na gestação, as hemorroidas preexistentes e assintomáticas possam ser agravadas; - É certo que aquelas previamente sintomáticas se agravam na gestação e, sobretudo, no parto e no pós-parto; - Avaliar: - Aumento da intensidade da dor; - Endurecimento do botão hemorroidário; - Sangramento retal.	- Realizar exercícios de contrações do assoalho pélvico para facilitar circulação anal e perineal; - Dieta rica em fibras, estimular a ingestão de líquidos e, se necessário, supositórios de glicerina; - Higiene local com duchas ou banhos após a evacuação; - Banho de assento com água morna; - Em qualquer alteração, se faz necessária avaliação médica.
Epistaxe: Sangramento Nasal	- O aumento de estrogênio característico da gestação provoca mudanças na mucosa que favorecem o sangramento nasal, principalmente em locais menos úmidos e no inverno; - Sendo em pequena quantidade e esporádico, não é motivo para preocupação; - Acompanhar pressão arterial sistêmica e capacidade de coagulação.	- Prescrever uso de Soro nasal com 2 a 4 gotas em cada narina, 3 a 4 vezes ao dia ou o suficiente para manter as narinas úmidas; - Compressão com aplicação de compressa fria na base do nariz; - Encaminhar para avaliação médica, caso necessário.
Síndrome do Túnel Carpeano	- Ocorre devido a compressão geralmente relacionada ao edema do nervo mediano em torno do polegar; - Os sintomas se iniciam geralmente com sensibilidade, dormência e formigamento podendo evoluir para dor.	- Usar talas no pulso para dormir, aplicação de frio local; - Dormir com as mãos elevadas; - Exercícios de alongamento dos membros superiores ajudam bastante.

Continua.

MODIFICAÇÕES E DESCONFORTOS MAIS FREQUENTES NA GESTAÇÃO

Modificação / Desconforto	Observações	Orientações / Prescrições de Enfermagem
Leucorreia	- O aumento do fluxo vaginal é comum na gestação, sendo importante realizar avaliação adequada pelo fato de as vulvovaginites infecciosas estarem associadas ao parto prematuro, baixo peso ao nascer, rotura prematura de membranas; - Avaliar sempre: - Se há queixas de mudanças do aspecto do corrimento, coloração, presença de sintomas associados como prurido, ardência, odor e outros; - O fluxo vaginal normal é comumente aumentado durante a gestação e não causa prurido, desconforto ou odor fétido;	- Usar calcinhas confortáveis de malha, lavar com sabão neutro e secar ao ar livre se possível; - Fazer higiene íntima no sentido antro posterior com sabão neutro; - Encaminhar bacterioscopia conforme avaliação; - Tratar caso necessário conforme capítulo anterior sobre vulvovaginites.
Estrias	- Lesões dermatológicas definitivas que aparecem na segunda metade da gravidez e se localizam, preferencialmente, no abdome inferior, na região glútea, nas coxas e nos seios; - Orientar que são frequentes após o 5º mês de gestação, geralmente no quadril, abdome e mamas, ocasionadas pela distensão dos tecidos, e que não existe método eficaz de prevenção ou de tratamento.	- Ainda que polêmica, na tentativa de preveni-las, pode ser recomendada as seguintes orientações: - A hidratação reflete também na elasticidade da pele, por isso orientar e estimular aumento da ingesta hídrica; - O uso de cremes e óleos específicos para gestação pode ajudar; - O ganho adequado de peso também vai atuar na prevenção de estrias; QUALQUER TRATAMENTO DE ESTRIAS ESTÁ CONTRAINDICADO NA GESTAÇÃO, INCLUSIVE O USO DE ÁCIDO RETINOICO, É TAMBÉM CONTRAINDICADO NA AMAMENTAÇÃO.
Sangramento nas Gengivas	Devido a ação da produção de hormônios esteroides que resultam em um aumento da vascularização e vasodilatação dos tecidos conjuntivos, as gengivas apresentam-se mais sensíveis e a cavidade oral e dentição mais propensa a doença periodontal.	- Encaminhar toda gestante para consulta e avaliação odontológica; - Fazer uso de uma escova de dente macia e suave.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

6.6 - IMUNIZAÇÃO PARA GESTANTES SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL

VACINAS ROTINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	VIA DE ADM/ VOL DOSE	HISTÓRICO VACINAL	DOSES RECOMENDADAS			IDADE/GRUPO POPULACIONAL	INTERVALO ENTRE AS DOSES	
					ESQUEMA BÁSICO	REFORÇOS	PERIÓDICAS		RECOMENDADO	MÍNIMO
Vacina hepatite B (recombinante) – HB¹	Infecções causadas pelo vírus da hepatite B e suas complicações (hepatite B, hepatite D)	Antígeno recombinante de superfície do vírus purificado (HbsAg) (monovalente)	<u>Via de Administração</u> (IM) Intramuscular <u>Vol da Dose</u> Laboratório LG/Butantan 0 a 15 anos, 0,5 mL (12,5 mcg) A partir de 16 anos de idade, 1,0 mL (25 mcg) Laboratório Merck Sharp & Dohme LLC/Recombivax 0 a 19 anos, 0,5 mL (5 mcg) Laboratório GSK/Engerix B 0 a 19 anos, 0,5 mL (10mcg) (As informações podem variar conforme laboratório produtor)	Sem esquema vacinal completo	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com a situação vacinal, observando os intervalos recomendados	*	-	Atualizar a situação vacinal desde a 1ª consulta pré-natal	1 mês entre a 1ª e a 2ª dose 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose	1 mês entre a 1ª e a 2ª dose 2 meses entre a 2ª e a 3ª dose 4 meses entre a 1ª e a 3ª dose

gov.br/saude



1



MINISTÉRIO DA SAÚDE



ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

VACINAS ROTINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	VIA DE ADM/ VOL DOSE	HISTÓRICO VACINAL	DOSES RECOMENDADAS			IDADE/GRUPO POPULACIONAL	INTERVALO ENTRE AS DOSES	
					ESQUEMA BÁSICO	REFORÇOS	PERIÓDICAS		RECOMENDADO	MÍNIMO
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis acelarular (Triplíce bacteriana acelarular tipo adulto) – dTpa² e Vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dupla bacteriana adulto) – dT	dTpa: Difteria (<i>C. diphtheriae</i>), tétano (<i>C. tetani</i>), coqueluche (<i>B. pertussis</i>) e suas complicações. Uma estratégia importante para o controle da coqueluche em recém-nascidos	dTpa: Toxoides diftérico (teor reduzido) + tetânico + pertussis (acelarular) purificados	Via de Administração (IM) Intramuscular Vol da Dose 0,5 mL (As informações podem variar conforme produto disponível)	Histórico vacinal de pelo menos 3 doses de vacina contendo componentes tetânico e diftérico	-	1 dose de reforço com dTpa a partir da 20ª semana gestacional, a cada gestação Observar o intervalo recomendado	-	Revisar a situação vacinal na 1ª consulta pré-natal e iniciar a atualização de esquemas em atraso e agendar as próximas doses, se necessário Agendar a dose da vacina dTpa a partir da 20ª semana de gestação	60 dias	30 dias
				Histórico vacinal de pelo menos 2 doses de vacina contendo componentes diftérico e tetânico	1 dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação Observar o intervalo recomendado	-				
				Histórico vacinal de 1 dose contendo componentes diftérico e tetânico	1 dose de dT e 1 dose de dTpa (esta a partir da 20ª semana gestacional) Observar o intervalo recomendado	-				
Vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada) - INF3³	Influenza (gripe), causada pelo <i>Myxovirus influenzae</i> , e suas complicações	Vírus inativados fracionados	Via de Administração IM (intramuscular) ou SC (subcutânea) Vol da Dose A partir de 9 anos de idade 0,5 mL (dose única) (As informações podem variar conforme produto disponível)	-	-	-	1 dose com a vacina da temporada	Qualquer fase gestacional, qualquer idade	-	30 dias da última dose recebida

VACINAS ROTINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	VIA DE ADM/ VOL DOSE	HISTÓRICO VACINAL	DOSES RECOMENDADAS			IDADE/GRUPO POPULACIONAL	INTERVALO ENTRE AS DOSES	
					ESQUEMA BÁSICO	REFORÇOS	PERIÓDICAS		RECOMENDADO	MÍNIMO
Vacina covid-19 ⁴	Formas graves e óbitos por covid-19, causadas pelo vírus SARS-CoV-2, e complicações	RNA mensageiro de cadeia simples, codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2 (vacinas Spikevax e Comirnaty)	<u>Via de Administração</u> IM (Intramuscular) <u>Vol da Dose</u> Vacina Covid-19 RNAm Pfizer (Comirnaty) - Menores de 12 anos de idade 0,3 ml (frasco-ampola tampa cor azul/não diluir) - A partir de 12 anos de idade 0,3 ml (frasco-ampola tampa cor cinza/não diluir)	Independente da quantidade de doses prévias recebidas	-	-	1 dose a cada gestação	Qualquer fase gestacional, qualquer idade	-	6 meses da última dose recebida
		Proteína S (spike) do SARS-CoV-2 associada ao adjuvante Matrix-M produzida por tecnologia de DNA recombinante (vacina Serum/Zalika)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) - Menores de 12 anos de idade 0,25 mL - A partir de 12 anos de idade 0,5 mL Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika A partir de 12 anos de idade 0,5 mL (As informações podem variar conforme produto disponível)					Observar as faixas etárias indicadas para cada produto disponível		

6.7 - PLANO DE PARTO

O plano de parto é um instrumento que promove a autonomia da mulher ao permitir que ela manifeste suas preferências, valores e desejos para o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Trata-se de uma ferramenta de comunicação entre a gestante e os profissionais de saúde, que fortalece a humanização do cuidado, favorece o vínculo e contribui para uma experiência de parto mais segura, respeitosa e positiva.

A equipe de enfermagem tem papel fundamental na construção, acolhimento e valorização do plano de parto, promovendo escuta ativa, garantindo acesso à informação qualificada e apoiando decisões informadas. Além disso, o plano de parto contribui para a prevenção da violência obstétrica e reforça o modelo de cuidado centrado na mulher.

Incentivar sua elaboração desde o pré-natal é uma prática baseada em evidências e alinhada às diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

A seguir, uma sugestão de modelo de Plano de Parto, deixando à vontade profissionais e gestantes a liberdade de construir o seu de acordo com suas expectativas e vontades. (Versão para impressão disponível em ANEXO I – MODELO DE PLANO DE PARTO, bem como pelo QR Code abaixo).



Anexo I - Protocolo 03 PMF
Florianópolis
Modelo de Plano de Parto

O que é o plano de parto?

O plano de parto é uma carta que a gestante elabora, relatando seu desejo referente ao momento do parto, possibilitando o planejamento do nascimento do seu bebê. É um importante instrumento de empoderamento feminino e de informação sobre as práticas recomendadas para a assistência ao parto.

⚠ Sinais de Trabalho de Parto ⚠

- Sangramento;
- Eliminação do tampão mucoso com raia de sangue;
- Rompimento Espontâneo da Bolsa de líquido Amniótico (pode ser com perda de líquido em grande ou pequena quantidade);
- Contrações regulares, por vezes dolorosas (3 contrações ou mais com 20 seg em 10min);

Então, é hora de procurar o serviço de referência ao parto!

Estamos cientes das recomendações e escolhas relacionadas ao parto e desejamos receber atenção humanizada e respeitosa no nascimento do seu bebê.

Gratos.



Maternidade HU (Hospital Universitário)
Endereço: R. Prof.ª Maria Flora Paucowang - Trindade, Florianópolis
Telefone: (48) 3722-9190

Maternidade Carmela Dutra
Endereço: R. Imã Benedita, 208 - Centro, Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3664.3500

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
SAÚDE

MEU PLANO DE PARTO

Nome: _____ DPP: _____

Nome do bebê: _____

Maternidade: _____

Local: onde realizou pré natal: _____



DURANTE O TRABALHO DE PARTO	DURANTE O TRABALHO DE PARTO	
Acompanhamento: Você quer a presença de pessoas durante o parto? () Sim () Não Quem você quer presente durante o parto? Escolha alguém além da sua doula. A raspagem dos pelos e a lavagem intestinal não são necessárias. É comum que a mulher elimine fezes, mas, se desejar, pode pedir um supositório de glicerina para esvaziar o intestino e reduzir essa possibilidade. Deseja usar supositório de glicerina? () Sim () Não Métodos para alívio da dor: Diversas técnicas estão disponíveis (massagens, exercícios, banhos, respiração, uso de medicamentos, etc.). Conforme a disponibilidade da maternidade, escolha as opções que você gostaria de experimentar: Você também pode tomar líquidos para manter-se hidratada. Conforme disponibilidade da maternidade, o que deseja ingerir? Você gostaria de fazer uso caso a maternidade ofereça práticas integrativas? (ex: acupuntura, meditação...) () Sim () Não	Posição durante o parto: Você pode escolher a posição mais confortável para você (sentada, de lado, de cócoras, deitada com a cabeça elevada e genupectoral). A posição mais adequada vai sendo experimentada e mudada conforme o momento. Ambiente do parto: Manter o ambiente com pouca luminosidade e com música para ajudar a relaxar e tranquilizar. O que você deseja? Em casos específicos, pode ser necessário o uso de extratores (fórceps ou vácuo-extractor) ou a realização de episiotomia (corte na vagina), mas esses procedimentos não devem ser rotina, apenas em situações de emergência. A equipe deve informar a necessidade de sua utilização. APÓS O PARTO A Hora Dourada do Nascimento: Ao nascer, o bebê é acolhido e colocado em contato pele a pele com a mãe antes de cortar o cordão umbilical, que deve ser cortado após cessar a pulsação (cerca de um minuto após o nascimento). O bebê deve ser colocado para mamar logo após o nascimento e permanecer com a mãe durante toda a internação. Por quem você deseja que seja feito o corte do cordão umbilical?	Amamentação: A OMS recomenda amamentar na primeira hora de vida para fortalecer o vínculo e reduzir riscos. Você deseja amamentar imediatamente? () Sim () Não Para evitar o risco de doença hemorrágica, após o parto, será administrado 1mg de vitamina K intramuscular. O primeiro banho é dado após 24 horas, respeitando a temperatura e a proteção da pele. Realizar higiene do coto umbilical. Quem você deseja que dê o primeiro banho do bebê? Caso a mãe esteja bem, pode tomar banho e se alimentar normalmente, enquanto os profissionais monitoram o sangramento pós-parto e auxiliam na amamentação. Caso tenha outros desejos e expectativas em relação a vivência do parto, registre aqui e converse com a equipe da maternidade a respeito deles: Durante a internação, mãe e bebê devem permanecer no Alojamento Conjunto. Caso haja alguma condição de saúde que impeça isso, a equipe informará e esclarecerá as dúvidas.

Fonte: Adaptado MG, 2015.

6.8 - PRÉ-NATAL DO PARCEIRO OU PARES DO MESMO GÊNERO

Quadro 51 – Pré-Natal do Parceiro ou Pares do Mesmo Gênero

PRÉ-NATAL DO PARCEIRO OU PARES DO MESMO GÊNERO	
Etapas	Ações
Acolhimento	- Solicitar a presença da parceria para participar das consultas de pré-natal. Viabilizar o acesso da melhor forma possível; - Sensibilizar e orientar de como pode ser a participação da parceria no pré-natal, parto e puerpério; - Resgatar a história do nascimento dos pares e expectativas sobre a gestação, paternidade e períodos de pré-natal, parto e puerpério; - Estar atenta a grau de entendimento e dificuldades desse momento e dessa participação; - Planejar e acordar entre os pares a participação na assistência pré-natal, orientando rotinas e fluxos e flexibilizando agendamentos, quando necessário; - Elaborar uma linha de cuidado para o pré-natal que inclua a participação da parceira; - Aconselhamento sobre planejamento reprodutivo de acordo com as expectativas dessa e de uma nova gestação; - Realizar atendimento a parceria no pré-natal, a fim de promover e trabalhar aspectos da saúde dos pares; - Discutir com a gestante possíveis ausências da parceria, a fim de resgate da figura na consulta.
Exame Físico Imunização Solicitação De Exames	- Agendar consulta para a parceria, a fim de ser um espaço de escuta de suas queixas de saúde, levantar história de cuidado e identificar possíveis comorbidades ou situações de vulnerabilidade; - Realizar exame físico, aferição de sinais vitais e antropometria; - Orientar sobre calendário vacinal e oferecer a imunização oportuna no momento; - Realizar ou encaminhar exames conforme necessidade; - Avaliar cada queixa, segundo condutas centradas na pessoa e baseadas em evidências, de acordo com os protocolos de enfermagem; - Realizar aconselhamento pré e pós-testes. Considerações: - Oferecer sempre TR Anti HIV, Sífilis, Anti HCV, HBSAg e /ou sorologias. Tipagem sanguínea, se necessário; - Se julgar necessário, com base no exame físico e na história de comorbidades e antecedentes, solicite exames ou rastreamentos conforme os protocolos de enfermagem vigentes. - Identificar queixas álgicas, nutricionais, sociais, emocionais, motoras etc. Encaminhar/Discutir com as equipes Multiprofissionais (e-Multi) ou outros órgãos necessários.
Envolvimento na Rotina Pré Natal, Parto e Puerpério	- Orientar continuamente sobre intercorrências, decisões compartilhadas, rotina do pré-natal, acompanhamentos e encaminhamentos necessários. - Resgatar e vincular periodicamente a participação da parceria nas consultas, assegurando a saúde e participação de todos; - Avaliar periodicamente como o envolvimento e a participação da parceria, pode assegurar a manutenção da saúde e participação de todos (as); - Orientar sobre período de parto e pós-parto, bem como primeiros cuidados e rotinas com o RN e puérpera; - Estimular visitas à maternidade, atividades educativas, grupos, atividade física (quando possível, sempre que não ofereça risco); - Orientar sobre a construção do plano de parto e estimular a construção conjunta desse; - Estimular momentos de lazer e afeto, como passeios, escrever diários e cartas para o bebê, pintura corporal etc., a fim de promover a saúde mental, vínculo e afeto de todos (as) envolvidos (as); - Discutir sobre a participação do pai ou pares na hora do parto, seguindo a lei do acompanhante – REFORÇAR E QUE A ESCOLHA É DA GESTANTE.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

7 - ATENÇÃO À MULHER NO PUERPÉRIO – CONSULTA PÓS-NATAL

Quadro 52 – Cuidados de Enfermagem No Período Puerperal

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PUERPERAL	
Período	Cuidados de Enfermagem / Conduta
Puerpério Imediato (1º a 10º dia de pós-parto)	- Esta consulta vem agendada desde a maternidade pelo Capital Criança e tem prioridade; - Verificar Cartão de pré-natal e Carteira de Vacinação do RN. Checar todas as informações técnicas descritas sobre o parto e realizar escuta do relato do parto; - Atentar para situação vacinal da puérpera, exames, medicamentos, sinais vitais, sinais flogísticos, lóquios, comorbidades, queixas, e intercorrências do período; - Realizar teste rápido de HIV, sífilis e hepatites; - Realizar exame físico detalhado que segue: - Avaliar mucosas, hidratação, condições da pele; - Verificar sinais vitais e antropometria (atentar principalmente para temperatura, pressão arterial e perda de peso); - Auscultar cardíaca e pulmonar; - Avaliação das mamas (avaliando pega, sinais de fissuras, ingurgitamento); - Palpação do abdômen – avaliar involução uterina, cicatriz de ferida operatória em caso de cesárea; - Avaliar o períneo e vulva (atentar para lacerações, pontos cirúrgicos, lóquios), avaliar região anal. - Avaliar membros inferiores, (atentar para presença de edema e varicosas). - Orientar sobre amamentação, se possível observar mamada e pega, avaliando as condições das mamas; - Atentar para os aspectos sociais e emocionais, rede de apoio ou familiar; - Estimular a manter uma boa postura, adequar lugar que amamenta e postura no leito evitando dor musculoesquelética, estimular a deambulação precoce; - Estimular a realização de exercícios metabólicos a fim de evitar a estase venosa e edema, exercícios respiratórios para aumentar a expansão torácica e exercícios de alongamento focando membros inferiores e superiores a fim de favorecer a motilidade gastrointestinal; - Prescrever paracetamol 500-1000mg de 6/6 horas ou ibuprofeno 300mg de 8/8 horas se necessário, por até 5 dias, se lesões doloridas no períneo sem infecção; - Evitar contração perineal e abdominal até cicatrização da sutura, após retirar os pontos orientar automassagem para evitar alterações na cicatriz, em caso de cesárea; - Encaminhar para sala de vacina, caso não tenha vacina VTV comprovada; - Avaliar e orientar padrão nutricional e verificar encaminhamentos caso necessário; - Registrar adequadamente em prontuário; - Agendar retorno.
Puerpério Tardio (11º a 45º dia)	- Atentar para alterações físicas, sinais vitais, condições de sono, e sinais flogísticos no período; - Atentar para aspectos emocionais, sociais e rede de apoio familiar; - Avaliar e estimular o aleitamento materno exclusivo; Demais itens na próxima página.

Continua.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PUERPERAL	
Período	Cuidados de Enfermagem / Conduta
Puerpério Tardio (11º a 45º dia)	• Demais itens na página anterior. • Avaliar condições nutricionais da puérpera tendo em vista matriciamento ou encaminhamento para a nutricionista caso necessário; • Realizar exame físico (boa parte do exame pode ser seguido conforme <u>Quadro 39</u>); • Oferecer métodos de contracepção e trabalhar com a paciente o retorno da atividade sexual segundo suas percepções e escolhas.
Puerpério Remoto (45º dia em diante)	• Avaliar método de contracepção escolhido; • Orientar e agendar Coleta de preventivo caso necessário; • Avaliar Aleitamento Materno e condições da mama; • Avaliar padrão nutricional e perda ou ganho de peso; • Avaliar questões sociais e emocionais, rede apoio, círculo social e familiar, vínculos afetivos, relação mãe e bebê; • Identificar vulnerabilidades e riscos; • Orientar seguimento com alto risco ou avaliação médica em caso de pacientes que tiveram intercorrências na gestação e parto.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

No ANEXO II – ALTERAÇÕES EMOCIONAIS MAIS COMUNS EM PUÉRPERAS deste protocolo, encontra-se um quadro com as alterações emocionais mais comuns em mulheres puérperas.

7.1 - ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NO PUERPÉRIO

As disfunções sexuais afetam a qualidade de vida das mulheres, especialmente no ciclo gravídico-puerperal, período em que mais de 70% destas relatam algum tipo de queixa relacionada à sexualidade. No primeiro semestre pós-parto, é comum a prevalência de dispareunia e a redução do desejo sexual, reflexo de alterações hormonais, emocionais, físicas e das novas demandas da maternidade. Essas condições evidenciam a importância de uma abordagem integral à saúde sexual da mulher nesse período.

Diferentes fatores podem contribuir para a ocorrência de disfunções sexuais no puerpério, entre eles o cansaço excessivo, a presença de dor associada a traumas perineais, como lacerações ou episiotomia, e o sangramento vaginal nas semanas subsequentes ao parto. Alterações hormonais também desempenham papel central, especialmente em mulheres que amamentam exclusivamente ou fazem uso de anticoncepcionais à base apenas de progestágeno, o que pode levar à atrofia vaginal e redução da lubrificação. A queda nos níveis de estrogênio e progesterona, somada ao aumento da prolactina, contribui para a diminuição da libido, interferindo diretamente na saúde sexual e no bem-estar da puérpera.

O retorno à atividade sexual no pós-parto, normalmente, é influenciado pela liberação de um profissional de saúde. De maneira geral, recomenda-se que esse retorno ocorra idealmente após quatro semanas do parto, desde que respeitados o conforto, o desejo e as condições clínicas da puérpera.

Quadro 53 – Abordagem da Sexualidade no Puerpério ^{53, 54, 55, 56, 57, 58, 59}

ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NO PUERPÉRIO	
Exame Físico	• Avaliar vulva e períneo (Ver Quadro 52 e quadro 39). • Observar pontos de: ○ Cesárea, episiotomia e laceração
Diagnósticos de Enfermagem	• Desempenho sexual eficaz; Desempenho sexual prejudicado; Autoimagem positiva; Autoimagem negativa; Prazer eficaz; Prazer prejudicado.
Planejamento de Enfermagem	• Informar sobre fatores que afetam a sexualidade no puerpério e possíveis dificuldades (dor, lubrificação reduzida). • Conversar sobre retorno às relações sexuais (em cerca de 4 semanas após o parto, respeitando o conforto e desejo da mulher); • Prescrever lubrificante à base de água e sugerir masturbação e brinquedos eróticos. • Estimular a participação da parceria nas consultas. • Trabalhar autoestima (peso, imagem corporal, vulva/vagina) com o auxílio de espelho. • Abordar baby blues e depressão pós-parto. • Auxiliar escolha de método contraceptivo (3.2 – MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 1,12,13,49,50,51). • Avaliar necessidade de matriciamento ou outros profissionais. • Investigar sinais de violência, rotina e rede de apoio.
Evolução de enfermagem	• Questionar sobre sexualidade em consultas de seguimento.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

7.2 - TRATAMENTO DA ANEMIA NO PUERPÉRIO

Quadro 54 – Tratamento da Anemia no Puerpério

TRATAMENTO DA ANEMIA NO PUERPÉRIO	
Condição	Conduta
Se uso de sulfato ferroso	Manter sulfato ferroso 40mg/60mg (1 comprimido) ao dia por 3 meses.
Se Hb 7-11 g/dL	- Prescrever sulfato ferroso 120mg (3 comprimidos de 40 mg) ao dia e repetir hemograma em 1 mês; Se Hb subindo: Continuar tratamento e repetir hemograma a cada 1-2 meses até Hb > 11g/dL, então reduzir sulfato ferroso para 40mg/60mg (1 comprimido) ao dia até 3º mês pós-parto; Se Hb estagnada ou caindo: aumentar sulfato ferroso para 240mg (6 comprimidos de 40 mg) ao dia e repetir hemograma em 1 mês Se Hb Subindo: continuar tratamento e repetir hemograma a cada 1-2 meses até Hb > 11g/dL, então reduzir sulfato ferroso para 40mg/60mg (1 comprimido) ao dia até o 3º mês pós-parto; Se Hb estagnada ou caindo: Encaminhar para avaliação médica.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024.

7.3 - ABORDAGEM AO ALEITAMENTO MATERNO ^{1,11,12}

O **aleitamento materno** é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, salvo em algumas situações excepcionais. São benefícios do aleitamento materno para o bebê:

- Redução da mortalidade infantil por causas evitáveis;
- Fornece nutrição adequada e ajuda a desenvolver a imunidade infantil, o que contribui para a prevenção de doenças na infância e a promoção da saúde física e emocional do bebê/criança;
- Favorece o desenvolvimento da fala;
- Diminui o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 1, leucemia e obesidade na vida adulta.

São benefícios do aleitamento materno para a mãe:

- Prevenção de doenças como os cânceres de mama, ovário e útero, além do diabetes tipo 2.

A **amamentação** favorece a relação afetiva mãe-filho e o desenvolvimento da criança, do ponto de vista cognitivo e psicomotor. Apresenta, também, a propriedade de promover o espaçamento das gestações e de diminuir a incidência de algumas doenças na mulher. Dentre os 12 passos para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de 2 anos, recomendados pelo Ministério da Saúde, consta: **“amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses”**.

7.3.1 - Técnica de Amamentação

Os primeiros dias após o parto são cruciais para o sucesso da amamentação. É neste período que mais ocorrem as intercorrências relacionadas ao processo de amamentação, que se não forem detectadas e tratadas podem interromper precocemente o processo da amamentação.

Quadro 55 – Principais Itens a Serem Observados na Mamada

Principais Itens a Serem Observados na Mamada	
Posição Correta	Pega Correta
• A mãe deve estar em posição confortável. Pode estar sentada, deitada ou em qualquer outra posição agradável, familiar e adequada ao momento (Figura 1); • Bebê de frente para o corpo da mãe, com a cabeça e o corpo alinhados (pescoço não pode estar torcido e a orelha deve ficar alinhada ao ombro do bebê); • Posição tradicional: mãe sentada, bebê bem junto à mãe, com o corpo do bebê virado para o corpo da mãe e bem apoiado pelo braço do mesmo lado da mama que está sendo oferecida (Figura 1); • Posição jogador de futebol americano: mãe sentada, com o bebê posicionado na sua lateral (Figura 1); • Posição tradicional invertida: mãe sentada, apoiando o bebê com o braço oposto ao da mama que está sendo oferecida (Figura 1); • Posição deitada: mãe deitada junto ao bebê (Fig. 1);	• Não há obstáculos entre a boca do bebê e a parte da mama que o bebê precisa abocanhar, como panos, mão da mãe, braço do bebê; • A boca do bebê deve ficar bem aberta (se necessário, estimular o bebê a abrir a boca tocando o seu queixo ou seus lábios com o dedo ou mamilo); • O bebê abocanha parte da aréola (2 a 3 cm); • O queixo do bebê toca a mama da mãe; • Vê-se pouca aréola por baixo da boca do bebê; • Os lábios do bebê devem estar voltados para fora, como uma “boca de peixe” (Figura 2); • Se necessário, puxar o queixo do bebê para baixo, com o dedo indicador, fazendo com que a boca abra mais e o lábio inferior esteja virado para fora;

Continua.

Principais Itens a Serem Observados na Mamada

Posição Correta	Pega Correta
• Posição de cavaleiro: mãe sentada, com o bebê apoiado ao seu corpo verticalmente (Figura 1); • A face do bebê deve voltar-se para o seio, o nariz ou o lábio superior em frente ao mamilo; • O bebê deve ser levado ao seio, não o contrário.	• A mãe não deve sentir dor ou ardência nos mamilos durante as mamadas. • Pode-se apoiar a mama com a mão em forma de “C” para que os dedos não atrapalhem a pega do bebê (Figura 3).

Sucção Adequada

- O bebê suga, faz uma pausa e suga novamente (no início da mamada o bebê pode sugar de forma mais rápida e contínua, mas após o reflexo de ejeção do leite, passa a fazer sucções lentas e profundas);
- As bochechas do bebê ficam cheias durante a sucção;
- É possível ver e/ou ouvir o bebê deglutir;
- Afundamento da bochecha e/ou sons de estalidos durante a sucção indicam que a amamentação não está acontecendo de forma adequada;
- A mãe percebe sinais do reflexo de ocitocina.

Posições para amamentar



Posição tradicional



Posição jogador de futebol americano



Posição deitada

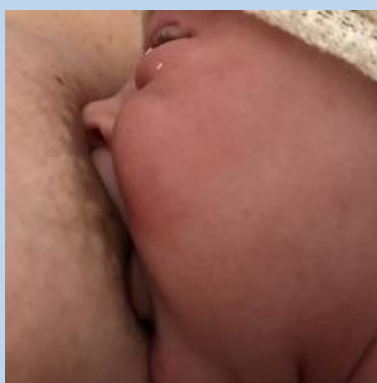
Posição tradicional invertida



Posição de cavaleiro

Fonte: Adaptador de Brasil, 2019.

Pega Correta



Fonte: Brasil, 2019.

Fonte: Brasil, 2015; Brasil, 2019.

Posição em “C” das mãos



Fonte: Brasil, 2019.

O Ministério da Saúde sugere a utilização do Formulário de Avaliação da Mamada, preconizado pela Organização Mundial da Saúde e UNICEF (ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MAMADA), por equipes da APS na consulta de primeira semana de vida e nas demais consultas de puericultura. Com base na avaliação da mamada, o enfermeiro terá subsídios para realizar o manejo e suporte necessário objetivando o acolhimento da pessoa que amamenta e o sucesso na amamentação. É importante observar a mamada por completo (a posição da pessoa que amamenta e do bebê, a pega, a sucção e o final da mamada) e de preferência nas duas mamas, assim como registrar os dados em prontuário para acompanhamento por toda equipe da APS e nos demais pontos da RAS municipal.

7.3.2 - Prevenção e Manejo dos Principais Problemas Relacionados à Amamentação

Quadro 56 – Prevenção e Manejo dos Principais Problemas Relacionados à Amamentação

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
O bebê não suga ou tem sucção fraca	- Os bebês podem apresentar dificuldades para mamar nos primeiros dias de vida. Algumas vezes a recusa pode estar associada ao uso de bicos artificiais, chupetas, mamadeiras ou à dor ao ser posicionado (posicionamento incorreto, fratura em clavícula, torcicolo congênito) para mamar; - O bebê pode não conseguir abrir a boca o suficiente para abocanhar a aréola e fazer uma boa pega, as mamas podem estar ingurgitadas e dificultar a pega ou ainda a mãe pode ter mamilos planos ou invertidos. - Bebês com o frênulo lingual curto (língua presa), dependendo do grau, podem ter dificuldade na pega e sucção (essa condição específica será abordada individualmente entre os tópicos abaixo).	- A mãe deve sempre insistir nas mamadas por alguns minutos; - Se as mamas estiverem muito cheias, com a pele esticada, deve-se esvaziá-las um pouco antes de amamentar, para amaciar a aréola e facilitar a pega; - Sucção deficiente do bebê pode ser secundária ao uso de bicos de mamadeiras, silicone e chupetas, e se for o caso, devem ser suspensos; - Melhorar a pega e variar a posição do bebê no momento de amamentar; - Enquanto a criança estiver com dificuldade para sugar: fazer a retirada do leite do peito, de 6 a 8 vezes ao longo do dia, e oferecer ao bebê o leite retirado no copo ou colher. Deve-se retirar apenas a quantidade e na frequência suficiente para a alimentação do bebê, mimetizando a amamentação fisiológica.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
O leite demora a descer	Em algumas mulheres o leite pode demorar de três a quatro dias para descer (apojadura).	- Deve-se tranquilizar a mulher. - Fomentar a rede de apoio/suporte familiar. - Estimular a mama com sucção frequente do bebê. - Enquanto o leite não desce, o bebê pode ser alimentado por meio da relactação, que consiste em colocar o leite, de preferência humano (pasteurizado), em um recipiente (copo). O recipiente deve ser colocado abaixo das mamas, a ponta da sonda (sonda nasogástrica nº 4 ou 6) deve ser colocada dentro do copo de leite e a outra junto ao mamilo. O bebê se alimenta enquanto suga o leite do recipiente (copo) e ao mesmo tempo estimula a lactação ao fazer o estímulo de sucção na mama.
Pouco leite ou leite fraco * - Observações pág. 157	- Muitas vezes, essa percepção de pouco leite ou leite fraco é reflexo da insegurança materna, quanto a sua capacidade de nutrir plenamente o seu bebê. A mãe, algumas vezes, interpreta o choro do bebê e as mamadas frequentes (comportamentos normais do bebê) como sinais de fome. - Sinais de que a quantidade de leite produzida pela mulher é oferecida ao bebê é suficiente: bebê ativo e respondendo aos estímulos; bebê urina várias vezes ao dia (no mínimo 6 vezes) e está crescendo, ganhando peso e se desenvolvendo adequadamente; - No entanto, algumas vezes, a percepção da mãe de que tem pouco leite é correta. Ela sente a mama murcha (flácida). A constatação pode ser feita pelo acompanhamento do peso do bebê, se ele estiver com ganho de peso inadequado, a preocupação da mãe será pertinente.	- Avaliar os fatores maternos (desejo de amamentar, estresse, falta de apoio e outros); - Acolher a mãe e aceitar a sua queixa (sem necessariamente concordar); - Avaliar se as mamas estão cheias ou flácidas; - Verificar se a pega e o posicionamento do bebê estão corretos, e se necessário, adequar a pega e o posicionamento; - Aumentar a frequência das mamadas, inclusive à noite. - Massagear suavemente as mamas durante as mamadas. * - Oferecer as duas mamas em cada mamada e dar tempo para o bebê mamar bastante em um dos peitos antes de trocar para o outro; - Se a criança estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente, estimulá-la: fazer carinho nos pés, conversar com o bebê, tirar um pouco de roupa do bebê; - Após a mamada, realizar a extração do leite residual (se a translactação estiver indicada, este leite pode ser armazenado, para utilizar na translactação); - Acompanhar o ganho de peso e o desenvolvimento da criança; - A mãe deve consumir dieta saudável, ingerir água em quantidade suficiente e repousar sempre que possível. - Em situações em que é constatada a hipolactação com repercussões na saúde e desenvolvimento do bebê, além dos cuidados citados anteriormente, deve-se realizar consulta compartilhada com o médico da equipe ou encaminhar para consulta médica para avaliação. Nesses casos, avaliar a indicação de translactação e/ou relactação até que a produção do leite materno seja compatível com as necessidades do bebê. Se indicada a translactação e/ou relactação, o/a enfermeiro/a deve demonstrar/ensinar o procedimento para a mãe.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
Mamilos planos ou invertidos ** - Observações pág. 157	Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o início da amamentação, mas não a impede, pois o bebê abocanha a aréola e o mamilo.	- Não realizar exercícios para os mamilos e não utilizar buchas ou seringas para esticá-los, pois não são efetivos e podem machucar; - Não é recomendado utilizar bicos de silicone; - Encorajar a mãe, pois à medida que o bebê vai sugando, os mamilos vão se tornando mais propícios à amamentação; - Ajudar a mãe a fazer o bebê abocanhar os mamilos e parte da aréola, para isso é necessário que a aréola esteja macia. Assim, se a mama estiver muito cheia, antes de iniciar a amamentação pode ser útil retirar um pouco de leite para a aréola ficar mais macia; - Tentar posições diferentes e observar em qual delas a mãe e o bebê se adaptam melhor; - Enquanto o bebê não sugar efetivamente, o leite deve ser ordenhado** e oferecido ao bebê com copo (copinho com bordas arredondadas e finas) ou siringa.
Possível complicação do bloqueio dos ductos lactíferos * / *** - Observações pág. 157	- O leite passa por canais dentro da mama chamados de ductos lactíferos. Durante a amamentação pode ocorrer situação em que o leite materno não consegue fluir livremente através dos ductos da mama. - Pode ocorrer quando a mama não está sendo esvaziada adequadamente, seja porque as mamadas são muito espaçadas ou porque o bebê não está conseguindo retirar o leite da mama de maneira eficiente. - Pode ser causado também quando existe pressão local em uma área (uso de sutiã apertado; uso de cremes nos mamilos, obstruindo a saída do leite). - Comumente a mulher com bloqueio de ductos lactíferos apresenta: nódulos localizados, sensíveis e dolorosos, acompanhados de dor, vermelhidão e calor na área afetada.	- Proporcionar a amamentação em livre demanda com a técnica correta (pega e posições corretas); - Praticar a amamentação responsiva: a mãe responde aos sinais do bebê, bem como ao seu próprio desejo de amamentar, reconhecendo a relação recíproca entre mãe e bebê e os benefícios da amamentação que vão além do alívio da fome; - Utilizar distintas posições para amamentar, oferecendo primeiramente a mama afetada, com o queixo do bebê direcionado para a área afetada, o que facilita a retirada do leite do local. - Uso de sutiã adequado que não bloqueie a drenagem do leite; e, evitar roupas apertadas; - Não utilizar cremes nos mamilos; - Massagem suave na área afetada*; - Se necessário, prescreva analgésicos/anti-inflamatórios***: paracetamol 500-1000 mg 6/6 horas ou Ibuprofeno 300-600 mg 8/8 horas por até 5 dias. Não prescrever se febre (maior ou igual a 38°C) ou sintomas sistêmicos, nesse caso, encaminhar para avaliação médica. - Orientar sobre os sinais de mastite (possível complicação do ingurgitamento mamário) para retorno imediato para reavaliação e manejo. - Se um ponto de obstrução no mamilo, que representa as células inflamatórias ductais propagando-se à superfície e se alojando no local, estiver presente, não perfure o ponto, pois essa ação irá causar trauma e piorar o quadro. - Reavaliar em 24-48 horas.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
Ingurgitamento Mamário * / ** / *** - Observações pág. 157	- O ingurgitamento mamário envolve três componentes básicos, o aumento da vascularização da mama/congestionamento, retenção de leite nos alvéolos e edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático. - Geralmente, o ingurgitamento das mamas ocorre de três a cinco dias após o parto, mas pode acontecer em qualquer período da lactação. - Nos primeiros dias pós-parto a produção de leite e o corpo estão se ajustando à demanda do bebê. Ficar com a “mama cheia” antes de o bebê mamar é normal e não requer nenhum tratamento. - O ingurgitamento mamário patológico geralmente ocorre devido à remoção inadequada do leite, seja por separação entre mãe e bebê, práticas de amamentação restritivas e/ou sucção ineficaz ou, menos frequentemente, por superprodução de leite.	- Ingurgitamento mamário patológico: mama excessivamente distendida, mamilos achatados, o leite não flui com facilidade, pode apresentar nódulos doloridos, áreas com pele avermelhada, edemaciadas e brilhantes, e por vezes, acompanhada de febre e mal-estar. - Mamada por livre demanda do bebê (sempre que o bebê quiser, sem horários rígidos e sem pressa); - Praticar a amamentação responsiva: a mãe responde aos sinais do bebê, bem como ao seu próprio desejo de amamentar, reconhecendo a relação recíproca entre mãe e bebê e os benefícios da amamentação que vão além do alívio da fome; - Massagem suave* e circulares nas mamas e retirar um pouco de leite para facilitar a pega, de preferência manualmente. ** - Massagem suave durante a mamada. * - Posicionamento e pega corretos do bebê ao seio durante a amamentação - Uso do sutiã com alças largas e firmes, para sustentação anatômica das mamas; - A lactante pode realizar ordenha/extração manual ou com bomba de extração** de pequenos volumes de leite para conforto até que sua produção reduza para se adequar às necessidades do bebê; - Caso a amamentação direta não seja possível, a lactante deve fazer a ordenha manualmente, preferencialmente, ou com bomba de extração* para alívio, mas somente o volume que o seu bebê consome, evitando o ciclo de hiperlactação; - Considere e avalie o uso de compressas com base nas preferências da mulher: - Frio local (compressas frias) após a amamentação, para reduzir edema e inflamação e fornecer alívio sintomático; - Calor local (compressas mornas ou banho morno) antes da amamentação para facilitar a liberação de ocitocina, e ativar o reflexo de ejeção do leite. - Se necessário, prescreva analgésicos/anti-inflamatórios***: paracetamol 500-1000 mg ou Ibuprofeno 300-600 mg a cada 6 horas por até 5 dias. - Se febre maior ou igual a 38,0°C ou dor intensa, realizar consulta compartilhada com MFC devido diagnóstico diferencial de mastite infecciosa. - Reavaliar em 24-48 horas.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
Lesões ou Dor nos mamilos *** - Observações pág. 157	Trauma mamilar (fissuras, edema, bolhas, hematomas, equimoses) é a causa mais comum de dor na amamentação, geralmente, devido a pega e posicionamento inadequados. Outras causas também contribuem, como mamilos planos, curtos, invertidos, disfunções orais na criança (freio de língua excessivamente curto), uso inadequado de bomba de extração de leite, retirada do bebê do peito de forma inadequada, uso de óleos/cremes e produtos que podem causar reação alérgica e ressecamentos nos mamilos, uso de protetores de mamilos e forros úmidos por período prolongado.	- Evitar o uso de óleos, cremes, sabonetes, álcool ou qualquer produto secante, nos mamilos; - Observar a mamada e corrigir a pega e a posição, se necessário; - Se a mama estiver tensa, dificultando a pega, retirar um pouco de leite antes das mamadas; - Amamentar em livre demanda (a criança é levada ao seio assim que sinaliza fome, isso evita a sucção com muita força); - Desencadear o reflexo de ejeção do leite (ordenhar um pouco de leite), evita que o bebê realize a sucção com muita força para desencadear o reflexo; - Variar a posição das mamadas, reduzindo a pressão nos pontos dolorosos; - Início da mamada pela mama menos afetada; - Observar presença de anquiloglossia; - Introduzir o dedo mínimo na comissura labial do bebê para interromper a vedação da boca do bebê/mama, se for necessário interromper a mamada; - Quando os mamilos estiverem machucados: enxaguá-los com água limpa pelo menos uma vez ao dia a fim de evitar infecções; - Não existe comprovação científica de que passar leite materno ajude nos casos de lesões. - Se dor, pode-se prescrever analgésico***: paracetamol 500-1000 de 6/6 horas mg por até 5 dias. - Se a dor for intolerável para a lactante, pode-se suspender temporariamente a oferta de uma das mamas e retirar o leite do peito manualmente para prevenir outros problemas como o ingurgitamento mamário. Nesse caso, pode-se oferecer o leite extraído ao bebê em um copo, colher ou seringa.
Mastite * - Observações pág. 157	É um processo inflamatório que acomete um ou mais segmentos das mamas, geralmente, unilateral, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. A estase do leite é o evento inicial da mastite e ocorre com mais frequência na segunda ou terceira semana após o parto, mas pode surgir em qualquer período da amamentação. Ductos bloqueados, ingurgitamento ou danos nos mamilos ou no tecido mamário favorecem a mastite não infecciosa. • <u>Ver próxima página.</u>	Mastite não infecciosa – Dor, edema, hiperemia e calor local. - Mesmo manejo do ingurgitamento mamário patológico (exceto aplicação de calor local); - Estimular o repouso, hidratação adequada e o apoio emocional dos familiares; - Reavaliar em 24-48 horas após a implementação dos cuidados de enfermagem. Se os sintomas não melhorarem após esse período, ou ainda ocorrer a piora dos sintomas, realizar consulta compartilhada com médico para avaliação interdisciplinar e necessidade de medida farmacológica adicional. - Orientar os sinais e sintomas de agravamento do quadro que necessitam de retorno imediato para reavaliação e manejo (febre maior ou igual 38,0°C, piora do quadro de dor, abscesso mamário, calafrios e mal-estar geral); • <u>Ver próxima página.</u>

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
Mastite * - Observações pág. 157	- A mastite infecciosa pode ocorrer devido a mamilos rachados ou traumatizados e está comumente relacionada ao <i>Staphylococcus aureus</i>, e por vezes ao <i>Escherichia coli</i> e ao <i>Streptococcus agalactiae</i>. - A condição é dolorosa e pode comprometer o estado geral. - A mastite bacteriana não oferece riscos ao bebê, não sendo necessária a interrupção da amamentação.	- Oriente sobre a prevenção de mastite: estratégias de remoção eficaz do leite, garantindo um bom posicionamento e pega do bebê, massagem suave* na mama durante a amamentação e ingestão adequada de líquidos. Mastite infecciosa – Dor intensa, hiperemia, edema, calor local, febre (maior ou igual a 38,0°C), calafrios e mal-estar. - Mesmo manejo do ingurgitamento mamário patológico (exceto aplicação de calor local). - Encaminhe para atendimento médico para avaliação de antibioticoterapia; - Reavaliar em 48 horas; - Oriente sobre a prevenção de mastite: estratégias de remoção eficaz do leite, garantindo um bom posicionamento e pega do bebê, massagem suave* na mama durante a amamentação e ingestão adequada de líquidos; - Caso a mastite evolua para um abscesso mamário, leia atentamente o item/linha abaixo.
Abscesso mamário	- O abscesso na mama, em geral, é causado por mastite não tratada, tratamento iniciado tardiamente ou ineficaz. É comum após a interrupção da amamentação na mama afetada pela mastite, sem a ordenha do leite. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico: febre mal-estar, calafrios e presença de área de flutuação no local afetado. - No diagnóstico diferencial do abscesso, deve-se considerar galactocele, fibroadenoma e carcinoma da mama.	- Verificar a presença de nódulo duro que não regride, febre, às vezes, muito alta e de instalação súbita, sensação de mal-estar geral; - Consulta médica, no mesmo dia.
Candidíase (infecção da mama por cândida sp)	- A infecção da mama no puerpério por cândida sp é comum. A infecção pode atingir somente a pele do mamilo ou da aréola ou comprometer os ductos lactíferos. Pode ser causada pela umidade e lesão dos mamilos, uso de antibióticos, pela mulher, contraceptivos orais e esteroides. Muitas vezes, é a criança quem transmite o fungo, mesmo quando não está aparente. - Na infecção por cândida sp, a mulher costuma se queixar com coceira, sensação de queimadura e dor tipo agulhadas nos mamilos. Os mamilos e aréolas podem apresentar a pele avermelhada, brilhante ou irritada com descamação. Raramente se observa placas esbranquiçadas. - A criança pode apresentar crostas orais esbranquiçadas, que devem ser distinguidas das crostas de leite (essas últimas são removidas sem machucar a língua ou gengivas).	- Após as mamadas enxaguar os mamilos, secá-los e mantê-los arejados; - Não utilizar protetores nos mamilos, se precisar, usar panos limpos e secos; - As chupetas e bicos não devem ser utilizados, mas se forem, devem ser fervidos uma vez ao dia por 20 minutos; - Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente; - Nistatina solução oral - passar na mucosa oral da criança 1 conta-gotas (1ml) ou 0,5ml em cada bochecha, 4 vezes ao dia por 14 dias. A mãe também deve usar nos mamilos e aréolas pelo mesmo período; - Observação: muitas espécies de cândida são resistentes a nistatina; - Se o tratamento tópico falhar, encaminhe para consulta médica.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Queixa/ Intercorrência	Por Que Ocorre	Manejo
Hiperlactação	A mulher produz mais leite do que o bebê consegue consumir, o que pode desencadear algumas dificuldades na amamentação (bebê irritado, engasgos e/ou regurgitos, ou com gases e cólicas).	- Retirar manualmente leite das mamas apenas se elas estiverem muito cheias, causando desconforto; - Amamentar apenas em uma mama em cada mamada e, se necessário, retirar um pouco do leite da mama não usada pelo bebê para o conforto. Esta prática pode ser realizada até que a produção do leite se ajuste a necessidade do bebê, com necessidade de acompanhamento do enfermeiro a fim de reduzir o risco de complicações (como por exemplo, dor mamária, obstrução de ductos e mastite) e o desmame precoce; - Não utilizar conchas devido o risco de infecções; - Em relação a posição da amamentação: colocar o bebê para mamar em uma posição de cavaleiro, pois isso ajuda o bebê a ter mais controle sobre a mamada; ou, a mulher pode ficar em uma posição mais deitada, ou de lado, em vez da tradicional sentada, pois essas posições dificultam a ejeção do leite e, conseqüentemente, o fluxo diminui. - Não existe evidência científica que recomende enfaixamento compressivo de mamas na hiperlactação. Por tanto, não oriente essa prática à lactante. - Para casos persistentes de hiperlactação, que não respondem adequadamente aos cuidados acima mencionados, discutir tratamento com o médico da equipe; - Pensar na possibilidade de doar leite materno para um Banco de Leite Humano.
Anquiloglossia (freio lingual curto / língua presa)	É uma anomalia congênita que pode prejudicar a capacidade do bebê se alimentar ao seio e causar desconforto na mulher ao provocar trauma e dor nos mamilos. O bebê pode ter dificuldade de fazer e manter a pega. Ocorre quando o freio lingual (frênulo) que prende a face inferior da língua restringe os movimentos da língua.	- Se bebê tem dificuldade na pega, mesmo após os cuidados de enfermagem para o posicionamento e pega correta na amamentação, encaminhe para consulta odontológica para avaliação do frênulo lingual. - Se essa condição estiver dificultando a amamentação, está indicada a frenotomia. De acordo, com o Protocolo de Saúde Bucal o procedimento é realizado no Centro de Especialização Odontológica (CEO) e deve ser encaminhado pelo cirurgião-dentista dos Centros de Saúde.
Torcicolo Congênito	- Condição em que há uma contratura unilateral do músculo esternocleidomastoideo, sendo uma das características clínicas a cabeça do bebê ficar inclinada para um lado e o queixo aponta para o ombro oposto. - Uma das queixas clínicas nessa condição é a amamentação prejudicada, sendo relatado pelas nutrizes: recusa do bebê por uma das mamas, sucção fraca, irritabilidade e baixa tolerância do bebê a mudanças de posição.	Na suspeita de torcicolo congênito, realizar avaliação compartilhada com o médico da equipe ou agendar/encaminhar para consulta médica. Esta condição necessita de diagnóstico precoce para a realização do tratamento em tempo oportuno, evitando complicações.

Continua.

PREVENÇÃO E MANEJO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Observações

- *Não realize massagem profunda ou vigorosa nas mamas em nenhuma das queixas/intercorrências decorrentes da amamentação, pois esta prática pode causar aumento da inflamação e do edema tecidual.
- ** O uso de bombas extratoras deve ser minimizado, visto que: estimulam a produção de leite sem extrair leite fisiologicamente como um bebê faz; favorece a disbiose; podem causar trauma ao parênquima mamário e ao complexo aréolo-mamilar se tamanhos inadequados de funis, se a sucção é muito alta, ou se está ordenhando por um tempo excessivo.
- *** Os medicamentos indicados no protocolo são seguros na amamentação, porém usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível para minimizar a exposição do bebê aos medicamentos. Oriente a nutriz a observar no bebê sinais de reação adversa. Antes de prescrever, questione sobre uso anterior, reações adversas na pessoa que amamenta e no bebê. Não prescrever Ibuprofeno se existem contraindicações para o uso da medicação (úlceras pépticas, alergia ou exacerbação de asma com o uso, doença renal, insuficiência cardíaca ou em uso de varfarina). Em pessoas amamentando com diagnóstico de asma, dar preferência pelo uso do paracetamol. Importante: a prescrição de antiinflamatórios e analgésicos é uma **conduta complementar** às medidas não farmacológicas no tratamento do ingurgitamento mamário, ductos bloqueados e mastite.
- **Atenção:** A maior parte das intercorrências durante o aleitamento materno são manejadas com sucesso pelos profissionais da saúde na Atenção Primária à Saúde. Quando a equipe Saúde da Família não atingir sucesso no manejo ou apresentar dificuldade para o manejo, a usuária pode ser encaminhada para a Policlínica da Mulher e da Criança, com o contato prévio com a equipe deste serviço e realizando carta de encaminhamento e referência/contrareferência, a fim de continuar coordenando o cuidado do binômio mãe-filho.

Continua.

7.3.3 - Suspensão do Aleitamento Materno – Contraindicações Absolutas e Relativas

O aleitamento materno é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, salvo em algumas situações excepcionais. Assim, não se justifica, na maioria das vezes, a interrupção da amamentação impedindo desnecessariamente que mãe e criança usufruam dos benefícios do aleitamento materno. A indicação para a interrupção da amamentação deve ser criteriosamente indicada com segurança pelo profissional de saúde. Os critérios podem ser vistos no quadro a seguir.

Quadro 57 – Condições Clínicas Avaliadas na Manutenção ou Contraindicação de Aleitamento Materno

CONDIÇÕES CLÍNICAS AVALIADAS NA MANUTENÇÃO OU CONTRAINDICAÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO		
Condição Clínica Materna	Conduta do Enfermeiro	Justificativa
Infecção por HIV	Contraindicar o aleitamento e encaminhar a criança para o médico ou pediatra a fim de assegurar a nutrição adequada do bebê.	Risco de transmissão da mãe para o bebê.
Infecção pelo HTLV 1 e 2 (vírus linfotrópico humano de células T)	Contraindicar o aleitamento e encaminhar a criança para o médico ou pediatra a fim de assegurar a nutrição adequada do bebê.	Risco de transmissão da mãe para o bebê.
Infecção pelo vírus da hepatite B	Manter aleitamento materno.	A administração da imunoglobulina específica após o nascimento praticamente elimina o risco de transmissão via leite materno.
Infecção pelo vírus da hepatite C	Discutir com médico. Geralmente o aleitamento não é contraindicado, exceto se fissuras mamilares ou carga viral elevada.	Possibilidade de transmissão para o bebê
Tuberculose pulmonar	Manter o aleitamento. A mãe não tratada, ou que esteja tratando a menos de duas semanas, deve higienizar as mãos e proteger boca e nariz com uma máscara ou lenço em todas as mamadas.	As drogas empregadas no tratamento da tuberculose não causam prejuízo ao bebê.
Doença de chagas	Contraindicar na fase aguda ou na ocorrência de sangramento dos mamilos.	Risco de transmissão da mãe para o bebê.
Drogas consideradas lícitas, como: tabaco e álcool	Desencorajar o uso de cigarro e bebida alcoólica. Manter o aleitamento materno.	Nutriz tabagistas devem manter a amamentação, pois a suspensão da amamentação pode trazer riscos ainda maiores à saúde do lactente.
Varicela se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto	Manter aleitamento materno após as lesões assumirem a forma de crosta. Antes disso, discutir com médico a fim de assegurar a nutrição adequada ao bebê, uma vez que a mãe deverá estar isolada. A criança deve receber Imunoglobulina Humana Antivaricela Zoster (Ighavz), disponível nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIES) que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, aplicada o mais precocemente possível.	Risco de transmissão da mãe para o bebê.
Em tratamento farmacológico	Alguns fármacos são considerados contraindicados (absolutos ou relativos) ao aleitamento materno, como por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos. Se a mãe estiver em uso de algum medicamento destes ou outro que possa ter relação semelhante, encaminhar a mãe ao médico para avaliação e conduta. Acesse o site e-lactancia.org para ter acesso às informações quanto a compatibilidade dos medicamentos com a amamentação.	Possíveis efeitos colaterais e/ou tóxicos para o bebê.

Continua.

CONDIÇÕES CLÍNICAS AVALIADAS NA MANUTENÇÃO OU CONTRAINDICAÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO

Condição Clínica Materna	Conduta do Enfermeiro	Justificativa
Uso drogas ilícitas: anfetaminas, cocaína, crack, fenciclidina, heroína, inalantes, LSD, maconha e haxixe	Contraindicar o aleitamento e encaminhar a criança para o médico ou pediatra a fim de assegurar a nutrição adequada do bebê.	Possíveis efeitos tóxicos para o bebê.
Infecção Herpética com vesículas localizadas na pele da mama	Manter aleitamento materno na mama sadia.	Caso haja contato com a mama afetada, há o risco de transmissão da mãe para o bebê.

7.3.3.1 - Acompanhamento de Nutrizes Quanto à Infecção pelo HIV

Quadro 58 – Acompanhamento de Nutrizes Quanto à Infecção pelo HIV

Acompanhamento de Nutrizes Quanto à Infecção pelo HIV

1. Testagem Rápida para HIV em Nutriz

- A(o) enfermeira(o), deve garantir a realização da testagem rápida (TR) para HIV em todas as nutrizes, iniciando a partir de 30 dias após o parto, com repetição a cada 3 meses durante todo o período de amamentação, independentemente de testes não reagentes anteriores no pré-natal ou no parto.

2. Indicações adicionais para testagem:

- Imediatamente após exposição de risco**, como:
 - Relação sexual desprotegida;
 - Exposição a material biológico.
- Em situações de vulnerabilidade social** ou conforme **avaliação clínica individualizada**, considerar **testagens mais frequentes**.

3. Parcerias sexuais da Nutriz:

- Recomenda-se a **testagem rápida para HIV de todos os parceiros(as)** da lactante.

4. Abordagem integrada na APS:

- Durante atendimentos de puericultura, vacinação ou atendimento social, a equipe deve:
 - Questionar sobre a **realização de TR-HIV pela Nutriz**;
 - Orientar sobre os **riscos de transmissão vertical do HIV via amamentação**;
 - Incentivar a **realização da testagem regular**.

5. Implementação de Enfermagem

- Nos casos de a nutriz apresentar resultado do TR Reagente:
 - Suspender imediatamente o Aleitamento Materno;
 - Discutir e encaminhar com médico para atendimento imediato a nutriz e a criança;
 - Viabilizar notificação e investigação;
 - Inserir Criança no Programa de Fórmulas Infantis;

Fonte: Adaptado de MS, 2023; e RS, 2024.

7.3.4 - Retirada e Armazenamento do Leite Materno ²⁹

Em casos cuja amamentação não esteja contraindicada, mas que a mulher esteja impossibilitada de amamentar, é importante estimular a manutenção do aleitamento materno.

A correta ordenha pode ajudar a manter o aleitamento materno em casos de fissura mamária, onde a pausa da amamentação pode auxiliar a recuperação, dificuldade de pega, ingurgitamento mamário e outras situações.

Quadro 59 – Passo a Passo para Retirada, Armazenamento e Oferta do Leite Materno ao Bebê

PASSO A PASSO PARA RETIRADA, ARMAZENAMENTO E OFERTA DO LEITE MATERNO AO BEBÊ

1. Prepare o frasco para guardar o leite.

- Escolher um frasco de vidro de boca larga e com tampa plástica que possibilite fechamento perfeito, de fácil higienização e resistente ao processo de fervura. Lavar com água e sabão, esfregando e enxaguando bem;
- Ferver o vidro e a tampa, colocando-os em uma panela com água, por 15 minutos, a contar do início da fervura;
- Colocar o frasco e a tampa para secar naturalmente, de boca para baixo em um pano limpo ou papel toalha;
- Quando estiver seco, fechar o frasco com a tampa e guardar em um recipiente fechado;

2. Retire o leite materno das mamas

- Escolher um lugar limpo, tranquilo e longe de animais ou outras pessoas;
- Prender e cobrir os cabelos com touca ou lenço e cobrir a boca e o nariz com máscara, lenço ou fralda;
- Retirar adornos das mãos e braços (anéis, aliança, pulseiras e relógio);
- Lavar as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão e lavar as mamas apenas com água;
- Secar as mãos e as mamas com toalha limpa ou papel toalha;
- Evitar falar durante a retirada do leite;
- Abrir o recipiente e colocar a tampa com a parte estéril virada para cima sobre mesa de apoio;
- Massagear as mamas com as pontas dos dedos ou palma das mãos, de forma circular, começando pela aréola e subindo até a parte superior do seio;
- Posicionar o dedo polegar na borda superior da aréola e os demais dedos na borda inferior/base da mama (dedos em forma de C), pressionando e soltando o polegar e o indicador levemente para dentro em direção a parede torácica, repetidamente. Os primeiros jatos/gotas de leite devem ser desprezados antes de iniciar a coleta. A ação de pressionar e soltar, pressionar e soltar não deve machucar ou doer. Se doer, a técnica está errada;
- Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas, alternando a mama quando o fluxo de leite diminuir, repetindo a massagem e o ciclo várias vezes.

Continua.

PASSO A PASSO PARA RETIRADA, ARMAZENAMENTO E OFERTA DO LEITE MATERNO AO BEBÊ

3. Guarde o leite materno retirado

- Identificar o recipiente com rótulo contendo data e hora da coleta;
- O leite retirado e não ofertado após a coleta ao bebê, deverá ser imediatamente armazenado em congelador ou freezer. O tempo máximo de congelamento do leite cru é de 15 dias. Após esse período deverá ser descartado;
- Na próxima vez que for retirar o leite, pode-se usar outro recipiente de vidro (como copo, xícara, caneca) devidamente higienizado e fervido como feito com o frasco, e, ao terminar, acrescentar esse leite ao frasco que está no freezer ou congelador. O frasco deve ser completado até, no máximo, 2 dedos abaixo da tampa. Quando vários leites forem guardados no mesmo frasco, conta-se a validade a partir da data da primeira coleta;
- O prazo de validade do leite cru é de 12 horas se guardado na geladeira. O manuseio e oferta deste produto seguem as mesmas recomendações sobre o preparo do recipiente, retirada do leite, armazenamento e aquecimento.

4. Oferte o leite materno retirado ao bebê

- Antes de realizar o degelo do leite, lave as mãos com água e sabão;
- Colocar água para aquecer o recipiente em banho-maria (temperatura média de 40°C);
- Retirar do freezer os frascos que serão degelados e colocá-los no banho-maria para o degelo;
- Descongelar o leite em banho maria com fogo apagado até que se desmanche todo o gelo e ele fique completamente líquido.
- Esterilizar o utensílio para o oferecimento do leite assim como realizado com o frasco antes da retirada;
- Agitar levemente o recipiente para homogeneizar o leite;
- Abrir o frasco e colocar um pouco do leite que foi retirado do peito em copo ou xícara limpos;
- Ofertar o leite para o lactente no copo ou xícara: acomode a criança no colo, acordada e tranquila, posicionando-a o mais sentada possível, com a cabeça firme e o pescoço alinhado ao corpo, não devendo ficar torcido. Encoste a borda do copo ou xícara ou colher no lábio inferior da criança e deixe o leite materno tocar o lábio. Pode ser utilizada uma colher para a oferta, seguindo as mesmas orientações. A criança fará movimentos de lambida, engolindo o leite.
- Em caso de translactação, colocar o leite no dispositivo (copo ou seringa) a ser utilizado. A translactação pode ser realizada com uma sonda nasogástrica nº 4 ou 6, sendo que uma de suas pontas (com maior abertura) ficará dentro do copo, que estará abaixo das mamas, e a outra ponta junto ao mamilo, podendo ser fixado com micropore. Também pode ser feita com uma seringa de 10 ou 20 ml, sem o êmbolo, acoplada à sonda nasogástrica nº4, com a outra ponta da sonda junto ao mamilo, fixada junto ao peito da mãe, a altura do ombro, e o leite colocado na seringa. Em ambas as situações, o bebê abocanha a aréola e a sonda, realizando a sucção na aréola da mama, e com isto, o leite fluirá tanto do copo ou seringa através da sonda, como também da mama da mãe. A sonda deverá ser fechada, dobrando-a, quando o bebê fizer pausas. Ao retornar a sucção, libera-se a sonda.
- Desprezar o leite do copo/xícara/seringa que não for consumido.
- O leite descongelado que ficou no frasco deve ficar na prateleira de cima da geladeira por até 12 horas para posterior oferta ao bebê. Se não for oferecido em até 12 horas, deve ser descartado.

Continua.

PASSO A PASSO PARA RETIRADA, ARMAZENAMENTO E OFERTA DO LEITE MATERNO AO BEBÊ



Dedos em C



Retirada do Leite



Oferta do Leite ao Bebê

Fonte: Adaptado de Brasil, 2013; Brasil, 2021.

7.3.5 - Modificações sobre a Lactação Normal

7.3.5.1 - Drogas Galactogogas

Galactagogos são substâncias que auxiliam o início e a manutenção da produção adequada de leite. Os fármacos galactagogos atuam como antagonista dopaminérgico, reduzindo a ação inibitória da dopamina sobre a secreção de prolactina.

O uso de galactagogos deve ser reservado para situações em que foram descartadas as causas tratáveis de hipogalactia como o hipotireoidismo materno, por exemplo. O enfermeiro deverá questionar o uso dos seguintes medicamentos, e caso o identifiquem solicitar interconsulta com médico para avaliação de risco-benefício da manutenção ou retirada dos mesmo e discussão da forma de nutrição do bebê:

- Bromocriptina
- Bupropiona
- Cabergolina
- Ergometrina
- Ergotamina
- Estrogênios, como o etinilestradiol
- Levodopa
- Lisurida
- Modafinila
- Nicotina
- Pseudoefedrina
- Testosterona

Se mesmo após assegurar que a técnica de amamentação está correta, que já foram esgotadas as medidas que sabidamente aumentam a produção de leite (tais como maior frequência das mamadas e esvaziamento adequado das mamas) o enfermeiro deverá solicitar interconsulta com médico para discutir a possibilidade de uso de galactagogos nos seguintes casos:

- Induzir a lactação em mulheres que não estavam grávidas, como em mães adotivas ou que aguardam seus filhos nascerem de uma barriga de aluguel;
- Auxiliar na relactação;
- Aumentar do suprimento insuficiente de leite decorrente de separação mãe-filho por doença materna ou do lactente, como em mães de recém-nascidos pré-termo em unidades de terapia intensiva neonatais;
- Corrigir o baixo ganho ponderal do bebê afastando-se outras etiologias.

Dentre as substâncias que induzem, mantêm e aumentam a produção de leite, a metoclopramida é a única disponível na rede. No entanto, sua prescrição deverá ser exclusivamente médica.

Caso seja prescrita, o enfermeiro deverá acompanhar a mãe durante o período de uso em função do risco de depressão materna relacionado à metoclopramida e encaminhá-la ao médico caso observe algum sinal/sintoma depressivo. Atenção para a ocorrência de reação extrapiramidal, que exige atenção médica imediata.

7.3.5.2 - Inibição da lactação

No caso de contraindicação da amamentação conforme condição clínica (Quadro 57) enfermeiro deverá orientar medidas de supressão da lactação e garantir a nutrição adequada do bebê:

- Oferecer apoio às mulheres que não podem amamentar ou não desejam amamentar (respeitando a autonomia da mulher, após decisão informada), e encaminhar o bebê para o médico ou pediatra (referenciar para os serviços de assistência social nas situações em que a mulher e a família não têm condição de adquirir os insumos necessários);
- Manter as mamas comprimidas (enfaixar ou usar sutiã apertado); promovendo a inibição mecânica da lactação;
- Se já tiver ocorrido a apojadura, ordenhar as mamas e realizar a inibição mecânica da lactação na sequência;
- Desencorajar a aplicação de compressas ou banhos quentes nas mamas a fim de diminuir a vasodilatação e aumento de produção láctea.

”

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

7.4 - ABORDAGEM OPORTUNÍSTICA SOBRE IMUNIZAÇÕES NO ATENDIMENTO À MULHER

Em todo e qualquer atendimento há a oportunidade de verificar o status vacinal da mulher e, havendo indicação, encaminhar a paciente para a sala de vacinas a fim de atualizá-lo (ver quadro abaixo).

Quadro 60 – Vacinas de Rotina Preconizadas para Mulheres em Idade Fértil

VACINAS DE ROTINA PRECONIZADAS PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL					
Vacina	Proteção	Esquema básico	Reforço	Gestante pode fazer	Idade recomendada
Hepatite B	Hepatite B	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal	-	sim	
dT (Difteria e Tétano)	Difteria e Tétano	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal	A cada 10 anos. Ferimentos graves, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos	sim	
Difteria, Tétano, Pertussis (DTPa- acelular)	Difteria, Tétano e Coqueluche	Dose única	-	sim	Gestantes a partir da 20ª semana de gravidez e puérperas até 45 dias
Triviral- SRC	Sarampo, Rubéola e Caxumba	2 doses (20-29 anos) 1 dose acima de 30 anos	-	não	
Febre amarela (VFA)	Febre amarela	Dose única	Reforço, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade		

Fonte: Adaptado de MS, 2014.

- Ficar atento às campanhas de imunização que ocorrem periodicamente, principalmente as anuais como Influenza ou Covid-19, as quais encontram-se disponíveis para grupos prioritários.
- Maiores informações poderão ser consultadas em:
 - Manual de normas e procedimentos de vacinação.
 - Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
 - Instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação de 2024
 - Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/GEDIM/Atualizados/INCV-2024.pdf>.
 - Calendário do adulto e idoso
 - Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/GEDIM/calendario-vacinacao/calendario-nacional-vacinacao-adulto-idoso-2023.pdf>.
 - Calendário da gestante
 - Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/GEDIM/calendario-vacinacao/calendario-nacional-vacinacao-gestante-2023.pdf>.

8 - MENOPAUSA E CLIMATÉRIO

O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 40 e 65 anos.

A menopausa, marco do período climatérico, é a interrupção permanente da menstruação e o diagnóstico é feito de forma retroativa, após 12 meses consecutivos de amenorreia, ocorrendo geralmente entre os 48 e 50 anos de idade. Mulheres que se apresentem menopausadas antes dos 40 anos deverão ser referenciadas para o MFC para investigações adicionais.

A consulta de enfermagem para mulheres nestas etapas de seu ciclo de vida trata-se de momento oportunístico para o rastreamento de Risco Cardiovascular (RCV) (conforme [Protocolo de Enfermagem volume 1](#))¹⁷, de cânceres de colo/mama e oferta de Check-up sorológico, preferencialmente por meio do uso dos testes rápidos.

É importante lembrar que a avaliação de RCV deve ser realizada em todas as pessoas com HAS, DM, DCV. Mulheres sem estas comorbidades, maiores de 65 anos, com IMC ≥ 25 e circunferência abdominal $> 88\text{cm}$ merecem atenção especial. Deverá ser solicitada a dosagem sérica (sangue) de: - Triglicerídeos, colesterol total, HDL e calculado o LDL [LDL colesterol mg/dL = Colesterol Total - HDL Colesterol - (Triglicerídeos/5)].

- Para calculadora do risco cardiovascular: <http://www.cvriskcalculator.com/>.
- Para calculadora do LDL: <https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/?page=10>

Não se deve deixar de realizar exame físico, perguntar sobre sintomas, DUM e uso de método contraceptivo no momento e comorbidades.

8.1 - TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH)

Muitas mulheres nessa fase da vida buscam no serviço de saúde a prescrição de Terapia de Reposição Hormonal (TRH), no entanto acabe ao enfermeiro orientá-la sobre indicações, contraindicações e limitações no tempo de uso (máximo de 4 anos) e idade (até no máximo 60 anos). O uso prolongado de TRH pode aumentar o risco de câncer de mama, doenças tromboembólicas e cardiovasculares.

O enfermeiro poderá prescrever apenas a TRH tópica por via intravaginal, com reavaliação semestral e respeitando os limites de tempo e idade máximos de uso, contanto que a mulher não apresente contraindicações absolutas e/ou relativas ao método. Mulheres em TRH deverão aferir os níveis pressóricos trimestralmente. Deverá ser reservada aos quadros de estrogenização relacionada ao rastreamento de câncer cérvico-uterino ([Quadro 29](#)) no caso de queixas relacionadas à sexualidade e funções urinárias, cujo esquema prescrito deverá ser **Estriol 1mg/g creme vaginal, 0,5g/dia inserido por 21 dias e, pausa de 7 dias, repetir a conduta se necessário (tempo máximo de tratamento por até 3 meses). Na persistência de sintomatologia, encaminhar para avaliação médica.**

Quadro 61 – Contraindicações à Terapia de Reposição Hormonal (TRH)

CONTRAINDICAÇÕES À TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH)	
Contraindicações absolutas à TRH	Contraindicações relativas à TRH
• História de e/ou câncer de mama; • História de e/ou câncer de endométrio; • História de e/ou doença hepática grave; • Sangramento genital não esclarecido; • História de tromboembolismo agudo e recorrente; • Porfiria.	• Hipertensão arterial não controlada; • Diabetes mellitus não controlado; • Endometriose; • Miomatose uterina;

8.2 - MANEJO DAS QUEIXAS MAIS COMUNS NO CLIMATÉRIO

Quadro 62 – Manejo das Queixas Mais Comuns no Climatério

MANEJO DAS QUEIXAS MAIS COMUNS NO CLIMATÉRIO	
Queixa	Conduta do Enfermeiro
Disúria, nictúria, polaciúria, urgência miccional, infecções urinárias de repetição, dor e ardor ao coito (dispareunia), corrimento vaginal, prurido vaginal e vulvar que podem estar relacionados à atrofia genital	• Orientar o uso de lubrificantes vaginais durante a relação sexual; • Prescrever TRH: estrogênio tópico vulvovaginal, (contanto que não haja contraindicações para este método – ver <u>Quadro 61</u>); • Sempre investigar outras possíveis causas.
Fogachos	• Orientar a: ○ Dormir em ambiente bem ventilado; ○ Usar roupas em camadas que possam ser facilmente retiradas se perceber a chegada dos sintomas; ○ Usar tecidos que deixem a pele “respirar”; ○ Beber um copo de água ou suco quando perceber a chegada deles; ○ Não fumar; ○ Evitar consumo de bebidas alcoólicas e de cafeína; ○ Ter um diário para anotar os momentos em que o fogacho se inicia e, desse modo, tentar identificar situações-gatilho e evitá-las; ○ Praticar atividade física; ○ Perder peso, caso haja excesso de peso; ○ Respirar lenta e profundamente por alguns minutos;
Alterações emocionais/ do sono	• Valorizar a presença de situações de estresse e a resposta a elas, como parte da avaliação de rotina; • Estimular a participação em atividades sociais; • Praticar atividade física, evitando 03 horas antes de dormir; • Deitar-se e levantar-se sempre nos mesmos horários diariamente, mesmo nos fins de semana; • Evitar tirar cochilos, principalmente depois do almoço e ao longo da tarde; • Escolher uma atividade prazerosa diária para a hora de se deitar, como ler livro ou tomar banho morno; • Assegurar que a cama e o quarto de dormir estejam confortáveis; • Não fazer nenhuma refeição pesada antes de se deitar e evitar bebidas à base de cafeína no fim da tarde; • Se permanecer acordada por mais de 15 minutos após apagar as luzes, levantar-se e permanecer fora da cama até perceber que irá adormecer; • Avaliar estados depressivos especialmente em mulheres que tenham apresentado evento cardiovascular recente; • Considerar tratamento para depressão e ansiedade a ser prescrito pelo MFC quando necessário e/ou encaminhamento à psicologia.
Continua.	

MANEJO DAS QUEIXAS MAIS COMUNS NO CLIMATÉRIO

Queixa	Conduta do Enfermeiro
Diminuição da libido	• Estimular o autocuidado; • Estimular a aquisição de informações sobre sexualidade (livros, revistas etc.); • Avaliar a presença de fatores clínicos ou psíquicos que necessitem de abordagem médica; • Apoiar iniciativas da mulher na melhoria da qualidade das relações sociais e familiares; • Estimular a prática de sexo seguro; • Orientar o uso de lubrificantes vaginais à base d'água na relação sexual; • TRH: considerar a terapia hormonal local

Fonte: Adaptado de Brasil, 2015.

8.3 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO CLIMATÉRIO/MENOPAUSA

- Implementação de Enfermagem:
 - Informar sobre a prevenção primária da osteoporose e o risco de fraturas associadas;
 - Orientar dieta rica em cálcio e vitamina D, incentivando o consumo de leite, iogurte, queijos (principais fontes), couve, agrião, espinafre, taioba, brócolis, repolho, sardinha e castanhas;
 - Aconselhar exposição solar, sem fotoproteção, por pelo menos 15 minutos diariamente antes das 10h ou após as 16h;
 - Orientar a prática de 150 minutos/semana de atividade aeróbica de intensidade moderada (sejam ocupacionais ou de lazer), sendo ao menos 10 minutos de atividades físicas de forma contínua por período;
 - Orientar a realização de atividades de fortalecimento muscular duas ou mais vezes por semana, além de práticas corporais que envolvam lazer, relaxamento, coordenação motora, manutenção do equilíbrio e socialização, diariamente ou sempre que possível;
 - Orientar exercícios da musculatura perineal.

8.4 - CONTRACEPÇÃO NO CLIMATÉRIO

- Se em uso de ACO ou progestágeno injetável, mude para método não hormonal ou pílula de progestágenos quando idade maior ou igual a 50 anos;
- Se em uso de método não hormonal, mantenha-o por mais 02 anos após o último ciclo;
- Se em uso de pílula de progestágeno, continue até os 55 anos ou se ainda menstruando, até 1 ano após o último ciclo.

9 - ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO À ADOLESCENTE ⁴

A consulta de enfermagem poderá ser realizada quando a adolescente é levada pelos pais/responsáveis/adulto da sua confiança, bem como pode ocorrer quando ela mesma resolve buscar sozinha e espontaneamente pelo atendimento. É seu direito consentir ou recusar o atendimento.

Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência é o período compreendido 10 e 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a adolescência, a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população.

É importante avaliar a maturidade da adolescente e encorajar a presença familiar, no entanto o acesso à consulta não poderá ser negado caso a adolescente deseje ser atendida sozinha.

O Ministério da Saúde preconiza que a consulta do adolescente deve ser considerada uma oportunidade esclarecer o uso do preservativo (masculino e feminino) e dos contraceptivos para a prevenção da gravidez e das ISTs/aids, enfatizando a dupla proteção. O momento também é propício ao esclarecimento sobre os efeitos adversos do uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas.

Alguns aspectos clínicos têm sua avaliação recomendada pelo Ministério da Saúde, devendo ser investigados e registrados pelo enfermeiro:

- **Anamnese:**
- **Perguntar o motivo da consulta;**
- **Verificar histórico de comorbidades e história familiar;**
- **Orientar sobre ciclo menstrual;**
- **Atentar para queixas e dúvidas;**
- **Questionar o humor e aspectos emocionais;**
- **Exame físico completo:**
 - Avaliação antropométrica
 - Cerca de 20 a 25% da altura do indivíduo adulto cresce neste período e 40 a 50% do seu peso final. Estes parâmetros são alcançados, em média, durante o intervalo de 3 a 5 anos no estirão da puberdade;
 - Atentar para casos em que o crescimento pré-puberal seja menor que 4 cm/ano, ou menor que 6 cm/ano em adolescentes na fase puberal;
 - As adolescentes podem ainda crescer em média 4 a 6 cm nos 2 ou 3 anos após a menarca;
 - Alterações abruptas no peso, para mais ou para menos, deverão ser avaliadas pelo MFC para investigação. Não se esquecer de atentar para distúrbios emocionais e alimentares.
- **Avaliação do estagiamento puberal pelos critérios de Tanner:**
 - O início da puberdade ocorre nas meninas entre 8 a 13 anos, com o aparecimento do broto mamário. O broto mamário é o primeiro sinal puberal na menina, é chamado de telarca e pode apresentar-se unilateralmente sem significado patológico. Observar a adolescente, tranquilizá-la e reavaliar após seis meses, quando a outra mama já terá aparecido e os primeiros pelos pubianos também. Caso isso não ocorra, o enfermeiro deverá encaminhar para consulta médica.
 - Atentar que a idade média da menarca em nosso meio é de 12 anos e 4 meses, mas pode ocorrer entre 9 e 16 anos, observar comportamento do evento na família e acompanhar o processo de cada adolescente. É frequente ocorrer um corrimento vaginal claro entre 6 a 12 meses antes da primeira menstruação ou menarca, fato marcante da puberdade feminina. Esclarecer a adolescente que é natural, pois trata-se do crescimento do tecido endometrial uterino e que se deve apenas cuidar mais da higiene corporal. Os primeiros ciclos menstruais são geralmente anovulatórios e irregulares, podendo essa irregularidade permanecer por até 2 ou 3 anos. O ciclo menstrual normal tem um intervalo que varia de 21 a 36 dias e uma duração entre 3 e 7 dias.
 - Encaminhar ao MFC se:

- O aparecimento de pelos pubianos for anterior ao do broto mamário, pois pode se tratar de uma puberdade de origem periférica e não central pelo estímulo hipofisário-gonadal;
- Puberdade precoce (antes dos 8 anos de idade);
- Puberdade tardia (meninas com ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 13 anos de idade).
- Exame ginecológico: para adolescentes que tenham queixas ginecológicas ou que já tenham iniciado sua vida sexual;

9.1 - ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS NO ATENDIMENTO À ADOLESCENTE

O atendimento à adolescente é, por vezes, polêmico no que diz respeito à forma como o mesmo deve ser realizado. Surgem questionamentos tais como:

- “Precisa estar acompanhada por um responsável legal maior de 18 anos?”
- “Posso realizar avaliação ginecológica sem nenhum outro colega no consultório?”
- “Posso ofertar sorologias e fornecer seus resultados para adolescentes desacompanhadas por um responsável legal maior de 18 anos?”

O Ministério da Saúde recomenda que qualquer exigência, como a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento no serviço de saúde, que possa afastar ou impedir o exercício pleno do adolescente de seu direito fundamental à saúde e à liberdade, constitui lesão ao direito maior de uma vida saudável. Caso a equipe de saúde entenda que o usuário não possui condições de decidir sozinho sobre alguma intervenção em razão de sua complexidade deve, primeiramente, realizar as intervenções urgentes que se façam necessárias e, em seguida, abordar o adolescente de forma clara sobre a necessidade de que um responsável o assista e o auxilie no acompanhamento. Havendo resistência fundada e receio que a comunicação ao responsável legal implique em afastamento do usuário ou dano à sua saúde, pode ser aceita pessoa maior e capaz indicada pelo adolescente para acompanhá-lo e auxiliar a equipe de saúde na condução do caso, mesmo que este não seja parente direto.

O artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, recentemente alterado pela Lei nº 13.257 de 08 de março de 2016, estabelece na nova redação que: “É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.”.

Ainda nesse sentido, a Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996 regula um conjunto de ações para o planejamento familiar, saúde sexual e saúde reprodutiva, mas não estabelece diretrizes ou restrições específicas para adolescentes, devendo, pois, ser interpretada conjuntamente com a Lei orgânica do SUS e o ECA.

De maneira geral, o atendimento da adolescente pode ser prestado sem a necessidade de um responsável legal presente, bem como lhe é assegurado o sigilo das informações. Assim, deve ser ofertado livre acesso a insumos de prevenção, métodos anticoncepcionais e orientação sobre saúde sexual e reprodutiva. Haverá exceções a esta regra que deverão ser analisadas caso-a-caso, como em se tratando de risco de morte (própria e de terceiros) e na suspeita de maus tratos, por exemplo. O adolescente precisa estar seguro do caráter confidencial da consulta, mas ficar ciente também das situações nas quais o sigilo poderá ser rompido, o que, no entanto, ocorrerá sempre com o conhecimento dele. Recomenda-se a discussão junto à equipe e registro em prontuário de todo o processo.

- **Atenção:**

Se durante o atendimento à adolescente for identificada violência ou suspeita, deverá ser preenchida a ficha de notificação e aplicado fluxo de atendimento às vítimas de violência do município. **Ainda, em se tratando de crianças/adolescentes, uma comunicação do caso deve obrigatoriamente ser feita ao Conselho Tutelar e/ou autoridades competentes, conforme exigência do ECA. XII.b.**

9.2 - TESTAGEM SOROLÓGICA PARA MENORES DE 18 ANOS

“Esta deverá ser voluntária e consentida pelo menor, sem necessidade de autorização de responsável, desde que aquele tenha capacidade de avaliar seu problema e atuar a respeito.”³

Assim como nos demais casos, deverá ser estimulado o acompanhamento por um adulto da confiança da adolescente.



10 – INFERTILIDADE ¹

Quando houver demanda sobre dificuldade para engravidar, é necessário questionar quanto tempo o casal está tentando. De maneira geral, investigar casais que não atingiram a concepção dentro de 12 meses de atividade sexual regular desprotegida.

As etiologias femininas são detectadas em 13% (fator tubário), 15% (disfunção ovulatória), 31% (reserva ovariana diminuída), 8% (endometriose), 6% (fator uterino) e 12% (vários fatores) dos casos de infertilidade. A avaliação do parceiro é necessária, com pelo menos uma análise do sêmen, enquanto se avalia a mulher.

- **Questionar/Examinar:**

- Idade (se >35 anos, pode haver alguma diminuição da fertilidade);
- Menstruação irregular ou ausente (ciclo menstrual normal varia de 24 a 35 dias de duração e o sangramento menstrual ocorre por 3 a 7 dias);
- História de infecção sexualmente transmissível ou outro processo pélvico inflamatório;
- Cirurgia prévia (associada à disfunção tubária);
- Dispareunia (associada à endometriose);
- Problemas endócrinos;
- Exposição a substâncias químicas;
- Doenças autoimunes;
- Uso de medicamentos dopaminérgicos;
- Galactorréia;
- Hirsutismo e/ou acne;
- Exame pélvico alterado.

- **Para a investigação da infertilidade da mulher, o(a) enfermeiro(a) poderá solicitar:**

- Hormônio luteinizante (LH);
- Hormônio folículo estimulante (FSH);
- Estrogênio;
- Testosterona livre;
- TSH.

O fator masculino contribui isoladamente em 20% dos casos de casais inférteis e em 30% a 40% adicionais em combinação com outros fatores. Deve-se suspeitar de infertilidade por fator masculino na presença de ovulação normal e tubas patentes na parceira do sexo feminino de um casal infértil.

O principal objetivo da avaliação da infertilidade por fator masculino é encontrar uma causa que possa ser corrigida.

- **Questionar/Examinar:**

- ISTs, varicocele, criptorquidia, infertilidade, trauma local, quimioterapia ou radioterapia prévia;
- Medicamentos em uso;
- Fibrose cística e ausência congênita bilateral do canal deferente, anomalias do cromossomo Y, síndrome de Klinefelter (47,XXY), endocrinopatia;
- Tabagismo (cigarro e maconha);
- Uso de banheira de hidromassagem ou sauna.

- **Para a investigação da infertilidade no homem, o(a) enfermeiro(a) poderá solicitar:**

- Espermograma.

Se alterado, encaminhar para consulta médica.

Após os resultados dos exames para investigação de infertilidade encaminhe e discuta com o MFC para seguimento.

REFERÊNCIAS

- 1 BRASIL. Ministério da Saúde/Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf> acesso em 17 jun 2016.
- 2 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde**. 2. ed., 2. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2014. Disponível em <<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en/>> acesso em 17 mai 2016.
- 3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. **Implicações Éticas do Diagnóstico e da Triagem Sorológica do HIV**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/imp_eticas_0.pdf> acesso em 21 jul 2016.
- 4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Orientações básicas de atenção integral à saúde de adolescentes nas escolas e unidades básicas de saúde**. 1. ed., 1 reimpr. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacao_basica_saude_adolescente.pdf> acesso em 4 nov 2016.
- 5 BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Caderno de Atenção Primária nº 29: rastreamento**. Brasília-DF, 2010. Disponível em <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/linha_tempo_cab29.pdf> acesso em 4 nov 2016.
- 6 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Guia do Pré-natal do parceiro para profissionais de saúde**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf> acesso em 4 nov 2016.
- 7 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília-DF, 2016. 1ª edição atualizada Disponível em: <<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/25/GVS-online.pdf>> acesso em 4 nov 2016.
- 8 BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58357/miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406.pdf> acesso 4 nov 2016.
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Protocolo de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual**. Florianópolis-SC, 2010. Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/05_08_2011_9.35.51.3a63f3314c0be02ad278320128d3574a.pdf> acesso em 4 nov 2016.
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Protocolo de Infecções Sexualmente Transmissíveis e outros agravos de interesse em Saúde Pública**. Florianópolis-SC, 2016. Disponível: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/19_04_2016_10.56.01.af76ea1aadb35e63ae487c5a0d844ca2.pdf> acesso 4 nov 2016.

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Pack Brasil Adulto/Versão: Florianópolis**. Ferramenta de manejo clínico em Atenção Primária à Saúde. Florianópolis-SC, 2016.

12 DUNCAN *et al.* Medicina Ambulatorial. **Condutas de atenção primária baseadas em evidências**. Artmed. Porto Alegre-RS, 2014.

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Protocolo de Atenção Integral à Saúde da Mulher**. Florianópolis, 2010.

14 BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. Brasília-DF, 2014. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf> acesso 4 nov 2016.

15 BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Caderno de Atenção Básica nº 23**. Aleitamento materno e alimentação complementar. 2ª edição. Brasília-DF, 2015. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf> acesso em 4 nov 2016.

16 BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV**. Brasília-DF, 2015. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58168/pcdt_pep_20_10_1.pdf> acesso em 21 set 2016.

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Protocolo de Enfermagem Vol.1**. Hipertensão, diabetes e outros fatores associados a doenças cardiovasculares. Florianópolis-SC, 2016. Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_08_2016_21.59.34.ea6112e47c464ef756156513fb07d85e.pdf> acesso em 3 mai 2016.

18 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Procedimentos a serem adotados para a Febre do Zika no Brasil** (Nota Informativa). Brasília-DF, 2016. Disponível em: <<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/07/Nota-Informativa-zika.pdf>> acesso em 17 jun 2016.

19 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em <<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Manual-de-ACR-em-Obstetricia-versao-26-de-maio--4-.pdf>> acesso em 3 mai 2016.

20 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Cadernos de Atenção Básica, nº 32**: Atenção ao pré-natal de baixo risco. 1ª ed. rev. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. Disponível em <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf> acesso em 12 jul 2016.

21 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Gestação de alto risco**: manual técnico. 5ª ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. Disponível em <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf> acesso em 2 jul 2016.

22 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Brasília-DF, 2019. Disponível em <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>.

23 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. – 5. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022

24 Lifits-Podorozhansky YM, Podorozhansky Y, Hoffstetter S, Gavard JA. Role of vulvar care guidelines in the initial management of vulvar complaints. J LowGenitTractDis. 2012;16(2):88-91. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22227837>.

25 Brasil. Ministério da Saúde. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010. 2ª Ed. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf.

26 UpToDate. Incontinência urinária. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/urinary-incontinence-treatments-for-women-beyond-the-basics?topicRef=2727&source=see_link.

27 Dumoulin C, Cacciari LP, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD005654. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub4.

28 SOBEST - Associação Brasileira de Estomaterapia. Prevenindo e tratando a incontinência urinária feminina. 1.ed. - Taubaté: Casa Cultura, 2020. 28 pág. Disponível em: <https://sobest.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-Sobest-Incontinencia.pdf>

29 Assis GM, Silva CPC, Martins G. Proposal of a protocol for pelvic floor muscle evaluation and training to provide care to women with urinary incontinence. Rev Esc Enferm USP. 2021;55:e03705. doi: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019033503705>

30 Tran LN, Puckett Y. Incontinência Urinária. [Atualizado em 8 de agosto de 2023]. In: StatPearls [Internet]. Ilha do Tesouro (FL): Publicação StatPearls; 2024 janeiro-. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559095/>

31 FREBASGO - Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Manual de Condutas em Ginecologia Oncológica / HospitalA.C.Camargo, Departamento de Ginecologia. 1 ed.- São Paulo: FAP; 2010.68p.

32 Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev). Falando sobre câncer do colo do útero. – Rio de Janeiro: MS/INCA, 2002, 59 p.

33 Feuerschuette OHM *et al.* Candidíase vaginal recorrente: manejo clínico. FEMINA. 2010;38(2):31-36. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2010/v38n1/a005.pdf>

34 Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano. Procedimentos Técnicos para Ordenha, Manipulação e Administração do Leite Humano Cru Exclusivo da Mãe para o próprio filho em Ambiente Neonatal. Disponível em: https://rbhl.fiocruz.br/sites/rbhl.fiocruz.br/files/usuario/8/nt_procedimentos_ordenha_manipulacao_leite_cru.pdf

35 Coutinho T et al. Prevenção da doença perinatal pelo estreptococo do grupo B: atualização baseada em algoritmos. FEMINA. 2011;39(6):329-333. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2011/v39n6/a2684.pdf>.

36 Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Protocolo de Cuidado na Candidíase Vaginal. Disponível em: <https://www.mulheres.org.br/protocolo-cuidado-na-candidiase-vaginal/>

37 Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar – Manual Técnico. Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 40. Brasília. 2002. 4ª Edição.

38 Santos Filho OO, Telini AH. Infecções do trato urinário durante a gravidez. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, no. 87/ Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco).

39 Cabral AC, Duarte G, Moraes Filho OB, Vaz JO. Êmese da gravidez. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia; 2018. Capítulo 4, Classificação e tratamento; p.16-23. [Orientações e Recomendações FEBRASGO, no.2/Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal].

40 Metoclopramida. En e-lactancia.org. Recuperado 02 Diciembre, 2020 a partir de <http://e-lactancia.org/breastfeeding/metoclopramide/product/>

41 Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda. Carta Plasil Sanofi [Internet]. 2013. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>

42 Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil. Brasília, DF: OPAS, 2016. 32p.: il.

43 Silva, Quêzia Santos Moreira da; Silva, Ellen Brito. Uso de plantas medicinais na gravidez: uma revisão integrativa. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (graduação em Farmácia) – Departamento de Farmácia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017

44 DUARTE, Ana Flávia Schvabe et al. O USO DE PLANTAS MEDICINAIS DURANTE A GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO. Visão Acadêmica, [S.l.], v. 18, n. 4, feb. 2018. ISSN 1518-8361. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/55983>>. Acesso em: 02 dec. 2020. doi:<http://dx.doi.org/10.5380/acd.v18i4.55983>.

45 Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4.

46 BRASIL. Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 2022. Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar. 2022. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/36328536/publicacao/36329049> Acesso em: 26 maio de 2024.

47 CANOVA, Rodrigo Schroeder; CARUSO, Fernanda Borsatto; POLI, Marcelino Espírito Hofmeister. Contracepção de Emergência: Indicações e Métodos. Porto Alegre: Acta méd. 33(1), 2012, p. 6. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882343/contracepcao-de-emergencia-indicacoes-e-metodos.pdf> Acesso em: 26 maio de 2024.

48 FINOTTI, Marta. Manual de Anticoncepção. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2015. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/manual-anticoncepcao-febrasgo-2015-pdf.pdf> Acesso em: 26 maio de 2024.

49 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Guia rápido planejamento sexual e reprodutivo: versão profissional. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde, 1. ed., 2023. Disponível em: [https://subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Livro_GuiaRapido-PlanejamentoSexualReprodutivo_PDFDigital_20240219_\(1\)1.pdf](https://subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Livro_GuiaRapido-PlanejamentoSexualReprodutivo_PDFDigital_20240219_(1)1.pdf) Acesso em: 26 maio de 2024.

50 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Department of Sexual and Reproductive Health and Research (WHO/SRH) and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health / Center for Communication Programs (CCP), knowledge success. Family Planning: A Global Handbook for Providers (2022 update). Baltimore and Geneva: CCP and WHO; 2022. Disponível em: <https://fp handbook.org/sites/default/files/WHO-JHU-FPHandbook-2022Ed-v221114b.pdf> Acesso em: 26 maio de 2024.

51 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5ª ed. 2015. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/03/9789241549158_eng.pdf Acesso em: 26 maio de 2024.

52 GIORDANO, M.V.; GIORDANO, L.A.; PANISSET, K.S. Dispositivo intrauterino de cobre. *Femina*: 2015, vol. 43, suppl. 1. p. 15-20. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2015/v43nsuppl1/a4850.pdf>

53 ARAÚJO, Tatiane Gomes de; SCALCO, Sandra Cristina Poerner; VARELA, Daniele. Função e disfunção sexual feminina durante o ciclo gravídico-puerperal. *Revista Brasileira de Sexualidade Humana*, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 29-39, 18 fev. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.35919/rbsh.v30i1.69> BRASIL.

54 Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas Públicas. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

55 ENDERLE, Cleci de Fátima; KERBER, Nalú Pereira da Costa; LUNARDI, Valéria Lerch; NOBRE, Camila Magroski Goulart; MATTOS, Luiza; RODRIGUES, Eloisa Fonseca. Constraints and/or determinants of return to sexual activity in the puerperium. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 719-725, jun. 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-11692013000300010>

56 KLIEMANN, Barbarella de Souza Ribeiro de Araujo. SINTOMAS DE DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS APÓS O PERÍODO PUERPERAL. 2018. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Psicologia, Universidade do Sul de Santa Catarina, 2018. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/10123>

57 REZENDE FILHO, Jorge. *Rezende Obstetrícia*. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

58 VETTORAZZI, Janete; MARQUES, Florence; HENTSCHEL, Heitor; RAMOS, José Geraldo Lopes; MARTINS-COSTA, Sergio H.; BADALOTTI, Mariangela. Sexualidade e puerpério: uma revisão da literatura. *Hcpa*, [s. l.], v. 32, n. 4, p. 473-479, 2013. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/hcpa/article/view/32388/23916> ZUGAIB, Marcelo (ed.).

59 Zugaib *Obstetrícia*. 5. ed. Barueri: Manole, 2023.

ANEXO I – MODELO DE PLANO DE PARTO

O que é o plano de parto?

O plano de parto é uma carta que a gestante elabora, relatando seu desejo referente ao momento do parto, possibilitando o planejamento do nascimento do seu bebê. É um importante instrumento de empoderamento feminino e de informação sobre as práticas recomendadas para a assistência ao parto.

⚠ Sinais de Trabalho de Parto ⚠

- Sangramento;
- Eliminação do tampão mucoso com raíais de sangue;
- Rompimento Espontâneo da Bolsa de líquido Amniótico (pode ser com perda de líquido em grande ou pequena quantidade);
- Contrações regulares, por vezes dolorosas (3 contrações ou mais com 20 seg em 10min);

Então, é hora de procurar o serviço de referência ao parto!

Estamos cientes das recomendações e escolhas relacionadas ao parto e desejamos receber atenção humanizada e respeitosa no nascimento do seu bebê.
Gratos.



Maternidade HU (Hospital Universitário)
Endereço: R. Profa. Maria Flora Pausewang -
Trindade, Florianópolis
Telefone: (48) 3721-9140

Maternidade Carmela Dutra
Endereço: R. Irmã Benwarda, 208 - Centro,
Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3664-3900



MEU PLANO DE PARTO

Nome: _____ DPP: _____

Nome do bebê: _____

Maternidade: _____

Local onde realizou pré natal: _____



DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Acompanhamento: Você quer a presença de pessoas durante o parto? () sim () não

Quem você quer presente durante o parto?
Escolha alguém além da sua doula.

A raspagem dos pelos e a lavagem intestinal não são necessárias. É comum que a mulher elimine fezes, mas, se desejar, pode pedir um supositório de glicerina para esvaziar o intestino e reduzir essa possibilidade.

Deseja usar supositório de glicerina?
() Sim () Não

Métodos para alívio da dor: Diversas técnicas estão disponíveis (massagens, exercícios, banhos, respiração, uso de medicamentos, etc.).

Conforme a disponibilidade da maternidade, escolha as opções que você gostaria de experimentar:

Você também pode tomar líquidos para manter-se hidratada.

Conforme disponibilidade da maternidade, o que deseja ingerir?

Você gostaria de fazer uso caso a maternidade ofereça práticas integrativas? (ex: acupuntura, meditação...)
() Sim () Não

DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Posição durante o parto: Você pode escolher a posição mais confortável para você (sentada, de lado, de cócoras, deitada com a cabeça elevada e genupectoral). A posição mais adequada vai sendo experimentada e mudada conforme o momento.

Ambiente do parto: Manter o ambiente com pouca luminosidade e com música para ajudar a relaxar e tranquilizar. O que você deseja?

Em casos específicos, pode ser necessário o uso de extratores (fórceps ou vácuo-extrator) ou a realização de episiotomia (corte na vagina), mas esses procedimentos não devem ser rotina, apenas em situações de emergência. A equipe deve informar a necessidade de sua utilização.

APÓS O PARTO

A Hora Dourada do Nascimento: Ao nascer, o bebê é acolhido e colocado em contato pele a pele com a mãe antes de cortar o cordão umbilical, que deve ser cortado após cessar a pulsação (cerca de um minuto após o nascimento). O bebê deve ser colocado para mamar logo após o nascimento e permanecer com a mãe durante toda a internação.

Por quem você deseja que seja feito o corte do cordão umbilical?

Amamentação: A OMS recomenda amamentar na primeira hora de vida para fortalecer o vínculo e reduzir riscos.

Você deseja amamentar imediatamente?
() Sim () Não

Para evitar o risco de doença hemorrágica, após o parto, será administrado 1mg de vitamina K intramuscular.

O primeiro banho é dado após 24 horas, respeitando a temperatura e a proteção da pele. Realizar higiene do coto umbilical.

Quem você deseja que dê o primeiro banho do bebê?

Caso a mãe esteja bem, pode tomar banho e se alimentar normalmente, enquanto os profissionais monitoram o sangramento pós-parto e auxiliam na amamentação.

Caso tenha outros desejos e expectativas em relação a vivência do parto, registre aqui e converse com a equipe da maternidade a respeito deles:

Durante a internação, mãe e bebê devem permanecer no Alojamento Conjunto. Caso haja alguma condição de saúde que impeça isso, a equipe informará e esclarecerá as dúvidas.

ANEXO II – ALTERAÇÕES EMOCIONAIS MAIS COMUNS EM PUÉRPERAS

	Tristeza puerperal – “baby blues”	Depressão puerperal	Psicose puerperal
Frequência	50 a 70% dos nascimentos	10 a 15% dos nascimentos	1 a 5 em cada 1000 habitantes
Principais sintomas	Humor depressivo Fadiga Insônia Ansiedade Preocupação excessiva com os cuidados com o RN Choro fácil Dificuldade de concentração	Sensação de Incapacidade Sentimento de culpa Transtorno de sono Mudanças de humor Tristeza constante Baixa autoestima Desanimo ou cansaço extremo Incapacidade de cuidar de si ou do RN Pouco ou nenhum interesse pelo bebê Falta de apetite Medo de ficar sozinha Sentimento de culpa Cansaço extremo	Transtorno do Sono Irritabilidade Mudanças de Humor Sintomas psicóticos (delírios, crises, alucinações) Situações de risco de vida ao RN ou a paciente
Duração	O pico fica entre 3º e o 6º dia. Geralmente dura menos de 1 semana.	A maior parte dos casos ocorrem nos dois primeiros meses de pós-parto. A duração é variável	Da primeira semana ao 1º mês. A duração é variável
Hospitalização	Não necessita hospitalização	Pode necessitar hospitalização	Pode necessitar hospitalização
Prognóstico	Se duração maior que um mês, procurar um profissional	Melhor prognóstico que outras depressões	Pode ser o início de uma depressão psicótica, esquizofrenia ou síndrome cerebral orgânica
Conduta	Apoio familiar e dos profissionais da atenção primária	Acompanhamento com média complexidade especializada em saúde mental	Necessário tratamento com profissionais de saúde mental

Fonte: CEPÊDA, Teresa, et.al. Promoção da Saúde Mental na Gravidez e Primeira Infância: Manual de orientação para profissionais de saúde. Lisboa, 2006. Disponível em: <https://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i008180.pdf>

FIGUEIRA, Patrícia, et.al. Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo para triagem no sistema público de saúde. Revista Saúde Pública, vol.43, no. 1, 2009.

GONÇALVES, Ana, et.al. Reconhecendo e intervindo na depressão pós-parto. Revista Saúde em Foco, nº 10, 2018.

MEIRA, Bianca, et.al. Desafios para profissionais da atenção primária no cuidado à mulher com depressão pós-parto. Texto Contexto Enfermagem, vol.24, no. 3, 2015.

MORAES, Inácia, et.al. Prevalência da depressão pós-parto e fatores associados. Revista de Saúde Pública, vol.40, no.1, 2006.

Theme, Mariza, et.al. Factors associated with postpartum depressive symptomatology in Brazil: The Birth in Brazil National Research Study, 2011/2012. Journal of Affective Disorders, 2016.

ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MAMADA

Nome da mãe:		Data:	
Nome do bebê:		Idade do bebê:	
Sinais de que a amamentação está indo bem		Sinais de possível dificuldade	
Observação Geral da Mãe			
A mãe parece saudável		A mãe parece doente ou deprimida	
A mãe está relaxada e confortável		A mãe parece tensa e desconfortável	
Sinais de vínculo entre a mãe e bebê		Sem troca de olhar entre mãe e bebê	
Observação Geral do Bebê			
O bebê parece saudável		O bebê parece sonolento e doente	
O bebê está calmo e relaxado		O bebê está inquieto ou chorando	
O bebê alcança ou procura a mama quando tem fome		O bebê não tenta alcançar ou não procura a mama	
Mamas			
As mamas parecem saudáveis		As mamas estão vermelhas, inchadas ou doloridas	
Não há dor ou desconforto		Há dor na mama ou mamilo	
A mama é bem apoiada, com os dedos longe dos mamilos		As mamas são apoiadas com os dedos sobre a aréola	
Posição do Bebê			
A cabeça e o corpo do bebê estão alinhados		O pescoço e a cabeça do bebê estão virados para a mama	
A boca do bebê está bem aberta		O bebê não está próximo da mãe	
Lábio inferior voltado para fora		O bebê é apoiado apenas pela cabeça e pelo pescoço	
O queixo toca a mama		O bebê se aproxima da mama com o lábio inferior/queixo apontado para o mamilo	
Pega da Mama pelo Bebê			
Mais aréola visível acima do lábio superior do bebê		Mais aréola visível abaixo do lábio inferior do bebê	
A boca do bebê está bem aberta		A boca do bebê não está bem aberta	
Lábio inferior voltado para fora		Lábios apontam para frente ou para dentro	
O queixo toca a mama		O queixo não toca a mama	
Sucção			
Sucção lenta e profunda com pausas		Sucção rápida e superficial	
Bochechas cheias durante a sucção		Bochechas vazias durante a sucção	
Bebê solta a mama quando termina		A mãe tira o bebê da mama	
A mãe percebe sinais do reflexo de ocitocina		Não são percebidos os sinais de reflexo da ocitocina	

Fonte: Adaptado de WHO; 2004.

ANEXO IV – GRAU DE RECOMENDAÇÃO DE CONDUTAS⁵

Grau	Definição do grau	Sugestão para a prática
A	Recomendação de que se ofereça o serviço, pois existe extrema certeza de que o benefício é substancial	Oferecer/prover esse serviço
B	Recomendação que se ofereça o serviço, pois existe moderada certeza de que os benefícios variam de substanciais a moderados	Oferecer/prover esse serviço
C	Recomendação contra a oferta rotineira do serviço. Pode-se considerar a oferta do serviço para pacientes individuais. Existe de substancial a moderada evidência de que o benefício é pequeno.	Oferecer/prover esse serviço somente se tiver outras considerações que suportam a sua oferta para pacientes individuais.
D	Recomendação contra a oferta do serviço. Existe de moderada a muita certeza de que o serviço não traz benefício ou que os danos superam os benefícios.	Desencorajar a prática desse serviço.
I	A atual evidência é insuficiente para avaliar os benefícios e danos de se adotar o serviço. A evidência está faltando, é de má qualidade ou conflitua e, desse modo, impossível de determinar os benefícios e danos da sua adoção	Caso seja oferecida, o paciente deveria ser informado e estar ciente das incertezas sobre os danos e benefícios da intervenção.

Fonte: Adaptado de Brasil, 2010.

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

ANEXO V – CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Versão	Cap.	Pág.	Alteração	Data da alteração
1.1	-	-	Melhora geral na redação e correção de erros de grafia e formatação.	15/12/2016
1.1	2 e 6	16 e 74	Inclusão do tempo de uso do estrogênio intravaginal.	15/12/2016
1.1	2	17	Inclusão da avaliação da vacina tríplice viral.	15/12/2016
1.1	2	19	Separação pílula isolada de progestágeno e minipílula de noretisterona no quadro 2.2.	15/12/2016
1.1	5	52	Inclusão de sinais de alerta para dor abdominal/cólicas.	15/12/2016
1.1	5	53	Alteração na posologia do hidróxido de alumínio para adequação ao medicamento disponível na REMUME.	15/12/2016
1.1	-	-	Alteração na posologia dos medicamentos substituindo o número de comprimidos pela dose total necessária, podendo ser em qualquer apresentação disponível na REMUME (comprimidos, cápsulas, solução oral etc.).	15/12/2016
1.1	5	67	Modificação na redação da posologia da nistatina oral.	15/12/2016
1.2	2	17 e 19	Inclusão de observação sobre adaptação do quadro 2.2	04/08/2017
1.2	5	35	Mudança de “NIC III” para “Lesões de alto grau em colo uterino ou maiores”.	04/08/2017
1.2	5	35-36	Retirada da “restrição de crescimento uterino” como critério para encaminhamento imediato à urgência obstétrica, mantendo no alto-risco.	04/08/2017
1.2	2	18-20	Inclusão da possibilidade de prescrição dos métodos contraceptivos de critério 2.	04/08/2017
1.2	2	21	Habilitação do enfermeiro para colocação e retirada de DIU, quando treinado para tal fim.	04/08/2017
1.2	3	27	Inclusão de observações para coleta de citopatológico em mulheres HIV+.	04/08/2017
1.2			Inclusão do capítulo 8.	04/08/2017
1.3	1	8	Inseridos questões a serem abordadas na entrevista inicial	02/01/2020
1.3	1	11	Inserida orientação sobre candidíase de repetição e seu tratamento	02/01/2020
1.3	1	11	Inserida observação sobre contraindicação do fluconazol para gestante	02/01/2020
1.3	1	11	Inseridos possibilidades terapêuticas/naturais para tratamento da candidíase	02/01/2020
1.3	1	13	Retirada ducha vaginal para vaginose citolítica	02/01/2020
1.3	1	10, 15 e 18	Inseridos sinais de alerta no corpo dos fluxogramas	02/01/2020
1.3	1	13	Alterada observação sobre uso de metronidazol durante amamentação	02/01/2020
1.3	1	13	Inseridos tópicos sobre hipersensibilidade ao plasma seminal	02/01/2020
1.3	1	16	Incluído tratamento para disúria e bacteriúria assintomática em gestante e cefalexina como opção terapêutica para não gestante	02/01/2020
1.3	1	17	Inserida analgesia para alívio sintomático da disúria	02/01/2020
1.3	1	18	Inserida prescrição de hioscina para cólica menstrual	02/01/2020
1.3	1	19	Alterado tempo de tratamento com estriol e inserido critérios para não prescrever	02/01/2020
1.3	2	20	Inseridos tópicos sobre cisto e abscesso de Bartholin e incontinência urinária	02/01/2020
1.3	2	21	Inseridas condutas de enfermagem no período pré-concepcional	02/01/2020
1.3	2	23	Atualizado o quadro de Categorias de Elegibilidade para métodos anticoncepcionais	02/01/2020
1.3	2	23 e 24	Destacado em vermelho situações em que o enfermeiro não pode prescrever determinado método	02/01/2020
1.3	2	25 e 26	Alterada a ordem de apresentação do quadro 2.3 para ficar na mesma sequência dos MACs do quadro 2.2	02/01/2020
1.3	2	27	Inserida conduta para sangramento vaginal por uso de anticoncepcional	02/01/2020
1.3	2	28	Inserido quadro com outros Métodos Anticoncepcionais Hormonais disponíveis no mercado (não disponibilizados na rede pública)	02/01/2020
1.3	2	31	Inserido quadro Síntese de Métodos Anticoncepcionais não Farmacológicos de Abordagem Comportamental	02/01/2020
1.3	2	36	Inserida técnica para medição do diafragma	02/01/2020
1.3	2	37	Inseridos contraindicações para inserção do DIU	02/01/2020
1.3	2	38	Prescrição e inserção do DIU por enfermeiro(a) capacitado(a) institucionalmente	02/01/2020
1.3	3	44 e 45	Inseridos imagens de colos uterinos com achados normais e alterados	02/01/2020
1.3	4	46	Inserido quadro com aprazamento para solicitação de mamografia de rastreamento	02/01/2020
1.3	4	46	Alterado o termo “bianual” para “a cada 2 anos”	02/01/2020
1.3	4	48	Inserida solicitação de USG de mamas para investigação de nódulos	02/01/2020

Versão	Cap.	Pág.	Alteração	Data da alteração
1.3	4	48	Inserido fluxograma para mulher com queixa de nódulo(s) mamários	02/01/2020
1.3	5	51	Observação sobre a gestante em acompanhamento no alto risco manter consultas com sua equipe de referência	02/01/2020
1.3	5	59	Atualização da tabela de vacinas	02/01/2020
1.3	5	62	Atualização da tabela de exames de rotina para gestante e sua periodicidade	02/01/2020
1.3	5	62	Atualizado tratamento para anemia	02/01/2020
1.3	5	63	Atualização no rastreio da DM gestacional	02/01/2020
1.3	5	66 e 67	Inserida solicitação de eletroforese de hemoglobina para mulheres negras e haitianas e Streptococcus do grupo B	02/01/2020
1.3	5	71	Inserida prescrição de hioscina se cólica durante gestação	02/01/2020
1.3	5	77	Tópico sobre gestação e doenças infectocontagiosas colocado entre tópicos de pré-natal e puerpério	02/01/2020
1.3	5	79	Observação sobre solicitação de imunoglobulina na gestante exposta a varicela/herpes-zoster que necessita de bloqueio	02/01/2020
1.3	5	80	Inserida prescrição de paracetamol ou ibuprofeno para dor no períneo no puerpério	02/01/2020
1.3	5	81	Inserido tratamento da anemia no puerpério	02/01/2020
1.3	8	80	Retirado capítulo sobre PVHIV	02/01/2020
1.3	5	83	Inserido tópico sobre retirada e armazenamento do leite materno	02/01/2020
1.3	5	87	Substituição da dipirona por ibuprofeno para lactante com ingurgitamento mamário	02/01/2020
1.3	6	93	Inserida indicação de rastreamento para doença cardiovascular e links para calculadoras de risco cardiovascular e LDL	02/01/2020
1.3	6	95	Retirada da dosagem diária de cálcio e vitamina D em miligramas	02/01/2020
1.3	8	99	Inserido capítulo sobre infertilidade	02/01/2020
1.3	8	99	Inserida solicitação de hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo estimulante (FSH), estrogênio, testosterona livre, TSH e espermograma para avaliação da infertilidade	02/01/2020
1.3	Anexo	105	Inserida tabela com taxa de falha de métodos de contracepção	02/01/2020
1.3	Anexo	106	Inserida tabela com manejo das principais intercorrências relacionadas ao DIU	02/01/2020
1.3	Anexo	106	Inserida solicitação de radiografia de abdômen total para confirmar posição do DIU quando suspeita de transfixação uterina	02/01/2020
1.3	Anexo	113	Inseridos alterações emocionais mais comuns no puerpério	02/01/2020
1.3	Anexo	114	Inseridos graus de recomendação das condutas clínicas	02/01/2020
1.3	Todos	Todos	Inclusão de hiperlinks para fluxogramas, quadros e anexos	02/01/2020
1.4	1	16	Atualização do tratamento e exames laboratoriais ITU gestante	10/12/2020
1.4	1	17	Inclusão do quadro de considerações importantes no seguimento da gestante com ITU	10/12/2020
1.4	2	26	Atualização do quadro de métodos contraceptivos - DIU	10/12/2020
1.4	5	62	Atualização quadro de exames do pré-natal (1º e 2º trimestres / Urina tipo 1)	10/12/2020
1.4	5	71	Atualização das orientações para náuseas e vômitos	10/12/2020
1.4	5	86	Quadro tratamento anemia no puerpério	10/12/2020
1.5	Todos	Todos	Melhora de redação, correção de erros de grafia e formatação de quadros para novo padrão.	31/07/2025
1.5	Todos	Todos	Alterado padrão de numeração de quadros e fluxogramas, com inclusão de subcapítulos para identificação no sumário.	31/07/2025
1.5	1	11	Inserido novo capítulo 1 - Consulta de enfermagem ginecológica na atenção primária à saúde, contemplando entrevista e exame físico.	31/07/2025
1.5	2	21	Antigo cap. 1 passa a ser cap. 2, com alteração subsequente de todos os subcapítulos e inclusão dos textos em forma de quadros.	31/07/2025
1.5	2	21 e 22	Alterado texto introdutório e retirados tópicos de entrevista e exame físico (foram contemplados no capítulo anterior), incluído quadro 7, reestruturado fluxograma 1.1 para adequação ao novo capítulo.	31/07/2025
1.5	2	23	Desmembrado antigo quadro 1.1 em subcapítulos e novos quadros.	31/07/2025

Versão	Cap.	Pág.	Alteração	Data da alteração
1.5	2	23 e 24	Incluído quadro 8 para cap. Candidíase com inserção de observação em relação ao uso concomitante de métodos contraceptivos hormonais e antifúngico e alertas de contraindicação; Retirada de observação de adaptação de dose para Melaleuca/TeaTree; Observações para o bicarbonato de sódio; prescrição de alho e observação quanto prescrição de cápsulas manipuladas de <i>Lactobacillus acidophilus</i> e lembrete quanto observação de reação do corpo da mulher ao tratamento.	31/07/2025
1.5	2	25	Incluído quadro 9 para capítulo de vaginose bacteriana.	31/07/2025
1.5	2	26	Incluído quadro 10 para vaginose citolítica, com adição de intervenções como uso de calcinha de algodão, evitar alimentos ricos em lactobacilos e solicitar avaliação médica em caso de não melhora.	31/07/2025
1.5	2	27	Incluído quadro 11 para capítulo de hipersensibilidade ao plasma seminal, com inclusão de alerta para encaminhamento de avaliação com MFC.	31/07/2025
1.5	2	28	Incluído quadro 12 para bartholinite.	31/07/2025
1.5	2	31 a 33	Incluídos alertas nas prescrições medicamentosas do quadro 13 e incorporado a ele o antigo quadro 1.2.1	31/07/2025
1.5	2	34 a 38	Incluído quadro 14 e condutas para dor pélvica	31/07/2025
1.5	2	40	Incluído quadro 15 e alerta vermelho para contraindicação.	31/07/2025
1.5	2	41 a 43	Incluído quadro 16 e 17 para incontinência urinária	31/07/2025
1.5	3	44 e 45	Incluído quadro 18 para concepção e alterada prescrição de ácido fólico.	31/07/2025
1.5	3	45	Incluídos quadro 19, fluxograma 4 e quadro 20 (antigo anexo I) para consulta de enfermagem na anticoncepção.	31/07/2025
1.5	3	50 a 52	Alterado quadro 22 com revisão dos critérios de elegibilidade e modificação subsequente das observações: Inserções: Coluna para implante; Linhas para nulípara, pós-parto não amamentando; gravidez ectópica anterior, múltiplos fatores de risco cardiovasculares; histórico de pressão alta na gestação; histórico familiar de TEP/TVP; dm sem complicações vasculares; dm com complicações vasculares; enxaqueca sem aura menos de 35 anos; enxaqueca sem aura mais de 35 anos; enxaqueca com aura - qualquer idade; doença da vesícula biliar atual ou história da doença relacionada ao ACO; hepatite viral aguda ou exacerbada; tumores hepáticos: adenoma hepatocelular ou hepatoma; Retiradas: linhas de DM ou COMPLICAÇÕES VASCULARES; ENXAQUECA SEM AURA; ENXAQUECA COM AURA;	31/07/2025
1.5	3	53 a 56	Alterado quadro 23 (antigo 2.3): Parte das colunas “como usar/condutas do enfermeiro” e “efeitos colaterais mais comuns” da linha de DIU deslocadas para página 56 (observações) e para capítulos 3.2.7 e 3.2.8. Na linha de métodos cirúrgicos: Incluída atualização da lei para requisitos e retiradas solicitações de exame pré-operatórios na coluna “como usar/condutas do enfermeiro”. Incluída linha para conteúdo de “Dispositivos contraceptivos implantáveis” Nas observações: Incluídos avisos para atrasos e grifo vermelho para realização de teste de gravidez.	31/07/2025
1.5	3	57 a 59	Alterado quadro 24 (antigo 2.4) com inclusão da coluna de efeitos colaterais, modificação da recomendação de uso de método de barreira para o anel vaginal de 3 para 2 horas caso fique fora da vagina e retirada da linha “Dispositivos contraceptivos implantáveis”.	31/07/2025
1.5	3	66 a 70	Inserido “Quadro 26 – Contraindicações para o DIU de Cobre” e “quadro 27 - Manejo das Principais Intercorrências Relacionadas ao DIU” (antigo anexo II), nesse segundo, inserida observação na linha para reação vaginal; retirada solicitação de radiografia de abdômen e inserida solicitação de USG para as linhas “transfixação uterina” e “DIU não identificado na cavidade uterina”; inserida conduta para linha “Colpocitologia oncológica alterada”.	31/07/2025
1.5	3	71	Inserido quadro 28 e DIU de Cobre como método anticoncepcional de emergência.	31/07/2025
1.5	4	73	Incluído capítulo 4.1 – TÉCNICA DE COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA	31/07/2025

Versão	Cap.	Pág.	Alteração	Data da alteração
1.5	4	74 e 75	Alterado quadro 29 (antigo 3.1) e incluídos: linha “Mulheres até 24 anos”, recomendação de encaminhamento para colposcopia ao primeiro exame alterado para linha “Mulheres infectadas pelo vírus HIV ...”,	31/07/2025
1.5	4	76	Incluído recomendação para encaminhamento conforme quadro 32 para as linhas de “Atipias de significado indeterminado”, “Lesão intraepitelial de alto grau” e “Lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasor.” No quadro 30.	31/07/2025
1.5	4	81	Incluído capítulo 4.5 – COLPOSCOPIA	31/07/2025
1.5	5	83	Atualizado todo o quadro 33 (antigo 4.1)	31/07/2025
1.5	5	85	Atualizado fluxograma 6 (antigo 4.1)	31/07/2025
1.5	6	88 a 93	Retirado antigo quadro 5.1 e inseridos fluxograma 7, quadro 36 e quadro 37.	31/07/2025
1.5	6	94 a 108	Retirados antigos capítulo “5.2– Roteiro das Consultas”, “Quadro 5.2 – Síntese de Condutas Conforme o Trimestre de Gestação” e “Quadro 5.3 – Exame Clínico Obstétrico - Sentido Cefalocaudal”, sendo substituídos pelo capítulo “6.2 – PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA CONSULTA PRÉ-NATAL”.	31/07/2025
1.5	6	--	Deslocado capítulo “7.4 - ABORDAGEM OPORTUNÍSTICA SOBRE IMUNIZAÇÕES NO ATENDIMENTO À MULHER” (antigo 5.3 – pág. 59) para capítulo seguinte.	31/07/2025
1.5	6	---	Retirada primeira linha do antigo quadro “5.6–Exames a serem solicitados por padrão no pré-natal, interpretações e condutas” com informações incorporadas no quadro 41.	31/07/2025
1.5	6	110 a 120	Retirado antigo quadro “5.6–Exames a serem solicitados por padrão no pré-natal, interpretações e condutas” e inserido capítulo “6.3 – EXAMES DE ROTINA PARA GESTANTE”	31/07/2025
1.5	6	122	Inserção do item 6.3.2 - Recomendação e Evidência sobre a Ultrassonografia nos Diferentes Períodos da Gestação	31/07/2025
1.5	6	123	Inserção do item 6.4. “Manejo de Comorbidades Mais Prevalentes na Gestação”	31/07/2025
1.5	6	132	Inserção do quadro 49 - “Tratamento medicamentoso conforme cultura identificada nos casos de rastreamento de NG e/ou CT”	31/07/2025
1.5	6	133 a 139,	Quadro 50 - Modificações e Desconfortos Mais Frequentes na Gestação” (antigo quadro 5.7): Na linha Náuseas/vômito, inserção da possibilidade de prescrição de Dimenidrinato 50mg ou 100mg ou Possibilidade de prescrição de Dimenidrinato (50mg ou 100mg) + Piridoxina 10mg; Inserção do alerta de avaliação de alergia ou sensibilidade à medicação. Na linha Estrias, inserido o quadro de alerta sobre a contraindicação do tratamento de estrias na gestação e na amamentação.	31/07/2025
1.5	6		Retirado item 5.6.1 - “Zika”	31/07/2025
1.5	6	140	Introdução do item 6.6 - “Imunização para Gestantes Segundo Calendário Nacional”	31/07/2025
1.5	7	145	Item 5.8 passa a ser Capítulo 7 - Atenção à Mulher no Puerpério - Consulta Pós-Natal	31/07/2025
1.5	7	146	Introdução do Item 7.1 - Abordagem da Sexualidade no Puerpério	31/07/2025
1.5	7	147	Alteração no Quadro 5.9.1 - “Tratamento de Anemia no Puerpério”, que passa a ser Quadro 54. - Introdução da possibilidade de prescrição do comprimido de Sulfato Ferroso 60mg	31/07/2025
1.5	7	149	Alteração item 5.9 - “Abordagem ao Aleitamento Materno”, que passa a ser item 7.3	31/07/2025
1.5	7	149	Alteração do Quadro 5.10 - “Principais itens a serem observados na mamada”, que passa a ser Quadro 55	31/07/2025
1.5	7	151	Alteração do Quadro 5.11 - “Queixas/intercorrências Mais Comuns na Amamentação”, que passa a ser Quadro 56 - “Prevenção e Manejo dos Principais Problemas Relacionados À Amamentação”	31/07/2025
1.5	7	158	Introdução do item 7.3.3 - “Suspensão do Aleitamento Materno - Contraindicações Absolutas e Relativas”	31/07/2025
1.5	7	159	Alteração Quadro 5.12 - “Condições Clínica Avaliadas na Manutenção ou Contraindicação de Aleitamento Materno”, que passa a ser Quadro 57	31/07/2025
1.5	7	160	Introdução do item 7.3.3.1 e quadro 58 - “Acompanhamento de Nutrízes Quanto à Infecção pelo HIV”	31/07/2025
1.5	7	161	Introdução do item 7.3.4 - “Retirada e Armazenamento do Leite Materno”	31/07/2025

Versão	Cap.	Pág.	Alteração	Data da alteração
1.5	7	161	Introdução do Quadro 59 - “Passo a Passo para Retirada, Armazenamento e Oferta do Leite Materno ao Bebê”	31/07/2025
1.5	7	165	Introdução do item 7.4 - “Abordagem Oportunística Sobre Imunizações no Atendimento à Mulher”	31/07/2025
1.5	8	166	Capítulo 8 - Menopausa e Climatério	31/07/2025
1.5	8	166	Introdução de hiperlinks	31/07/2025
1.5	9	169	Capítulo 9 - “Orientações Para Atendimento à Adolescente”	31/07/2025
1.5	ANEXO		Retirado o Anexo I - “Taxa de Falha de Métodos de Contracepção”	31/07/2025
1.5	ANEXO	178	Alteração Anexo III - “Modelo de Plano de Parto”, que passa a ser Anexo I	31/07/2025
1.5	ANEXO		Retirado o Anexo IV - “Evidências Sobre a Realização da Ultrassonografia nos Diferentes Períodos da Gestação”	31/07/2025
1.5	ANEXO	180	Alteração do Anexo V - “Alterações emocionais Mais Comuns em Puérperas”, que passa a ser Anexo II	31/07/2025
1.5	ANEXO	181	Introdução do Anexo III - “Formulário de Avaliação da Mamada”	31/07/2025
1.6	5	83-84	Inserção de nova atualização de diretriz do MS para rastreamento do câncer de mama. Também atualizado quadro 33 - Aprazamento Das Mamografias De Rastreamento.	02/10/2025

ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis